جامعة الزقازيق
كلية التربية النوعية

الصحة النفسية والإرشاد النفسي

الفرقة الثالثة
الفصل الدراسي الثاني

إعداد
الأستاذ الدكتور
إيهاب الببلاوي
أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله $الذي أرسل رحمة للعالمين... وبعد:

هذا الكتاب يعتبر إسهامًا في مجال - الصحة النفسية- حيث يضم بين دفتيه ستة فصول تناول أول هذه الفصول مدخل إلى الصحة النفسية وتضمن المقدمة، ومفهوم الصحة النفسية، وأهداف الصحة النفسية، ونظريات الصحة النفسية، ومؤشرات الصحة النفسية.

فيما تناول الفصل الثاني: السواء واللاسواء في الصحة النفسية ، وتم عرض بين السوية واللاسوية، والسلوك السوى، وشدة السلوك، وكمون السلوك، ومعايير ومحكات السوية واللاسوية.

أما الفصل الثالث فجاء بعنوان حيل الدفاع النفسية وتضمن كل من حيل الكبت، والإعلاء، والإسقاط، والتبرير، والنكوص، والتعويض، والإنكار، والنقل أو الإزاحة، والتقمص، والتكوين المضاد، والإبدال أو التحويل، وأحلام اليقظة أو الخيال.

في حين تضمن الفصل الرابع: الاضطرابات النفسية والعقلية وتناول مفهوم المرض النفسي، وتعريف الاضطرابات النفسية أو العصابية، وتعريف الاضطرابات العقلية أو الذهانية، والعوامل المرتبطة بالاضطرابات النفسية والعقلية.

بينما تناول الفصل الخامس: الاضطرابات النفسية (العصابية) وتضمن مدى حدوث الاضطرابات العصابية، وأسباب الاضطرابات العصابية، وأعراض الاضطرابات العصابية، وأولًا: اضطرابات القلق، وثانيًا: اضطرابات الوجدان.

وأخيرا تضمن الفصل السادس: الاضطرابات العقلية (الذهانية) وتضمن أعراض الاضطرابات الذهانية، وأسباب الاضطرابات الذهانية، وتشخيص

الاضطرابات الذهانية، وعلاج الاضطرابات الذهانية، ونماذج من الاضطرابات الذهانية.

ويعد هذا تقديم موجز لمحتويات هذا الكتاب و موضوعاته،ويرجو المؤلفان أن يكونا قد أسهما بإضافة جديدة للمكتبة العربية سواء للمتخصصين من الطلاب والباحثين أو أولياء الأمور والمعلمين أو طالبي المعرفة من القراء العاديين، كما يرجوا من الله- عز وجل- أن يتقبل هذا العمل المتواضع خالصا ابتغاء مرضاته انه سميع مجيب

المحتويات	الصفحة
المقدمة	٣-٤
الفصل الأول : مدخل إلى الصحة النفسية	١١- ٢٧
الفصل الثاني : السواء واللاسواء في الصحة النفسية	٢٨ - ٤٦
الفصل الثالث : حيل الدفاع النفسية	٤٧ – ٦٨
الفصل الرابع : الاضطرابات النفسية والعقلية	٦٩ - ٩٢
الفصل الخامس : مدخل للإرشاد النفسي	٩٣ - ١٢٢
الفصل السادس : القائمين على الإرشاد بالمدرسة	١٢٣ - ١٤٤
الفصل السابع : مجالات الإرشاد بالمدرسي	١٤٥ - ١٦٠
الفصل الثامن : أساليب التوجيه والإرشاد النفسي المدرسي	١٦١ - ١٩٦
الفصل التاسع : تطبيقات على مشكلات الطفولة والمراهقة	١٩٧ - ٢٤٨
مراجع الكتاب.....	٢٤٩ - ٢٥٧

الفصل الأول

مدخل إلى الصحة النفسية

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على مفهوم الصحة النفسية.
- الوقوف على أهداف الصحة النفسية.
- التمكن من التفرقة بين الصحة النفسية عند مدرسة التحليل النفسي والمدرسة السلوكية.
- الإلمام بمحطات المؤشرات التى يستدل بها على تمتع الفرد بالصحة النفسية.

الفصل الأول
مدخل إلى الصحة النفسية

مقدمة:

الصحة النفسية علم له شقان **أولهما**: شق نظري علمي يهتم بمعرفة الكيفية التى ينمو بها السلوك السوى، والعوامل التى تجعله ينحرف عن مساره ويخرج إلى حدود اللاسواء، أو الانحراف، **وثانيهما**: شق تطبيقي عملي يستهدف مكافحة ومواجهة الاضطرابات النفسية والعقلية بكافة صورها وأنواعها ودرجاتها، ويهدف إلى وقاية الناس منها. وتزويدهم بالمعارف والمعلومات للمحافظة على صحتهم النفسية، ومعاونتهم على مواجهة مشكلاتهم، وفهمها بطرق سليمة وصحيحة، كما أنه يقدم الطرق العلاجية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية، ولهذا كله أدى علم الصحة النفسية إلى ظهور الحركة التربوية الصحية التى تهتم بمشكلات التوافق لدى الأسوياء وغير الأسوياء، وأصحاب الأجسام السليمة وذوى الإعاقات، الجانحين وغير الجانحين (أشرف عبدالغنى، ٢٠٠١).

مفهوم الصحة النفسية:

لقد وقع علماء النفس فى مشكلة ولا يزالون كلما حاولوا تحديد الصحة النفسية، من أين يبدأون؟، وإلى أى شئ يتوصلون؟، وعلام يتفقون؟، وكم هم مختلفون؟ فيبدو أنهم قد اتفقوا على مصطلح الصحة النفسية فى حد ذاته، وتباينت تعريفاته ومدلولاته لدى كل فريق منهم، ولعل المصدر الحقيقى لتلك الصعوبة يتمثل فى تحديد واختيار المكان والمعايير التى فى ضوئها نصف شخصًا ما بأنه صحيح نفسيًا، أو غير ذلك (عادل هريدى، ١٩٨٨).

وربما يرجع ذلك أيضًا إلى تعقد السلوك الإنسانى وغموض النفس الإنسانية، وبالتالى هناك صعوبة بالغة يواجهها كل من يحاول تعريف الصحة النفسية، وخاصة وأنها تعنى ضمنيًا الحكم على ذلك السلوك المعقد وتقييمًا لتلك النفس الغامضة، ثم وصفها بالصحة، أو بالمرض، والسواء، أو اللاسواء.

ولما كان الإنسان كائنًا اجتماعيًا لا تستقيم حياته إلا فى جماعة يتفاعل معها يؤثر فيها ويتأثر بها؛ فإن للبيئة الاجتماعية تأثيراتها القوية المباشرة وغير المباشرة فى تشكيل الجوانب الفكرية، والدينية، والنفسية، والسلوكية لأفرادها، وبالتالى نتوقع تفاوتًا ثقافيًا من مجتمع لآخر، الأمر الذى يمثل صعوبة إضافية، حيث نصبح مطالبين بتحديد أنواع شتى من الصحة النفسية، يخص كل منها ثقافة بعينها، الأمر الذى لا نجد مثيلًا له فى الصحة الجسمية، حيث إن أعراض الأنفلونزا – مثلًا – هى نفسها فى أى منطقة بالعالم، لا يختلف عليها اثنان من الأطباء.

وبالتالى يتميز مفهوم الصحة النفسية بأنه مفهوم ثقافي ونسبي بطبيعته، وهو متغير بتغير ما يجد علينا من معلومات عن الحياة، وما ينبغى أن نكون عليه، كما أنه يتغير بما نكتشفه عن أنفسنا وسلوكنا، وما نحب أن نصل إليه فى حياتنا (عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٦).

ولقد عرف علاء الدين كفافى (١٩٩٠) الصحة النفسية مؤكدًا ضرورة تقبل المجتمع لسلوك الفرد بأنها: "حالة من التوازن والتكامل بين الوظائف النفسية للفرد، تؤدي به أن يسلك بطريقة تجعله يتقبل ذاته، ويتقبله المجتمع، بحيث يشعر من جراء ذلك بدرجة من الرضا والكفاية".

ويؤكد أحمد عبد الخالق (١٩٩١) على أن الصحة النفسية هى: " حالة دائمة نسبيًا، فهى ليست ثابتة إما أن تتحقق، أو لا تتحقق، وإنما هى حالة متحركة ونسبية تتغير من فرد إلى آخر، ولدى الفرد ذاته من وقت إلى آخر، كما تختلف معاييرها تبعًا لمراحل النمو التى يمر بها الفرد، وتتغير تبعًا لتغير الزمان وتغير المجتمعات".

ويعرف حامد زهران (٢٠٠٥) الصحة النفسية بأنها: "حالة دائمة نسبيًا، يكون فيها الفرد متوافقًا نفسيًا (شخصيًا، وانفعاليًا، واجتماعيًا) أي مع نفسه ومع بيئته، ويشعر فيها بالسعادة مع نفسه، ومع الآخرين، ويكون قادرًا على تحقيق ذاته، واستغلال قدراته وإمكانياته إلى أقصى حد ممكن، ويكون قادرًا على مواجهة مطالب الحياة، وتكون شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عاديًا بحيث يعيش فى سلامة وسلام".

ولكن قد وجه النقد إلى التعريفات المتداولة فى الصحة النفسية بأنها تمثل تعبيرات مجازية غير دقيقة، وأنه يجب أن نستبدلها بمفاهيم ومصطلحات وصفية دقيقة وذات معنى (نجيبة الخضرى، ١٩٨٥).

ويعرف عبد المطلب القريطى (١٩٨٨) الصحة النفسية بأنها: "حالة عقلية انفعالية إيجابية، مستقرة نسبيًا، تعبر عن تكامل طاقات الفرد ووظائفه المختلفة، وتوازن القوى الداخلية والخارجية الموجهة لسلوكه فى مجتمع ووقت ما ومرحلة نمو معينة، بالإضافة لتمتعه بالعافية النفسية والفاعلية الاجتماعية".

وهذه التعريفات تؤكد ما يتمتع به الشخص الصحيح نفسيًا من صفات إيجابية تؤهله إلى أن يكون قادرًا على مواجهة المشكلات والأزمات بكفاءة عالية، وقدرته على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه (بالأسرة، أو المدرسة، أو المجتمع) بصورة إيجابية.

فى حين تعرف وجدان الكحيمى وآخرون (٢٠٠٣) الصحة النفسية بأنها "التوافق التام، أو التكامل بين الوظائف النفسية والجسمية، مع قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع الآخر ين، وقدرته فى مواجهة الأزمات النفسية التى تطرأ على حياته، واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن، بحيث يترتب على هذا كله شعوره بالسعادة والراحة النفسية".

ولقد استعرض علاء الدين كفافى (١٩٩٠) ما قدمه كولمان Coleman من تلخيص لأهم الاتجاهات النظرية التى تظهر فى تعريفات الصحة النفسية ،بعد استعراضه لأعمال أربعة عشر من العلماء فى مفهوم الصحة النفسية، وهذه الاتجاهات هى:

(١) **الاتجاه الطبيعى:** يركز على الدوافع الغريزية فى الإنسان، مثل الجوع، والجنس، ويرى أن الصحة النفسية هى القدرة على إشباع هذه الدوافع. على أن يتم هذا الإشباع فى الحدود التى وضعتها البيئة، وهى ما يسمى بالمواءمة، والاضطراب العقلى هو الفشل فى تحقيق هذه المواءمة.

(٢) **الاتجاه الإنسانى:** يركز على وجهة النظر القائلة بأن الإنسان كائن عاقل ومفكر ومسؤول، ويستطيع أن يسلك سلوكًا حسنًا ينمى به ذاته ويحققها إذا تهيأت الظروف لذلك. والسلوك اللاسوي ينتج بسبب إعاقة الإنسان عن تحقيق ذاته.

(٣) **الاتجاه الاجتماعي:** يؤكد على الطبيعة الاجتماعي للإنسان، ويرى أن الهدف الأساسى أمام الإنسان هو التوافق مع المتطلبات الاجتماعية، وبذلك تكون الصحة النفسية هنا مرتبطة بقدرة الفرد على إقامة علاقات اجتماعية مثمرة مع الآخرين، وفشله فى ذلك يعنى الاضطراب النفسي.

(٤) **الاتجاه الوجودى:** يشير إلى انهيار القيم، وضرورة بحث الإنسان عن هوية خاصة به، وأن يعرف معنى وجوده، وأن يسعي لتحقيق هذا الوجود، والفشل فى تحقيق هذا الهدف يعنى الاضطراب بكل صوره.

(٥) **الاتجاه الدينى:** يؤكد هذا الاتجاه على ضعف الإنسان، واعتماده على الله، وعلى أن خلاص الإنسان لن يتم إلا بلجوئه إلى الله، واعتماده عليه.

أهداف الصحة النفسية:

توجد العديد من الأهداف للصحة النفسية، حيث تهدف بشكل عام إلى المحافظة على صحة الفرد النفسية فى أحسن وضع ممكن، ويمكن تحقيق هذا الهدف الرئيس من خلال تفاعل الأهداف التالية:

(١) الوقاية من الاضطرابات النفسية، وذلك من خلال إزالة الأسباب التى تؤدي إليها، والعمل على توفير الظروف المناسبة للفرد بحيث يتمكن من مواجهة المشكلات والاضطرابات بكفاءة عالية.

(٢) المعرفة الدقيقة بكل ما يعترى صحة الفرد النفسية فى حالات التكيف المختلفة التى تمر به سواء فى البيت، أو المدرسة، أو العمل، أو كان أمام مشكلات فى حياته العامة فى إطار المجتمع الذى يعيش فيه.

(٣) الاستمرار فى رعاية الصحة النفسية للفرد، وذلك من خلال التشجيع، والتعزيز، وتوفير الظروف التى من شأنها استمرار الصحة النفسية فى أحسن وضع ممكن، وعلاج الحالات التى لا تتمكن من مواجهة الاضطرابات، أو المشكلات لوحدها فى مؤسسات علاجية متخصصة (أحمد الزعبى، ٢٠٠٦)

نظريات الصحة النفسية:

مع تعدد مفاهيم الصحة النفسية نجدها تختلف تبعًا لاختلاف النظريات النفسية والأطر الفكرية التى تبناها الباحثون، وفيما يلى النظريات المفسرة للصحة النفسية، أو كما يعبر عنها البعض بالشخصية السوية، والتى استعرضها كل من صلاح مخيمر (١٩٧٩)؛ وعبد السلام عبد الغفار (١٩٧٦)؛ وعلاء الدين كفافي (١٩٩٠) على النحو التالى:

الصحة النفسية عند مدرسة التحليل النفسي:

إن الصحة النفسية من وجهة نظر التحليل النفسي – الفرويدى خاصة – تكمن فى مقدرة الأنا على التوفيق بين أجهزة الشخصية ومطالب الواقع، ويرى فرويد فى الشخصية ثلاث قوى، أو وظائف أساسية: الوظيفة الأولى وهى ما يطلق عليها "الهى" (ID) وتشير إلى الدوافع الفطرية التى يولد الفرد مزودًا بها، وهى تمثل الطاقة الأساسية للسلوك عند الإنسان، وهى تدفعه إلى النشاط والحركة لإشباع دوافعه، وهذه الطاقة تتضمن غريزتين أساسيتين هما: غريزتا الجنس والعدوان. أما الوظيفة الثانية فى الشخصية فهى الوظيفة العاقلة، أو وظيفة التحكم، وهى يمكن أن تبصر المرء بعواقب سلوكه ويطلق عليها وظيفة "الأنا" (Ego)، والوظيفة الثالثة هى وظيفة الرقابة والردع ممثلة فى "الأنا الأعلى" (Super Ego) وهى تشير إلى المثل العليا والقيم الخلقية السائدة فى الجماعة، ويستدخل الفرد هذه المثل إلى داخل نفسه أثناء عملية تنشئته الاجتماعية. والشخص يصبح سوي ويتمتع بالصحة النفسية، عندما تكون الوظيفة الثانية "الأنا" قوية بحيث تستطيع أن يوازن بين الوظيفتين الأخرتين، التى تطلب الإشباع، و"الأنا الأعلي" والقيم الخلقية السائدة فى الجماعة، ويكون نجاحها فى مهمتها المتمثلة فى إحداث التوازن، أما إذا فشلت "الأنا" فى مهمتها بسبب ضعفها فإن الفرد يكون معرضًا لأية صورة من صور اللاسواء.

وقد ظهرت اتجاهات تحليلية نفسية جديدة ربط أصحابها بين الصحة النفسية، أو الشخصية السوية وبعض المفاهيم الأخرى كالتوجه المنتج Productive Orientation عند "فروم"، والإبداعية Creativity عند "رانك"، وإدراك الذات، أو معرفتها Self Realization عند "هورنى"، بينما أوضح "إريكسون" أن تحقيق مطالب "الأنا" عبر مراحل النمو النفسي الاجتماعي وخلال عملية التنشئة، هو الذى يحقق الصحة النفسية، وهذه

المطالب هى الثقة فى العالم الخارجى والثقة بالنفس، والاستقلالية، والمبادأة، والمقدرة على الإنجاز، والشعور بالهوية وتقدير الذات. والمقدرة على الإنتاج وتكامل الأنا.

الصحة النفسية عند المدرسة السلوكية:

تعد الصحة النفسية من وجهة نظر السلوكيين نتاجًا لعملية التعلم والتنشئة، وهى تكمن فى اكتساب الفرد عادات مناسبة وفعالة تساعده فى التعامل مع الآخرين، وفى مواجهة مختلف المواقف التى يتعرض لها.

وينتج الاضطراب الانفعالي عن الفشل فى تعلم، أو اكتساب السلوك المناسب، أو عن تعلم أساليب سلوكية غير مناسبة، أو مواجهة الفرد لمواقف صراعية نفسية تستلزم تمييزًا، أو اتخاذ قرارات يشعر أنه عاجز عنها؛ وبالتالى فإن الإنسان من وجهة نظر السلوكيين صفحة بيضاء يتعلم ما يعرض عليه حسب فرص التدعيم، ولذلك فإن علماء المدرسة السلوكية وجهوا اهتمامهم إلى دراسة وتوضيح الأسس والقواعد التى على أساسها تتكون العادات ثم تقوى وتستقر، أو تضعف وتتلاشى، وعلى هذا الأساس فإن الشخصية السوية عند السلوكيين مرتبطة بتعلم عادات صحية سليمة، وتجنب اكتساب العادات غير الصحية، أو غير السليمة، والصحة والسلامة هنا تتحدد بناء على المعايير الاجتماعية السائدة المحيطة بالفرد، وبذلك فإن مظاهر الشخصية السوية عند السلوكيين هى أن يأتى الفرد السلوك المناسب فى كل موقف، حسب ما تحدده الثقافة التى يعيش فى ظلها الفرد.

الصحة النفسية عند المدرسة الإنسانية:

يرى أصحاب هذا المذهب الإنسانى أن الصحة النفسية تتمثل فى تحقيق الفرد لإنسانيته تحقيقًا كاملًا، ومن المؤشرات الدالة على ذلك مدى ما يمارسه الفرد من حرية، ومدى إدراكه لمدى هذه الحرية وحدودها وتحمله لمسئولياتها، ومقدرته على التعاطف مع الآخرين وحبهم، والتزامه بالقيم العليا كالحق والخير والجمال، والشعور بالطمأنينة والانتماء، وتقبل الذات وتحقيق إمكانات الفرد وأهدافه، ويرى "ابراهام ماسلو" كممثل لهذا التيار، أن صاحب الشخصية السوية هو الشخص الذى يحقق ذاته، وتحقيق الذات يعنى

تحقيق القوى الكامنة الفطرية عند الشخص. والشخص الذى حظى بإشباع لحاجاته الأساسية هو الشخص الذى يستطيع أن يحقق ذاته. ويذهب "ماسلو" إلى أن صاحب الشخصية السوية يتميز بخصائص معينة، بالقياس إلى غير السوى، وأهم هذه الخصائص ما يلى:

- استقلالية الذات.
- تقبل للذات وللآخرين وللطبيعة.
- إدراك أكثر فاعلية للواقع، وعلاقات مريحة معه.
- القدرة على الانسلاخ مما حوله من مثيرات، والحاجة إلى الخلوة الذاتية.
- علاقات شخصية متبادلة عميقة.
- تكوين خلق ديمقراطى.
- التمييز بين الوسائل والغايات.
- الابتكار والإبداع.

مؤشرات الصحة النفسية:

إن الصحة النفسية تكوين فرضى، بمعنى أننا لا نراها ولا نلاحظها مباشرة، وإنما نفترض وجودها بناء على أساليب سلوكية تصدر عن الفرد، نستطيع أن نلاحظها وأن نقيسها بصورة من الصور، ويمكننا أن نستدل من هذه الأساليب السلوكية على وجود الصحة النفسية، أو عدم وجودها، وعلى ذلك فنحن نصف شخصًا ما بأنه يتمتع بالصحة النفسية إذا صدر عنه سلوك له صفات معينة، ونصف شخصًا آخر بأنه لا يملك قدرًا كبيرًا من الصحة النفسية، أو لديه نقص فى الصحة النفسية (علاء الدين كفافى، ١٩٩٠).

ويرى كل من محمد عودة وكمال مرسى (١٩٨٩) بأن مؤشرات الصحة النفسية تتمثل فى:

(أ) **الجانب الروحى:** يشمل الإيمان بالله، وأداء العبادات، والقبول بقضاء الله وقدره، والشعور الدائم بالقرب من الله، وإشباع الحاجات بالحلال، والمداومة على ذكر الله تعالى.

(ب) **الجانب البيولوجى:** يشمل سلامة الجسم من الأمراض والعيوب التكونية، وتكوين مفهوم ايجابي عن جسمه والعناية الصحية به.

(ج) **الجانب النفسي:** يشمل الصدق مع النفس، والاتزان الانفعالي، والسيطرة وضبط النفس، والاعتماد على النفس، والقدرة على تحمل الإحباط والقلق، وتقبل الذات، وسلامة الصدر من الحقد والحسد والكره.

(د) **الجانب الاجتماعي:** يشمل حب الوالدين، وشريكة الحياة والأولاد، والجرأة فى قول الحق، والصدق مع الآخرين، وحب العمل، وتحمل المسؤولية الاجتماعية والابتعاد عما يؤذى الناس من الكذب والغش والسرقة... وغير ذلك.

ولقد استعرض كل من أحمد الزعبى (٢٠٠٦)؛ وإيمان فوزى (١٩٩٦)؛ وعبد المطلب القريطى (١٩٩٨)؛ علاء الدين كفافى (١٩٩٠)؛ ومحمد عبد الظاهر الطيب (١٩٩٤) أهم المؤشرات التى يستدل بها على تمتع الفرد بالصحة النفسية، ومن بين هذه المؤشرات ما يلى:

(١) النظرة الواقعية للحياة:

كثيرًا ما نلاحظ أشخاص يعانون من عدم قدرتهم على تقبل الواقع، وفى المقابل هناك من يقبل على الحياة بكل ما فيها من أفراح وأحزان؛ ولذا فإن الفرد الذى يحدد أهدافه فى الحياة، وتطلعاته للمستقبل على أساس إمكاناته الفعلية، وعلى أساس المدى الذى يمكن أن يصل إليه باستعداداته فهو فرد سوى، وهذا يعنى أن السوى لا يضع لنفسه أهدافًا صعبة التحقيق بالنسبة له، حتى لا يشعر بالفشل؛ بل أنه يعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه، أى أنه يريد ما يستطيع، ويستطيع ما يريد، وبالتالى فهو يشعر بالنجاح ولذة تحقيق الإمكانات، وفى المقابل فإن الشخص الذى يختار لنفسه أهدافًا سهلة التحقيق بالنسبة له طالبًا الشعور بالنجاح، فإن هذا الفرد لا يسلك سلوكًا سويًا أيضًا؛ فالواقعية هنا هى ألا يبالغ الفرد فى تقدير ذاته، أو يقلل من قيمتها، وكذلك لا يبالغ فى تقدير الأهداف، أو يقلل من قيمتها.

والشخص الذى يتمتع بالصحة النفسية، نجد أنه لديه توازنًا نفسيًا داخليًا لا يقوم بتشويه الواقع، بعكس الشخص الذى لديه اعتلال فى الصحة النفسية، فنظرًا لمشاعره السلبية إزاء نفسه وإزاء الآخرين، فإنه يدرك دائمًا الأمور على هواه، وليس كما هى فى

الواقع، فتحدث عمليات التشوية التى تجعله لا يعيش واقعه كما هو؛ بل يعيشه كما يحب ويتمنى.

(٢) التوافق النفسي:

يعد التوافق النفسي أساس الصحة النفسية السليمة، إذ كلما كان الفرد أقدر على التوافق النفسي دل ذلك على تمتعه بصحة نفسية أفضل.

والتوافق يتضمن جانبين، الأول: هو علاقة الفرد مع نفسه، بمعنى قدرته على مواجهة ما يعتريه من صراعات وإحباطات ومدى تحرره من القلق والتوتر الناجم عنها، أما الجانب الثانى: فيظهر فى علاقة الفرد مع محيطه المادى والاجتماعي بما يتضمنه من أشخاص، وعلاقات، ومجالات، وأحداث، ومشكلات (عبد المطلب القريطى، ١٩٩٨).

(٣) الشعور بإشباع الحاجات النفسية:

حتى يتوافق الفرد مع نفسه ومع الآخرين، فإن أحد مؤشرات ذلك أن يشعر بأن حاجاته النفسية مشبعة، ويتمثل ذلك فى شعوره بأنه محبوب من الآخرين، وأن لديه القدرة على الحب، وشعوره بأن لديه القدرة على الإنجاز، كما أن الإنسان نفسه فى حاجة أيضًا إلى التقدير والحرية وإلى الانتماء، كما يتمثل أيضًا فى شعوره بالأمن والطمأنينة بصفة عامة، وهذا لا يعنى أن الفرد السوى لا ينتابه القلق ولا يشعر بالخوف؛ بل إنه يقلق عندما يتعرض إلى ما يثير القلق، ويخاف إذا تهدد أمنه، ولكن فى هذه الحالات يسلك السلوك الذى يعمل مباشرة على حل المشكلة، أو يعمل على إزالة مصادر التهديد، وإذا كان الشعور بالأمن والطمأنينة هو القاعدة فى حياة الفرد السوى الذى يتمتع بالصحة النفسية، فإن الخوف والقلق والتوجس هى المشاعر التى تشكل أرضية الحياة الانفعالية للفرد غير السوى، وبالتالى فإن شعور الفرد بأن معظم حاجاته الأساسية مشبعة فإن هذا يعد أحد المؤشرات المهمة لتمتعه بالصحة النفسية، ويحدث العكس إذا ما شعر بأنه غير مشبع وأن حاجاته محبطة، فإنه يقترب من سوء التوافق الذى يؤدي إلى العصاب.

(٤) التكامل بين الوظائف النفسية:

يعنى هذا المظهر أن تنتظم أداء كل من جوانب الشخصية الجسمية، والعقلية، - المعرفية، والمزاجية، والانفعالية، والاجتماعية جميعها فى كل موحد، بحيث تتناسق فيما بينها لتحقيق وظائفها وأهدافها، دون أن يطغى جانب على جانب آخر، وذلك بما يحقق التوازن والانسجام بين القوى النفسية للفرد.

(٥) المرونة واتساع الأفق:

يتسم الفرد الذى يوصف بهذه الصفة بقدرته الفائقة على تحليل الأمور وفرز الإيجابيات من السلبيات، والتوازن فى تصرفاته، وهذا يعنى أن الفرد السوى يحاول دائمًا أن يجد بدائل للسلوك الذى يفشل فى الوصول إلى الهدف. كما أن من دلائل المرونة أن الفرد يمكن أن ينصرف عن المواقف كلية إذا وجد أن المشكلة، أو الهدف أعلى من مستوى إمكاناته، أو أنها لا تستحق الجهد الذى يبذل فيها، كذلك يتسم سلوك هذا الفرد ببعدى القيادة والتبعية، إذ تتطلب بعض المواقف أن يكون الفرد قائدًا خصوصًا إذا تتطلب الموقف خبرته المناسبة فى هذا المجال، كما تتطلب مواقف أخرى أن يكون تابعًا إذا ما وجد داخل الجماعة شخص آخر أكثر خبرة وحنكة فى هذا المجال فتكون له القيادة، وفى المقابل فإن السلوك غير السوى، يتضمن تكرارًا للمحاولات ولو كانت فاشلة، وإن ذلك التغير يمس الشكل دون الجوهر، ويسمى السلوك فى هذه الحالة بالسلوك الجامد. ويعود السلوك الجامد إلى عدم قدرة الفرد على إيجاد أساليب سلوكية أخرى بديلة بسبب نقص المرونة، أو الجمود، وبالطبع فإن الشخص غير السوى يبرر فشله فى هذه الحالة بعوامل أخرى، حيث أنه لا يرى إلا ما تحت قدميه ويصعب التعامل معه، ودائمًا يعانى هذا الشخص من سوء التوافق.

(٦) القدرة على ضبط النفس:

يعنى هذا المظهر القدرة على التحكم فى الذات وضبطها وكف اندفاعاتها، والتحكم فى مشاعره ورغباته وسلوكياته، وضبط أهوائه ونزعاته بإرادته الذاتية، والتحكم فى مواجهة مشكلات

الحياة اليومية، والمواقف العصبية، والظروف الضاغطة، والقدرة على إدارة الأزمات والشدائد، والقدرة على التصرف بهدوء واتزان فى هذه المواقف.

(٧) الثبات الانفعالي:

إن هذه السمة من أهم السمات التى تميز الشخص المتمتع بالصحة النفسية، والتى تتمثل فى قدرته على تناول الأمور بأناة وصبر، ولا يستثار من الأحداث التافهة، ويتسم بالهدوء والاتزان، وهذا لا يعنى أنه لا يشعر بجميع الانفعالات من سرور وأسى، وحزن ودهشة وكل الانفعالات الأخرى، ولكن يعبر عنها بقدر مناسب للمثيرات التى اثارتها، وبالتالى يكون هناك تناسبًا بين سلوك الشخص السوى والموقف الذى يصدر فيه السلوك. أما السلوك غير السوى فيتضمن مبالغة فى الانفعال، تزيد عما يتطلبه الموقف.

ولا يولد الشخص حاملًا لهذه السمة ولكن تنمو معه فى ظل بيئة أسرية هادئة يسود فيها التعاطف والثقة بالنفس بين الأفراد داخلها، وقد ثبت أن الآباء العصابيين مثلًا تتكون لدى أبنائهم صفة القلق الانفعالي؛ مما يدل على أن البيئة العصابية المشحونة بالتوتر تولد القلق.

(٨) الشعور بالسعادة والرضا عن الذات والآخرين:

الشخص الصحيح نفسيًا يشعر غالبًا بالطمأنينة والسعادة والراحة النفسية، ويكون متفائلًا، وتنحسر لديه مشاعر القلق والشعور بالذنب؛ مما يزيد من دافعيته لبذل مزيد من الجهد، والإقبال على الحياة والاستمتاع بمباهجها المشروعة، ولكن سعادة الفرد يجب ألا تكون على حساب سعادة الآخرين؛ بل إن شعور الفرد الصحيح نفسيًا يجب أن يمتد ليشمل سعادته بعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين. فالشخص السعيد حقًا هو ذلك الشخص الذى لا تتعارض حاجاته ورغباته مع مصالح الآخرين.

ولذلك فإن مقدرة الفرد على بناء روابط أسرية متينة، والإسهام بدور إيجابى فى المناسبات الاجتماعية، وإقامة علاقات إنسانية وصداقات مثمرة مع الآخرين، والتفاعل مع الآخرين بشكل مثمر فى محيط السكن والدراسة والعمل والنادي، وشعوره بتقدير الآخرين ومساندتهم الوجدانية له، وكذلك حاجاته لأن يحب ويحب ويتعاون ويتفاعل اجتماعيًا،

وقدرته على الاستمتاع بهذه العلاقات وشعوره بالسعادة الناجمة عنها، يعد من أهم المؤشرات للصحة النفسية السليمة.

(٩) العلاقة الصحية مع الذات:

تتمثل هذه العلاقة فى ثلاثة أبعاد: وهى فهم الذات، تقبل الذات، وتطوير الذات، وفهم الذات: يعنى أن يعرف المرء نقاط القوة والضعف لديه، وأن يفهم ذاته فهمًا أقرب إلى الواقع، فلا يبالغ فى تقدير خصائصه وصفاته، ولا يقلل من قيمتها، انطلاقًا من المفهوم النسبي العام، بأنه لا يوجد من يخلو من بعض الجوانب السلبية، كما لا يوجد من هو فاقد كلية للجوانب الإيجابية.

ثم يأتى البعد الثانى وهو تقبل الذات: ويعنى تقبل الفرد لذاته بإيجابيتها وسلبياتها وألا يرفضها، أو يكرهها؛ لأن رفض الذات، أو كراهيتها يترتب عليه عجز الفرد عن تقبل الآخرين تقبلًا حقيقيًا، وتقبل الفرد لذاته لا يعنى بالطبع الرضا السلبى عن الذات؛ بل أن هذا التقبل لا يمنع أن ينتقد الفرد ذاته، وأن يحاسبها، وأن يقيم سلوكه باستمرار.

أما البعد الثالث تطوير الذات: فيعنى ألا يقتنع الفرد بتقبل ذاته كما هى؛ بل عليه أن يحاول تحسينها وتطويرها، والتحسين والتطوير يحدث بتأكيد جوانب القوة، ومحاولة التغلب على النقائص ونقاط الضعف، والتخلص من العيوب، أو التقليل من أثرها على الأقل، وبالتالى فتقبل الذات مقدمة لتحسينها؛ لأن من يرفض ذاته لن يحاول تطويرها بالطبع.

(١٠) النجاح فى العمل والرضا عنه:

من مظاهر الصحة النفسية السليمة مدى قدرة الفرد على تحقيق النجاح فى عمله ورضاه عنه، وشعوره بإشباعه لحاجاته وطموحاته.

كما يعد الرضا عن العمل من أهم مقومات التوافق المهنى السليم للفرد ويتجلى رضا الفرد عن العمل ونجاحه فيه، بإقباله عليه برغبة، وبذل الجهد الكافى وتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة فيه، وحسن استخدام أدوات العمل، والقدرة على إقامة علاقات اجتماعية ناجحة

ومثمرة مع زملائه ورؤسائه فى العمل، بحيث يشعر بأن حاجاته النفسية والاجتماعية والمادية مشبعة من خلال ممارسته لعمله.

فهناك بعض الأفراد الذين يؤدون أعمالهم كارهين لها، أو أعمالًا لا تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم فقد تكون أعلى من هذه القدرات وقد تكون أقل منها، فمثلًا قد يكون لأحد الأشخاص قدرات إبداعية، ولكنه يقوم بعمل روتينى فيصبح لذلك غير راض عن هذا العمل، وعلى العكس إذا كان العمل الذى يقوم به فرد من الأفراد أعظم من قدراته فإن ذلك يشعره بالعجز وعدم الملائمة، أما إذا كان العمل مشبعًا لحاجات الفرد المادية والنفسية فإن ذلك يجعله سعيدًا راضيًا، ويساعد على تمتعه بالصحة النفسية.

(١١) الإفادة من الخبرة:

يعدل الفرد السوى من سلوكه دائمًا بناءً على الخبرات التى يمر بها، فهو يغير ويعدل من سلوكه حسب ما تعلمه من المواقف السابقة، خاصة المواقف ذات العلاقة والصلة بالموقف الذى يمر به، فكل موقف يمر به يضيف جديدًا إلى مجموعة الخبرات، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة المواقف التالية، أما الشخص غير السوى فلا يبدو أن سلوكه يتعدل بناءً على ما يقابل من مواقف؛ لأن معظم الحالات لا يكون فى وضع يسمح له باكتساب خبرة حقيقية فى المواقف التى يمر بها، حيث أنه لا ينتبه إلى جوانب مهمة فى الموقف، وبالتالى فغالبًا لا يدرك الفرد غير السوى العلاقة بين ما سبق أن مر به وتعلمه وبين الموقف الراهن الذى يمر به.

(١٢) الاستقلالية:

يقصد بالاستقلالية هنا أن يقيم الفرد الأمور ويختار بين أفضل البدائل المتاحة أمامه؛ فالإنسان السوى لا يعد نفسه ضحية للظروف مهما كانت قسوتها، ولا يفقد القدرة على الاختيار من بين البدائل مهما كانت ندرتها، والإنسان المستقل هو الذى يعى حدود حريته، ويدرك مسئولياته، ويقدم على تحملها دون تردد، أو اعتماد على الآخرين، وهو الإنسان المدفوع من الداخل Self motivated الذى يرسم لنفسه الأهداف التى تتلائم مع إمكاناته الواقعية ويتحمل مسئولية تحقيقها وحده متقبلًا بشجاعة نتائج اختياره سواء أصاب النجاح، أو صادفه الفشل فلا يلجأ للتبرير وخلق الأعذار وإنما يعاود النشاط بمثابرة كى يعوض ما

فاته، وهذا لا يعنى أن الإنسان المستقل يعزل نفسه عن الآخرين من منطلق اعتماده على ذاته، ولكن على العكس من ذلك، فاستنادًا إلى ثقته بنفسه وقدرته على توجيه حياته يمكن أن يعتمد أيضًا على الآخرين فى سياق تبادل الأدوار الاجتماعية لإشباع بعض حاجاته، أو لتفادى الإحباط، أو للتعاون مع الآخرين لتحقيق مهام اجتماعية لإشباع بعض حاجاته، أو لتفادى الإحباط، أو للتعاون مع الآخرين لتحقيق مهام اجتماعية؛ فالشخص السوى يستطيع أن يصبح عضوًا فعالًا فى الجماعة التى ينتمى إليها دون أن يفقد احترامه لذاته، ودون أن تتميع هويته.

(١٣) النمو المستمر:

إن تحقيق الذات قد يفهم على أنه الوصول للقمة والتربع عليها بما يعنى الجمود عند هذا الحد، ولكن واقع الأمر يكشف أن توقف الإنسان عند مرحلة معينة من الأداء لمجرد أنه حقق النجاح فهذا لا ينتمى للسوية؛ لأنه سرعان ما يتخلف عن الآخرين بل وعن ذاته أيضًا؛ لأن الطبيعة الإنسانية تحمل دائمًا إمكانات التطور والتغير، وعلى الإنسان أن يلاحق هذا التطور باستمرار، وقد تناول صلاح مخيمر (١٩٧٩) معنى الاستمرار فى النمو الذى لا يتوقف إلا بتوقف الإنسان عن الحياة، حيث إن إيجابية الإنسان التى تتحقق من خلال تغييره لواقعه إلى الأفضل لا يكون لها معنى إلا من خلال النمو المستمر للذات فى الاتجاه الإيجابى.

(١٤) ثبات اتجاهات الفرد:

إن ثبات اتجاهات ومواقف الفرد أمر لا يأتى إلا مع وجود خط فكرى واضح وخلفية فلسفية رصينة تصدر عنها أحكام الفرد وتصرفاته المختلفة؛ مما ييسر عليه أن يتصرف بصورة ثقافية تقريبًا لأغلب الموضوعات والقضايا، وتكوين فلسفة واضحة فى الحياة ليس بالأمر السهل، أو الهين بل هو عملية تدريجية تتأثر بما نكونه من قيم خلال الحياة وخلال خبراتنا المنوعة فى الأسرة، وفى المجموعات الاجتماعية الأخرى، كما تتأثر أيضا بثقافة الفرد واجتهاداته الشخصية ولا نعنى بثبات الاتجاهات أن تكون جامدة غير قابلة للتعديل؛ بل أن المرونة مطلوبة وهى دليل على النمو والتقدم، والمقصود ألا تتصف اتجاهات الفرد بالتذبذب والتناقض على المدى القصير، ومن الواضح

أن ثبات اتجاهات الفرد ينم عن تكامل الشخصية، كما ينم كذلك عن الاستقرار الانفعالي إلى حد كبير.

(١٥) القدرة على إقامة علاقات اجتماعية ناجحة:

بعض الأفراد أقدر من غيرهم على إنشاء علاقات اجتماعية وعلى الاحتفاظ بالصداقات والروابط المتينة فى الجماعات التى يتصلون بها.

وتعد هذه العلاقات سندًا وجدانيًا مهمًا ومقومًا أساسيًا من مقومات الصحة النفسية، أما إذا أتت علاقات الفرد الاجتماعية متدهورة سيئة فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على معنوياته العامة وعلى توافقه النفسي، ومعنى هذا أن النجاح، أو الفشل فى إقامة علاقات اجتماعية مشبعة فى مجال الأسرة والزمالة والصداقة هو واحد من المعايير المهمة التى نحكم بها على مدى ما يتمتع به الفرد من الصحة النفسية.

الفصل الثاني

السواء واللاسواء
في الصحة النفسية

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على :

- إدراك معني السلوك السوى.
- الوقوف على الفرق بين أسس السوية واللاسوية.
- توضيح المحك الباثولوجى.
- التعرف على شدة السلوك.
- الإلمام بأساليب المحك الذاتى.
- التمييز بين ما يؤخذ على كل من المحك الاجتماعى و المحك الذاتى.

الفصل الثاني
السواء واللاسواء في الصحة النفسية

مقدمة:

مفهوم السواء وكذلك مفهوم الشذوذ كلاهما مفهوم نسبى لو نظرنا إليه من أية زاوية، فالانحراف عن أى محك، أو معيار يستطيع الشخص تقبله يمكن أن يكون طفيفًا لا يستحق الاهتمام، أو قد يكون واضحًا لا يدع مجالًا للشك بأنه ذات طبيعة شاذة؛ إلا أنه لا يوجد حد قاطع بين ما هو سوى وما هو شاذ يمكن أن نعتبره حدًا مميزًا، ففى أى مجموعة من الأشخاص لا نستطيع أن نقول بقدر كبير من الثقة "أن هذا سوى" إلا إذا كان الشذوذ واضحًا تمامًا.

وهذا معناه، أن سلوك الآخرين قد يبدو لنا مقبولًا أحيانًا، ويبدو غير مقبول فى أحيان أخرى، فى الحالة الأولى نظهر الارتياح، أو نطلق حكم الاستحسان، أو نمر بالسلوك من غير أن نطلق أى حكم خاص باعتباره السلوك العادى الذى تقتضيه المناسبة، أما فى الحالة الثانية، فأكثرها ما يحدث هو أن نقف موقف المستغرب، أو المستهجن، أو الناقد، ونطلق أحكامًا على ذلك السلوك غير العادى تتفاوت فى درجة ما تنطوى عليه من استغراب، أو استهجان، أو نقد، فهو غير عادى أحيانًا، وهو فى حالات أخرى غريب، أو غير مألوف، أو مستهجن، أو فظيع، أو منحرف، أو خطر، أو شاذ ... الخ، وقد نقنع أحيانًا بهذا الحكم العام، وقد نتجه منه، أحيانًا أخرى إلى بعض المبادئ الاجتماعية، أو الأخلاقية لنبنى عليها حكم الاستهجان والاستغراب الذى أطلقناه (عبد الفتاح دويدار، ٢٠٠٠، ٣١)

بين السوية واللاسوية:

تعددت الآراء حول مفهوم السواء واللاسواء، فكلمة سواء تعنى معيارًا قاعديًا، وبالتالى تعنى كلمة سوى الالتزام بهذا المعيار، وتكون الشخصية السوية بذلك هى الشخصية التى يساير سلوكها ذلك المعيار القاعدى، والشخصية غير السوية هى التى لا يتفق سلوكها مع ذلك المعيار (رشاد موسى، ٢٠٠٦)

ويذكر حامد زهران (٢٠٠٥) أن السوية هي: "القدرة على توافق الفرد مع نفسه، ومع بيئته، والشعور بالسعادة، وتحديد أهداف وفلسفة سليمة للحياة يسعى لتحقيقها".

والسلوك السوى هو السلوك العادى أى المألوف، والغالب على حياة غالبية الناس، والشخص السوى هو الذى يتطابق سلوكه مع سلوك الشخص العادى فى تفكيره، ومشاعره، ونشاطه، ويكون سعيدًا ومتوافقًا شخصيًا وانفعاليًا واجتماعيًا، أما اللاسوية فهى الانحراف عما هو عادى. واللاسوية حالة مرضية فيها خطر على الفرد نفسه، وعلى المجتمع أن يتدخل لحماية الفرد، أو حماية المجتمع، والشخص اللاسوى هو الشخص الذى ينحرف سلوكه عن سلوك الشخص العادى فى تفكيره ومشاعره ونشاطه، ويكون غير سعيد، وغير متوافق شخصيًا وانفعاليًا واجتماعيًا (رشاد موسى، ٢٠٠٦).

والسوية واللاسوية لا يفهم أحدهما إلا بالرجوع إلى الآخر، والفرق بينهما فرق فى الدرجة وليس فى النوع، أى أن الأفراد يمكن ترتيبهم على متصل بين السوية واللاسوية، وبين العادية والشذوذ، وبين الصحة النفسية والمرض النفسي، ويلاحظ أن السوية واللاسوية مفهومان نسبيان فى مراحل العمر المختلفة، وفى الأزمنة المختلفة، وفى الثقافات المختلفة (حامد زهران، ٢٠٠٥، ١١)

ويعرف مصطفى الشرقاوى (١٩٨٣، ٣٣) مفهوم السواء واللاسواء بأن السواء هو لغة الاعتدال، أو العادية، فى حين أن مفهوم الشذوذ يشير إلى الانفراد، أو المخالفة، أو الندرة، فالسواء يعنى الالتزام والمسايرة والانضباط، بينما يعنى الشذوذ: الانحراف بمفهومه الإجتماعى والتخريب والضلالة، وفى هذا الإطار قامت محاولات كثيرة للباحثين فى مجال الصحة النفسية لوضع تحديد للسلوك السوى والسلوك غير السوى.

وينقل شيفر وميلمان (١٩٨٩، ٢) عن أنا فرويد Anna Freud قولها: "أن تحديد الخط الفاصل بين الصحة العقلية والمرض يكون أصعب فى مرحلة الطفولة فى حال مقارنتها بالمراحل اللاحقة، وأن الفرق بين السلوك السوى وغير السوى هو فرق فى الدرجة، أى فى مدى تكرار السلوك الذى يؤدى إلى حدوث مشكلة للطفل، أو الأسرة، أو المجتمع، وإذا كان عدم الارتياح الناتج عن السلوك بالنسبة للطفل، أو الآخرين يتكرر باستمرار، أو كان شديدًا بطبيعته، أصبح من الضرورى الحصول على إرشاد نفسي متخصص، أو علاج نفسي للطفل

والأسرة، وكلما زاد ما يظهره الطفل من سلوك غير سوى، وكان سلوكه لا يتناسب مع عمره، وكلما مر عليه فترة زمنية أطول، وزادت مقاومته للجهود المبذولة لمساعدته، كلما دل ذلك على الحاجة إلى مساعدة متخصصة لحل المشكلة".

السلوك السوى:

فى محاولة لتعريف الشخصية السوية والسلوك السوى قام علماء النفس – منذ سنوات طويلة بالتأكيد على كلمة توافق Adjustment إذ كان يعتقد أن سمات الشخصية السوية هى التى تساعد الناس على التوافق مع البيئة ومع الآخرين وبعبارة أخرى قبول حقائق الحياة المادية والمجتمع والسلوك فى اتساق معهما.

غير أن إريكسون (١٩٦٨) يرى أن عدد السيكولوجيين الذين يرون أن السلوك السوى ليس مجرد التوافق؛ بل بذل جهد فعال للتلاؤم مع مشكلات الحياة، وتحقيق نوع من الإدراك النفسي الآمن، والاستقلال، وتحقيق الذات يتزايد يومًا بعد يوم، وأصبح بعض السيكولوجيين يعرفون الأشخاص الأسوياء بأنهم من يحافظون بشعور ثابت تجاه أنفسهم، أو من يملكون الحرية الداخلية لاتخاذ قراراتهم بدلًا من الخضوع لضغوط البيئة وضغوط الآخرين فى كل الأحيان (فاروق موسى، ١٩٨٥، ٤٤٣)

معنى السلوك السوى من الناحية اللغوية:

(أ) فى اللغة العربية: الاستواء هو الاعتدال والوسطية فى الشئ، يقال شخص سوى الخلق، أو مستوى الخلق، ويقال أن الحداد سوى قضيب الحديد، أى جعله مستويًا دون أعوجاج.

(ب) فى اللغة الانجليزية: الإستواء هو الإتساق مع المعيار والتطابق كما هو شائع ومعروف، وفى العمل كما هو طبيعى وعادى ومنتظم (نفسيًا)الاستواء هو مرادف للصحة النفسية. فالشخصية السوية هى العادية، أو المتوسطة (القريبة من المركز).

شدة السلوك:

يقصد به درجة السلوك، أى أن السلوك يعد شاذًا إذا كانت شدته غير عادية فالسلوك قد يكون قويًا جدًا، أو قد يكون ضعيفًا جدًا، فالأطفال جميعهم يتحدثون ولكن بعضهم

يتحدث بصوت غير مسموع، وبعضهم الآخر يتحدث بصوت مرتفع جدًا، وهناك سلوكيات غير الأصوات قد تكون قوية جدًا وقد تكون ضعيفة جدًا، وهذه الشدة فى السلوك تنسحب أيضًا على المشاعر؛ مثل: القلق، أو الخوف، أو الحب... وغيرها من المشاعر التى ترتبط بالانفعالات. ويتم الحكم على هذه السلوكيات حسب ارتياحنا للمقبول منها، أو عدم رضانا للمزعج منها فنصفنها إلى سلوكيات عادية (سوية)، أو غير عادية (شاذة).

كمون السلوك:

يشير كمون السلوك إلى الفترة الزمنية التى تمر بين المثير وحدوث السلوك، أى استتار وغياب السلوك، أو الاستجابة لفترة معينة، ثم يعود السلوك الغائب، أو المستتر إلى الظهور، ومن مظاهره أيضًا، عدم القدرة على الاستجابة لمثير معين فى الوقت المعقول للاستجابة، أو تأخره فى الاستجابة أكثر مما هو متوقع. ففى داخل الفصل المدرسى يعانى المعلم أحيانًا من بعض الحالات التى لا يتكلم فيها الطفل مهما حاول المعلم معه. وإذا تكلم فإنه يتأخر كثيرًا عن الوقت المعقول، فإذا طلب من الطفل حل مسألة ما فإنه يمضى وقت حتى يستجيب الطفل لهذا الطلب، أو أن استجابته تكمن لفترة، مع أنه يعرف الحل، وفي الوقت التي يريدها المعلم لاستكمال الشرح فى حصته، والسبب فى ذلك يعود إلى عدم ثقة الطفل بنفسه، أو خوفه الذى يمنعه من الكلام، أو الاستجابة، وأكثر ما تحدث هذه المشكلات مع الأطفال الجدد فى المدرسة، كما فى روضة الأطفال، أو فى الصف الأول الابتدائى.

معايير ومحكات السوية واللاسوية:

تعد المظاهر السوية لدى الأفراد نسبية وتعنى السوية قدرة الشخص على التكيف والتوازن بين المتطلبات البيئية والشخصية وتحقيق إمكانياته والشعور بالسعادة مع الذات والآخرين، وهناك أطر عامة فى غالبية المجتمعات تعد محدودات لسوية السلوك لدى الأفراد؛ مثل: الحدود الدينية، والأخلاقية، والقانونية وما يعاقب عليه أم لا، والمعايير الاجتماعية، والتقاليد، والعرف، والعادات السلوكية التى أصبحت مألوفة لدى أى جماعة، أو أسرة، أو قرية، أو دولة ما، كما يظهر ذلك من الدراسات التى يطلق عليها الدراسات عبر الحضارية المقارنة،

فعند قيام الفرد بمسلك يتساءل عن الحكم الدينى والخلقى له ثم موقفه من القانون ثم مدى مقبوليته اجتماعيًا بين المجتمع ثم الأسرة، واتجاهه ذاتيًا نحو هذا المسلك أيضًا، وهل يصاحبه رضا وارتياح أم توتر وخوف مع أن مشاعر الفرد نحو نتيجة أى مسلك ليست هى المعيار الدقيق؛ فمشاعر الذنب الحقيقية تعد مغير ومهذب لمسار السلوكيات غير المرغوب فيها عند الأسوياء فتنخفض مشاعر الذنب (آمال باظة، ٢٠٠٢).

والسلوك السوى هو الذى يواجه الموقف بما يناسب فى ضوء ما يغلب على الناس، فإذا كان الموقف يدعو إلى السرور واجهوه بالسرور، وحين يظهر أحدنا الحزن بدل السرور فى هذا الموقف نستغرب ذلك ونستهجنه، وهذا يعنى أن السلوك السوى هو السلوك المألوف الذى يغلب على حياة غالبية الناس (أحمد الزعبى، ٢٠٠٢).

وبهذا المعنى يكون الشخص سويًا إذا تطابق سلوكه مع سلوك الشخص العادى فى تفكيره ومشاعره ونشاطاته، ويكون سعيدًا ومتوافقًا شخصيًا وانفعاليًا واجتماعيًا.

وتوجد معايير عديدة لتحديد السلوك السوى والسلوك غير السوى، أو الشاذ، ومن هذه المعايير:

أولًا: المحك الإحصائى

إن التوزيع الطبيعى وفقًا للمعيار الإحصائى يميل إلى التوسط والاعتدال بالنسبة لما تنطوى عليه من الحوادث ومظاهرها الكمية، وإن أكثر الحالات تقع حول المتوسط فى حين لا يقع فى حقل التطرف إلا القليل منها (نعيم الرفاعى، ١٩٨٧). كما يشير هذا المعيار إلى مدى انحراف السلوك عن المتوسط الشائع فى البيئة المحيطة، ولذلك يدخل فى عداد ذوي الإعاقة، أو الموهوبين؛ مثل: العباقرة وذوي الإعاقة الفكرية وذلك بحكم انحراف هاتين الفئتين عن المتوسط الشائع.

ففى متغير الذكاء يقع أغلبية الناس ويدورون حول المتوسط (١٠٠) حيث يوصف ذكاؤهم بأنه ضمن المتوسط، وتبدأ حالات الإعاقة الفكرية نزولًا بعد معامل ذكاء مقداره (٧٠)، وتبدأ حالات التفوق العقلى صعودًا بعد حاصل ذكاء مقداره (١١٠)، وعليه فإن متوسطى الذكاء هم من يوصفون بالسواء، والذين ينحرفون عن المتوسط من ذوي الإعاقة الفكرية ومن المتفوقين عقليًا هم من يوصفون بالانحراف عن المتوسط. إذا الفرض الإحصائى

يقول أن المدى السوى يضم فقط ما يقرب من الثلثين اللذين يقعان وسط التوزيع فى أغلب المجموعات التى درست.

ويذكر خالد الطحان (١٩٩٦، ١١١ – ١١٢) أن هناك ثلاثة أسباب تدعونا إلى الاعتماد على المحك الإحصائى هى:

الأول: وهو سبب نظرى إذ يشير إلى أن اللاسواء هو المغالاة، أو الانحراف عن السلوك غير العادى؛ إلا إذا كان لدينا مفهوم واضح عن السلوك العادى.

الثانى: وهو سبب عملى ويقوم هذا البرهان على أساس أن كثيرًا من الأفراد الذين يعانون من الاضطراب النفسي يمكن معالجتهم وإعادتهم إلى حالة السواء وذلك عن طريق الإرشاد أو العلاج النفسي، أو تعديل السلوك، وهذا يعنى أن مفهوم العادية، أو السواء يمكن فهمه وإدراكه من خلال درجة مواءمة السلوك، وإسهامه فى تحقيق التوافق السوى للفرد، إذا نحن نلاحظ أن السلوك السوى واللاسوى من طبيعة واحدة، ولكنهما يختلفان من حيث الدرجة، إذ أن جهود الإرشاد أو العلاج النفسي تنقص وتخفض درجة عدم ملاءمة السلوك أى درجة اللاسواء عند الفرد.

الثالث: وهو سبب ثقافى، ذلك أن المستوى الحضارى والثقافى للمجتمع الذى يعيش فيه الفرد هو الذى يحدد ما إذا كان السلوك الذى يصدر عن الفرد ينم أى يكشف عن سلوك سوى، أو غير سوى، ولذلك فإنه كلما تقدم المجتمع، نلاحظ أنه يتقبل قيمًا جديدة، ويرفض قيمًا أ خرى، وفى هذه الحالة فإن الإنسان يكون سويًا وعاديًا عندما يكون قادرًا على استيعاب وتمثل القيم المتجددة فى المجتمع، وفى هذه الحالة يكون عاديًا وكل من لا يرتبط بهذه القيم بدرجة مناسبة يكون غير سوى.

وفى مجال الصحة النفسية، نجد أن الأفراد الذين يقعون من حيث ما يمتلكون من خصائص نفسية مع الغالبية العظمى، أى مع العاديين، نقول أنهم ينعمون بقدر مناسب من الصحة النفسية، فى حين أن أولئك الذين ينحرفون عن الغالبية العظمى فى خصائصهم النفسية فإننا نقول أنهم لا ينعمون بقدر مناسب من الصحة النفسية.

وهكذا يمكن القول أن المحك الإحصائى يعتمد على فكرة التوزيع الطبيعى التى تذهب إلى أن الطبيعة تميل بصورة عامة إلى الاعتدال والتوسط فيما تنطوى عليه الحوادث والمظاهر

الكمية، وأن أكثر الحالات تقع عادة حول المتوسط بينما لا يقع فى مجال التطرف إلا القليل منها، فمثلًا متوسط أعمار الناس تقع غالبًا ما بين الخمسين والستين وأن القليل منهم من يموت طفلًا، أو يعمر فوق الحد المتوسط، وهذه الفكرة يعبر عنها بمنحنى التوزيع الاعتدالي – كما سبقت الإشارة – أو منحنى جاوس GAUSS والذى تحدد فيه مكانة كمية نسب التوسط ونسب الانحراف، وبناء على ذلك فإن التوزيع الاعتدالى ينظر إلى التوسط على أنه السواء، وينظر على الانحراف على أنه اللاسواء.

ويذكر علاء الدين كفافى (١٩٩٠، ٤٥) أنه إذا كان مقبولًا أن نسم سلوك ذوي الإعاقة الفكرية بالشذوذ فإنه مما يثير اللبس أن نصف سلوك المتفوقين عقليًا والابتكاريين بالشذوذ واللاسواء، وهو ما يمكن أن يحدث – أيضًا– عندما نطبق المحك الإحصائى فى الجوانب الانفعالية والاجتماعية. ففى مقاييس الشخصية يصبح أصحاب التقديرات العالية والتقديرات المنخفضة من الشواذ وغير الأسوياء. فهل يمكن اعتبار أصحاب التقديرات المتطرفة (المرتفعة والمنخفضة) فى أحد المقاييس التى تقيس بعد العصابية – قوة الأنا – من الشواذ؟ إن هذا يعنى أن كلًا من أصحاب الأنا القوية وأصحاب الأنا الضعيفة من غير الأسوياء، وكذلك يكون الحال مع الحاصلين على درجات مرتفعة ودرجات منخفضة على مقياس القلق، وطبقا لذلك فنحن نضع فى سلة واحدة الذين يحصلون على درجات عالية فى مقياس القيادة (القادة)، والذين يحصلون على درجات منخفضة فى نفس المقياس (الاتباع).

وهذا معناه أن الصورة تختلف فى القياس النفسي بمعنى أن القياس النفسي يقوم على أسس معينة إن لم تراع فى القياس يصبح الرقم الذى نخرج به مضللًا، ولا معنى له، والقياس النفسي قياس غير مباشر فنحن نقيس شيئًا عن طريق قياس مظاهر نفترض أنها تعبر عما يقاس، كما أن القياس النفسي قياس نسبى، إذ لا توجد لدينا نقطة صفر، والمتوسط هو نقطة البداية، فنحن نقيس ما لدى الفرد مما يقاس بالنسبة إلى ما لدى معظم الناس، كما أن المظاهر النفسية التى يتم قياسها والتى يفترض أنها تعبر عما يقاس تتأثر بالعديد من العوامل، أى أننا لا نقيس مظهرًا نقيًا لما يقاس، ولهذا يتحدث هؤلاء عن مصطلحات مثل

صدق وثبات الأدوات التي نقيس بها السلوك أو المظهر الانفعالية مثلًا (عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٦، ٥٨ – ٦٠).

إلا أن هناك بعض الاعتراضات على استخدام المعيار الإحصائى فى تحديد مفهوم السوية واللاسوية للأسباب الآتية:

(أ) أن المتوسط أمر غير مرغوب فى كل وقت، أو كل وقت.

(ب) أن المعيار نسبي يتوقف على نوع العينة التى يشتق منها هذا المتوسط.

(ج) أن الوسط أمر نسبي سواء بالنسبة للفرد، أو المجتمع، أو بالنسبة للقائم بعملية استخدام ا لمعيار.

(د) أنه عند الحكم على شخصية فرد ما، أو تقديرها لا يمكن حساب هذا التقدير كميًا، أو حسابيًا (بالأرقام) فالشخصية "كل دينامى" متفاعل لا ينبغى تفتيتها إلى وحدات رقمية ثم تجميعها بعد ذلك، وعادة ما يستعان على ذلك بعمل ما يسمى (التخطيط النفسي)، أو البروفيل النفسي (أشرف شريت، محمد حلاوة، ٢٠٠٣).

ثانيًا: المحك الذاتى

وفقًا لهذا المعيار فإننا نحكم ذاتنا وكيانها الشخصى الفردي حينما نتحدث عما هو سوى، أو غير سوى، ونحكمها معتمدين على كل ما قبلته وألفته فى خبرتها السابقة، وهذا يعنى أن السلوك السوى بالنسبة إلينا هو ما نرغب فيه وما يتلاءم مع أفكارنا وآرائنا، أما السلوك غير السوى فهو ما لا نرغب فيه، وما يختلف عن آرائنا وأفكارنا.

يشعر الفرد بذاته ويتخذ منها إطارًا عامًا للحكم على سلوكياته ومدى تمتعها بالسوية، أو اللاسوية ويتضمن ذلك أولًا وعى الفرد بذاته بدون تشويه، أو ترفيع من شأنها ومعرفته أيضًا بمدى التغير الذى يطرأ على سلوكياته من فترة لأخرى، أو مع التقدم فى العمر الزمنى، والمرور بخبرات الحياة، وما يوجهه من مواقف وأزمات ومدى تجاوبه، أو تناوله لتلك المواقف ويجب الأخذ فى الاعتبار الدفاعات التى يلجأ إليها الفرد عند وصف ذاته كى يحصل على تبريرات، أو هروب من بعض المسالك غير السوية وبذلك يجب أن ينظر إلى الفرد فى علاقته بالبيئة الخاصة به، وضمن إطار قيمه ومعاييره الاجتماعية والدينية والخلقية،

وهناك بعض الحالات لا نستطيع الاعتماد والثقة فى المعيار الذاتى، أو الشخصى مثل الحالات الذهانية والأطفال ويجب أن يراعى التغير عبرة فترة زمنية (آمال باظة، ٢٠٠٢).

ولذلك فإن هذا المحك ذاتى، أو شخصى، لأنه يعتمد على الأطر المرجعية للأفراد، ومع ذلك فإنه يصلح المحك ذاتى فى بعض الحالات كمحك جيد فى التمييز بين الصور السوية والصور اللاسوية من السلوك، حيث يتضمن جزءًا لا بأس به من الموضوعية رغم ذاتيته؛ لأن الإطار المرجعى لأى فرد يتشابه فى الكثير من ملامحه مع الإطار المرجعى العام للجماعة، فالأفراد الذين ينشأون فى بيئة واحدة ويتعاملون على أساس ثقافة واحدة، يجدون أن هذه الثقافة تصنف كثيرًا من أساليب السلوك باعتبارها أساليب مقبولة، أو مرغوبة، وتصنف أساليب أخرى غير مقبولة، أو غير مرغوبة (علاء الدين كفافى، ١٩٩٠، ٤٣ – ٤٤).

ويؤخذ على هذا المحك:

(١) أنه لا يترك مجالًا للكشف عن معيار عام وغير شخصى نميز به بين ما هو سوى وما هو لاسوى (شاذ).

(٢) أنه لا يمكن تسيير الناس عامة حسب رأى شخص واحد، وأن نطلق عليهم الأحكام جزافًا ووفقًا لرأينا الذاتى.

(٣) أن الأحكام التى تصدر على أساس المحك الذاتى، تتعرض فى الكثير من الحالات للتشويه والتحريف، وذلك بحكم دوافع الفرد واتجاهاته وعلاقاته بالآخرين، خاصة فى المواقف التى لا يكون فيها الفرد فى موقف حيادى.

ولذلك، فإن هذا المحك إذا كان يصل لإصدار أحكام السواء اللاسواء فى بعض مواقف الحياة العامة، فإنه لا يمكن الركون إليه باعتباره محكًا علميًا دقيقًا.

ثالثًا: المحك الإجتماعى

حسب هذا المعيار فإن التوافق بين سلوك الفرد وقيم المجتمع ومعاييره الاجتماعية استواءً، ويكون عدم التوافق شذوذًا، ولذلك فإن مسايرة الفرد لقيم المجتمع الذى يعيش فيه ومعاييره، يعد أساسًا للحكم على سلوكه بالسواء، أو الشذوذ، ولذلك يعد القبول الاجتماعي المحك الاجتماعي للحكم على السلوك بالسواء، أو عدم السواء (علاء كفافى، ٢٠١٢).

يستمد المعيار الاجتماعي أسسه من التقاليد والعرف والقيم السائدة بين المجموعات والتى تختلف من مجموعة فى مجتمع ما إلى أخرى، ومن مجتمع لآخر، ومن دولة لأخرى، ويعد من أوضح المعايير للحكم على السوية؛ لأنه يظهر من خلال التفاعل والتعامل مع الآخرين، ويرجع للتنشئة الاجتماعية والأسرية ومجاراة القيم والعادات السائدة فى مجتمع ما. ولا يعد المعيار الاجتماعي صادقًا فى الحكم على السوية إلا إذا كان صادرًا عن تحقيق رغبات الفرد واعتقاداته، وليس مجرد مجاراة حتى لا يصبح الشخص سلبى تجاه قضاياه الذاتية وأيضًا فى علاقته مع الآخرين، ويلاحظ أنه لا يمكن فصل المعايير السابقة عن بعضها فهى مجتمعة تساعد فى تحديد درجة السوية واللاسوية.

فضلًا عن ذلك يختلف الحكم على السلوك السوى والسلوك غير السوى بالنسبة لفرد ما باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون سلوك ما سويًا ومتوافقًا فى مجتمع ما، ولكنه يكون سلوكًا غير سوى فى مجتمع آخر، ومثال ذلك: اختلاط الرجال بالنساء فى بعض المجتمعات دون الأخرى. كما أن ما نعده سلوكًا سويًا وتوافقيًا فى مجتمع ما منذ زمن بعيد (مثل عدم خروج المرأة إلى العمل) يعد سلوكًا غير مقبول فى الوقت الحاضر، وهذا ما يؤكد نسبية الحكم على صحة الفرد النفسية، وبناء على ذلك لابد للمرشد، أو المعالج النفسي من أن يأخذ ظروف المجتمع الذى يعيش فيه المسترشد بعين الاعتبار، وأن يكون على دراية ومعرفة بعاداته وتقاليده الدينية والخلقية قبل إصدار الأحكام على المسترشد (محمد الهابط، ١٩٨٩).

وبهذا نجد أن الفرد فى المجتمع يعمل على احترام هذه المعايير والقوانين التى بدورها تضبط سلوك الفرد (رشاد موسى، ٢٠٠٦، ٢٨). ويتفق ما سبق مع ما ذهب إليه الخريجى (١٩٨٢، ٤٢) من أن وظيفة الضبط الاجتماعى الأساسية هى تحديد نطاق السلوك المقبول فى المجتمع، ففى كل مجتمع، أو جماعة توجد مقاييس مطلوبة يتوخاها الفرد فى إنجاز دوره الاجتماعى، كما أن هناك تصرفات لا يسمح بها المجتمع، ولا يجيز لأفراده القيام بها فى أثناء تأديتهم لأدوارهم الاجتماعية، أو ممارستهم لنشاطاتهم الاجتماعية والجماعية.

ويؤخذ على المحك الاجتماعى فى تحديد السواء واللاسواء المآخذ الآتية:

(أ) يمكن أن يتحيز المجتمع إلى مجموعة من القيم الاجتماعية دون غيرها.

(ب) يعتمد المحك الاجتماعي بصفة أساسية على مجاراة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة فيه وهى قيم متغيرة من زمان لآخر، بمعنى أن التطور التاريخى يؤثر فى تغيير كثير من العادات والتقاليد فى المجتمع الواحد، وفى ضوء ذلك يختلف المعيار فى الحكم على السلوك من وقت لآخر.

(ج) قد يختلف أبناء المجتمع الواحد على السلوك اللاسوى (الشاذ) وذلك حسب طبقاتهم الاجتماعية، أو أوضاعهم الاقتصادية.

(د) هناك أشكال كثيرة من السلوك تعدها مجتمعات أنها شاذة فى حين أن مجتمعات أخرى لا تعدها كذلك، وذلك لأسباب فكرية، أو عقائدية، أو ثقافية، أو معرفية لدى أفراد هذه المجتمعات.

(هـ) هناك أشكال من الشذوذ لا توجد إلا فى بعض المجتمعات ويصعب تعميمها على كافة المجتمعات.

رابعًا: المحك المثالي

السوية هى المثالية والكمال، أو ما يقرب منهما، واللاسوية هى الانحراف عن المثل العليا، أو الكمال، وهذا معناه أن المحك المثالي يرى أن السوى هو الكامل، أو ما يقرب منه، أو الخالى من النقص والخطأ: فقوة الإبصار السوية ليست قوة الإبصار المتوسطة بل الكاملة، وكذلك الحال فى الجمال، والصحة، والذكاء، والخير، والحكمة، ولكن هذا المحك غير واقعى، فلا يوجد إنسان يخلو من النقص والصراع وجوانب الضعف، كما أن عدد الأفراد الذى يحققون هذا المعيار قد يكون نادرًا جدًا من الناحية الإحصائية، وقد لا يوجد على الإطلاق فى المجتمع الذى ننظر فيه؛ ولذا يكون الأسوياء ندرة، والشواذ هم الغالبية، كما أن هذا المعيار نسبى تبعًا لعوامل شتى وجلي أنه يستمد أصوله من الأحكام الخلقية وأحكام القيمة (أحمد عبدالخالق، ١٩٩٣، ١٤١)

كما تجدر الإشارة إلى أن سعد جلال (١٩٨٠، ٥٦٠ – ٥٦١) يرى أن الشذوذ وفقًا لهذا المعيار هو الانحراف عن المثل الأعلى، فالمعيار الذى يقاس به مدى الانحراف، أو الشذوذ هو مدى اقتراب الفرد من المثل الأعلى، وبالتالى فإن الشخص السوى هو المتكامل فى كل شئ، إلا أن صفة

التكامل لا تتوافر إلا فى أقلية قليلة جدًا من الناس، بل نادرًا ما نجد فى مجتمعنا من تتوفر فيه هذه الصفة (وهذا من عيوب المحك المثالى) نظرًا لعوامل الضغط المختلفة التى تتكاتف على الفرد، فتؤثر فى سلامة توافقه.

خامسًا: المحك النفسي - الموضوعى

توصف الحالة النفسية باللاسواء، أو الانحراف عندما يقودنا التحليل العلمى الدقيق إلى التأكد من وجود الاضطراب الوظيفى الشديد فيها، وبهذا المعنى فإن الفحص والتحليل الدقيق للحالة النفسية هو الأساس فى الحكم على الحالة، ثم بعد ذلك نعدها قليلة الحدوث من حيث نسبة وقوعها بين الناس، وأنها مختلفة فى أعراضها عما يبدو عند الآخرين، والفحص هو الذى يكشف فى النهاية عن وجود الاضطراب الشديد بدرجة تسمح بتسمية الحالة بأنها شاذة، وهذا الفحص يعتمد على ما لدينا من معارف علمية حول الحالات الشاذة، وما تؤدي إليه من اضطراب فى الوظائف النفسية.

أما الحالة النفسية السوية فهى الحالة التى يكشف لنا الفحص الدقيق عن التأكد من عدم وجود الاضطراب الوظيفى الشديد فيها، وأنها متكيفة مع نفسها ومع الآخرين بصورة فعالة (أحمد الزعبى، ٢٠٠٦).

يحتاج هذا البعد إلى تدخل الاخصائي النفسي المتمرس، أو الاكلينيكى الذى يتميز بمهارات القياس والتقييم وإقامة التشخيص بعد الإلمام والجمع بين معطيات ونتائج كل الاختبارات والمقاييس ودراسة الحالة، أو المقابلة سواء التشخيصية، أو المعرفية، أو المسحية وتتم عملية التشخيص النفسي على مرحلتين وهما جمع بيانات كميته وكيفيته عن الشخص ثم المماثلة، أو التأويل كما تعكسه تلك البيانات وهناك بعض الأدوات التى تشمل كل صور الاضطرابات والانحرافات عن السوية فى صورة شاملة مثل الدليل الاحصائى للاضطرابات النفسية الذى تصدره رابطة الأخصائيين النفسية الأمريكية (DSM) ويصدر منه كل فترة طبقة جديدة يتم تعديلها وفقًا لما تصل إليه البحوث والدراسات فى هذا المجال، ويتم درج هذه المسالك ضمن أحد محاور ذلك الدليل، هذا مع الاستعانة بالأدوات السيكومترية المحكمة بالدرجات؛ مثل: الاختبارات المعرفية، واختبارات الشخصية... وغيرها، بالإضافة إلى

الاختبارات الاسقاطية بفنياتها الكثيرة المتنوعة وأدواتها، ويلاحظ أن عملية التشخيص والتأويل للأغراض المضطربة للحالات المرضية تأخذ الأعراض معًا لتشخيص الحالات ولا تأخذ بكل عرض على حدة، بالإضافة إلى ملاحظة التداخل فى الأعراض واختلاطها فلا توجد حالات نمطية نقية تمامًا، ولذلك يؤخذ بفاعلية الأعراض، فهناك الاكتئاب والقلق المختلط فى مرحلة الطفولة والمراهقة ووجود الفوبيا عامل مشترك وأساس لغالبية الاضطرابات الوجدانية، فكل حالة مرضية لها زملة أعراض محددة لها بالإضافة إلى المصاحبات النفسية الأخرى.

أى أن هذا المعيار يتعمد فى تحديده لمفهوم الشخصية السوية على تحديده لمفهوم الشخصية المعتدلة نفسيًا؛ فالشخصية الشاذة تتسم بأعراض مرضية معينة كالمخاوف والوساوس وارتفاع مستوى القلق، وعلى هذا يصبح من خصائص الشخصية السوية خلوها النسبي من مثل هذه الأعراض.

سادسًا: المحك القيمى والخلقى أو الدينى

يستخدم المنظور القيمى مفهوم التوافق لوصف مدى اتفاق السلوك مع المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك السائدة فى المجتمع، وعلى هذا النحو ينظر للتوافق على أنه مسايرة أى اتفاق السلوك مع الأساليب، أو المعانى التى تحدد التصرف، أو السلك السليم فى المجتمع، ولذلك فالشخص المتوافق هو الذى يتوافق سلوكه مع القيم الاجتماعية السائدة فى جماعته، وقد ينظر للتوافق بنظرة أخلاقية، وذلك فى ضوء مبادئ أخلاقية، أو قواعد سلوكية تقرها ثقافة المجتمع.

والمحك الخلقى يتم اكتسابه من القرآن والسنة والآراء الدينية المفسرة لهما، ومن خلال التنشئة الأسرية ومدى التزامها بالمبادئ والمعايير الدينية فى حياة الأسرة وأفرادها فى مرحلة الطفولة، وهو أول الأطر العامة للحكم على السلوك، أو رفضه، أو القيام به وعند قيام الفرد بأى مسلك يتساءل عن مدى صحة هذا المسلك وهل هو حرام أم حلال؟ هل مرغوب خلقيًا أم مرغوب؟ وقد تختلف مستويات الحكم الخلقى من فرد لآخر ومن أسرة لأخرى، كأن المعيار الدينى هو الفيصل والأساسى فى المعيار الخلقى لكل المجتمعات والأسر، ويصاحب ذلك

مشاعر ذنب فى مستويات متباينة بتباين شعور الفرد بالخطأ، ودرجة هذا الخطأ ومخالفته للمعايير الدينية والخلقية.

وإذا كان هناك مشاعر ذنب تتناسب مع الخطأ الذى ارتكبه الفرد لهذا هو السوية، وإذا كانت مشاعر الذنب وهمية لا ترتبط بارتكاب خطأ حقيقى فهذا هو الاضطراب النفسي، أو انخفاض مستوى مشاعر الذنب واللامبالاة بما يأتى من أخطاء فهذا لاسوية والأخير هذا لا يصحح أخطائه طالما لم يشعر بالذنب من جراء ما اقترفه من أخطاء (آمال باظة، ٢٠٠٢).

سابعًا: المحك التكاملى

يحترم المحك التكاملى قيمة الفرد وإمكاناته، ويمنحه حرية الاختيار، كما أنه لا يتماشى مع ما هو سائد، أو شائع؛ بل يتماشى مع المعرفة الممكنة حول ذات الفرد، ومع المجتمع الذى يعيش فيه، وحاجات ذلك الفرد على المستويات العضوية والنفسية والاجتماعية، والسلوك اللاسوى يشمل ضمن هذا المعيار الانحرافات الجنسية والمعرفية أى التمييز الطبقى، والغش، والادمان، والأعصبة، والرهابات (المخاوف المرضية) والأذهنة، واضطرابات التوافق الشخصى والاجتماعي التى تهدد حاجة الفرد إلى تحقيق ذاته، أو تهدد المجتمع وسلامته ووجوده وتقدمه (سعيد العزة، ٢٠٠٢، ٢٢).

إن للمحك التكاملى آثار مهمة وتطبيقات مفيدة فى تشخيص السلوك الشاذ (اللاسوى) وعلاجه ورسم طرق الوقاية، فهو يهتم ببناء شخصية الفرد ودفعها للنمو إلى أقصى حد ممكن عقليًا واجتماعيًا ونفسيًا ومهنيًا مع الاهتمام بتصحيح علاقاته مع أسرته ومع سائر أوضاعه الاجتماعية والشاذة التى تمنعه من التوافق، وذلك عن طريق إقصاء الصعوبات الاقتصادية من طريقه، وتعديل بيئته الاجتماعية المسببة للانحراف، ويساعد الفرد على فهم ذاته وتبصيره بها، ويساعده على النمو فى ظل شروط متطورة، وبذلك يمكن القول أن علاج الفرد اللاسوى لا يتم بإخضاعه للشروط الاجتماعية القائمة بصرف النظر عن طبيعة الفرد الذاتية وإنما يهدف إلى بناء شخصية الفرد وتقويتها ودفعها إلى النمو على المستوى الفردى جنبًا إلى جنب مع مسايرة الأوضاع الاجتماعية.

ثامنًا: المحك الباثولوجى

إن السلوك الشاذ – من وجهة نظر المحك الباثولوجى – هو نتيجة حالة مرضية، أو مضطربة نستدل عليها من وجود أعراض إكلينيكية معينة، من قبيل المخاوف المرضية التى لا أساس لها – كما هو الحال عند العصابيين، أو الهذاءات والهلوسات كما هو الحال عند الذهانيين، أو سلوك مضاد للمجتمع كما هو الحال عند السيكوباتيين.

والخلاصة أن هذا المحك الباثولوجى يفترض أن الشخص الذى يملك شخصية سوية هو شخص بلا أعراض، وعلى الرغم من ذلك فإن الخبرة تعلمنا أنه نادرًا ما نجد فردًا خاليًا تمامًا من الأعراض، وبخاصة فى ظل الظروف الضاغطة، ومع ذلك فالعرض، أو مجموعة الأعراض هى علامات واضحة عن اضطراب الشخصية، والشخص الذى تظهر عليه هذه الأعراض يعد شاذًا.

ومن المنطقى أن يركز المحك الباثولوجى على المرض، إذ أن هدفه علاج هذا المرض، وكلما كان المرض معديًا، أو قابلًا لنشر العدوى كان أخطر، ولذلك يعرف السلوك الشاذ تبعًا لذلك بأنه: "حالة مرضية يكون فيها الفرد خطرًا على نفسه، أو على المجتمع، ومن ثم يتطلب السلوك الشاذ هنا التدخل لحماية الفرد، أو المجتمع، أو كليهما" (سعد جلال، ١٩٨٠، ٥٥٧)

ويكون ذلك عادة بعزل المرضى بأمراض معدية لحماية المجتمع من انتشار العدوى وينسحب الأمر ذاته على الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية تبعًا لهذا المحك.

ولكن هذا المعيار، أو (المحك) قاصر فى تركيزه على خطورة المرض والمريض فقط، فقد يعانى المريض من أعراض تسبب العجز، ولكنها غير خطرة كضعف العقل، اللهم إلا فى بعض حالات الإعاقة الفكرية الشديدة والحادة، ومعنى هذا أن يكون الشخص غير السوى (الشاذ) هو من ينحرف انحرافا شديدًا عن السوية إلى درجة تهدد الفرد والمجتمع وبهذا سيكون غير الأسوياء قلة نادرة، وسيكون الأسوياء هم الغالبية ويدخل فى عدادهم أيضًا عدد كبير من المرضى غير الخطرين.

كما تجدر الإشارة إلى ما ذكره رشاد موسى (٢٠٠٦، ٣٢) من أنه قد يكون هناك من يتسم سلوكه بالانحراف، ولكنه الانحراف الذى ليس فيه ضرر على الفرد، أو المجتمع مثل

بعض العصابيين الذى يعانون من مرض الخوف من التلوث، فيغسلون أيديهم كلما صافحوا أحدًا، أو لمسوا شيئًا؛ فهؤلاء لا يعدون مرضى طبقًا لهذا المحك، بالرغم من حاجتهم إلى المساعدة والعلاج. أما تحديد السلوك غير السوى فى ضوء الخطر الذى يهدد المجتمع، فإن هذا التحديد يقيس الأمور بمعيار غير ثابت: فكيف يعرف الخطر الذى يتعرض له المجتمع، لن يتفق اثنان على هذا التحديد؛ لأنه ما قد يعد خطرًا فى مجتمع ما، قد يعد غير خطر فى مجتمع آخر، وهكذا نجد أنه على الرغم من أن هذا المحك وإن كان عمليًا، إلا أنه يختلف من ثقافة إلى أخرى أى أنه محك نسبى إلى حد كبير.

تاسعًا: محك الشخصية السوية

الشخصية السوية المتكاملة هى الشخصية التى يتميز سلوكها بأنه سلوك بنائى إنشائى واقعى وليس سلوكًا هروبيًا هدامًا (رشاد موسى، ٢٠٠٦، ٣١٥)

وقد وضع ماسلو Maslow ومتلمان Mitelmann قائمة بالخصائص التى تصف لنا – وصفًا تفصيليًا – الشخص السوى الصحيح، وتتضمن هذه القائمة الخصائص التالية:

(١) تلقائية مناسبة.

(٢) انفعالية معقولة.

(٣) شعور كاف بالأمن.

(٤) اتصال فعال بالواقع.

(٥) أهداف واقعية فى الحياة.

(٦) تكامل وثبات فى الشخصية.

(٧) القدرة على التعلم من الخبرة.

(٨) درجة معقولة من الاستبصار (تقويم الذات).

(٩) القدرة على إشباع حاجات الجماعة، مع درجة ما من التحرر من الجماعة (أى الفردية).

(١٠) رغبات جسمية غير مبالغ فيها مع القدرة على إشباعها فى صورة مقبولة.

ويتعين على المتتبع لهذه الخصائص، أن يفهم أنها تضع جميعها مستويات نسبية، فليس من المتوقع أن يكون الشخص السوى نموذجًا كاملًا فى كل منها، فقد يكون متخلفًا

إلى حد ما فى واحد، أو أكثر من هذه الخصائص، ولكنه يتمتع بصحة نفسية عامة جيدة، أى أنه يعد سويًا، ولكن إذا كان متخلفًا فى كثير من هذه الخصائص، أو ضعيفًا بشدة فى واحد، أو إثنين منها، فإنه يعد فى هذه الحالة شاذًا (والتر كوفيل وآخرون، ١٩٨٦، ٢٠–٢١).

وفى نفس الإتجاه يحدد رشاد موسى (٢٠٠٦، ٣٢–٣٤) تسعة مظاهر، يرى أنها أبرز خصائص الشخصية السوية، وهذه المظاهر هى:

(١) تقبل الذات.

(٢) الثقة بالنفس.

(٣) تحقيق الذات.

(٤) تحمل المسؤولية.

(٥) النضج الانفعالى.

(٦) التوجه خارج الذات.

(٧) الشعور الواضح بالهوية.

(٨) مقاومة الغواية والإغراء.

(٩) الاستمرار فى النمو الشخصى.

الفصل الثالث

حيل الدفاع النفسية

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على مفهوم الحيل الدفاعية.
- إدراك أسباب لجوء الفرد إلى الحيل الدفاعية.
- التمكن من التفرقة بين الاعلاء والإسقاط.
- توضيح أسباب لجوء الفرد إلى التكوين المضاد.
- التعرف على دور النكوص كحيلة دفاعية.
- الإلمام بالوظيفة الدفاعية لأحلام اليقظة.

الفصل الثالث

حيل الدفاع النفسية

مقدمة:

تعد الحيل الدفاعية أو ميكانزمات الدفاع (Defense Mechanisms) أساليب وطرائق لإحداث التوافق النفسي من جانب الفرد لمواجهة مشكلات الحياة ومواقفها. وأحيانًا شعورية وأخرى لا شعورية وذلك للحصول على الأمن النفسي والتخلص من التوتر والقلق في مواجهة المواقف التى تهدد هذا الأمن والاستقرار النفسي ووقاية الذات مع الاحتفاظ بقدر من تقديرها والتخلص أيضًا من مشاعر الذنب، أو الإبقاء على التوازن النفسي لما يصيبه من خلل من جراء فكرة، أو فعل، أو تخيل يهدد هذا التوازن.

وتعرف بأنها: "أساليب توافقية لاشعورية يستخدمها الفرد عند فشله في تحقيق أهدافه بفعل عوامل الإحباط والصراع هروبًا من المواقف المؤلمة لهذه العوامل التي يعجز عن مواجهتها بأساليب مباشرة يبرز فشله وجعله فشلًا منطقيًا أمام نفسه وأمام الآخرين، فيتخلص من التوتر، ويتحرر من القلق والشعور بالذنب، ويشعر بالارتياح والتوافق مع الموقف" (صالح الداهري وناظم العبيدي، ١٩٩٩).

ويمارس الحيل الدفاعية النفسية هذه كل من الأسوياء والمضطربين نفسيًا على حد سواء، ويرجع الا ختلاف بينها فى درجة تكرار الممارسة للحيلة فعند الأسوياء واقعية ومعتدلة وعند المضطرين تظهر بإسراف يؤدي إلى الابتعاد عن مواجهة الواقع. فيحدث لدى الأول التوافق والثاني الإحباط والفشل وتعد كعرض للاضطراب (آمال باظة، ٢٠٠٢).

وميكانزمات الدفاع كما يبدو من اسمها حيل، أو أساليب تهدف إلى الدفاع عن الشخصية ضد أي تهديد – داخل الفرد، أو خارجه – والفرد في الموقف الإحباطي يمر بمرحلة يكون في مقدوره أن يتحمل الإحباط، ثم يمر بمرحلة أخرى يطبق فيها الإحباط، أي أنه يتحمله ولكن بمشقة بالغة، ثم تأتي المرحلة التالية التي يبلغ فيها التوتر درجة عالية. حينئذ تظهر الميكانزمات الدفاعية وبصفة خاصة فى الدوافع الثانوية، حيث تخفف من شدة التوتر، فإذا نجحت في ذلك فإنها تقود الفرد إلى حياة أقرب إلى حياة السواء، أما إذا فشلت فإنها

تسلم الفرد إلى حالة يكون معرضا فيها إلى نوع من أنواع الاضطرابات النفسية، والذي يظهر على شكل سلوك لا توافقي، أو لا سوى (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

كما يعرف محمد الطحان (١٩٩٢) الحيل الدفاعية بأنها: "عبارة عن قنوات، أو مسالك لإشباع الرغبات بطريقة مقبولة اجتماعيًا إذا ما استخدمت بصورة شعورية للحفاظ على التوازن النفسي. وكثيرًا ما تنجح وتؤدي دورها فى تحقيق التوافق، في حين إذا أفرط الفرد في استخدامها وأصبحت لاشعورية فإنها تكون أساليب للتوافق اللاسوي".

ويرى حامد زهران (٢٠٠٥) أن حيل الدفاع النفسي تعد محاولات الفرد للإبقاء على التوازن النفسي من أن يصيبه الاختلال وهي حيل عادية يلجأ إليها كل الناس – السليم والمضطرب، ولكن الفرق بينهما هو نجاح الأول وإخفاق الثاني باستمرار ووجودها بصورة معتدلة عند الأول وبصورة مفرطة عند الثاني.

من خلال ما تقدم نستنتج أن آليات الدفاع النفسية هي:

(١) أساليب سلوكية هدفها الدفاع عن الشخصية ضد أي تهديد خارجي، أو داخلي وهدفها المحافظة على التوازن النفسي من أن يصيبه الاضطراب.

(٢) ليست خاصة بأشخاص دون آخرين ولكنها عامة في شكلها السوي، ويلجأ إليها أيضا المضطرب والسليم.

(٣) تصبح شكلًا من أشكال السلوك غير السوي عندما يصيبها التطرف ويمارسها الإنسان بعد ذلك من دون وعي.

(٤) إنها عادات سلوكية مكتسبة يتعلمها الفرد في البداية بصورة شعورية من المحيط الذي يعيش فيه للتخلص من التوتر والقلق الناجم عن المواقف الإحباطية، أو المواقف التي يدركها الفرد على أنها مهددة بالخطر (أحمد الزغبي، ٢٠٠٦).

وتتعدد حيل الدفاع النفسى وتنقسم إلى أقسام منها:

(١) **حيل الدفاع الانسحابية، أو الهروبية**؛ مثل: الانسحاب، والنكوص، والتفكك، والتخيل، والتبرير، والإنكار.

(٢) **حيل الدفاع العدوانية، أو الهجومية** ؛ مثل: العدوان والإسقاط والاحتواء.

(٣) **حيل الدفاع الإبدالية** ؛ مثل: الإبدال والإزاحة والتحويل والإعلاء والتعويض والتقمص وتكوين رد الفعل والتعميم والرمزية والتقدير المثالى.

وهناك تقسيم آخر لحيل الدفاع النفسى وهو:

أ - **حيل الدفاع السوية:** وهى غير عنيفة وتساعد الفرد في حل أزمته النفسية وتحقق توافقه النفسى مثل الإعلاء والتعويض والتقمص والإبدال.

ب - **حيل الدفاع غير السوية:** وهى عنيفة يلجأ إليها الفرد عندما تخفق حيله الدفاعية السوية فيظهر سلوكه مرضيا مثل الإسقاط والنكوص والعدوان والتفكك والسلبية (أشرف شريت ومحمد حلاوة، ٢٠٠٣).

وسوف نستعرض فيما يلي عددًا من أبرز ميكانزمات الدفاع:

الكبت Repression

يعدّ الكبت أساس آليات الدفاع النفسية جميعها، ويعود ذلك إلى المكانة التي يحتلها من نشاط اللاشعور، فهو أكثر عمقًا في تأثيره وأكثر دفعًا نحو التطرف، وأن مكانته في حالة الاضطراب المختلفة أوسع وأكثر فاعلية من آليات الدفاع النفسية الأخرى (أحمد الزغبي، ٢٠٠٦).

ويعرف الكبت بأنه: "العملية اللاشعورية التي تستبعد الأنا بمقتضاها المحفزات الغريزية والرغبات المستهجنة (المستكرهة) والأفكار والصراعات والذكريات المؤلمة والمثيرة للقلق من مستوى الشعور (الوعي والإدراك) إلى مستوى اللاشعور (اللاوعي)، حيث أن هذه المواد المختلفة المحظورة إن بقيت ماثلة في شعور الفرد، فإنها تمثل تهديدًا لذاته وتشعره بالخزي والذنب والألم والتوتر لأنها غير مقبولة اجتماعيًا؛ لذا تنزع الأنا إلى نفيها من الشعور وترحيلها إلى منطقة اللاشعور، ومنعها من التعبير عن نفسها بشكل مباشر صريح، حماية لنفسها مما يحقرها ويؤلمها، وخفضًا لمستوى توترها وقلقها" (عبد المطلب القريطى، ١٩٩٨).

والكبت لا يتم دائما بطريقة لاشعورية ولا عمدية؛ بل إنه يتم أحيانا عن طريق الوعى والشعور. أي أن عملية الاستبعاد تتضمن بعض الجوانب الشعورية والقصدية، وفى هذه الحالة يميل كثير من الباحثين إلى تسمية هذه العملية بالقمع (Suppression) وهى أقرب إلى ما

يفهمه العلماء ذوو التوجهات السلوكية في عملية الاستبعاد ولا يعترفون بالمفاهيم التي يصعب إخضاعها للملاحظة المباشرة مثل مفهوم "اللاشعور".

فالكبت من وجهة نظر فرويد يحدث عند الناس جميعا؛ إلا أن الأنا عند الأسوياء تكون قوية وتستطيع تحمل ضغط الهو والأنا الأعلى، وتتحكم في الرغبات المكبوتة، أما عند العُصابيين (المضطربون نفسيًا) فتكون الأنا ضعيفة ولا تستطيع تحمل هذه الضغوط، وتظهر الرغبات المكبوتة على شكل أعراض مرضية (محمد الهابط، ١٩٨٩).

ومن الجدير بالذكر أن الكبت ينشط فى السنوات الأولى في حياة الإنسان حيث يعتمد عليه الطفل بدرجة كبيرة لإلحاح الدوافع والحاجات الأولية عليه، وعدم قدرته على مواجهة القلق والتهديد الناتجين عن الإحباط وعدم إشباع هذه الحاجات. ولذلك ينشأ الكبت في البداية لحماية الأنا وخفض مستوى توترها، ويستخدمه الناس في أعمارهم وأحوالهم النفسية المختلفة، إلا أن الاعتياد على هذه العملية والإسراف في استخدامها له مضار كثيرة، أهمها تبديد الطاقة النفسية واستنزافها.

ويختلف الكبت عن النسيان Forgetting رغم وجود النسيان كقاسم مشترك بينهما؛ إلا أن المادة التي تنسى عن طريق الكبت ينكر الفرد وجودها أصلا ومن ثم تندثر تمامًا، ولا يمكن استحضارها من جديد واستعادتها سوى بمساعدة أخصائي تحليل نفسي، أو منوم مغناطيسي، وغالبًا ما يدهش الفرد لها عندما تبزغ في وعيه ويكتشف وجودها، بخلاف النسيان المعتاد لمادة معينة – كمعلومة ما – فربما يرجع ذلك انقضاء فترة طويلة على تعلمها وتُنسى نتيجة لعامل الزمن، أو لأنها غير ذات أهمية بالنسبة لنا؛ إلا أنه في جميع الحالات يسهل استعادتها بالإرادة والتركيز، أو بإعادة تعلمها أصلا (عبد المطلب القريطي، ١٩٩٨).

كما يختلف الكبت عن القمع فى أن الكبت عملية لاشعورية تصدر عن الفرد دون قصد، أو إرادة فلا يكون الفرد واعي بنوازعه التي تم كبتها؛ لأنها حيلة من حيل الأنا للحفاظ على تكامل وتوافق شخصية الفرد. أما القمع فهو عملية شعورية واعية إرادية يكون الفرد على علم بدوافعه ورغباته التي يجد أنها لابد ألا تظهر أمام الآخرين فيقوم بقمعها وضبطها خضوعًا لأوامر ونواهي الجماعة التي ينتمي إليها (سهير كامل أحمد، ٢٠٠٢).

وهكذا يبدأ الكبت بالقمع وينتهى باللاشعور، والكبت عملية دفاعية يقوم بها الفرد لإبعاد الدوافع الغريزية التى يتعارض إشباعها مع فكرته عن نفسه، أو مع التقاليد والمعايير الاجتماعية، عن طريق نسيانها، فإذا نُسيت خرجت عن مجال الشعور وأصبحت مكبوتة فى اللاشعور، وظلت قوية فى تأثيرها على الفرد. وعلى سبيل المثال، قد يرى الفرد الذي تساوره رغبة جنسية نحو أحد محارمه فى هذه الرغبة ما لا يتفق مع فكرته عن نفسه، ومع ما يتوقعه المجتمع منه من حمايته لذوى القربى، فيحاول قمع هذه الرغبة، وقد ينجح فى ذلك وينساها، إلا أنها تبقى حية في اللاشعور تتحين الفرصة للظهور فى شكل اضطراب (حنان العناني، ٢٠٠٥).

وإذا كان الدفاع في الإعلاء يتم عن طريق تجريد الأفكار من طاقتها، أو من الوجدانات المحيطة بها وربط هذه الطاقة بأهداف أخرى. بمعنى أن الفكرة تبقى والوجدان يتحول إلى موضوع آخر. فإن الدفاع في الكبت يتم عن طريق استبعاد الفكرة بوجداناتها معا وليس باستبعاد الوجدان فقط. فما يحدث فى كثير من الحالات أن الإعلاء لا يستبعد كل الطاقة، أو الوجدان المرتبط بالأفكار غير المقبولة، بأن تبقى جزء من الطاقة مرتبطًا بهذه الأفكار، ويمكن أن يكون هذا القدر كافيا لبعث القلق بسبب احتمال التعبير عن هذه الأفكار والمشاعر والحاجات المحظورة، وهنا يكون الفرد في حاجة إلى استبعاد الأفكار ذاتها مع وجداناتها، أى إلى كبتها (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

النقل أو الإزاحة Displacement

يطلق على هذا الميكانيزم أحيانا التحويل Transference، أو النقل، أو الإزاحة Displacement، وهى حيلة لاشعورية أخرى تقوم بها الأنا استكمالا لعملية الكبت ضد المواد الكريهة غير المقبولة التى تنذر وتهدد بالظهور إلى مستوى الشعور، فعندما يعاق إشباع الموضوع الأصلى للغريزة بسبب عدم ملاءمته اجتماعيًا، أو يصعب التعامل معه مباشرة نظرًا لقوته، أو خطورته، فإن الأنا تستبدل ذلك الموضوع بموضوع آخر تزاح، أو تنقل إليه طاقة الموضوع الأصلى بحيث يجد الفرد نفسه متنفسا لهذه الطاقة فى الموضوع الجديد.

ولميكانيزم الإزاحة، أو النقل وظيفة للتنفيس، بقدر محدود ومحسوب من المشاعر الحبيسة وبالتالي جعل مستوى التوتر دون المستوى الخطر والذي يهدد بالسلوك غير المسيطر عليه، أو المرضي، ويحفظ على الشخصية القدر اللازم من التماسك والاتزان وهي حيلة تحمى الفرد عند ممارستها من التعرض للوم المباشر، أو العقاب من قبل الآخرين (عبد العزيز القوصى، ١٩٨١)

في هذه الحيلة يتم التعبير عن المشاعر والانفعالات ولكن ليس نحو المصدر الأصلي الذي ينبغي أن يتجه نحوه التعبير؛ بل إلى مصدر آخر بديل، ويتم النقل، أو الإزاحة بسبب قوة المصدر الأصلى وعدم تمكن الفرد من التعامل معه مباشرة، كما يحدث في حال العدوان المزاح، فمن يحبط من رئيسه قد ينزل العقاب بأحد أفراد أسرته، والتلميذ الذى يعاقب من قبل معلمه قد يتربص بأخيه الأصغر ويعتدى عليه، والسيدة التى تحبط في علاقاتها مع زوجها تسقط الأخطاء على أبنائها والآخرين، ولميكانيزم الإزاحة، أو النقل وظيفة التنفيس المحدود والمحسوب عن المشاعر الحبيسة، وبالتالي جعل مستوى التوتر دون المستوى الخطر والذي يهدد بالسلوك غير المسيطر عليه، أو المرضى، ويحفظ على الشخصية القدر اللازم من التماسك والاتزان، وهي حيلة تعفى الفرد – عند ممارستها – من التعرض للوم المباشر والعقاب من قبل من يملكون ذلك (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

الإعلاء Sublimation

يعدّ الإعلاء الميكانيزم الذي يصنفه كثير من العلماء كدفاع ناجح ومقبول، والإعلاء يعنى تحويل الطاقة المرتبطة بدوافع يضع المجتمع قيودًا على إشباعها إلى أهداف وإنجازات أخرى يقبلها المجتمع، بحيث تصبح هذه الدوافع الجنسية والعدوانية – وقد جردت من طاقاتها، أو جزء كبير منها – غير ملحة، وهذا يعنى أنها لم تعد تشكل خطرًا على الشخصية، أو على الذات، ولم تعد تثير القلق لدى الفرد. ولهذا السبب يعتبره البعض ميكانزمًا ناجحًا؛ ولذا فإن تكرار السلوك المعلى واستمراريته لا يمثل عبئًا على تكامل الشخصية. فالطالب الذي يتجه إلى ممارسة الألعاب الرياضية والتفوق فيها يحقق إعلاء

لدوافعه العدوانية، كما أن كتابة الشعر والقصة ورسم اللوحات... وغيرها من الأعمال الفنية تعد إعلاءً مقبولًا عن النزعات الجنسية.

والإعلاء نوع من التحويل يرتبط بالدافع إلى اللذة، وهو عملية لاشعورية يحول الفرد فيها طريقة التعبير عن دافع ينتقده المجتمع إلى سلوك مرغوب فيه ويقدره المجتمع. فالشاعر الإيطالى "دانتي" على سبيل المثال عندما لم يتسطع أن يرتبط بمحبوبته الارستقراطية فجابه نزعاته الجنسية بالتسامي فكتب في محبوبته أجمل القصائد، ونال بسبب ذلك مكانة عالية ومنزلة رفيعة في العالم.

ومن خلال الإعلاء يجد الفرد مسالك عديدة لإشباع وجوه الحرمان التي يعانى منها. فالسيدة التي حرمت من إشباع دوافع الأمومة ربما ترضى هذا الدافع من خلال اشتغالها بالتمريض، أو الخدمة الاجتماعية، أو التدريس (وجدان الحكيمى وآخرون، ٢٠٠٣). ويتضمن الإعلاء تجريد الموضوعات الأصلية المحظورة من طاقاتها أو شحناتها العاطفية التى تشكل خطرًا على الشخصية، وتثير الإحباط والقلق لدى الفرد، وصرف هذه الطاقة في أشكال من شأنها أن تعود بالنفع والخير على كل من الفرد والمجتمع. وقد أكد فرويد على أن تطور الحضارة قد قام أساسًا على تحويل الطاقة الغريزية إلى مسارات مقبولة اجتماعيًا، وأشكال خلاقة من النشاط الإنساني، كالفنون والآداب والعلوم... وغيرها بفعل عملية الإعلاء.

ووفقا لميكانيزم الإعلاء فإن الحفزات والدوافع الجنسية المكبوتة، ومختلف ألوان الحرمان والإحباط يمكن أن تجد متنفسها في نشاطات الفنون والآداب والشعر والموسيقى مثلا، كما يمكن للحفزات والدوافع العدوانية المكبوتة أن تفرغ طاقاتها في النشاطات التركيبية البنائية التشكيلية. ومن خلال الإعلاء يجد الفرد مسالك عديدة لإشباع وجوه الحرمان التي يعاني منها (عبد المطلب القريطى، ١٩٩٨).

وهكذا، فإنه عن طريق الإعلاء والتسامي لا تعبر المواد المكبوتة عن نفسها بطريقة فجة بدائية يشعر معها الفرد بالذنب والقلق والتوتر، وإنما بطريقة مهذبة يشعر معها الفرد بالإشباع والرضا وتحقق أهدافًا أخلاقية واجتماعية سامية سواء بالنسبة للفرد، أو الجماعة التي ينتمي إليها. لذا يعتبر الإعلاء من أفضل الميكانيزمات الدفاعية تعبيرًا عن المواد المكبوتة وتوظيفها بشكل بنائي إيجابي (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

الإسقاط Projection

الإسقاط وسيلة دفاعية يلصق فيها الفرد ما يتصف من صفات غير مقبولة اجتماعيا بفرد آخر، وهي وسيلة يحكم فيها الفرد على الآخرين من خلال ذاته، فالشخص المنافق مثلا يتهم الآخرين بالنفاق، وغير الأمين يرى كل الناس غير أمناء. ويرتبط الإسقاط بالتبرير من حيث أنه يعبر عن العملية التي بمقتضاها يلوم الفرد غيره من الأفراد على نواحي فشله وخطئه، ومثال ذلك الذي يتورط في مشاجرة مع زميل له ويلقي عليه اللوم بقوله أنه هو الذي بدأ الشجار.

والإسقاط قد يكون حيلة نفسية مفيدة فهو من ناحية يعمل على تخفيف مشاعر الذنب والقلق والتوتر، ومن ناحية أخرى يقف وراء كثير من الأعمال الإبداعية الرائعة عند الأدباء والشعراء والرسامين والنحاتين، فكم من كاتب أسقط ما فى داخله في قصة، أو قصيدة، وكم رساماً عبّر عن مشاعره في لوحات فنية رائعة.

والإسقاط ميكانيزم مركب ومعقد؛ لأنه يتضمن عدداً من العمليات العقلية وهى: الإنكار، والكبت، والطرح، فالصفة غير المقبولة تقابل بالإنكار من جانب الفرد، ومن ثم يميل إلى كبتها، ثم يطرحها، أو يسقطها على الآخرين ممن لا يحبهم، ثم يعبر عن ضيقه ونقده لهؤلاء بسبب صفاتهم السيئة، فالبخيل يرى المحيطين به بخلاء، والمتعالي يرى فيمن حوله من الناس أشخاصًا متكبرين... وهكذا، ويمكن أن نكتشف هذا النمط من الإسقاط عند الأفراد الذين يكثرون من وصف الآخرين بصفة سلبية معينة (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥). وهكذا فالإسقاط يتم على مراحل ثلاث: في المرحلة الأولى ينكر صاحبها وجود المواد المؤلمة والمثيرة للقلق والتوتر ويتبرأ منها. وفي المرحلة الثانية يلصق الفرد هذه المواد المؤلمة بغيره، وفي المرحلة الثالثة يصف الفرد الآخرين بصفات سيئة ويجعل من نفسه مصلحًا ومعاقبًا لهم (محمد كمال مرسي، ١٩٨٩).

كالزوج الذي يكذب على زوجته يميل إلى اتهامها بالكذب. والإفراط في استخدام هذه الحيلة يعوق معرفة الفرد بنفسه وتؤدي إلى إفراطه في السخرية واتهام الآخرين؛ مما يفسد العلاقات الاجتماعية (أشرف عبد الغنى، ٢٠٠٢). كالطفل الذي كثيراً ما يلصق بغيره

من الأطفال أسباب ارتكابه لخطأ ما، فيجب على المدرسين مساعدة تلاميذهم على القيام بعمليات التوافق بأساليب تحميهم وتحفظ ذواتهم (مصطفى الشرقاوي، ١٩٨٣).

وبناء على ذلك نجد أن التلميذ يلقي اللوم على المعلم في حالة إخفاقه في الامتحان، كما يلقي الأبناء بأخطائهم على آبائهم وعلى المجتمع بدلًا من تحمل هذه الأخطاء، وما ينجم عنها. كما أن الشخص المنافق غالبًا ما يرى غيره من الناس منافقين، والشخص الشكاك يرى غيره أنهم كذلك ويبرئ نفسه من الشك (محمد كمال مرسي، ١٩٨٩).

وهناك نمط آخر من الإسقاط وهو الإسقاط التكميلي (Complimentary projection). وفى هذا النمط ليس من الضروري أن يتصف الفرد بمنقصة حتى يلصقها بالآخرين؛ بل إنه يبحث عن مبررات لسلوك غريب، أو مستهجن لديه، ولا يتحمل أن يتضح في شعوره الأسباب الحقيقية لهذا السلوك فينسب إلى البيئة المحيطة به بعض الصفات، أو الخصائص التي تعد دوافع مقبولة، أو عللًا مبررة لهذا السلوك. وفى هذه الحال لا يبدو سلوكه غريبًا، أو مستهجنًا أمام نفسه، أو أمام الآخرين. وعلى هذا فالشخص الخائف والفزع يميل إلى أن ينسب اتجاهات العداوة والشر إلى الآخرين حتى يبدو سلوك الخوف والفزع مقبولا ومبررًا.

ويعد الإسقاط الميكانزم الأساسي الذي يحكم لاشعوريًا المصابين بالبارانويا الذين يتوهمون الاضطهاد والإيذاء والضرر من الآخرين، بينما يفترض أن الرغبة في الإيذاء هي من خصائص المضطربين أنفسهم ولكنهم ينكرونها ولا يعترفون بوجودها، تجنبًا ما تثيره من قلق في أنفسهم والتماسًا للراحة والطمأنينة النفسية والحفاظ على صورة الذات.

والإسقاط هي العملية التي تعتمد عليها الاختبارات الإسقاطية، فتقوم فكرة هذه الاختبارات على تقديم مثير غامض، يسمح بشتى التأويلات وعندما يستجيب الفرد لهذه المثيرات فإنه يسقط أفكاره ومشاعره ودوافعه خلال استجابته، وعند تحليل هذه الاستجابات يمكن أن نتعرف على المشاعر المرفوضة والكريهة، والتى يلجأ الفرد إلى كبتها وإبعادها عن الشعور.

ويضاف إلى هذا فائدة الاسقاط الكلينيكية فى تشخيص المشاعر والاتجاهات والحاجات والدوافع اللاشعورية عند الناس وهو ما يعرف بالمنهج الإسقاطى، ويتم ذلك

باختبارات الشخصية التى تقوم على آلية الاستنباط؛ مثل: اختبار تفهم الموضوع للكبار (T.A.T)، واختبار تفهم الموضوع للصغار (C.A.T.) ، واختبار (الروشاخ) ففى اختبار (T.A.T.)، أو (C.A.T.) حيث يسقط الشخص نفسه على حكاية يحبكها، فهو يتكلم عن بطل القصة كما لو كان هو نفسه هذا البطل، أى أن يخلع دوافعه وانفعالاته المكبوتة بالتعبير عن نفسها والخروج إلى الحياة وإن لبست شخصيات أخرى غير شخصيات أصحابها (سهير كامل أحمد، ٢٠٠١).

التبرير Rationalization

يعدّ التبرير عملية لاشعورية يحاول الشخص من خلالها تعليل السلوك، أو تفسيره بأسباب تبدو معقولة ومنطقية ومقبولة اجتماعيًا، وإخفاء الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها التي تستثير قلقه وتؤذي مشاعره.

ولذلك فإن تقديم الشخص لهذه التبريرات تجعل من الفشل الذي لحق به، ومن التصرفات التي قام بها خارجة عن إرادته وطاقته ليعفي نفسه من اللوم والمسئولية، ويحميها من الشعور بالعجز والقصور (أحمد الزعبي، ٢٠٠٦).

ويمارس الفرد التبرير لأنه لا يحتمل أن يظهر في وعيه وشعوره أسباب غير إنسانية، أو غير اجتماعية لسلوكه، فهو حريص على أن يبدو أمام نفسه كشخص خلوق وشريف، كما يحب أن يراه الآخرون على هذا النحو، ومن العوامل التي تدفع الفرد أحيانًا إلى التبرير أنه يسلك في كثير من الحالات مدفوعًا بدوافع لاشعورية، أي دوافع لا يعرف كنهها بدقة، وقد يسيء إليه، أو يقلقه ألا يعرف أسباب سلوكه ودوافعه، لذا نجده في هذه الحالة مضطرًا إلى الإتيان بأسباب ودوافع لسلوكه، وبالطبع فإن المسوغات التي يعلنها كدوافع لسلوكه تكون أكثرها اجتماعية وراقيا من الناحية الخلقية، وهي من الصور الشهيرة للتبرير (عبد السلام عبد الغفار، ١٩٧٦).

ويختلف التبرير عن الكذب، فالكذب عملية إرادية يدرك فيها الفرد أن ما يسوقه من أسباب غير حقيقي، وأنه يتعمد التحريف ويقصده ليخدع بذلك غيره من الناس، بينما التبرير عملية لاشعورية لا يدرك فيها الفرد حقيقة أسباب سلوكه. ويعتقد جازمًا أن المبررات

التي يقدمها صحيحة تمامًا، ومن ثم يخدع بها نفسه فهو يكذب لكي يفلت من عقاب، أو يكذب لينتقم من آخرين، أو يكذب لتحقيق مصلحة لنفسه. أما التبرير فهو عملية لاشعورية بمعنى أنها خداع للذات قبل أن تكون خداعًا للآخرين (أشرف شريت، محمد حلاوة، ٢٠٠٣).

وقد يكون في الأسباب والمسوغات التي يسوقها الفرد لتبرير سلوكه بعض الصحة، ولكن تناول هذه الأسباب وعرضها ومناقشتها يتم بشئ من التحريف حتى تتحقق الغاية من عملية التبرير. ويميل الفرد في موقف التبرير إلى كراهية من يفند أقواله، ويضيق عليه بما قد يظهر فيها من تناقض منطقي، أو من مخالفة للواقع، وهو لا يريد أن يكون سلوكه وأقواله موضع نقاش؛ لأن النقاش قد يكشف له قبل غيره زيف ما يدّعى، وهذا النقاش يفسد عمل الميكانزم بإظهار الدافع الحقيقي وتسليط الضوء عليه، فالتبريرات عند صاحبها أشبه بالأحكام النهائية لا تجوز مناقشتها ومراجعتها (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥). ومثال ذلك التلميذ الذى يفشل في أداء الامتحان فيعلل فشله إلى صعوبة الأسئلة، أو أن المدرس اضطهده، أو أسئلة الامتحان صعبة، أو الذين نجحوا قد حققوا ذلك عن طريق الغش، أو عندما يكره التلميذ المدرسة ويتغيب عنها، ويعلل غيابه بمرض أمه، فالطالب والتلميذ لا يعترفون بالأسباب الحقيقية لفشلهم ويعطون التبريرات التي تجعل فشلهم مقبولًا وخارجًا عن إرادتهم، وبالتالي ينخفض توترهم ويخف قلقهم، فالتبرير حيلة نفسية تقي الإنسان من الاعتراف بالدوافع الحقيقية لسلوكه، وتعفيه من مسئولية ما حدث له من فشل في تحقيق بعض أهدافه، وتحميه من الشعور بالعجز والدونية، وتخفف عنه مشاعر الذنب والقلق والتوتر (محمد عودة وكمال مرسي، ١٩٨٩).

ومن الصور الشهيرة للتبرير ما تشير إليه تعبيرات (العنب الحامض) و(الليمون الحلو)، ويقصد (بالعنب الحامض) أنه في إطار عملية التبرير يميل الفرد أن يقلل من قيمة الهدف الذي لا يحصل عليه أو لا يحققه، إشارة إلى القصة القديمة التي تشير إلى الثعلب الذي حاول الوصول إلى العنب، فلما لم يستطع وصفه بأنه عنب حامض. أمّا تعبير (الليمون الحلو) فيشير إلى الظاهرة العكسية، وهي ميل الفرد إلى تعظيم قيمة الشئ الذي بين يديه، أو الهدف الذي استطاع إنجازه، والظاهرتان تهدفان إلى حماية الفرد من مشاعر الامتهان من ناحية، وتحسين صورة الذات من ناحية أخرى.

ويختلف التبرير عن الإسقاط، ففي التبرير دفاع واعتذار، بينما الإسقاط هجوم وقذف، كما يختلف التبرير عن الكذب في أن التبرير عملية لاشعورية، لا يدرك فيها الفرد حقيقة أسباب سلوكه، ويعتقد أن المبررات التي يقدمها صحيحة تمامًا، ومن ثم يخدع بها نفسه، بينما الكذب عملية شعورية مقصودة يدرك فيها الفرد أن ما يسوقه من أسباب غير حقيقة، وأنه يتعمد التحريف ويقصده ليخدع به الآخرين (عبد المطلب القريطى، ١٩٩٨).

والتبرير من أكثر الأساليب الدفاعية التي تستخدم في الحياة اليومية، وهو يؤدي وظيفتين مهمتين للفرد، إذ يساعده على معقولية سلوكه . ويمكّنه من تخفيف حده الإحباط والقلق والصراع.

النكوص Regression

يعرف النكوص بأنه تراجع الفرد إلى أساليب طفلية، أو بدائية من السلوك والتفكير والانفعال حين تعترضه مشكلة، أو يلتقى بموقف متأزم، فإذا به يستبدل بالطرق المعقولة أساليب ساذجة يبدو فيها اضطراب التفكير فقد يرتد العالم الرصين فينكص إلى التفكير الخرافى ومن مظاهره: الصراخ، التمارض، الغيرة، البكاء عند الارتطام، والإسراف فى الحنين إلى الماضى، خاصة عند من كانت طفولتهم يغشاها الأمن والطمأنينة (أشرف عبد الغنى، ٢٠٠١).

والنكوص هو العودة، أو الردة، أو الرجوع، أو التقهقر إلى مستوى غير ناضج من السلوك والتوافق، حيث تعترض الفرد مشكلة، أو موقف محبط، والنكوص يختلف عن التثبيت أى توقف نمو الشخصية عند مرحلة من النضج لا يتعداها، فالفصام مثلا يرتبط بالتثبيت على المرحل الفمية المبكرة فيربط هنا المحللون النفسيون بين شكل الاضطراب ومرحلة التثبيت (حامد زهران، ١٩٩٨).

فالنكوص هو نوع من الهروب أمام التوتر وتعبيرًا عن قلة الحيلة، ويرى المحللون النفسيون أن النكوص هو من أهم أسباب الاضطرابات النفسية والعقلية، وهو يحدث نتيجة التثبيت Fixation على ما لم يتم إشباعه عبر مراحل النمو النفسى المتتابعة، حيث يحدث

النكوص فى مواقف الصراع والإحباط إلى الأساليب السلوكية السابقة المعتادة فى مرحلة النمو التى تم عندها التثبيت (أحمد الزعبى، ٢٠٠٦).

فالطفل فى عمر ست، أو ثمان سنوات مثلا قد ينكص إلى سلوكيات طفل حديث الولادة، فيمص أصابعه فى موقف ضاغط عصيب لا يقوى على مواجهته، أو يعاود التبول اللاإرادى بعد أن يكون قد تعلم ضبط عملية الإخراج عندما يشعر بالخوف الشديد، أو يعتريه القلق، أو تتملكه مشاعر الغيرة من أخيه المولود حديثًا، وكأنه يحاول لاشعوريًا استعادة اهتمام الأم عندما كانت تحنو عليه وتهتم به حينما كان يتبول على نفسه فى طور سابق من أطوار نموه، وقد يحدث لمراهق، أو راشد أن يتراجع إلى أسلوب بدائى كالبكاء والعويل، أو قضم الأظافر، عندما يعجز عن التغلب على بعض الصعوبات التى يصادفها فى مواقف الحياة اليومية (أشرف شريت، محمد حلاوة، ٢٠٠٣).

ومن أشكال النكوص ما نلاحظه على بعض المسنين فى شيخوختهم من الإسراف فى العناية بمظهرهم الخارجى وتقليد الشباب، وكذلك ما نلاحظه من اشتداد وطأة الشعور بالغربة والحنين إلى الوطن Home Sickness الذى يحدث لبعض الأشخاص عندما يسافرون إلى الخارج، أو ينتقلون إلى بيئات جديدة، وقد يصبح هذا الحنين مرضيًا عندما يعجزون عن مواصلة الحياة فى هذه البيئات والتوافق معها، كما هو الحال لدى طالب يقطع دراسته فى الخارج لعدم قدرته على تحمل آلام الغربة، أو لدى إحدى المتزوجات حديثًا تترك بيت الزوجية لشعورها بالعجز واستحالة مواصلة حياتها بعيدًا عن أمها التى تجد فى قربها الرعاية والحماية والشعور بالأمن (حلمى المليجى، ١٩٨٧).

والجانب الدفاعى فى النكوص يتمثل فى أنه قد يستدر اهتمام وعطف الآخرين مما قد يجعلهم يعفونه من المسؤولية، وأحيانا ما يكون السلوك النكوصى تعبيرًا عن قلة الحيلة، وأحيانًا ما يعكس سلوكًا سبق تعزيزه فى فترات سابقة ولكنه لم يعد يناسب المرحلة الجديدة، ولذا فالسلوك النكوصى يرتبط ويختلط مع السلوك المثبت (Fixed) والسلوك الجامد (Rigid) وهى صور من السلوك تشير إلى أساليب كانت مناسبة فى مواقف معينة واكتسبت قيمتها على هذا الأساس ولكنها لم تعد تناسب المواقف الحالية.

والاستجابة النكوصية باعتبارها عودة سلوكية إلى الوراء، تمثل أفضل تمثيل قضية الدفاع فى مقابل النمو باتجاهها المضاد للاستجابة الدالة على النمو، فالنمو اتجاه إلى الأمام ويعبر عن الارتقاء، أما النكوص فعودة إلى الوراء ويعبر عن التقهقر في مدارج النمو والتطور (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

التعويض Compensation

يعبر التعويض عن مجموعة ردود الفعل التي يلجأ إليها الفرد عندما يعاني الشعور بالنقص، أو قصور واقعي، أو متخيل، من أجل التغلب على الشعور بالدونية والظهور بصفة أخرى أفضل للتخفيف من الشعور بالتوتر والقلق الناجم عن ذلك، ومثال ذلك سعي الفرد للظهور بالشخصية الجذابة المرحة لتغطية القصور الموجود به. وسعي الطفل المنبوذ إلى سلوك عدواني من أجل لفت الانتباه، وسعي الطالب الذي يعاني اضطرابات انفعالية ناتجة عن فشله الدراسي إلى التفوق في ميدان آخر كالكمبيوتر، والرسم، والرياضة.

والتعويض هو إحدى الحيل الدفاعية التي يلجأ إليها الفرد عندما يعاني من بعض مشاعر القصور في جانب ما من جوانب حياته، من أجل التغلب على الشعور بالدونية، والوصول بالأنا إلى الشعور بالتقدير وتخفيف درجة القلق (محمد الطحان، ١٩٩٢) ويبدو في صورة اهتمام زائد بسلوك معين وهو جهد لاشعورى يدفع الفرد إلى العمل على معالجة النقص الحقيقي، أو الوهمي بالكفاح لتحقيق النجاح المطلوب، أو الاستعاضة عنه بهدف آخر (أشرف عبد الغنى، ٢٠٠١).

ويجب أن نفرق بين الشعور بالنقص Inferiority Feelings وعقدة النقص Inferiority Complex. فالشعور بالنقص شعور عادي وسوي، ومن الطبيعي أن يشعر الفرد عندما يقارن بين نفسه وبين شخص يفوقه علمًا، أو مالًا، أو مكانة، فيشعر أنه أقل منه، ولكن هذا الشعور لا يدفعه إلى سلوك تعويضي لاشعوري، أما عقدة النقص أو الشعور اللاسوي بالنقص فهو يقابل بالإنكار على المستوى الشعوري ثم يدفع الفرد إلى سلوك تعويضي لاشعوري لتحقيق التفوق في جوانب أخرى، ويلاحظ أن من يلجأ إلى التعويض اللاشعورى

يدافع عن عقدة النقص غالبا ما يستجيب بحماسة زائدة، أو بالثورة عندما تمس هذه الجوانب في حياته (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

والنقص الذى يشعر به الفرد قد يكون حقيقيًا، وقد يكون متوهمًا. ومفهوم الفرد عن ذاته – والذى يتكون في الطفولة من تعليقات وأحكام الوالدين والكبار وتقييمهم له ولسلوكه– هو الذي يحدد إدراكه لجوانب قصوره، وقد يكون عند أحد الأفراد مفهوم سالب للذات يتضمن أنه أقل من الآخرين في جانب معين، أو أنه دونهم في إمكانياته وقدراته بصفة عامة، حينئذ يشعر الفرد بالنقص، حتى ولو لم تكن هناك أوجه نقص واقعية. والعكس صحيح فإن بعض الأفراد يكونوا مفهومًا للذات يتضمن المبالغة فى تقدير إمكاناتهم وقدراتهم، ويتعاملون في بيئتهم الاجتماعية على هذا الأساس، وما نريد أن نؤكد هو أن الفرد قد لا يكون لديه نقص حقيقي يدركه الآخرون، ومع ذلك فقد يتوهم هذا النقص ويسلك لتعويضه (أشرف شريت، محمد حلاوة، ٢٠٠٣).

فالتعويض قد ينشأ إما عن أسباب حقيقية نتيجة إعاقات جسمية تحد من استعداد الفرد وتقلل من كفاءته عمن هم في مثل سنه، أو نتيجة لقصور في جانب من شخصيته يستشعر أهميته في حياته. ومن ثم يمثل له مصدرا للإزعاج والإيلام والتهديد، وقد ترجع هذه المشاعر إلى أسباب وهمية غير واقعية نتيجة إسراف المحيطين بالفرد بأن طفولته في انتقاده وتأنيبه وتعريضه لمقارنات ظالمة، أو الزج به في منافسات غير متكافئة مع من هم أكبر منه سنًا وأكثر منه خبرة وتفوقًا؛ إلا أنها – أى تلك المشاعر المكبوتة – سواء نتجت عن أسباب حقيقية واقعية أم عن أسباب غير واقعية، تكون مزعجة للفرد ومؤلمة ومقلقة فينزع إلى كبتها.

الإنكـــار Denial

إذا كان الكبت هو نوع من رفض جوانب الواقع الداخلى للفرد، أو للذات الواقعية فإن الإنكار نوع من رفض جوانب الواقع الخارجي. فالفرد يتخذ من ميكانيزم الإنكار وسيلة يتحاشى بها إدراك الجوانب المؤلمة، أو المكدرة، أو المهددة للذات من الواقع المحيط به. والإنكار حيلة شائعة بين الناس؛ لأن الإنكار من الميكانيزمات البسيطة في الدفاع عن الذات، وهي شائعة

عند الأطفال والكبار على السواء، ويمارس الفرد الإنكار على المستوى اللاشعوري، أو على المستوى الشعوري.

وإذا كان علماء التحليل النفسي هم الذين قدموا هذا المصطلح في البداية وقصدوا به العملية اللاشعورية التي يتجاهل من خلالها الفرد ما يكدره ويثير القلق لديه، فإن علماء نفس التعلم وغيرهم من التجريبيين تحدثوا عن نفس العملية وقصدوا بها العملية الشعورية، أو قبل الشعورية التي يتجنب الفرد فيها ما يؤلم من المثيرات واستخدموا للتعبير عنها مصطلح "الدفاع الإدراكي " كما أسلفنا.

والأساس في ميكانيزم الإنكار هو مبدأ اللذة والواقع، فالفرد عندما ينكر مثيرات، أو موضوعات معينة فإنه لا يتحمل ما هو في الواقع حينئذ، وينكص من المرحلة التى يحكم السلوك فيها مبدأ الواقع إلى المرحلة السابقة عليها، وهي المرحلة التي يسلك الفرد فيها حسب مبدأ اللذة، فمن يرهف السمع وينتبه إلى ملاحظة سريعة تتضمن المديح والثناء بينما يتجاهل عبارات واضحة وصارخة تنتقده وتقلل من شأنه ينكر الواقع طلبا للذة، ومن يرى أقل العيوب في الآخرين ولا يرى أكبر منها في نفسه، أو من يحب نكران الواقع طلبا للذة (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

التقمص (التوحد) Indentification

هو العملية اللاشعورية التى يدمج عن طريقها الفرد شخصيته في شخصية فرد آخر يتوحد به ويتمثل صفاته وأخلاقياته، ويمتص قيمه واتجاهاته ويستدمجها في ذاته ويجعلها من مكونات شخصيته (عبد المطلب القريطى، ١٩٩٨)

والتوحد إحدى العمليات المهمة جدًا في سياق النمو النفسي للفرد. وقد أشار علماء التحليل النفسي إلى هذه العملية بصفة خاصة، وعنوا بها ميل الطفل اللاشعورى إلى تقليد والده من نفس الجنس بعد أن كان يشعر نحوه بمشاعر سلبية إبان المرحلة الأوديبية.

إذن فعملية التوحد في المفهوم التحليلي هي العملية التي تنهي الموقف الأوديبي عن طريق تطابق، أو تقمص، أو ميل الطفل – اللاشعوري– لوالده من نفس الجنس وإحلال الحب محل الكراهية، والتوحد عند أصحاب المدرسة السلوكية هو أن يفكر الفرد ويشعر وكأن

خصائص شخص آخر – أو جماعة أخرى– هى أفكاره ومشاعره، وتتضمن عملية التوحد إعجاب المتوحد بالمتوحد به، وإدراكه له باعتباره نموذجًا يحتذى ويقتدى به، وهو يتوحد به لأنه يحوز صفات القوة والكفاءة كما أنه يوفر الرعاية والأمن (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

والتوحد حيلة نفسية قد تكون مفيدة وقد تكون ضارة بحسب تأثيرها على نمو شخصية الفرد، فالتوحد المفيد هو الذى يتم مع شخص ناضج نفسيًا واجتماعيًا وخلقيًا، أو مع جماعة صالحة، أهدافها مشروعة ومعاييرها حسنة، حيث يساعد هذا النوع من التوحد على نمو الشخصية ونضوجها، واكتساب السلوك المقبول، وامتصاص العادات والتقاليد والاتجاهات الحسنة، بينما التوحد الضار هو الذى يتم مع شخص فاسد منحرف المزاج، أو مع جماعة جانحة منحرفة الأهداف؛ لأنه قد يؤدي إلى نمو الشخصية الجانحة، أو الفاسدة، عندما يقلد الفرد سلوك من توحد بهم، ويمتص معاييرهم وقيمهم، وقد يؤدي التوحد إلى إعاقة نمو الشخصية عندما يتم التوحد مع شخص مسالم مستكين، ضعيف عاجز، مغلوب على أمره (محمد عودة، وكمال مرسى، ١٩٨٩).

فالتقمص وسيلة دفاعية تخلص الفرد من القلق الناجم عن طريق إدعائنا مزايا شخص آخر تقمص به، أو عن طريق توحدنا مع جماعة لا يوجد لديها هذا القلق، فظاهرة شخصية البطل معروفة وكثيرة الحدوث في الطفولة والمراهقة، كما أن التوحد مع الجماعة في مرحلة المراهقة ظاهرة عامة (عبد الرحمن عدس ومحيى الدين توق، ١٩٩٧).

والتوحد لا يتم فقط مع الآباء بل إنه يتم أحيانا مع شخصيات خارج الأسرة، فالطفل المراهق قد يتوحد مع معلمه، أو معلمته في المدرسة، ، أو مع أحد الشخصيات في محيط عائلته، أو في النطاق الاجتماعي الذي يتحرك فيه، كذلك قد يتوحد الفرد مع إحدى الشخصيات التاريخية. مما يعكس إعجابه بالمثل التي تمثلها هذه الشخصية، وفي توحده يتمنى لو كانت هذه المثل هي مثله الشخصية، وأن قوة تلك الشخصية وكفاءتها هي قوته وكفاءته، وهذا يعني أن التوحد يؤدي نفس الوظائف الدفاعية سواء تم مع شخصيات من داخل الأسرة، أو من خارجها. وخطورة عملية التوحد أنها تجعل الطفل يتشرب كثيرًا من القيم والعادات والأساليب السلوكية للنموذج الذي توحد معه مما يظهر قيمة الأسوة، أو القدوة في عملية التربية والتنشئة (أشرف شريت، محمد حلاوة، ٢٠٠٣).

التكوين المضاد Reaction Formation:

أو رد الفعل، أو التكوين المنعكس يرى فرويد أن تكوين رد الفعل وسيلة دفاعية تساعد الأنا على استمرار كبت الرغبات غير المقبولة التي لا ترغب في الإفصاح عنها، فعندما تدرك الأنا تهديد الرغبات المكبوتة لها بالظهور في الشعور تشعر بالتوتر والقلق، وتلجأ لاشعوريا إلى تبني صفات ومشاعر على النقيض التام من الرغبات المكبوتة مما يقوي دفاعاتها، ويمنع هذه الرغبات من الظهور فيخفف التوتر والقلق ووقاية النفس من الشعور بالذنب، ويساعد على تحسين التفاعل الاجتماعي، وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال إخفاء مشاعر العداوة والبغضاء وتكوين مشاعر المودة والمحبة، ولكن أحيانا يكون رد الفعل ضارًا، فقد يؤدى إلى جعل الشخص يبالغ في المسالمة والطاعة والاتكالية، وجميعها سلوكيات غير ناضجة تدل على ضعف شخصى وعجزه عن التوافق الاجتماعي الإيجابي (محمد عودة وكمال مرسى، ١٩٨٩).

ويمكن للملاحظ أن يفرق بين السلوك الدفاعى القائم على التكوين الضدي والسلوك العادي القائم على الاعتبارات الخلقية فالسلوك الأول يتسم بالمبالغة وعدم الواقعية وأحيانا عدم التناسب مع الموقف، كما يمكن التعرف على السلوك الدفاعى برد الفعل الشديد الذى يبدو على الفرد إذا ما واجهناه بدوافعه الحقيقية، وبأنه يميل إلى أن يفعل عكس ما يدعو إليه.

وتظهر بوضوح فاعلية ميكانيزم التكوين الضدي في المواقف التي يتحرر فيها الفرد من ضغوط معينة كانت تجعله يلجأ إلى تبني اتجاهات متناقضة لما يشعر الفرد ويرغب حينئذ نجد الفرد يسلك على نحو معاكس لما كان بفعل؛ لأنه يعبر عن نفسه وعن دوافعه الحقيقية بحرية، ويبدو هذا واضحًا بصفة خاصة عند الأطفال الذين يسلكون على نحو مخالف إذا شعروا بأنهم متحررون من ضغوط الكبار ولكن هذا لا يعنى انتهاء فاعلية المكانيزم؛ بل لأنه يعود للعمل إذا ما عادت الضغوط والقيود التى تؤثر على سلوك الفرد (أشرف شريت، محمد حلاوة، ٢٠٠٣).

أحلام اليقظة أو الخيال Day– Dreams

أحلام اليقظة حيلة نفسية شائعة فى جميع الأعمار، لكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين خاصة أولئك الذين يعيشون في ظروف أسرية تعرضهم للحرمان والقسوة، مما يجعلهم يهربون من واقع حياتهم المؤلم إلى الخيال، كما أنها مفيدة عندما تكون وسيلة للاسترخاء والانسحاب المؤقت من المشكلات حتى يمكن وضع خطة جديدة لمواجهتها والتغلب عليها في الواقع وعندما تكون مصدر خصب للخيال المبدع في المجالات الفنية والأدبية والعلمية، فكل الاختراعات كانت في بدايتها أحلامًا قبل أن تصبح حقيقة واقعة (محمد عودة، وكمال مرسى، ١٩٨٩).

والوظيفة الدفاعية لأحلام اليقظة هي التخفيف من مشاعر الألم والكدر والامتهان التي تترتب على الإخفاق، أو على الفشل في مجاراة الآخرين، أو تحقيق ما كان يصبو إليه الفرد، وتعوّض الأحلام الفرد عن ذلك بإشباع وهمى؛ ولذا يشعر الفرد بالضيق لو اضطر إلى قطع الاسترسال في أحلام اليقظة بطريقة فجائية.

واسترسال الفرد لأحلام اليقظة يعبر عن سوء التوافق؛ لأنها تعني أن الفرد يعاني من إحباطات كثيرة في مجالات متنوعة، ويصادف واقعًا مريرًا ومؤلمًا وهو ما يدفعه إلى الخيال، وهذا يعنى أن أحلام اليقظة ميكانيزم قائم على الهروب من الواقع غير المرغوب فيه، ولكن ليس كل تخيل هو ميكانيزم هروب من واقع؛ بل أحيانا ما يكون التخيل ضربًا من الإبداع، أو أن يكون له طبيعة تخطيطية لما يمكن لأن يؤدى إلى واقع، بل إن بعض التخيل قد يكون دافعًا للإنجاز والعمل، أى أن الاستغراق فى التخيل الذى يعكس الهروب من الواقع هو ما يعد حيلة دفاعية لأنها تؤدى وظائف الدفاع، أما إذا زادت فترتها وطالت فإنها تحسب كأحلام يقظة دفاعية وتدل حينئذ على سوء التوافق الشديد، وتصل أحلام اليقظة إلى مداها عندما تعزل الفرد عن الواقع بشكل يكاد يكون كليًا، وهو ما يحدث فى بعض صور الفصام (علاء الدين كفافى، ٢٠٠٥).

وهكذا، فالاعتياد على أحلام اليقظة كوسيلة يهرب الفرد من واقعه ويحتمى بها كلما واجهته مشكلة ليستمتع بمشاعر إشباع، أو نجاح، أو تفوق مزعومة لا أساس لها في الواقع فالطالب الراسب الذي يتخيل أنه نجح وتفوق، ويكتفي بهذه الخيالات والأحلام ويعيشها كأنها حقيقة يفشل في حياته الدراسية؛ لأن النجاح في الخيال لا يغير واقعه

الدراسي في شئ فإنها تكون معوقًا لنموه وتكامله النفسي ومؤشرًا على سوء توافقه، فالخيالات وأحلام اليقظة يكن أن تؤدي إلى إغراق الفرد في عالم من الوهم يحول دون الاتصال والاندماج والتفاعل الحقيقي المثمر مع العالم الواقعي مثلما هو الحال لدى مرضي فصام الشخصية وجنون العظمة (عبد المطلب القريطي، ١٩٩٨).

الانسحاب Withdraw

الانسحاب هو وسيلة دفاع لاشعورية يستخدمها الفرد لتجنب موقف ما والتوتر والقلق يشعر بأنها صعبة ولا يستطيع تحمل الصراع والتهديد والضغوط الناجمة عنها، مما يجعله ينسحب من هذه المواقف تجنبًا لتحمل المسؤولية، أو الفشل فى التغلب على الصعوبات التي تواجهه، فالانسحاب كما يعده علماء النفس من التلازمات المنذرة بالخطر والتي تؤدي إلى سوء التوافق، وتأخر في نضج الشخصية والشعور بالنقص، والخجل والانطواء، وخاصة عندما يشعر الفرد بعدم تمكنه فى مواجهة مواقف الحياة اليومية (أحمد الزعبى، ٢٠٠٦).

ويأخذ هذا الانسحاب صورًا عديدة ومختلفة؛ منها: الانطواء، والخيال، وأحلام اليقظة، وتعاطي العقاقير والمخدرات.

فالانطواء يعنى الهرب ماديًا ومعنويًا، واعتزال العالم الخارجي (الناس والأحداث، والعمل، أو الدراسة) والانصراف إلى العالم الداخلي الذي ليس فيه أي احتكاك بالعالم الواقعي الخارجي، ويصل في حالاته المرضية إلى حد الإضراب اللاشعورى عن أي تفاعل إيجابي، أو اتصال حتى ولو لفظيًا بالآخرين كمن في الحالات المتأخرة من مرضى فصام الشخصية.

الفصل الرابع

الاضطرابات النفسية والعقلية

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على العوامل المرتبطة بالاضطرابات النفسية والعقلية.
- إدراك الأسباب الوراثية ذات العلاقة بالاضطرابات النفسية والعقلية.
- التمكن من التفرقة بين الأسباب الوراثية والبيئية المرتبطة بالاضطرابات النفسية والعقلية.
- الوقوف على الأدلة المؤكدة على تأثير الوراثة في الشخصية.
- التعرف على تاريخ الأسر كأحد الأدلة على دور الوراثة.
- الإلمام بالعوامل الاجتماعية الحضارية.
- التمييز بين العوامل المرتبطة بالوالدين في الإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية.

الفصل الرابع
الاضطرابات النفسية والعقلية

مقدمة:

الاضطرابات النفسية والعقلية من مظاهر الاضطراب في الشخصية فما هو الفرق بين الاضطرابات النفسية والأمراض العقلية.

يجد البعض صعوبة فى التفرقة بين الاضطرابات النفسية والاضطرابات العقلية وإن كان بعض علماء النفس ينظرون إلى الفروق القائمة بينهما على أنها فروق فى الدرجة أكثر من كونها فروق فى النوع، وقد أطلق البعض على الاضطرابات النفسية (العصاب) الاضطرابات الصغرى، حيث يلحق سلوك الفرد وشخصيته قدرًا من الاضطراب لا يعطل الفرد ولا يعوقه كثيرًا عن أداء أعماله اليومية فى مختلف مجالات الحياة.

أما الاضطرابات العقلية (الذهان) ذات تأثيرات أكثر خطورة على الشخصية من العصاب؛ لذا يطلق البعض عليها الاضطرابات الكبرى، حيث تؤدى إلى اضطراب كبير فى سلوكه وعلاقاته بالناس والبيئة المحيطة به، كما أنها تلحق التفكك والانحلال بشخصية الفرد كلها بحيث يصعب الاعتماد عليه فى أى عمل من الأعمال، وهى تسمى بالذهان، وأطلق عليها العامة من الناس لفظة (جنون)، وهى تؤثر تأثيرًا سيئًا على جميع أساليب توافق الشخص وعلى سلوكه فى مختلف نواحى الحياة، فالشخص المصاب بالاضطراب العقلي غير مدرك للحالة التى صار عليها، ولا يكون لديه بصيرة بالنسبة لما حدث له من تغيير غير مرغوب فيه فى سلوكه وأفعاله وتصرفاته، ولا يمكنه القيام بأعماله المعتادة، أو ممارسة أوجه النشاط المختلف الذى يقوم به الأفراد العاديون (علي أحمد، ب. ت). وتسود الهلاوس وعدم الاستبصار وأوهام العظمة والاضطهاد والعجز عن التمييز بين الواقع والخيال، والاضطراب والجمود فى الحياة الوجدانية والانفصال الاجتماعى عن الواقع والتعلق بعالم وهمى خيالى، مما يقود فى النهاية إلى العجز عن الأداء والتواصل الاجتماعى، بينما قد لا تؤدى الاضطرابات العصابية سوى إلى اضطرابات بسيطة وتغيرات محدودة تظل الشخصية من حيث وظائفها العقلية والانفعالية على قدر من التماسك والاتصال بالواقع، كما تظل الأنا أو الذات قادرة إلى حد

ما على ممارسة عملية الكبت وعلى التحكم فى المحتويات اللاشعورية المتحفزة للظهور رغم ازدياد حدة الصراع فيما بين هذه المحتويات والأنا (عبد المطلب القريطى، ١٩٩٨)

مفهوم المرض النفسي:

عرف عطوف ياسين (١٩٨٧) المرض النفسي بأنه: "اضطراب وظيفى مزاجى فى الشخصية، يرجع إلى الخبرات، أو الصدمات الانفعالية، أو اضطراب العلاقات الاجتماعية، ويرتبط بحياة الفرد الخاصة ".

ويعرف المرض النفسي أيضًا بأنه: "اضطراب وظيفي فى الشخصية، يرجع أساسًا إلى الخبرات المؤلمة الانفعالية، أو اضطرابات الفرد مع البيئة الاجتماعية التى يتفاعل معها بألوان من الخبرات المؤلمة التى يتعرض لها فى الماضى والحاضر وأثرها فى المستقبل" (مصطفى فهمى، ١٩٨٧).

ويرى حامد زهران (١٩٩٧، ٩) أن المرض النفسي عبارة عن: "اضطراب وظيفى فى الشخصية، نفسي المنشأ، يبدو فى صورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة، يؤثر فى سلوك الشخص، فيعوق توافقه النفسي، ويعوقه عن ممارسة حياته السوية فى المجتمع الذى يعيش فيه".

من هذه التعريفات السابقة نتبين أن المرض النفسي لا ينجم عن علة عضوية، وإنما اضطراب وظيفى يعطل ويعرقل الكثير من أعضاء الجسم عن القيام بوظائفها بالشكل السليم، مما يؤثر فى سلوك الفرد، ويجعله أقل توافقًا من الشخص السليم فى المجتمع الذى يعيش فيه (أحمد الزعبى، ٢٠٠٦).

تعريف الاضطرابات النفسية أو العصابية:

يتفق معظم علماء النفس الحديث على أن الاضطرابات النفسية تشير إلى حالات سوء التوافقMaladaptive مع النفس، أو الجسد، أو البيئة الطبيعية، أو الاجتماعية، ويعبر عنها عادة بدرجة عالية من القلق، والتوتر، واليأس، والتعاسة، والقهر، وليس لها أسباب عضوية واضحة، وإنما هى نتاج تفاعل أكثر من عامل واحد، وغالبًا ما تمس البعد الانفعالي

للشخصية، ويظل معها الفرد المضطرب متصلًا بالحياة الواقعية (محمد عودة وكمال مرسى، ١٩٨٩).

ومصطلح الاضطرابات النفسية حديث نسبيًا، وقد بدأ يحل تدريجيًا مكان الاضطرابات النفسية فى كثير من دوائر الطب النفسي، مراعاة للآثار النفسية السلبية لكلمة (مرض) ومع بدايات هذا القرن كان المصطلح الأكثر شيوعًا هو (العصابNeurosis بعد أن طرحته مدرسة التحليل النفسي الفرويدية كتعبير عن الحالة النفسية الناشئة عن الصراعات اللاشعورية التى يعيشها بعض الأفراد، ولكمة (العصاب) كانت معروفة فى الدوائر الطبية منذ عام ١٧٩٦ ولكنها كانت عامة بحيث تشمل ما يعرف الآن باضطراب الذهانPsychosis والعصابNeurosis، فالعصاب فى ذلك الوقت كان يشير إلى أى مرض يكون نتاجًا لاضطراب المراكز الحسية، أو الحركية فى الجهاز العصبى (أشرف عبد الغنى، ٢٠٠١).

وهناك فرق بين الاضطرابات النفسية العصابية وبين الأمراض العصبية العضويةOrganic التى تحدث نتيجة تلف، أو إصابات فى الخلايا والألياف العصبية بسبب اضطرابات هرمونية، وهذا يبرهن على أن العصاب ليس له علاقة بالأعصاب، وباختصار فإن السلوك العام للعصابى وإن كان مضطربًا إلا أن غرابته معقولة لأنه يساير العادات والتقاليد والأعراف والمعايير الاجتماعية، ويشعر بمرضه ويرغب فى العلاج ويسعى إليه إلا أن القاسم المشترك بينها هو عدم النضج والسطحية والوتر والحساسية الانفعالية وعدم الرضا ونقص البصيرة وتدنى الإنتاج والإنجاز ومعظم حالات العصاب قابلة للشفاء ومن المناسب ان نقول لا توجد مستحضرات طبية لعلاج الاضطرابات النفسية ولكن توجد مستحضرات لعلاج الأعراض الناجمة عن الاضطرابات النفسية ويستمر العلاج والشكوى ما لم تنتهى الأسباب (هويدا أحمد، حمدى شاكر، ٢٠٠٦).

والشخص العصابى يبنى خطة تكيفه مع الحياة، على أساس الهروب، وتجنب الأسباب التى تؤدى إلى الاضطراب، إنه يلجأ إلى حيل دفاعية، يحاول من خلالها تجنب صعوبات الحياة ومشكلاتها بدلًا من أن يواجهها ويتعامل معها تعاملًا مباشرًا، كما ان العصابيين أشخاص تسهل استثارتهم، وتسيطر عليهم مشاعر النقص والشعور بالكآبة، وتسيطر عليهم المخاوف التى لا مبرر لها من بعض الأمراض الجسمية، أو الأماكن العامة، أو من بعض الموضوعات التى لا

تسبب الخوف لأمثالهم، أو لمن هم فى مثل سنهم، كما يستطيع العصابيون عادة مواصلة نشاطهم وعملهم بالرغم من شعورهم الظاهر بالعجز، كما يتصف سلوكهم بالتعاسة، وتسيطر عليهم مشاعر الذنب وقلة الفاعلية فى المواقف الاجتماعية، ومواقف العمل (عبد الستار ابراهيم، ١٩٨٨).

تظهر الاضطرابات العصابية عند الناس فى العقدين الثالث والرابع من العمر، ونادرًا ما نجدها بعد هذا العمر، حيث تصيب حوالى ٤٠ -٨٠ شخصًا فى كل ألف شخص من السكان، وهى أكثر انتشارًا عند النساء منه عند الرجال، كما أن نسبة حالات العصاب الملاحظة فى عيادات الأطباء العامين تقدر بحوالى ٢٠ -٣٠٪ من المرضى، وقد كشفت الدراسات أن الأعراض العضوية تكون أقل تعقيدًا فى الشكوى عند أبناء القرى، وتكون الأعراض النفسية أكثر ظهورًا عند الأفراد المثقفين.

أما فيما يتعلق بالعوامل التى تسبب الاضطرابات العصابية، فيمكن أن تشترك فيها العوامل البيولوجية، والبيئية، والنفسية، حيث تتضافر معًا لتهيئ بعض الأفراد للإصابة بالمرض النفسي، فقد يكتسب الشخص سمة نفسية، أو خصائص شخصية معينة، بالإضافة إلى وجود بعض الاضطرابات البيولوجية، ولذلك الظروف البيئية مثل: الشدائد والضغوط النفسية Stress المفاجئة، أو المستمرة التأثير التى تحد من قدرة الجهاز النفسي للإنسان ليتفاعل بنجاح مع الضغوط الخارجية، كما تسرع مثل هذه الضغوط النفسية من حدوث المرض النفسي عند الشخص استنادًا إلى بيئته البيولوجية، فى حين نجد أن أفرادًا آخرين من الأسرة نفسها لا يصابون بالمرض النفسي نتيجة ما يمتلكونه من قدرة عالية على التعامل بنجاح مع هذه الظروف الضاغطة (أحمد الزعبى، ٢٠٠٦)

تعريف الاضطرابات العقلية أو الذهانية:

الاضطرابات العقلية من أخطر الأمراض التى تصيب الفرد، تبدو فى صور اختلال شديد فى القوى العقلية، ويصنف الذهان إلى ذهان عضوى Organic Psychosis وله أسباب فسيولوجية بما فى ذلك حالات ترجع إلى الشيخوخة وتصلب شرايين الدماغ والتسمم

الكحولى وإصابات الدماغ، وذهان وظيفىFonctional psychosis يشمل الفصام وذهان الهوس والهذاء، أو البارانويا.

يرى عطوف ياسين (١٩٨٨) بأنه: "اضطراب عقلي ذهاني شديد وخطير انفعاليًا وسلوكيًا وشخصيًا ويمثل خللًا فى التفكير والقوى العقلية وجهلًا بأسباب المرض وعدم القدرة على الضبط والاستبصار، ويتناول كافة جوانب الشخصية وهو عضوى وفيه جانب وظيفى"، وهذا التعريف يتفق مع التعريف السابق.

وتعرف الاضطرابات العقلية بأنها: "اختلال عقلي فى صور النشاط الإنساني يؤدى إلى خلل شامل فى شخصية المريض وفى سلوكه؛ مما يفقد صلته بالواقع ويكون لنفسه عالم خاص به من الأوهام والخيالات مع وجود مدركات حسية خاطئة لديه". ومن هذا نرى أن الاضطراب العقلي، أو الذهان هو: "اضطراب كامل فى الشخصية يجعل سلوك المريض مضطربًا ويعوق نشاطه الاجتماعى كما أن المريض ينفصل عن الواقع" (فوزى أبو جبل، ٢٠٠٠)

ويعرفه أيضًا بأنه: "المرض الذى يتناول كافة الاضطرابات الانفعالية والسلوكية والذهنية والشخصية بصفة عامة وتعكس حالات انعدام التوافق والاضطراب العقلي ويعانى فيه صاحبه اختلالًا شاملًا واضطرابًا خطيرًا فى شخصيته، ويبدو فى صورة اختلال شديد فى التفكير والقوى العقلية" (أشرف عبدالغنى، ٢٠٠١)

العوامل المرتبطة بالاضطرابات النفسية والعقلية

هناك العديد من العوامل التي تقف خلف الإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية من أهم تلك العوامل ما يلي:

أولًا: العوامل الوراثية

على الرغم من أننا نعلم الكثير عن دور الجينات في الحيوانات الدنيا؛ إلا أن السر الغامض المتصل بدورها في تحديد السمات النفسية عند الإنسان لا يزال يحير علماء النفس والوراثة على السواء، ومن المسلم به أن الوراثة هى العامل الرئيس المحدد للسمات الحسية من قبيل: الجنس، والطول، والوزن، ولون البشرة، والتذوق... وغيرها من السمات البيولوحية،

وكذلك ثبت أن عدداً معيناً من أوجه الشذوذ الجسمي، أو الطبي متصلة اتصالاً مباشراً بالجينات، ومن ذلك عمى الألوان لمنطقة الأحمر والأخضر، والهيموفيليا، ومرض السكر... وغيرها من الأمراض، ومع ذلك فقد ثارت خلافات شديدة حول دور الجينات في تأثير الخصائص النفسية والعقلية. وقد ترتب على قضية الطبع أم التطبع أن انقسم العلماء إلى معسكرات متقابلة بحسب اعتقادها في الأهمية القصوى للوراثة، أو للبيئة في السلوك العقلي.

وبصفة عامة نقول إن السيكوباثولوجيا تقبلت الاتجاه البيئي بقبول أحسن من تقبلها للاتجاه الآخر، صحيح أن عدداً من أوجه الشذوذ له أسباب قوية وراثية؛ إلا أن أغلبية أنواع العصاب والذهان يحسن فهمها إلى درجة أكبر من خلال الاتجاه البيئي، وقد اشتملت الحجج التى تغلب التحليلات غير الوراثية على العقبات الهائلة التى تقف في وجه الدراسات العلمية المنضبطة انضباطاً دقيقاً للتناسل الإنساني والتى يمكن أن تثبت أهمية الوراثة الشخصية، والتحليلات، والنتائج التى تبدو مناسبة والتى نجدها في منهج تاريخ الحالة السيكوديناميكى، والدليل المقنع على تغير السلوك من خلال تغيير البيئة والتدعيم والبيانات الدامغة المتصلة بتكوين العصاب التجريبى، لكن هناك أحداثاً وقعت أعادتنا إلى الالتفاف إلى دور الوراثة في الشخصية، ذلك أن الاكتشاف النووى والتدمير النووى، وكذلك المنافع النووية جعلت من الاشعاع رفيقاً دائماً للبشرية كما أن خطر الاشعاع من التغير المفاجئ في الجينات قد آثار الحرص على ازدياد المعرفة المتصلة بالأساس الوراثى الجينى للإنسان.

المبادئ الأساسية في الوراثة عند الإنسان:

يرى علم الوراثة الحديث أن الإنسان يتكون من خلايا تحتوى على مواد مستطيلة ميكروسكوبية تسمى الكروموزمات، وكل خلية من خلايا الإنسان فيما عدا الحيوان المنوى عند الرجل والبويضة عند الأنثى تحتوى على (٢٣) زوجاً من هذه الكروموزمات مرتبة في شكل ملتو التواءً حلزونياً ونصف هذه الأزواج من الكروموزمات التى أسهم بها الأب على حين أن النصف الآخر يمثل الكروموزمات المقابلة التى أتت من الأم والواقع أن كل كروموزم في حد ذاته مؤلف من عدة أجزاء هلامية مسئولة عن تحديد سمات الإنسان وخصائصه وهذه الأجزاء

تسمى جينات، والعدد الكلى للجينات لا يزال غير معروف ولكن التقديرات الحالية تتراوح من أربعين ألفًا إلى ثمانين ألفًا على الأقل في الكروموزمات كلها أي في الأزواج الثلاثة والعشرين.

والخصائص الجسمية تحددها هذه الجينات، زوج واحد منها فقط في بعض الأحيان، أو أن معظم السمات تحددها عدة جينات تحديدًا متعددًا.

والتوائم أحادية الزيجوت هى التى تهمنا في دراستنا للوراثة والشخصية لأننا نستطيع التأكد من تشابهما الوراثى، ولذلك يمكن أن نعزو بينهما في الخصائص العقلية إلى العوامل الوراثية وذلك كما هو الحال بالنسبة للخصائص الجسمية، ومن الطبيعى أن المرء لا يستطيع أن يتيقن تمامًا من أن كل العوامل الأخرى يمكن استبعادها مثل الظروف البيئية ومع ذلك فإن الحجة تزداد قوة أن ظلت التوائم المطابقة تبدى نفس سمات الشخصية، أو تشابها في سمات الشخصية إذا تربيا في بيئات منفصلة.

الأدلة على تأثير الوراثة في الشخصية:

تجمعت بيانات مختلفة أثناء المحاولات التى بذلت لإثبات أهمية الوراثة على أن مناهج البحث يمكن أن تنقسم إلى خمس مقولات دراسات الحيوانات التى تتضمن دراسات الحيوانات، ودراسات تاريخ الأسر الإنسانية، ودراسات السكان الإنسانية، والدراسات التى تتضمن تقديرات احتمال المرض، ودراسات الكروموزمات.

(١) دراسات الحيوانات:

على الرغم من أن دراسات الحيوانات ينبغى أن تظل ظروفًا مثالية لدراسة الوراثة؛ إلا أن هناك في الواقع قليلًا من الأبحاث المعقولة المخصصة مباشرة للقضية موضع البحث.

أما الدراسات التى تمت فقد تناولت الفئران البيضاء وسلالات مختلفة من الكلاب وبعض أعضاء عائلة الطيور، ومع ذلك فقد تيسر إثبات الفروق بين السلالات في الشخصية الحيوانية بالنسبة للأبقار والأرانب.

(٢) دراسات تاريخ الأسر الإنسانية:

في منهج تاريخ الأسر، ينظر الباحث في أشجار النسب لأفراد اتصفوا ببعض أوجه الشذوذ النفسى، ولأننا لا نستطيع التحكم في تكاثر البشر بحسب أنماط علمية مخططة، فإن

أقرب ما يمكن عمله هو أن نسترجع نتائج الزيجات التى تيسر لدينا معلومات عما ترتب عليها من أجيال، وقد تضمنت دراسات النسب من هذا النوع حالات من السمات الباثولوجية التى يسهل تتبعها وراثيًا، في أسر تكون من التفرع بحيث تنتج ذرية كافية تسمح ببعض التحليل وأظهرت الأمثلة من هذا النوع من البرهان هى المرتبطة بقصور معامل الذكاء، وأوضح مثال لذلك نتائج العديد من الدراسات التى تمت على كل من أسرة "جيوك" وأسرة "كاليكاك" المشهورتين وقد استخدمهما الباحثين كثيرًا كأمثلة للدلالة على ما يحدث عند توارث الجينات المعينة وفي كل من الأسرتين كان نقص معامل الذكاء والانحطاط ينتقل من جيل آخر.

(٣) دراسات السكان البشرية:

في هذه الدراسات يستكشف تأثير الوراثة عن طريق استخدام تعداد السكان والإحصاءات الحيوية، أو السجلات عن الأمراض التى لابد من الإبلاغ عنها وفحص البيانات التى نحصل عليها باستمرار من السكان قد يكشف عن اتجاهات في تطور تلك الجماعة. كما أنه يمكن الحصول على البيانات الخاصة بالصحة العقلية من كل الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة التى تتميز بدرجة عالية من الثبات البيئى والاجتماعي، من قبيل المدن الريفية.

ولو أننا تتبعنا التغيرات التى تطرأ على نسبة بعض الأمراض العقلية المعينة وتفحصنا هذه المعدلات بالمقارنة ببعض البيانات الأخرى من قبيل معدل الزواج بين أقارب الدم، أو بحث الإنسان لكان من الممكن أن تحسن من منهج الأنساب وتزيد من فائدته المحدودة؛ بل إن هذا الأسلوب تكون له فوائده الحقة حين مكتشف بعض الانعزالين، أى تلك الجماعات من الناس الذين يعيشون في بيئات مغلقة منعزلة والذين يتميزون بمعدل مرتفع من الزواج الداخلى مثل ما حدث في قبيلة "الهوترايت" وهى قبيلة تؤمن بأن الزواج من خارج القبيلة جناية، ولذلك فإن ما يتميز به النظام الاجتماعي في "الهوترايت" من جمود وثبات على مر الزمن، وارتفاع نسبة الزواج الداخلى؛ بالإضافة إلى الانعزال المفروض عن كل المؤثرات الخارجية ذات الأهمية، كل أولئك يؤيد التفسير الوراثى للمرض العقلي.

(٤) دراسات احتمالات المرض عند الإنسان:

في دراسات احتمال المرض يقوم الباحث بحساب فرص إصابة عدد من أفراد أسرة واحدة بمرض أصيب به شخص معين من هذه الأسرة نفسها، ثم تدرس هذه الأرقام الدالة في فرصة الإصابة في ضوء فرص إصابة غير الأقرباء، أو الجمهور العام، فلو كان المرض وراثيًا، ترتب على ذلك أن تتفشى الإصابة بين أقرباء الدم بدرجة أكبر من تفشية بين غير الأقرباء، وبذلك يزداد الاحتمال، أو معدل الإصابة على أن هناك سبيلين اثنين لتقديم بيانات فرص الإصابة هذه: الأول أن نقدم نسب انتشار المرض في الأجيال التى تنحدر عن آباء مختلفين (أحدهما فقط مصاب، أو كلاهما مصاب بالمرض) والثانى أن نقدم نسب انتشار المرض لدى الأشخاص الذين تتفاوت درجات قرابة الدم التى تربط بينهم وبين المريض الأصلى (التوائم، الأشقاء، الأخوة، الخلط، أو أولاد الزوج وأولاد الزوجة من زيجات سابقة).

وقد تم حساب احتمال الإصابة بالفصام للآباء المختلفين فتبين أن من جملة (٣٤) حالة من الحالات التى تزوج فيها رجل مصاب بالفصام بامرأة مصابة به، خرجت نسبة من الأطفال مقدارها (٣٩,٢٪) مصابين بالفصام، كذلك وأنه من بين (٢٠) حالة تزوج فيها رجل مصاب بجنون الهوس والاكتئاب بامرأة مصابة بنفس المرض خرجت نسبة مقدارها (٤٤,٤٪) من الأطفال مصابة بنفس الاضطراب العقلي الذى يعانى منه الآباء.

وهكذا يتضح من نتائج التقارير السابقة أن نسبة احتمال الإصابة بالفصام لفرد ينشأ عن أبوين مصابين تزيد بمقدار النصف، أو الثلاثة أمثال عما إذا كان أحد الأبوين على الأقل سويا صحيحًا، وأن نسبة الاحتمال هذه كبيرة إلى درجة هائلة إذا ما قورنت بمعدلات انتشار المرض بين الناس ينحدرون من أبوين سليمين.

كذلك اشتغل الكثيرون لمدة طويلة بدراسة الدور النسبي للوراثة والبيئة في نشأة السيكوباثولوجا.

إن الغموض الذى يكتنف دور الوراثة والبيئة في نشأة الاضطراب العقلي لم يزل بعد قائمًا، ولعل هناك نوعين من الفصام أولهما متوارث وثانيهما يشبهه في الأعراض ولكنه ينشأ عن عوامل نفسية، كما أن هناك احتمالًا آخر جديرًا بالتمحيص وهو اعتقاد "كولمان" بأن هناك نظامًا دفاعيًا يرثه الفرد ويتفاعل مع عامل الفصام الوراثى، الأمر الذى يتيح لبعض الأفراد أن يظهروا مقاومة أكبر لهذا الاضطراب العقلي، ومن شأن عامل المقاومة المتوارث هذا

أن يفسر لنا الفروق في شدة الأعراض والنتائج وتلك الحالات التى لا يحدث فيها الاتفاق حيث تختفي الأعراض تمامًا في أحد التوأمين.

(٥) **دراسات الكروموزمات** (الكروموزمات):

ازداد الفحص المباشر للكروموزمات دقة بفضل استحداث وسائل التصوير الفوتوغرافية متناهية الدقة، وبذلك أصبح من الممكن الآن أن نحصل على صورة للكروموزمات تعرف باسم karyo type والكروموزمات يتم تصويرها في مسلسل زمني مرتب ثم يتم عندئذ تحديدها برقم مسلسل وفقًا لنظام تضيف دولي تم الاتفاق عليه في مؤتمر عقد في مدينة "دنفر" سنة ١٩٦٠، ونستطيع الآن أن نقارن بين صور الأشخاص الذين يعانون من شذوذ ما، وصور للأشخاص الأسوياء حتى نتبين إن كانت هناك اختلالات جينية، وتم الكشف عن هذه الأنواع من الاختلالات الكروموزمية أكثرها مرتبطة بأنواع من الشذوذ الجسمى، ولكنه لا يكون مرتبطًا بالضرورة بأنواع من الشذوذ النفسى، ومن بين تلك الأنواع الشذوذ في عدد الكروموزمات.

وذوي العرض داون هو نوع من الإعاقة الفكرية، والأدلة الراهنة تبين لنا أن الأفراد المصابين بهذا العرض لهم في العادة ثلاثة كروموزمات بدلًا من الصبغيين العاديين في واحد من الأزواج هو الجين رقم (٢١).

ولذوي العرض داون خصائص عقلية وجسمية متميزة واضحة فهم يتصفون بانخفاض معامل الذكاء الذى يتراوح بين الإعاقة الفكرية البسيطة والشديدة أضف إلى ذلك أنهم صغار القامة وأن لهم ملامح وجه تجعلهم يبدون شرقيين بعض الشئ (ومن هنا جاء مصطلح المنغولية) وأن السنتهم أميل إلى البروز والخروج من أفواههم، وقد أعقب الكشف عن الكروموزوم الإضافي سنة ١٩٥٩ أن آمن كثيرون بأن هذا يعطينا البرهان القاطع على أن العرض داون ذات أصل وراثى لكننا لا نزال نجهل حتى الآن كيف يؤدي هذا الخلل في الكروموزمات إلى التأخر؛ بل الواقع أن هناك احتمالًا آخر هو أن يكون الصبغ الزائد في حد ذاته عرضًا آخر من أعراض العرض داون بدلًا من أن يكون السبب فيها.

ثانيًا: العوامل الاجتماعية الحضارية

يتعارض مع الرأى القائل بأن الشخصية تتحدد بالوراثة وجهة نظر تذهب إلى أن المجتمع يشكل طبيعة الإنسان، وأن الإنسان نتاج بيئته الاجتماعية، والإنسان كائن اجتماعي ما في ذلك شك، فهو يفضل في أكثر الأحيان أن يعيش إلى جوار غيره ويبحث عن وسائل زيادة سبل الاتصال المحلية ففي "نيوهافن" بولاية "كونيكتيكت" مع التأكيد على الطبقة الاجتماعية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة تم تحديد خمس طبقات تمثل أولاها طبقة أولئك الذين ينحدرون من صلب أسرة كبيرة ويكونون قد تخرجوا من الجامعة وشغلوا وظائف إدارية كبرى، أو علموا أساتذة بالجامعات، بينما تمثل الطبقة الخامسة منها أصحاب الأعمال اليدوية بالمصانع والعمال غير المهرة الذين لم يصلوا من التعليم إلا لمستوى الصف السادس الابتدائي.

تبين أن هناك أنماطًا من العصاب مرتبطة بالطبقة الاجتماعية إذ كانت الاستجابات المناهضة للمجتمع والاستجابات غير الناضجة متركزة في الطبقات الثالثة والخامسة على حين تجمعت أنواع الفوبيا والقلق والاستجابات السيكوسوماتية في أفراد الطبقة الرابعة، بينما جنحت استجابات الاكتئاب إلى الظهور بين أفراد الطبقة الأولى والثانية وعند تلخيص نتائج الدراسة وصف المؤلفون أفراد الطبقات المختلفة كما يلى: العصابيون في الطبقة الخامسة يسوء سلوكهم، وفي الطبقة الرابعة يشكون الأوجاع الجسمية، ومريض الطبقة الثالثة يدافع عن نفسه بالخوف، ومريض الطبقة الأولى والطبقة الثانية غير راض عن نفسه، كذلك معدل الإصابة بالذهان بين أفراد الطبقة الخامسة حوالى ثلاثة أصناف الطبقتين الأولى والثانية، وبينما كان ذهان الهوس والاكتئاب أكثر شيوعًا بين الطبقة الأولى والثانية نجد أن الفصام لم يكن منتشر بين الطبقات الثلاث.

أما في اليابان فقد اتسمت مجموعات الدخل المنخفض بأعلى معدلات الذهان، وأما في سنغافورة فقد اتسمت طبقة رجال الأعمال وأصحاب المهن الراقية بنسبة من المقبولين بالمستشفيات أشد انخفاضًا بكثير من طبقة العمال غير المهرة، وأما في "فورموزا" فقد ظهر لدى الطبقة العليا معدل انتشار عن العصابين مقداره (٣,٥) في كل ألف من السكان في مقابل (١,٢) في كل ألف من أبناء الطبقة الوسطى، ومعدل قدره (٤,٥) في كل ألف من أبناء الطبقة

الدنيا، وعلى حين أن رجال الطبقة الدنيا ونساء الطبقتين الدنيا والوسطى في أمريكا الجنوبية يعبرون عن مشاعر الاضطهاد من خلال الأمور الدينية، نجد أن رجال الطبقة الوسطى أميل إلى (العلمانية) في هذا.

وفيما يلي عرض لأهم العوامل الاجتماعية الحضارية:

(١) الحالة الزواجية:

هو عامل من العوامل المرتبطة بالاضطراب العقلي التى تم تفسيرها من زاويا متعددة، وقد أظهرت عدة دراسات أن المتزوجين أقل تعرضًا للاضطراب العقلي من الأشخاص الذين ليس لهم شريك حياة، أو زوج، كما أن الأشخاص الذين لا زوج لهم إما بسبب الطلاق، أو الموت، أو لأنهم آثروا ألا يتزوجوا تنتشر بينهم معدلات أعلى من المرض مثال ذلك أن معدلات المقبولين لأول مرة في المستشفيات العقلية في كندا كانوا كما يلى: من المتزوجين (٥٦) في كل مائة ألف، غير المتزوجين (١١٥) في كل مائة ألف، المطلقين (٢٨٦) في كل مائة ألف، الأرامل (٨٩) في كل مائة ألف.

على أن الزواج قد يكون سببًا في عدم الاستقرار الانفعالى، كما قد يكون نتيجة له فقد يجر الزواج معه بعض جوانب الاستقرار من قبيل العلاقات الاجتماعية الايجابية والشعور بالانتماء والقيمة والصحبة المطمئنة، كما أن الزواج قد يتيح متنافسًا للرغبات الجنسية والاجتماعية لكل من الشريكين، ومن الناحية الأخرى نجد أن حياة العزوبة والطلاق والترمل بمثابة ظروف قد تثير عدة ضغوط من قبيل الشعور بالاغتراب عن الآخرين، والعزلة، والنبذ، وقلة الكفاءة، ولكن هناك احتمالًا آخر أيضًا هو أن عدم الاستقرار الانفعالى يمنع المرء من الوصول إلى حياة زوجية ناجحة بسبب أن أمثال هؤلاء الأفراد الذين يتصفون به قد لا يكون لهم من الجاذبية ما ييسر على الآخرين أن يتخذوا منهم أزواجًا، أو ما ييسر لهم سبيل التوافق السليم للحياة الزوجية وأما الترمل فيمكن أن نعده النتيجة النهائية لواقعه صادمة هى موت المحبوب، وبهذا المعنى يكون الشخص الأرمل معرض للاضطراب الانفعالى.

(٢) البيئة المحلية أو الجيرة:

أظهرت بعض الدراسات أن حالات الاختلال العقلي تتناقص كلما ابتعدنا عن مركز المدينة واتجهنا إلى محيطها بنفس الطريقة التى تتناقص بها معدلات جنوح الأحداث،

والبطالة، والأمراض المعدية. وقد كان الانهيار العصبى أقل شيوعًا بين سكان الأحياء السكنية في أطراف المدينة منه بين إناس يعيشون في وسطها قريبا من المركز، كما تبين وجود علاقة بين الحى السكنى من ناحية والأعراض، أو نمط الاضطراب العقلي من ناحية أخرى، أما أصحاب الهوس والاكتئاب فقد كانوا أكثر شيوعًا بين أولئك القادرين على سكنى الشقق في منطقة الايجارات المرتفعة، على حين الفصام البارانيويدى كان أكثر انتشارًا بين مستأجرى الغرف في العمارات السكنية، وهناك سلاسل من الأحداث تؤدي في آخر الأمر إلى الانهيار: حياة البيئة المفككة تزيد من العزلة الاجتماعية، والعزلة الاجتماعية تشجع على الانطواء المتطرف، وتصدع التفاعل السوى الناجح مع المجتمع ينتهى إلى الاضطراب العقلي، وبهذا المعنى نجد العزلة الاجتماعية نتيجة لتفكك البيئة المحلية، كما أنها السبب في الاختلال العقلي في آخر الأمر.

(٣) تأثير المدنية:

معدلات الإصابة بين سكان المدن أكبر بدرجة واضحة من معدلات الإصابة بين سكان الريف وذلك بالنسبة لكل أنماط الاضطراب العقلي، وقد أشير في تقرير أن المدن لسهم بعدد من المقبولين لأول مرة في المستشفيات العقلية ويزيد على ضعف العدد الذى تسهم به المناطق الريفية.

والذين يقبلون الفروق بين هذه المعدلات يشيرون إلى الضغوط والأزمات التى تشتمل عليها الحياة في المدينة من قبيل فقدان العلاقات الشخصية ومن قبيل التنافس المفرط، كما أن التقدم التكنولوجى القائم في المدن يضطر العمال إلى دوام الترقى في مجالاتهم وإلا استبدل بهم غيرهم كذلك نجد أن ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد مطالب الحياة المطلوبة، وارتفاع الضرائب قد تضيف أعباء جديدة تتميز بها ظروف الحياة المعقدة.

على أن الأرقام الدالة على أثر المدن تبدو في ظاهر الأمر مقنعة ولكن النقاد مع ذلك يشيرون إلى بعض الدراسات التفصيلية والتى عجزت عن تأكيد أوضاع الارتفاع للمعدلات في المدن ويرون أن ما يقوم من فروق يمكن أن ينسب إلى عدد من العوامل التى لا ترتبط بالضرورة بزيادة الضغوط في حياة المدينة من ذلك مثلا أن ارتفاع معدلات المقبولين قد تعكس زيادة

المستشفيات المتاحة، أو زيادة الرغبة عند أسر المدينة في الاعتماد على المستشفيات والوثوق بها عن سكان الريف، ثم إن هناك احتمالًا آخر هو أن انخفاض المعدلات في الريف يعود إلى أن رعاية المريض في بيئته أسهل في مناطق الريف واحتمال آخر هو أن كبار السن ينتقلون إلى المدن بعد أن يتقاعدون وينتهون من أعمالهم الزراعية ولكنهم يجدون في هذا التغير المريع عناء باهظًا.

(٤) الدين:

يبدو أن الاختلالات الذهانية كما أوضحت الدراسات الغربية أكثر انتشارًا بين البروتستانت منها بين الكاثوليك، أو اليهود على حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للأنواع الخفيفة من الأمراض التى نراها في عيادات الصحة العقلية إذ تبلغ نسبة المرضى اليهود ممن يتلقون العلاج فيها ضعف نسبتهم من السكان ثم يتلوهم الكاثوليك وأخيرًا البروتستانت.

(٥) الجماعة العنصرية:

دراسة الفروق التى تعود إلى الجماعة العنصرية من حيث الاضطراب العقلي أمر في غاية في الصعوبة بسبب الارتباط الشديد بين الأصل العنصرى والعوامل الأخرى، من قبيل المستوى الاجتماعي الاقتصادي والتربية والمستوى المهنى، وما إلى ذلك أضف إلى ذلك أن الجماعة العنصرية والعنصر كلمات تختلف معانيها باختلاف الناس.

هناك دراسة قامت بالمسح الشامل لولاية "تكساس" تبين فيها أن نسبة الذهانيين بين البيض من الأصل الأنجلو سكسونى أعلى من نسبتها بين كل من غير البيض الزنوج والهنود والشرقيين والأسبانيين الأمريكيين ولكننا نجد من ناحية أخرى أن معدلات القوقازيين، أو أنصاف الهاواى أدنى في جزر هاواى من معدلات اليابانيين، أو الفلبين.

(٦) الهجـرة:

وسائل السفر الحديثة جعلت النقل من ولاية إلى ولاية ومن قطر إلى قطر أمرًا كثير الشيوع في حياتنا ومعدلات القبول في المستشفيات النفسية في الولايات المتحدة أكثر ارتفاعًا

بين المهاجرين منها بين المواطنين، والفرق قد يرجع إلى عامل انتقائى بمعنى أن الذين آثروا أن يتركوا مواطنهم الأصلية إنما فعلوا ذلك بعد أن وجدوا أنفسهم عاجزين عن التكيف وعندئذ يكون الرحيل بمحاولة الهرب من الاخفاق الشخصى، وقد وجد الباحثين أن نسبة من يدخلون المستشفيات في ولاية مينيسوتا من الأمريكيين الذين هم من أصل نرويجى أعلى من النسبة في النرويج، كما أنه لم يجد دليلًا على أن ضغط، أو معناه الهجرة ذاتها يسهم في نشأة أعراض المرض النفسى وصحة ذلك إلى أن المرض كان قائمًا بالفعل من قبل أن تتم الهجرة وذلك عند مرضى الفصام بشكل خاص.

ثالثا: الأســـرة

يختلف الإنسان عن سائر الحيوانات في أنه يخبر فترة نمو وتطور على درجة غير عادية من العمر، وإذا كان كثير من الثدييات تولد وقد بلغت تمام التطور مستقلة عن الأبوين، فإن الإنسان لابد له من أن يقضى سنوات طوال من قبل أن تصل قدراته الجسمية والعقلية تمام النضج، والطفل يكون شديد الاعتماد على والديه خلال هذه السنوات التشكيلية، ولذلك نجدهما يؤديان دورًا مهمًا في تطور شخصيات الأبناء والوالدان هما الراشدان اللذان يحددان نوع البيئة التى ينمو فيها الطفل: وهل تكون بيئة تتصف بالقسوة والنبذ، أو الدفء والتقبل بالأمن والراحة، أو بالقلق وانعدام الطمأنينة، بجو أسرى صحى، أو بيئة ملتوية معوجة ومن بين جوانب الأسرة التى تؤثر في الطفل: وجود الأبوين شخصيات الأبوين، ثم سلوك الأبوين نحو الطفل (أساليب التنشئة).

(أ) وجود الأبوين:

لابد لكى ينمو الطفل نموًا سليمًا، من وجود شخص راشد في حياته وفي الحالات التى تخلو فيها فترة الرضاعة، أو الطفولة خلوا تامًا من وجود الراشدين، تبدو على الطفل سمات أدنى من سمات الإنسان، أما إذا أختفي الراشد الجوهرى الواحد (وهو الأم) فإنه تبدو على الطفل سمات إنسانية باثولوجية وأحسن الأمثلة على الحالة الأولى أولئك الأطفال الذين يقال لهم أطفال الغابة وهؤلاء هم أطفال تربوا في البرية من غير أن يكون لهم نصيب من رفقة البشر، أو رعايتهم من قبيل الطفل الوحشى في "آفيرون".

وقد تبين لهؤلاء الباحثين من دراستهم لكل الحالات سواء التى تعيش في المؤسسات، أو التى انفصلت عن الأم أن الآثار التى تعزى الحرمان مريعة وأن الانحرافات الأساسية في شخصيات هؤلاء الأطفال تتضمن:

(١) الجوع الوجدانى إذ نشأ في بعض الحالات لدى الأطفال رغبة جارفة لا سبيل إلى إشباعها في الأبناء، خاصة حين يجدون أنفسهم مع الآخرين، وكان الغرض هو التعويض عن حياة الحرمان.

(٢) الشخصية عديمة المودة، ففي عدد كبير من الحالات، اتضح أن الأطفال يتجنبون تقرب الآخرين اجتماعيًا إليهم، أو عدم اكتراثهم بذلك، كما اتضحت لديهم البلادة الاجتماعية، ونقص القدرة على تكوين علاقات ذات معنى مع الآخرين.

(٣) الاكتئاب الفمى، أو الحداد – وهذا الانحراف الذى يلاحظ بصفة خاصة في حالات الانفصال يتضمن سلسلة متتابعة درامية من السلوك الذى يبدأ بالاحتجاج المبدئى وبذل الجهود لاستعادة الأم المفقودة ثم الحداد والضغط الذى يصاحبه نقص في مستوى النشاط، وأخيرًا إما التدهور الجسمى والعقلي وإما إنكار الحاجة إلى الأم (ويقع هذا من كبار الأطفال) بحيث أن الطفل قد يرفض الاعتراف بالوالد الفعلي بعد أن يعود إلى الالتقاء به.

ومع ذلك فإن التقويم الوثيق المعلومات المتوفرة حتى الآن يكشف عن بعض الاتجاهات المبدئية:

(١) خبرات الانفصال لفترة قصيرة واحدة والتى تحدث في جو أسرى صحى لا تترك آثارًا دائمة؛ بل أن آثارها تزول تمامًا وبسرعة على الرغم من أن المحتمل أنها تترك ندبة خفية تجعل الشخص أكثر تأثرًا بالأخطار المستقبلة من قبيل زيادة التعرض للاكتئاب فيما بعد.

(٢) الانفصال قصير المدى يؤدي إلى زيادة الاعتماد، أو الاتكالية في قلق متزايد بعد التلاقي، على حين أن الانفصال الشديد يؤدي إلى الانسلاخ والانسحاب غير الودى.

(٣) خبرات الحرمان الطويلة نسبيًا في الطفولة المبكرة والتى يعقبها التلاقى يمكن أن تؤدي إلى تحسن رائع في الوظائف الاجتماعية والعقلية ولو أن الكلام قد يبدو متأخرًا.

(٤) الحرمان الشديد الطويل الذى يبدأ مبكرًا في السنة الأولى من الحياة (من الشهر الثالث، أو ما بعده) والذى يستمر لفترة يصل طولها إلى ثلاث سنوات يؤدي إلى نقص شديد في الجوانب العقلية وجانب الشخصية، نقص يبدو غير قابل للشفاء.

(٥) الطفل أقل قدرة على تحمل خبرات الانفصال قبل بلوغه سن الخامسة منه بعد بلوغها.

(٦) الحرمان الطويل الشديد الذى يبدأ في السنة الثانية من الحياة يؤدي إلى آثار جسمية في نمو الشخصية، آثار يبدو أنها لا تزول ولكن الآثار التى تلحق الوظائف العقلية يبدو أنها تزول وتنحسر.

(٧) الاختلالات التى تطرأ على اللغة والتفكير التجريدى والقدرة على عقد صلات اجتماعية ذات معنى تؤدي إلى اختلالات يصعب شفاؤها.

(٨) بصفة عامة، الآثار التى تترتب على الحرمان، أو الانفصال تتفاوت.

ولذلك يمكننا أن نستنتج أن هناك أنماطًا سلوكية معينة يمكن أن تستثار خلال فترات حرجة في الحياة وأن نمط التطبيع الأولى يتم اختياره خلال هذه الفترة المبكرة من الحياة وأننا أن بدانا في نمط سلوكى معين، أصبح من الصعب إعادة التنظيم، أو اكتساب أنماط بديلة، ولو أننا أردنا أن نطبق هذا على بيانات الحرمان من الأم التى ناقشناها من قبل، جاز لنا أن نفترض ما يلى:

(١) الإنسان يكتسب الأساليب السوية للسلوك والشعور والتفكير من خلال التفاعل الاجتماعي مع الآخرين.

(٢) الأبوان في العادة هما الوكلاء الأوائل الذين يقومون بعملية التطبيع الاجتماعي وأول ما يخبر الطفل من الأشخاص.

(٣) في العلاقة العائلية المناسبة، يستجيب الطفل للأبوين، ويستجيبان له، وهذا من شأنه أن يزيد العلاقة الشخصية القائمة بين الطفل وأبويه توثقا وهذا يحدث حوالى الشهر الثالث من عمر الطفل.

(٤) ولأن العلاقة بين الطفل وأبويه تعود على الجانبين بنتائج مدعمة، تنشأ لدى الطفل اهتمامات أكبر وأكبر بالاتصال بالآخرين وباكتساب الوسائل التى تؤدي إلى تحسين هذه العلاقة من قبيل اللغة مثلا، أو الالتفات إلى وجود الآخرين.

(٥) وبعد أن يتوجه الرضيع إلى الآخرين في بيئة نراه يظل يستجيب للأنماط التى يمثلونها، أو يشجعون عليها، ويقاوم إعادة التنظيم، التى تبعده عن الناس، أو تدفعه نحو الانعزال.

(٦) وما لم تكن الأم هى نفسها شاذة، أو منحرفة بحيث تقدم أنماطًا سلوكية شاذة منحرفة، نرى الطفل سرعان ما يكتسب الطابع الغريزى السوى بصفة عامة.

(٧) أما في ظروف الحرمان الباثولوجية، فإن الرضيع لا تستثيره مطلقًا البيئة الاجتماعية ولا يحصل على التدعيم أن هو اكتسب، أو تعلق بالأنماط السلوكية التى تميز غيره من الناس ثم إن هذا التنظيم لمقاومة التواصل السوى، أو الإقبال على الناس في المجتمع يستعصى بعد ذلك على إعادة التنظيم، ثم إن انعدام التطبيع يؤدي بدوره إلى مزيد من العزلة، حتى إذا أصبح الطفل لذلك بعيدًا عن اتصاله بالواقع الاجتماعي نراه يصبح كذلك معرضًا بدرجة متزايدة للانفصال عن الواقع النفسى، وهكذا يصل الأمر إلى نمط البلادة الاجتماعية وقلة الاكتراث بالعلاقات الاجتماعية المهمة التى نجدها في دراسات الحرمان من الأمومة.

(٨) في حالات الانفصال حيث يحدث الحداد نستطيع أن نفترض أنه يحدث عند الطفل اختيار الموضوع أولى مبكر يتخذ صورة الأم، ومن شأن هذا الاختيار أن وقع أن يصبح شبيهًا بالتطبيع الغريزى عند الطيور وأن تصبح العلاقة بينهما شديدة الامتناع على التغير وأن تتضخم الصدمة الناشئة عن خبرة الانفصال وفي آخر الأمر نجد الطفل يتخلى عن الأم بدلًا من أن يسمح لإعادة التنظيم بالوقوع فيقبل له أما بديلة.

(ب) شخصية الأبوين:

في حالات الباثولوجيا عند الطفل تكون الباثولوجيا عند الأبوين عاملًا مهمًا وفي حالات الباثولوجيا التى تظهر عند الراشد يمكن أن يقال أن تأثير الأبوين يظهر في نسبة

عالية من الحالات، وقد صدقت ملاحظة "وردورث" حين قال أن الطفل أبًا للرجل أى أن تكوين الشخصية يتشكل بتشكل في فترة الرضاعة ثم يجمد خلال مرحلة الطفولة والعقل والجسم يتطوران ويتشكلان بسرعة خلال السنوات التشكيلية من حياة المرء ويكونان قابلين للتأثر بصفة عامة للمؤثرات الخارجية والداخلية والشخصيات الهامة في خلال هذه الفترة تساعد في تشكيل الاتجاهات وإدراك الطفل للآخرين والمهارات الاجتماعية التى تصبح نماذج أولية لمرحلة الرشد والأسرة هى الجماعة الأولية بالنسبة للطفل الصغير وهى جوهر اتصالاته بالعالم. وتطور الطفل الاجتماعي والانفعالى والمعرفي يتوقف على الشخصيات في أسرته فإن هذه الشخصيات هى التى تزوده بالدلائل الخارجية الأساسية اللازمة للتعلم والتكيف في بداية الحياة.

على أن الباثولوجيا عند الأبوين يمكن أن تؤثر في نشأة الباثولوجيا عند الأطفال على ثلاثة أنحاء ممكنة.

(١) أن تنشأ عند الطفل نفس الأعراض التى عند الأبوين من خلال التعلم المباشر، أو التقمص.

(٢) أن يظهر عند الطفل ما يكون لدى الآباء من صراعات، أو حاجات غير مقبولة، أو مشكلات يسبب استثارة من جانب الأبوين.

(٣) أن يكون الطفل عضوًا في وحدة أسرية باثولوجية.

(ج) عملية التعلم والتقمص:

يظهر على الأطفال تشابهًا ملحوظة لآبائهم في أنماط العادات والميول واللزمات نتيجة لعمليتى التعلم والتقمص، ذلك أن الأب يقوم بتدعيم استجابات معينة يظهرها الطفل، والأب يفعل ذلك في سرور وانشراح، خصوصًا حين يكون في هذه الاستجابات تقليد لسمات الأب وهل هناك من يستطيع أن يقاوم هذا النوع من التعلق؟؛ بل أن مقدار الابتسام الذى يبديه الرضيع – وبالتالى ما قد يعرف بالمزاج الرائق – إنما يتوقف على التوجيه بالتدعيم لكن الذى يؤسف له أن من الصحيح كذلك فيما يبدو أن المخاوف تكتسب عن الأبوين بنفس الصورة فقد تبين أن هناك إرتباطًا مباشرًا بين طبيعة المخاوف وعددها عند الطفل من ناحية وعند الأبوين من ناحية

أخرى، كما أن هناك أنماطًا كبرى من السمات الانفعالية والسلوكية التى هى على مستوى أكبر من التعقيد قد يكتسبها الطفل من خلال التقمص أيضًا وهنا يصبح الطفل صورة مصغرة دقيقة من الوالد، أما لأسباب دفاعية، أو لأن الوالد قد ارتبط بالتدعيم الإيجابى، أما في الحالة الأولى وتسمى تقمص المعتدى، أو التوحد معه، فإن الطفل يتقمص نموذجًا يخشاه لأن هذا يجعل المرء يقف على نفس الجانب، أو يجعله أقدر على السيطرة (في الخيال والأوهام على الأقل) على الشئ الذى يخشاه من ذلك مثلا أن "يلتهايم" كتب عن الميل عند نزلاء معسكرات الاعتقال النازية إلى تقليد حراسهم من النازيين، وأما في الحالة الثانية وتسمى أحيانًا بالتقمص الأولى، أو تقمص النمو، فإن الطفل يربط بين الوالد وبين وقائع سارة حانية مثبتة ويتقمص حتى أنه يستعيد تلك المنبهات رغم أن الوالد غير موجود أى أن الطفل حين يسلك سلوكًا مشابهًا لسلوك الأب في غيابه يتمكن بذلك من أن يسترد تلك المشاعر السارة التى ارتبطت بخصائص الأب – كما أن الطفل قد يقلد السلوك الذى لا معنى له، أو السلوك الذى لا اتصاله له بالموضوع كما يقلد الاستجابات المناهضة للمجتمع تقليدًا.

وبعض الباحثين أثاروا كثيرًا من الاهتمام بوسائل الإعلام في تقاريرهم التى أوضحت أن الأطفال يقومون بتقليد السلوك العدوانى إذا هم شاهدوا أفلامًا يظهر فيها عدوان الكبار، أو أفلامًا كاريكاتورية تتضمن العدوان.

(د) عملية استثارة الآباء:

هناك حالات يكون فيها السلوك الباثولوجى الذى يصدر عن الطفل غير قائم على تقليد سلوك الأبوين، أو غير متفق معه وهذه هى الحالات التى يتركز فيها الانتباه عندئذ على المريض، أو على عوامل خارجة عن الأسرة حين تقوم بالبحث عن الأسباب والعمل، وفي بعض هذه الحالات نجد أن الأبوين في واقع الأمر أثرًا عميقًا تمامًا في التعبير بالأعراض أى أن العامل يكون هنا بمثابة ممثل لأنواع العصاب عند الأبوين، أو أقل الناطق بلسانهم وقد وصف لنا "سبيرنج" مقنعًا أمثال هذه الظروف التى يحس فيها الطفل ببعض الحاجات المكبوتة عند الأم فيخرجها بصورة حرفية كذلك لاحظ "باودر ماكروفرانك" عدة ظروف يحدث فيها أن يقوم أفراد العلاج النفسى الجمعي ممن يخبرون مشاهد عدائية تجاه المعالج بالضغط على

عضو من أعضاء الجماعة وبإزعاجه إلى الحد الذى يستثيره إلى أن يفعل ما يرغبون جميعًا فيه وهو أن يعتدى على المعالج وأهمية هذا النوع من نشأة الأعراض يتركز في أنه يشير لنا إلى ضرورة استبعاد المريض من تأثير الآخرين، أو إلى ضرورة توسيع نطاق العلاج ليشمل الأب المستثير كذلك، ومن الطبيعى أن هذا النوع من العمليات يمكن أن يحدث في كل المواقف التى نجد فيها شخصين، أو أكثر يدخلان في علاقة اجتماعية وثيقة ودائمة أحدهما مع الآخر مثل العلاقات التى تكون بين الطفل والوالد، أو بين الزوج وزوجته، أو بين ساكن الغرفة وشريكه في سكنى الغرفة وهكذا.

(هـ) الوحدة الأسرية الباثولوجية:

أصبح من الشائع بدرجة أكبر أن تتقمص الأسرة بوصفها وحدة واحدة بدلًا من أن نفرد عضوًا معينًا فيها -وهو الشخص المضطرب -لنضعه موضع الفحص والتحليل وبهذا المعنى يصبح المريض مسئولًا عن مرضه بمقدار مسئولية سائر أعضاء الأسرة، إن أفراد بعض الأسر يبدو عليهم من جيل إلى جيل، بعض أساليب التفاعل المؤدية إلى المرض، وبذلك نجد عصابًا معينًا يستمر فيهم على تعاقب الأجيال مثال ذلك أن نتائج اختبارات الشخصية كشفت لنا أن أفراد أسرة واحدة تنتشر عندهم مخاوف متشابهة إلى حد كبير من صورة الجسم ومشاعر عن تشويه غير عادى للجسم، على حين أن أفرد أسرة أخرى كانوا يتشابهون على تعاقب أجيالهم في الانشغال العقلي بالموت والتدمير، ولعلنا أن نتوصل إلى نتائج حاسمة إلا بعد أن تتفحص الجوانب الديناميكية في الأسرة التى تؤدي إلى الفصام أى بعد أن تتفحص الأسرة المولدة للفصام بدلًا من أن تدرس سمات الفصامى، أو سمات الأب المولد للفصام، أو الأم المولدة للفصام لكن هذا العمل يتضمن مشكلات كثيرة من حيث مناهج البحث.

وقد تابع بعض الباحثين دراسة بيئة الأسرة فكشفوا عن تكوين أسرى مشوه في جوهره يكون فيه أحد الأبوين أ كلاهما مصابًا بالباثولوجيا الخطيرة والزيجة في هذا النمط، أما أن تكون انفصالية بحيث أن العداوات والاتهامات بين الوالدين تقسم الأسرة إلى جناحين متعارضين، وأما أن تكون ملتوية بحيث أن أحد الزوجين يتمشى في سلبية مع الأساليب المنحرفة وطرق تنشئة الأطفال المعوجة التى تكون لدى أكثر الزوجين اضطرابًا، وهكذا ينشأ

الأطفال في جو تتخلله التشوهات والأمور غير المعقولة والشكوك المتصلة بالأدوار وانعدام نماذج الأدوار التى تكون توافقية من الناحية الحضارية وفعالة صحيحة والتى يمكن للمرء أن يتوحد معها.

والأسرة هنا تختلف عن سائر الأسر الأخرى في أن الوالد السوى لا يعوض عن النقص الشاذ لدى الأب المضطرب كما تبين أن أنماط الوالدين عند المرضى الإناث تختلف فيما تبدو عن أنماط الوالدين عند المرضى الذكور أما في أسرة المريضة الفصامية فإن الأب يكون هو الشخصية السيطرة وهو يكون على درجة عالية من النرجسية يحتقر شأن زوجته والنساء بصفة عامة، ويستدير تجاه ابنته ليتخذ منها بديلًا عن الزوجة، وأما الأم فإنها عاجزة عن أن تجعل من نفسها نموذجًا لابنتها لأنها تتقبل دورها ومكانتها الضئيلة وتعيش في عدم استقرار وهو أن جزء من أن تثبت ذاتها إزاء زوجها المسيطر والانفصام يقوم من حيث أن كلا من الأبوين منعزل عن الآخر، وقد تبين أن مريضات الفصام قد تحالفن مع الآباء، وأما في أسرة مرضى الفصام من الرجال فقد كان دور السيطرة والسيادة تقوم به أمهات على درجة شديدة من الاضطراب كانت الأمهات ساخطات في علانية على الزوج غير الكفء، ويعبرن عن سخطهن هذا لولدهن مع شئ من التوجيه الضمنى بأنه لابد له من أن يشب مختلفًا عن والده ومثل هذا النمط من الأمهات يواجهن صعوبة في أن يكن على علاقة وثيقة بأبنائهن وهم لا يزالون بعد في مرحلة الرضاعة، ولكنهن يتحولن من بعد ذلك إلى الإفراط في الحماية والتدليل أى أن المرحلة السابقة من قلة الدفء تستحيل من بعد ذلك إلى انفعال مقيد جارف يوصف أحيانًا بالتعبير الساخر "الحب الخانق".

ويعود بعض الآباء إلى التعامل مع أبنائهم بالأساليب التى تعكس توافقهم (أو سوء توافقهم) للحياة والزواج والأطفال على حين أن بعضهم الآخر يلتمسون النصح من المصادر الخبيرة حتى يستعينوا بها عند اتخاذ القرارات وقد تم التعرف على عدة أنماط من الاتجاهات تبين أنها تؤثر في أسلوب معاملة الوالد لطفلة وشخصية الطفل.

الفصل الخامس

مدخل للإرشاد النفسي

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على مراحل تطور الإرشاد النفسي
- التمييز بين مصطلحا التوجيه والإرشاد
- الإلمام أهداف التوجيه وأسسه
- الوقوف على مستويات التوجيه
- التعرف على الملامح العامة للإرشاد
- فهم المسلمات الأساسية لعملية التوجيه والإرشاد
- التعرف على نشأة وتطور الإرشاد المدرسي
- نشأة وتطور الإرشاد المدرسي
- أهداف التوجيه والإرشاد المدرسي
- أنواع برامج التدخل في مجال الإرشاد لمدرسي
- التعرف على مناهج واستراتيجيات التوجيه والإرشاد المدرسي

الفصل الخامس
مدخل للإرشاد النفسي

مراحل تطور الإرشاد:

لقد كان التوجيه هو الإطار الذي نشأ فيه وتطور الإرشاد، ومن الناحية التاريخية فإن استخدام كلمة التوجيه Guidance أسبق من استخدام كلمة إرشاد Counselling، وكان التوجيه يقدم النصح والإرشاد دون الدخول في علاقة تفاعلية بين الموجه والفرد الذي يحتاج إلى التوجيه. وعندما أصبح ملموسًا أن خدمات التوجيه غير كافية لمساعدة الفرد لتحقيق ذاته، أصبحت الحاجة ملحة لعملية الإرشاد التي تتضمن العلاقة وجها لوجه بين مرشد ومسترشد، ويعتبر الإرشاد محور عملية التوجيه، أو تتضمنه عملية التوجيه الواسعة الأبعاد، وهما يلتقيان في الأهداف من حيث تحقيق الذات، وتحقيق التوافق، وتسهيل النمو الطبيعي لدى الفرد، واكتساب مهارة النمو الذاتي ومن ثم تحسين العملية التربوية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الصحة النفسية لدى الأفراد. ولقد مرت عمليتا الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي بعدة مراحل يمكن إيجازها في الآتي:

(١) مرحلة التركيز على التوجيه المهني:

كانت حركة التوجيه المهني التي بدأت في أمريكا خلال فترة الكساد الاقتصادي في الثلاثينات هي مهد حركة الإرشاد والتوجيه. ولقد نشأ التوجيه المهني على يد " فرانك بارسونز" وكان يدور حول إيجاد وسائل يمكن بها وضع الشخص المناسب في المهنة المناسبة. وخلال تلك الفترة كان الإرشاد يعتبر أسلوبًا معاونًا في جمع المعلومات عن الفرد وعن المهنة والتوفيق بينهما. وأدى التركيز على جمع المعلومات إلى استخدام الوسائل والأساليب السيكولوجية من مقابلة واختبارات وخلافه، لتحليل الفروق بين الأفراد. وكان لذلك أثر إيجابي في نشأة الإرشاد النفسي، ولكن نتج عنه أثران سلبيان هما: (١) أن مهمة الإرشاد أصبحت تعتبر مجرد عقد جلسة أو جلستين مع العميل قبل دخوله إلى عالم العمل.(٢) أنه ارتبط بالاختيار المهني.(يوسف القاضي وآخرون، ١٩٨١)

لقد ظهر التوجيه المهني استجابة لعدد من العوامل من أبرزها التقدم التكنولوجي الذي أدى إلى ظهور مهن وتخصصات معقدة تقتضي تحليلا لهذه المهن أو التخصصات لمعرفة

ما تحتاجه من قدرات وإمكانات، ومن ثم اختيار الفرد الملائم لها، وهذه هي ركائز التوجيه المهني.

نتيجة لذلك ظهرت حركة القياس النفسي التي تهدف إلى تحليل قدرات الفرد واستعداداته، وصاحب ذلك التحليل الوظيفي للمهن لمعرفة ما تحتاجه كل مهنة من إمكانات وقدرات. وعليه أصبح التوجيه والإرشاد يعنى جمع المعلومات عن الفرد والمهنة باستخدام أساليب جمع المعلومات المعروفة من مقابلات واختبارات وأساليب القياس الأخرى. وقد وصل حد اعتماد التوجيه المهني على القياس النفسي حدًا كبيرًا حيث وصفه أحد الباحثين بأنه أصبح مدمنا عليه. ويبدو أن هذه المرحلة كانت بداية الاهتمام بتوجيه الطلاب إلى اختيار التخصص ونوع التعليم وفقا لمقتضيات سوق العمل. (محمود عقل، ٢٠٠٠)

(٢) مرحلة التركيز على التوجيه المدرسي:

نشأ عن التركيز على التوجيه المهني أن اتجه التفكير إلى توجيه الأولاد في المدارس وكذلك إلى الطبيعة التربوية لعملية الإرشاد. فقد اتضح لكثير من العاملين في المجالات التطبيقية التربوية أن هناك هوة واسعة تفصل بين ما يتلقاه التلميذ في المدرسة وما يواجهه في الحياة العملية، وأن هناك ضرورة لسد هذه الثغرة. ومن هنا أصبح ينظر إلى التربية على أنها نوع من التوجيه. فالتوجيه التربوي هو توجيه من أجل الحياة. وكان تأثير ذلك على حركة الإرشاد النفسي هو توسيع مجالها وخروجها من مجال التوجيه المهني إلى مجالات أوسع بحيث أصبح الإرشاد يشمل الحياة الكلية للفرد. ودخل الإرشاد النفسي إلى المدارس من أوسع الأبواب وأصبح ينظر إليه على أنه سلسلة من النشاطات والأفعال تسري خلال كل النشاطات التربوية. وكان لمثل هذا التطور ميزة أنه أُدخل إلى الإرشاد وإلى التربية في نفس الوقت فكرة حق كل طفل في أن تكون له فرديته وأن يتلقى التعليم الذي يتفق وتلك الفردية. ولعل الجانب السلبي لذلك التطور كان هو ارتباط الإرشاد النفسي بالتعليم بحيث كادا أن يصبحا شيئًا واحدًا.

(٣) مرحلة علم النفس الإرشادي:

لقد حدث تطور في بداية الثلاثينات من هذا القرن مفاده أن التوجيه ليس عملية ميكانيكية تتمثل في مطابقة قدرات الفرد مع متطلبات المهنة، وأن الإخصائي حقيقة لا يتعامل مع

مشكلات بقدر ما يتعامل مع أفراد لهم خصائصهم المتباينة. وقد تأثر هذا التطور بحركة الصحة النفسية والمدارس العلاجية المختلفة. ونتيجة لذلك تأثر التوجيه بدراسات علم النفس والمدارس النفسية والعلاجية. وقد عبر سوبر Super (١٩٥٥) عن ذلك في مقاله" الانتقال من التوجيه المهني إلى علم النفس الإرشادي " حيث حاول تحديد معالم هذا الميدان الجديد.

وعليه يمكن القول أن بداية الخمسينات شهدت ميلاد علم جديد هو الإرشاد النفسي، وظهر في عام١٩٥١ مصطلح علم النفس الإرشادي والإخصائي النفسي في مؤتمر عقدته لجنة متخصصة في مينوسوتا قبل انعقاد المؤتمر السنوي للرابطة الأمريكية للمشتغلين بعلم النفس. وقد تبع ذلك إنشاء قسم الإرشاد النفسي في الجمعية النفسية الأمريكية ومن ثم البريطانية. وفي عام ١٩٥٤ صدرت مجلة الإرشاد النفسي، ثم دخل موضوع الإرشاد النفسي ضمن مقررات علم النفس التربوي في الجامعات. (محمود عقل، ٢٠٠٠)

ويمكن أن نتبين في هذه المرحلة اتجاهين رئيسيين لهما أثر في تحديد مسار وأهداف هذا العلم الوليد "علم النفس الإرشادي " هما:

(أ) مرحلة التركيز على التوافق والصحة النفسية:

وكانت هذه المرحلة هي أبعدها أثرًا، فقد نشأت بتأثير عاملين كان لهما نفوذهما البالغ في علم النفس وفي حياة المجتمع عمومًا هما: الانتباه مجالًا أوسع للاختيار. وهكذا يكون موضوع الإرشاد النفسي هو تغيير السلوك بتوفير موقف يتاح فيه للعميل الراغب في تغيير سلوكه أ ن يصبح أكثر مسئولية وأكثر استقلالًا وأكثر سيطرة على نفسه وعلى سلوكه.

(ب) مرحلة التركيز على النمو النفسي "المرحلة البنائية التطويرية ":

أشرنا إلى أن هدف الإرشاد في الاتجاه الأول كان التركيز على تعديل السلوك وتحقيق التوافق. ولكن سرعان ما دخل طور جديد في الخمسينات من هذا القرن سمي بالتطور البنائي أو الإنشائي. وقد برز الاتجاه في دراسات علم نفس النمو وخاصة دراسات بياجيه وإريسكون وهافجهرست في مطالب النمو. وتشير هذه الدراسات إلى أن هناك مطالب أو مهاما أو واجبات خلال مراحل النمو يجب أن يكتسبها الفرد أو يتعلمها وأن

تحقيق هذه المطالب في أوقاتها يؤدي إلى عبور المراحل التالية بثقة وأمان في حين يؤدي الفشل في تحقيقها إلى اضطراب النمو. وعليه فإن وظيفة الإرشاد هي تسهيل نمو الفرد خلال مراحل نموه وذلك بمساعدة على بلوغ وتحقيق مطالب النمو في كل مراحله.

مصطلحا التوجيه والإرشاد:

إن كلًا من التوجيه والإرشاد يعبران عن معنى مشترك سواء من حيث المعنى ممثلًا في الاهتداء إلى الطريق السليم، أو من حيث الإجراءات الهادفة إلى التوعية والمساعدة وتقديم الخدمة وتغيير السلوك إلى الأفضل، فكلًا من التوجيه والإرشاد يرتبط بالآخر، ويكمله، كما أنهما وجهان لعملة واحدة، وكثيرًا ما يقترن التوجيه بالإرشاد، بل إن هناك من يرى أن التوجيه هو الإرشاد الفردي، بمعني أنه تلك العلاقة الهادفة التي تقوم بين شخصين أحدهما يمتلك الخبرة والكفاءة المهنية والآخر يحتاج إلى ذلك من أجل التمكن من أن يسلك على النحو الصحيح حيال مشكلة أو موضوع أو قرار معين.

مفهوم التوجيه:

يعرف يوسف القاضي وآخرون (١٩٨١) التوجيه بأنه " عملية مساعدة أو تقديم العون للأفراد حتى يتمكنوا من تحقيق الفهم اللازم لأنفسهم وتوجيهها بحيث يستطيعون الاختيار عن بينه ويتخذوا من السلوك ما يسمح لهم بالتحرك في اتجاه هذه الأهداف التي اختاروها بطريقة ذكية أو تسمح بتقويم المسار بشكل تلقائي ".

وعُرف التوجيه بأنه " مجموعة من الخدمات النفسية التي تقدم للأفراد في حياتهم العملية، لمساعدتهم على الاختيار الأنسب في كافة المجالات التي تهمهم، كالمجال المهني الأسري والتربوي "(عبد الحميد الهاشمي، ١٩٨٦).

وعرفه محروس الشناوي (١٩٩٥) بأنه " المساعدة التي تقدم للأفراد، لاختيار ما يناسبهم على أسس سليمة، في المجالات المختلفة في الحياة ".

ويعرف بأنه " هو مجموعة من الخدمات النفسية المقدمة في مجال من المجالات التي يحتاج إليها الفرد، وذلك بشكل جماعي على الأغلب " (حامد زهران، ١٩٩٨).

مفهوم الإرشاد:

إن أغلب التعريفات الحديثة للعملية الإرشادية ركزت علي الجانب المهني المنظم الذي يتناول الحاجات الإنسانية للفرد، مع الاهتمام بالناحية الوقائية والنمائية والعلاجية، ومن بين هذه التعريفات، ما يلي:

عرفت رابطة علماء النفس الأمريكية لعلم النفس الإرشادي APA (١٩٨٧) الإرشاد بأنه " مجموعة الخدمات التي يقدمها أخصائيو علم النفس الإرشادي الذين يعتمدون في تدخلهم على مبادئ ومناهج وإجراءات لتسيير سلوك الإنسان بطريقة إيجابية وفاعلة خلال مراحل نموه المختلفة، ويقوم الإخصائي بممارسة عمله مؤكدا على الجوانب الإيجابية للنمو والتوافق من منظور إنمائي، وأن هذه الخدمات تهدف إلى مساعدة الأفراد على اكتساب المهارات الشخصية والاجتماعية وتحسين توافقهم لمطالب الحياة المتغيرة، وتعزيز مهاراتهم للتعامل مع البيئة المحيطة بهم، واكتساب المهارات والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات ".

يُعرف الإرشاد النفسي بأنه "عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خبراته ويحدد مشكلاته وينمي إمكاناته ويحل مشكلاته، في ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه، لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهدافه وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيًا وتربويًا ومهنيًا وأسريًا وزواجيًا " (حامد زهران، ١٩٩٨).

كما يُعرف الإرشاد النفسي بأنه "عملية تعليمية تساعد الفرد على أن يفهم نفسه، وذلك بالتعرف على الجوانب الكلية المشكلة لشخصيته، حتى يتمكن من اتخاذ قرارته بنفسه وحل مشكلاته بموضوعية مجردة مما يسهم في نموه الشخصي وتطوره الاجتماعي والتربوي والمهني. ويتم ذلك من خلال علاقة إنسانية بينه وبين الإخصائي النفسي الذي يتولى دفع العملية الإرشادية نحو تحقيق الغاية منها بخبراته المهنية "(ماهر عمر، ١٩٩٩).

وقد عُرف أيضًا بأنه " عملية بناءة ومخططة، الهدف منها مساعدة الفرد لكي يفهم نفسه ويقوم بتحديد مشكلاته والعمل على حلها، وكذلك القيام بتنمية ما لديه من إمكانات، من أجل تحقيق التوافق في جميع جوانبه الشخصية والتربوية والمهنية والزواجية والأسرية " (عزيز سمارة وعصام نمر، ١٩٩٢).

كما تم تعريف الإرشاد بأنه " المساعدة المقدمة من فرد إلى آخر لحل مشكلاته والاستفادة من إمكاناته، واتخاذ القرارات المناسبة، والوصول إلى التوافق، وهو يهدف إلى مساعدة الأفراد على تنمية استقلالهم وتنمية قدراتهم على أن يكونوا مسئولين عن أنفسهم " (فاروق عبد السلام وآخرون، ١٩٩٢).

وفي المقابل يوضح حامد زهران (١٩٩٨) الفروق بين مصطلح التوجيه ومصطلح الإرشاد، علي النحو التالي:

جدول (١)

الفروق بين مصطلح التوجيه والإرشاد

التوجيه النفسي Guidance	الإرشاد النفسي Counselling
هو مجموع خدمات نفسية أهمها عملية الإرشاد النفسي، أي أنه يتضمن عملية الإرشاد.	هو العملية الرئيسية في خدمات التوجيه النفسي، أي أنه لا يتضمن التوجيه.
هو ميدان يتضمن الأسس العامة والنظريات المهمة والبرامج وإعداد المسئولين عن عملية الإرشاد.	هو عملية ، أي أنه يتضمن عملية الإرشاد نفسها عمليًا وتطبيقيًا ، ويمثل الجزء العملي في ميدان التوجيه.
التوجيه إلى الصحة النفسية.	مثل الإرشاد إلى العلاج النفسي.
التوجيه إلى التربية.	مثل الإرشاد إلى التدريس.
يشير إليه البعض على أنه التوجيه الجماعي، أي أنه لا يقتصر على الفرد ولا على فصل ولا على مدرسة مثلاً بل قد يشمل المجتمع كله.	يشير إليه البعض على أنه عملية الإرشاد الفردي تتضمن علاقة إرشادية وجه لوجه.
يسبق عملية الإرشاد ويعد لها ويمهد لها.	يلي التوجيه ويعتبر الواجهة الختامية لبرنامج التوجيه.

وقد خلص صالح أبو عباة وعبد الحميد نيازى(٢٠٠١) أن العملية الإرشادية تتميز بمجموعة من الخصائص التي توضح معالمها وتميزها عن غيرها من أساليب التدخل الأخرى، وهي:

(١) أن الإرشاد عملية تتميز بالتفاعل والدينامية بين الإخصائي والطالب يتحمل فيها كل منهما دوره ومسؤوليته في إنجاز الأهداف وإحداث التغيير المنشود.

(٢) أن أساس نجاح العملية الإرشادية يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقة الإرشادية التي أساسها التقبل والاحترام والتقدير وحق الطالب في التعبير عن أفكاره ومشاعره ومراعاة ظروفه وقدراته وإمكاناته الشخصية والبيئية.

(٣) أن الهدف من العملية الإرشادية هو اكتشاف جوانب القوة في شخصية الطالب وبيئته والاستفادة منها في إنجاز أهداف العملية الإرشادية وإحداث التغيير المطلوب.

(٤) أن العملية الإرشادية عملية مهنية تتطلب شخصًا مؤهلا يمتلك المعرفة بالسلوك الإنساني وأساليب التغيير والخبرة والمهارة التي تساعده في أداء عمله بصورة صحيحة.

(٥) أن العملية الإرشادية تتم من خلال علاقة الوجه لوجه، نظرًا لما تتيحه هذه العلاقة من فرص لكل من الإخصائي والطالب لفهم بعضهما بعضا ودراسة المشكلة بدقة والوقوف على السلوك اللفظي وغير اللفظي لكل منهما والاتفاق على جميع عمليات الإرشاد ورسم الأهداف ومن ثم تحقيقها.

(٦) أن التدخل الإرشادي يعطي أهمية بالغة لقيم ومبادئ وعادات ومعتقدات المجتمع الذي يتم فيه، كما يراعي الثقافة الفرعية للمسترشد.

وهكذا يعبر مصطلحا التوجيه والإرشاد عن معنى مشترك، فكل من التوجيه والإرشاد يتضمن من حيث المعنى الحرفي، الترشيد والهداية والتوعية والإصلاح وتقديم الخدمة والمساعدة، والتغيير السلوكي إلى أفضل، وكل من التوجيه والإرشاد مترابطان، وهما وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يكمل أحدهما الآخر.

وهكذا على بالرغم من التشابه بين التوجيه والإرشاد، إلا أن هناك اختلافات بينهما، فبينما يكون الإرشاد من اختصاص الإخصائي النفسي على النحو الذي يكون فيه التدريس

من اختصاص المدرس، فإن التوجيه يشارك فيه أكثر من متخصص، كالطبيب، والإخصائي الاجتماعي، والمدرس، والمرشد الأكاديمي، وفي بعض الحالات كما هو الحال في المشكلات البسيطة، فإن غير المتخصص يقوم بالتوجيه، فالمدرس يمكن أن يوجه التلاميذ إلى بعض الأنشطة لقضاء وقت فراغهم، والآباء بالاشتراك مع إدارة المدرسة يوجهون التلاميذ إلى كيفية استذكار الدروس، ورئيس المنظمة يوجه المرؤوسين إلى الالتزام بمسؤوليات العمل..، ففي هذه الأمثلة نتبين بساطة المشكلة أو موضوع التوجيه، كما نتبين أن القائمين بالتوجيه غير متخصصين في التوجيه كمجال مهني.لكن ذلك ينطبق فقط على الظروف أو المشكلات البسيطة، أو الخدمات العارضة، أما الموضوعات الحيوية أو التي تتعلق بمجموعات كبيرة من الأفراد . كطلاب المدارس أو الجامعات، أو العمال في أحد المصانع، أو العاملين في المنظمة أو عندما تكون هناك مشكلات في التوافق، فإن التوجيه يتخذ شكل البرنامج المنظم، الذي يقدمه فريق من المتخصصين، وقد يضم هذا الفريق أشخاصًا غير متخصصين ولكنهم على دراية بجوانب معينة في الموضوعات التي يختص بها برنامج التوجيه.

وبناء على اعتبارات مهنية تخصصية، وأخذًا في الاعتبار أن هناك نواح مشتركة بين التوجيه والإرشاد، فإننا يمكننا إجمال التمييز بينهما في النقاط الآتية:

- التوجيه يتضمن مجموعة من الخدمات، من بينها الخدمة الإرشادية أي أن التوجيه أكثر عمومية من الإرشاد.
- التوجيه يسبق الإرشاد، فالفرد قد يتلقى برنامجًا توجيهيًا، لكنه لا يتمكن من الاستفادة من هذا البرنامج، حينئذ يكون من الضروري أن يتلقى الفرد خدمة إرشادية.
- التوجيه ميدان ينتمي إليه مجموعة من العاملين مثل الإخصائي والمرشد والإداري، أما الإرشاد فهو عملية يقوم بها الإخصائي النفسي.
- التوجيه يتضمن أنشطة يغلب عليها الطابع الإعلامي (تقديم المعلومات الصادقة) ليستفيد منها الشخص، أما الإرشاد فيتضمن إجراءات يغلب عليها الطابع التحليلي والتفسيري المتعمق للمعلومات التي يتم الحصول عليها، وتوظيف هذه المعلومات وفق أسس محددة يشترك فيها الإخصائي والطالب.

- بعض جوانب التوجيه يمكن أن يقوم بها غير المتخصص، فالمدرس يمكن أن يوجه الطلاب إلى أنشطة معينة لقضاء وقت الفراغ، ويمكن أن يوجههم إلى تخصص معين كالموسيقي أو الرياضيات (رغم أن المدرس قد يكون متخصصًا في تدريس الكيمياء أو اللغة العربية.. الخ) أما الإرشاد فلا يمكن أن يقوم به إلا الإخصائي المتخصص المؤهل لممارسة الإرشاد.
- التوجيه يكون مركز ثقله جوانب حياة الفرد، أو جانب معين مثل المهنة، العلاقات الاجتماعية، الدراسة، أما الإرشاد فمركز الثقل فيه هو الشخصية كجوانب جسدية ونفسية.
- إذا كان التوجيه يتضمن خدمة إرشادية، فإنه قد يستمر إلى ما بعد انتهاء هذه الخدمة، كما أن عمل الموجه يستمر إلى ما بعد الإرشاد، ولكن العكس ليس صحيحًا، بمعنى أن عمل الإخصائي لا يستمر إلى ما بعد التوجيه إلا في حالات معينة، وعندما يستمر التوجيه إلى ما بعد الإرشاد فإن خدمات التوجيه تكون مطلوبة لتدعيم الأثر الإيجابي، مثلما تكون مطلوبة كنوع من المتابعة لدى الاستفادة من الخدمة الإرشادية (صالح أبو عباة ، عبد المجيد نيازي ، ٢٠٠١)

أهداف التوجيه وأسسه:

إن غاية التوجيه هي تحقيق التوافق والتكيف لدى الفرد بأقصى ما تسمح به قدراته وإمكانياته من المنظور الشخصي والبيئي، أيا كانت الأساليب والأهداف المتبعة أو المبتغاة من عملية التوجيه وبصفة عامة، فإن عملية التوجيه كما أوضح سعد جلال (١٩٩٢) تهدف إلى مساعدة الفرد على تحقيق العوامل الآتية:

- فهمه لنفسه عن طريق إدراكه لمدى قدراته ومهاراته واستعداداته وميوله.
- فهم المشاكل التي تواجهه مهما كان نوعها.
- فهم بيئته المادية والاجتماعية بما فيها من إمكانيات ونقص.
- استغلال إمكانياته الذاتية وإمكانيات بيئته.

- تحديد أهداف له في الحياة، على أن تكون هذه الأهداف واقعية يمكن تحقيقها وتتفق وفكرته السليمة عن نفسه.
- أن يرسم الخطط السليمة التي تؤدي به إلى تحقيق هذه الأهداف.
- أن يتكيف مع نفسه ومع مجتمعه فيتفاعل معه تفاعلًا سليمًا.
- أن ينمو بشخصيته إلى أقصى حد تؤهله إمكانياته وإمكانيات بيئته.

مستويات التوجيه:

كثيرًا ما تناول علماء النفس مستويات التوجيه من جوانب عدة، وإن كان يؤخذ على هذا التناول أنه يتعامل مع مستويات التوجيه في مجال معين (كالتربية، أو الأسرة، أو العمل..)، ويؤكد بشير الرشيدي وراشد السهل (٢٠٠٠) على أنه إذا ما أردنا تحديد مستويات التوجيه أيا كان المجال الذي يحدث فيه ، فإننا نرى أن هذه المستويات تتمثل في:

المستوى البسيط: وفي هذا المستوى يكون دور التوجيه محددًا في تقديم معلومات بسيطة لمن يحتاجها أو يطلبها أو يرغب فيها، ولا يتطلب الأمر سوى إلمام الموجه بالمعلومات الصحيحة والقدرة على توصيلها، أما الموضوع الذي يتم التوجيه بشأنه فعادة ما يكون موضوعًا بسيطًا، أو عامًا، ولا يصل إلى درجة المشكلة التي تعوق أداء الشخص.

المستوى التفسيري: وفي هذا المستوى يكون دور التوجيه أكثر عمقًا واتساعًا مقارنة بالمستوى البسيط، إنه يتضمن تحديد المشكلة وأسبابها ، ويبين للشخص جوانب سلوكه الإيجابية والسلبية، وكيف يتعامل مع المشكلة ويتخذ بشأنها القرار الصحيح على ضوء قدراته واستعداداته، وهذا المستوى من التوجيه يرتبط عادة بوجود مشكلات أو معوقات ، قائمة أو محتملة ، أي أنه يكون علاجيًا أو وقائيًا.

المستوى التفسيري/ التحليلي: وفي هذا المستوى يكون التوجيه متضمنًا أكثر من خدمة، أهمها خدمة الإرشاد النفسي، بالإضافة إلى دور الإخصائي الاجتماعي والطبيب النفسي وغيرهم من المتخصصين ذوي التأهيل العلمي الذين يساعدون في حل المشكلة، وهذا المستوي من التوجيه يكون في حالات المشكلات المعقدة ، وسوء التوافق الدراسي أو المهني أو الزواجي.

الملامح العامة للإرشاد:

هناك العديد من الملامح العامة التي تميز الإرشاد عن العلوم الأخرى، خاصة العلوم ذات الطابع الإنساني، وأهم هذه المميزات كما أوضحها محمد جمل الليل (٢٠٠٢) هي:

(١) الإرشاد هو عمل مهني يقوم به الإخصائي المؤهل الذي يتحمل المسؤولية في القيام بهذا الواجب، وذلك وفق خطوات وأسس ثابتة.

(٢) الإرشاد يقوم أساسًا على علاقة إرشادية بين الإخصائي والفرد والتي تعتبر الخطوة الأساسية في سبيل نجاح العمل الإرشادي، ومن صفات هذه العلاقة: الدفء والتسامح والتفهم والقبول. فالإرشاد ليس محادثة سطحية، أو علاقة عابرة بين شخصين.

(٣) يهتم الإرشاد ويركز على المهارات اللازمة عند الفرد والتي تساعده على تحديد أهدافه واتخاذ القرارات الصالحة لحل مشكلته. وذلك بعد قيام الإخصائي بتمهيد الطريق للفرد لطرح العديد من الاختيارات والحلول، ومناقشة ذلك للتوصل إلى الأفضل والمناسب منها على اعتبار أن الفرد ليس مريضًا عقليًا بل هو شخص قادر ومسئول عن اتخاذ قراراته والقيام بالسلوك التوافقي.

(٤) يتضمن الإرشاد مساعدة الفرد على تعلم نماذج جديدة وجيدة من السلوك والاتجاهات، إنه عملية تعلم وتعليم، فعندما يصل الطالب إلى حلول لمشكلته، عليه أن يدرك واقعه وإمكاناته، والنتائج المترتبة على الاختيارات.

(٥) يتضمن الإرشاد المجهود المشترك بين الإخصائي، والفرد القائم على الاحترام المتبادل. فمثلًا يشترك الاثنان في مناقشة ونقد الأهداف المأمولة من العملية الإرشادية، وذلك للتوصل إلى أهداف جيدة وقابلة للتحقيق.

(٦) يتضمن الإرشاد بعض المهارات اللازمة التي يجب توافرها في الإخصائي، مثل الحضور والانتباه التام والإصغاء الجيد والاستجابة المناسبة والقدرة على تغيير السلوك الذي يلزم تغييره أو تعديله.

(٧) الإرشاد هو أسلوب للحياة في حد ذاته، فهو يساعد الفرد على النمو المستمر بحيث لا تقتصر مهمته على تعديل السلوك المنحرف، بل يسهم ويساعد في نمو الفرد في كافة المجالات نحو الأفضل، فاهتمام العمل الإرشادي ينصب على حاضر الفرد ومستقبله.

المسلمات والمبادئ الأساسية لعملية التوجيه والإرشاد:

هناك العديد من المسلمات الأساسية لعملية التوجيه والإرشاد التي ينبغي على الإخصائي النفسي أن يضعها في اعتباره عند التعامل مع الأفراد، ومن بين هذه المسلمات ما يلي:

(١) إن الفروق بين الأفراد فروق ذات أهمية ودلالة في سلوكهم في مجال الدراسة والعمل. ومن أبرز الفروق بين الأفراد وأكثرها تقبلًا لدى الناس الفروق الجسيمة ثم الفروق في القدرة على التعلم، سواء كانت هذه القدرة عامة أم متخصصة كما أن من المسلم به أيضًا أن الأسلوب الذي يتبعه الفرد في معاملته للآخرين يختلف من فرد لآخر.

(٢) الفروق التي توجد في الفرد الواحد فروق ذات أهمية ودلالة في مجال الدراسة والعمل. فالفرد لا يختلف عن غيره من الأفراد فحسب، بل إن خصائصه تختلف الواحدة عن الأخرى قوة وضعفًا سواء كانت هذه الخصائص صفات جسيمة أم استعدادات عقلية أم تحصيل دراسي أم أساليب انفعالية ومزاجية. فالفرد مثلا قد يكون شديد الذكاء ولكنه ضعيف الشخصية، كما أنه قد يكون فوق المتوسط في قدرته العددية ولكنه أقل منه في قدرته المكانية.

(٣) إن الفرد في نموه الدراسي والمهني يخضع للمبادئ العامة للنمو كما أنه يخضع في سلوكه الدراسي والمهني، والمبادئ العامة للسلوك. إن النمو الدراسي والمهني ليس سوى مظهرين من مظاهر النمو، وهما بذلك يخضعان للمبادئ العامة التي يخضع لها النمو فهما يتأثران بالعوامل الوراثية والعوامل الاجتماعية، كما يتأثران أيضًا بمستوى النضج الذي يصل إليه الإنسان، فاختيار نوع الدراسة ليس بمعزل عن سن التلميذ وعن ظروفه الاجتماعية والاقتصادية، كما أن اختيار المهنة يتأثر بمستوى النضج الانفعالي والاجتماعي الذي وصل إليه الفرد. وأهم مبادئ النمو التي يمكن أن تنطبق على النمو الدراسي والمهني هي أنه عملية مستمرة تتخذ سرعة تختلف باختلاف الأفراد، وأن عمليات النمو لا تتكرر في الفرد الواحد، وأنها تتمايز في أنماط أو نماذج، وأن النمو يتخذ أنماطًا معينة وأنه يتجه إلى التعقيد والتركيب والتمايز والتكامل.

(٤) إن الدراسات والمهن المختلفة تستلزم من الأفراد لكي ينجحوا فيها مطالب مختلفة. فكل دراسة تختلف عن غيرها في الصفات أو السمات أو غير ذلك من الخصائص التي ينبغي توافرها في الأفراد الذين يلتحقون بها. فالدراسات العلمية مثلا تتطلب استعدادات تختلف عن الدراسات الأدبية، كما أن مستوى الدراسة التي يقوم بها الطالب تتطلب أيضًا استعدادات معينة.

(٥) يحتاج الأفراد في فترة ما أو أكثر من فترات حياتهم للمساعدة الفنية التي يقدمها الموجه أو الإخصائي سواء كانت هذه المساعدة في ميدان الدراسة أو في ميدان العمل. وقد نشأت هذه الحاجة نتيجة لتعدد الدراسات أو لتعدد المهن التي يمكن للفرد أن يلتحق بها، هذا التعدد الذي وصل إلى درجة أصبح معها من المستحيل على الفرد العادي أن يحيط بها، وأن يقرر ما يراه بشأنها، دون مساعدة فنية من الإخصائيين، وتختلف هذه الحاجة من فرد لآخر فالبعض في حاجة إلى المساعدة الكبيرة المستمرة التي تتناول أكثر من ناحية من نواحي الدراسة أو العمل. والبعض الآخر في حاجة إلى مساعدة بسيطة قصيرة تتناول ناحية من هذه النواحي، وليست هذه المساعدة أمرًا يتم بطريقة آلية أو في جلسة واحدة، ولكنها مساعدة علمية مقصودة، لا يقوم بها إلا الإخصائيون نظرًا لأهميتها وما قد يترتب عليها من آثار (لطفي بركات وآخرون، ب.ت).

الخدمات التي يتضمنها التوجيه والإرشاد التربوي:

أولًا: **الخدمة الخاصة بتعريف الطلاب بفائدة الدراسة وبفائدة الاستمرار فيها:** تهتم هذه الخدمة بتوضيح أنه كلما استمر الطالب في دراسته اتيحت له فرص أوسع للعمل ورقى أعظم للنواحي المادية والاجتماعية.

ثانيًا: **الخدمة المتعلقة بتعريف الطلاب بالإمكانيات التربوية المختلفة:** وتهدف هذه الخدمة إلى تعرف الطلاب باستعداداتهم وقدراتهم وميولهم وسماتهم الشخصية ومستويات تحصيلهم ومقارنة ذلك بزملائهم وبطلبة المدارس والكليات والمعاهد التي يفكرون في الالتحاق بها.

ثالثًا: **الخدمة المتعلقة بالاستشارات التربوية:** وهي تهدف إلى مساعدة الطلاب على اختيار الدراسة الملائمة لهم ولمستواهم وذلك بتعريف الطلاب بالدراسات المختلفة وما تستلزمه من استعدادات أو قدرات وغير ذلك ثم تعريفهم باستعداداتهم وقدراتهم وغير ذلك من خصائصهم الشخصية والملائمة بين إمكانياتهم والدراسة المتاحة لهم.

رابعًا: **الخدمة المتعلقة باكتشاف نواحي التأخر الدراسي:** وتهدف هذه الخدمة إلى اكتشاف نواحي التأخر في الدراسة سواء أكان هذا التأخر عامًا في جميع المواد أم خاصًا بمادة من المواد.

خامسًا: **الخدمة المتعلقة بالتكيف للدراسة وللحياة المدرسية بوجه عام:** وتهدف إلى اكتشاف نواحي عدم التكيف في المجال الدراسي والتربوي مثل التكيف للمنهج أو التكيف مع الزملاء أو في الحياة الاجتماعية والعمل على تلافيها عن طريق تعديل العوامل البيئية المؤثرة فيه: مثل العمل على نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو من فصل لآخر إذا استحال تكيفه في مدرسته الأصلية أو فصله الأصلي(لطفي بركات وآخرون ، ب.ت)

نشأة وتطور الإرشاد المدرسي:

لم يعد دور المدرسة كما كان في الماضي قاصرا على تلقين المعلومات، واكتساب المعارف فحسب، فقد صاحب التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات، والتطورات الحديثة في كافة مناحي الحياة، طفرة كبيرة في دور المدرسة، إذ أنه قد ألقُى على المدرسة عدد من الالتزامات والمطالب تعدت دورها التربوي ليمتد ويشمل كافة جوانب نمو الطلاب الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية والمهنية - ومن هنا بدأت تظهر حاجة ملحة لوجود الخدمات النفسية في المدارس من أجل بناء شخصية الطالب بناء متكاملا من مختلف جوانبها، وعلى العكس مما كان شائعا في مصر أن الخدمة النفسية لا تقدم إلا للطلاب ذوي المشكلات النفسية والسلوكية، مما أدى إلى إهمال تقديم تلك الخدمات لقطاع كبير من الطلاب. وفي محاولة لتدارك هذا القصور صدر قرار وزير التعليم رقم ١٤٢ بتاريخ ١٩٩٠/٥/٥ م بإدخال الخدمة النفسية لطلاب المدارس، ولكي

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ، فقد تطلب الأمر استحداث وظيفة جديدة. وهي وظيفة " الإخصائي النفسي المدرسي ".

وذلك بعد أن كان الإخصائي الاجتماعي يقوم بهذا الدور بسبب الخلط بين وظيفة الإخصائي الاجتماعي، وبين وظيفة الإخصائي النفسي في المدراس، إذ أدى التشابه في أهداف كل من الخدمة النفسية المدرسية، والخدمة الاجتماعية المدرسية إلى الاعتقاد بأن الإخصائي الاجتماعي يستطيع أن يقوم بدور الإخصائي النفسي المدرسي، إلا أن الكثير من المهام تتعدى إمكانات الإخصائي الاجتماعي واختصاصاته والتي لم يؤهل لها ليقوم بهذا الدور.

ومن الأسباب التي دعت لاهتمام المربين وعلماء النفس والتربية بالدعوة إلى إدخال الخدمة النفسية بالمدارس ما يلي:

١ - تقلص دور الأسرة التوجيهي:

لقد كان في الماضي عبء تربية الأبناء وتوجيههم يقع على عاتق الأسرة، ولكن بعد التطورات التي طرأت على الأسرة وابتعاد الأب ومن بعده الأم عن تربية الأبناء كانت هناك ضرورة بأن تحل إحدى وسائط التنشئة محلها، فكانت المدرسة هي المنوطة بسد الفراغ الذي تركته الأسرة، فأصبح على المدرسة القيام بالدور الذي كانت تقوم به الأسرة من توجيه وإرشاد لأبنائها الطلاب من الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية والمهنية والدينية، بل أن الأمر قد تعدى ذلك بأن أخذت المدرسة على عاتقها أمر توجيه الأسرة وإعدادها للقيام بوظائفها على أحسن وجه، ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة لوجود الإرشاد النفسي بالمدارس.

٢ - الانفجار الهائل في عدد السكان:

إن الزيادة الهائلة في أعداد السكان تبعه طفرة كبيرة في الأعداد المقبولة بالمدارس مما أدى إلى كثرة عددها وانتشارها، الأمر الذي تمخض عنه ظهور العديد من المشكلات التعليمية والنفسية والاجتماعية بين هؤلاء التلاميذ، مما دعي إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات فعالة لمواجهة كل هذه المشكلات وغيرها، فظهر التوجيه والإرشاد التربوي للتصدي لحل تلك المشكلات داخل المدرسة على أسس علمية سليمة ووفق أساليب فنية وتربوية مخططة.

٣ - التقدم التكنولوجي السريع:

لقد أحدث ظهور الآلة في حياة الإنسان طفرة كبيرة شملت كافة مناحي الحياة وخاصة عند ظهور الثورة الصناعية التي عمت أرجاء الأرض وما أحدثه التطور التكنولوجي المتلاحق من تغير كثير من المفاهيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فالتغيرات التكنولوجية تجعل كل ما هو متطور وحديث بعد فترة وجيزة متخلفا وغير متطور، وهذا التغير السريع حتى ولو كان مفيدا لصالح الإنسان إلا أنه يلقي عبئا على نفس الأفراد الذين يواجهون هذا التغير ويتعاملون معه ويتأثرون به، وكان تأثير ذلك على حركة الإرشاد النفسي هو توسيع مجالها وخروجها من مجال توجيه المهني إلى مجالات أوسع بحيث أصبح الإرشاد يشمل كافة جوانب الفرد. فدخلت الخدمة النفسية إلى المدارس من أوسع الأبواب وأصبح ينظر إليها على أنها ضرورة وخاصة بعد ظهور الهوة الواسعة التي تفصل بين ما يتلقاه التلميذ في المدرسة وما يواجهه في الحياة العملية، وأن هناك ضرورة لسد هذه الثغرة من خلال الإرشاد المهني في المدارس والذي يعد أحد الأدوار التي يقوم بها الإرشاد النفسي المدرسي.

٤ - تعقد الحياة وتشابك العلاقات الاجتماعية:

لم تعد الحياة التي نعيشها الآن بالحياة السهلة البسيطة التي كان يعيشها الناس في الماضي، فلقد تعقدت الحياة وتباينت الأدوار وتشابكت العلاقات الاجتماعية، كما زادت الضغوط الاجتماعية بسبب وضع كثير من القيود والضوابط على سلوك الفرد مما أثقل كاهله وأفقده بعضا من حريته حتى أصبح الفرد يجد نفسه يسلك سلوكا لا يرضى عنه ولكن كي يرضي الجماعات التي ينتمي إليها ويخضع نفسه لمعاييرها مثل جماعة الأسرة، وجماعة المدرسة، والجماعة الدينية.. وغيرها من الجماعات التي يمثل أحد أفرادها.

وقد أدى تعقد هذه المنظومة الاجتماعية إلى ضرورة إيجاد استراتيجيات لتنمية بعض المهارات التي تساعد الطلاب على الانخراط في المجتمع وتكوين علاقات اجتماعية إيجابية مع الآخرين وتزويدهم بمعلومات عن كيفية اختيار الأسلوب المناسب للحياة الاجتماعية.. ولن يأتي ذلك كله وغيره إلا من خلال إدخال الإرشاد النفسي بالمدارس.

وهكذا لم تعد الخدمة النفسية في المدارس ضربا من الرفاهية وإنما أصبحت ضرورة فرضتها المشكلات التي تعترض سبيل الطلاب في مواقف شتى ويتحتم عليهم مواجهتها، وترمي الخدمات النفسية إلى الأخذ بأيديهم في حل مشكلاتهم ومعاونتهم على مواجهة تلك المواقف والهدف من تلك المساعدة هو أن يتعرف الطالب على حالته كفرد له شخصيته وكيانه وكعضو في جماعة له حقوق وعليه واجبات. ويقتضي العون والمساعدة استثمار نواحي القوة عند الطالب وتقويم نواحي الضعف التي تعترض تقدمه أو تعويضه عنها، وتشمل المساعدة معرفة الطالب بالفرص التعليمية الميسرة له والهوايات التي يقضي فيها أوقات فراغه والعمل على تنميتها، وكذلك الكشف عن ميوله واستعداداته وتعهدها بالتنمية والرعاية.

أنواع برامج التدخل في مجال الإرشاد المدرسي:

يرى (Peterson & Nisenholz 1995) أن هناك أسلوبين أساسين من أساليب التدخل التي يقوم بها الإخصائي النفسي المدرسي هما:

1. الخدمات المباشرة.
2. الخدمات غير المباشرة.

فالخدمات المباشرة تشمل خدمات الإرشاد الفردي والجماعي والأسري والتوجيه النفسي التعليمي، وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز النمو الشخصي والاجتماعي للطالب وتحسين مستوى نموه العلمي والمهني. ومن القضايا والموضوعات والمشكلات التي يتعامل معها الإخصائي في هذا المستوى اتجاهات الطلاب وسلوكياتهم، والعلاقات مع الزملاء، ومهارات التعلم، واختيار التخصص، ومشكلات الإدمان، والمشكلات الأسرية كالعنف والطلاق وموت أحد أفراد الأسرة، حيث يقوم الإخصائي باستخدام طريقة التدخل الفردي أو الجماعي أو الأسري للتعامل مع هذه الموضوعات والمشكلات ومساعدة الطلاب على التغلب عليها وتجاوزها.

أما الخدمات غير المباشرة فتشمل تقديم الاستشارة، والتنسيق.. فتقديم الاستشارة يتطلب التعامل مع المعلمين والعاملين في المدرسة والوالدين بهدف مساعدتهم على تحسين أسلوب تفاعلهم مع التلاميذ، ويستخدم الإخصائي أساليب تدخل مختلفة لتقديم الاستشارة منها: المؤتمرات الفردية، وحلقات النقاش، وورش العمل، التي تستهدف إكساب الطلاب مهارات محددة تساعدهم في التعامل مع مشكلات معينة (صالح أبو عباة ، عبد المجيد نيازي ، ٢٠٠١).

مجالات التوجيه والإرشاد المدرسي:

لقد تعددت مجالات الإرشاد النفسي المدرسي لتشمل المجال النفسي والاجتماعي والأكاديمي والمهني للطالب، وقد حددت سهير درويش (١٩٨٨) الأنشطة الإرشادية التي تحقق النمو المتكامل للطلاب على النحو التالي:

١ -**الإرشاد النفسي:** الذي يهدف لمساعدة الطلاب الذين يعانون من اضطرابات انفعالية أو عاطفية، عن طريق الأنشطة الإرشادية التالية: تنمية القدرة على تقدير الذات وكيفية التغلب على الشعور بالنقص، ومواجه الصراع بين الواقعية والجوانب الروحية الخلقية، ومساعدة الطلاب في التخلص من الشعور باليأس والكآبة، ومساعدة الطلاب على الاحتفاظ بحالة مزاجية متوازنة، ومواجهة فقدان القدرة على التركيز الناتج عن الضغوط الانفعالية والعاطفية.

٢ -**الإرشاد الاجتماعي:** الذي يهدف لمساعدة الطلاب الذين يعانون من عدم التوافق مع البيئة المدرسية، عن طريق الأنشطة الإرشادية التالية: فهم أسلوب الإفادة المثلي من وقت الفراغ، والتوافق مع الواقع الفعلي المحيط بالطالب، وتطوير القدرة على تكوين علاقات إيجابية مع الزملاء، وفهم القوانين التي تحكم سلوك الطلاب، وتزويد الطلاب بمعلومات عن كيفية اختيار أسلوب الحياة الاجتماعية الأفضل، والتعريف بأسلوب تفهم المشاكل الأسرية ومعالجتها.

٣ -**الإرشاد الأكاديمي:** الذي يهدف لمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات تؤثر على أدائهم المدرسي، عن طريق الأنشطة الإرشادية التالية: التغلب على الرسوب في المقررات الدراسية، وتطوير الدافعية الذاتية للدراسة، تطوير القدرة على الدراسة والاستيعاب، والتعريف بأفضل أساليب الدراسة، والتعريف بكيفية التخطيط لبرامج الدراسة الثانوية والجامعية، والتعريف بكيفية وضع أهداف أكاديمية يمكن تحقيقها.

٤ -**الإرشاد المهني:** الذي يهدف لمساعدة الطلاب المتفوقين والعاديين والمتأخرين دراسيا في التخطيط الدراسي المهني، عن طريق الأنشطة الإرشادية التالية: التعريف بمدى ملاءمة قدرات الفرد المختلفة ومتطلبات المهنة التي يرغبها الطالب، وتكوين مهارات التعرف بالذات، والتعريف بالعلاقة بين التخصص الدراسي ومجالات العمل، وتقديم معلومات واقتراحات للطلاب عن سوق العمل، التعريف بكيفية المفاضلة بين المهن والوظائف التي تتعلق

بقدرات الطالب، وتكوين مفهوم لدى الطالب عن اهتماماته واتجاهاته وأسلوب حياته المهنية المستقبلية.

أهداف التوجيه و الإرشاد المدرسي:

يعرف برنامج التوجيه والإرشاد في المدرسة بأنه " ذلك البرنامج المخطط والمحدد والمنظم ضمن أسس علمية لتقديم خدمات توجيهية وإرشادية لفئة محددة أو عامة من الطلاب " فيتم تحديده من خلال أهداف وطرق وضمن أسس محددة، ويمكن تفصيل ذلك من خلال تحديد أهداف التوجيه و الإرشاد المدرسي، وحيث تقسم هذه الأهداف إلى قسمين:

أهداف عامة: وتشمل تحقيق فلسفة التوجيه والإرشاد النفسي في المدرسة ومساعدة الطلاب على تحقيق الذات والوصول إلى معالجة للاضطرابات النفسية الناجمة عن العملية التربوية وما يؤثر فيها.

أما الأهداف الخاصة فتتمثل في الوقاية من الاضطرابات النفسية وتحقيق أفضل مستوى من النمو النفسي وبشكل عام يمكن القول بأن الأهداف تتمثل في معالجة مشكلات العملية التربوية كاملة والتي سبق شرحها والحاجة إلى برنامج متكامل يتمثل في الحاجة إلى الإرشاد بشكل عام ويقوم البرنامج عادة على مبادئ واعتبارات ضرورية تتمثل في إتباع المناهج الثلاثة (العلاج ، الوقاية ، الإنماء) مما يساعد على توافق الطلاب ونموهم السليم والتخلص من المشكلات المدرسية التي تواجههم وحل المشكلات الناجمة عن ذلك وتقويم الإرشاد المهني والأسري مما يساعد على نجاح العملية التربوية (عزيز سماره، عصام نمر، ١٩٩٢).

إن رابطة علم النفس الأمريكية APA في تعريفها للإرشاد النفسي المدرسي تري بأنه " تلك الخدمة التي تهدف إلى مساعدة الأفراد على اكتساب وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وتحسين المواقف مع مطالب الحياة المتغيرة، وتعزيز مهارات التعامل بنجاح مع البيئة، واكتساب العديد من قدرات حل المشكلات واتخاذ القرار". وانطلاقا من هذا المفهوم يمكن تحديد أهداف الخدمة النفسية المدرسية على النحو التالي:

١ - تنمية مهارات المواجهة:

إن أحد أدوار الإرشاد النفسي المدرسي هو تنمية قدرة الطالب على مواجهة الضغوط النفسية والتسلح ضد القلق في الشدائد الحياتية، فكثير من الطلاب يواجهون عدد من المواقف والضغوط، وقليل منهم من يستطيع أن يتعامل معها، وهنا يبرز دور الخدمة النفسية في تدريب هؤلاء الطلاب على مهارات

المواجهة أو التعامل مع المواقف الضاغطة وإحباطات الحياة اليومية وذلك حتى لا يصبحوا فريسة سهلة للضغوط الشديدة الواقعة عليهم فينتهي بهم المطاف إلى سوء التوافق الشخصي والاجتماعي.

٢ - تنمية المهارات الاجتماعية:

تعد المدرسة نقطة الالتقاء لعدد كبير من العلاقات الاجتماعية المتشابكة المعقدة، وهذه العلاقات هي المسالك التي يتخذها التفاعل الاجتماعي والقنوات التي يجري فيها التأثير الاجتماعي، ويمكن تحليل العلاقات الاجتماعية المركزة في المدرسة على أساس الجماعات المتفاعلة فيها، وأهم هذه المجموعات هي مجموعة الإداريين ومجموعة المدرسين ومجموعة التلاميذ، ونوع العلاقة التي تربط بين هؤلاء الأفراد هي التي تؤثر على مدى توافقهم الاجتماعي، مما ينعكس بدوره على أدائهم المدرسي.

ويعد تحسين العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع المدرسي أحد أهم أهداف الخدمة النفسية المدرسية، إذ أن تحقيق جو نفسي صحي يعد مطلبًا أساسيًا لتحسين العملية التعليمية وهذا بدوره يتطلب تنمية قدرة الطلاب على تفهم الآخرين والتعاطف معهم وتلمس خبراتهم الوجدانية واستيعابها، ولتحقيق ذلك ينبغي تنمية المهارات الاجتماعية لدى الطلاب وتنمية قدراتهم على إدارة العلاقات والتفاعلات مع الآخرين مما يشكل أساس الكفاءة الاجتماعية ويعزز شبكة العلاقات، ويعزز القدرات القيادية ويقوي مشاعر الانتماء للجماعة.

٣ - تنمية القدرة على حل المشكلات:

يتصور الطالب الذي يعاني من مشكلة ما، أن المشكلة التي تؤرقه هي من أعقد المشكلات التي يمكن أن تواجه أحد الأفراد، وأنه قد حاول قدر استطاعته التوصل إلى حل مناسب لها، ولكنه في كل مرة يفشل في الوصول إلى الحل المناسب. وهنا يأتي دور الإرشاد النفسي المدرسي ممثلة في الإخصائي النفسي المدرسي في تدريب الطلاب على مواجهة المشكلات التي تعترض حياتهم، وتنمية قدرتهم على الوصول إلى الحلول المناسبة بتقديم حلول جاهزة. إذ أن هدف الإرشاد النفسي هنا ليس فقط حل المشكلات التي تواجه الطلاب وإنما إعدادهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم في المستقبل، هنا يصبح دور الإخصائي النفسي دور المساعد فقط، فعلى الطالب أن يقترح أنسب الحلول لحل مشكلته في ضوء ما لديه من معلومات ومعطيات،

فالإخصائي النفسي لا يفرض الحل ولا يختاره وإنما يوجه ويرشد عندما يجد أن الطالب يحيد عن الحل الصحيح.

٤ - تنمية القدرة على اتخاذ القرار:

هو أحد أهداف التوجيه والإرشاد النفسي المدرسي، فكل طالب يمر بمرحلة حرجة في حياته تتطلب منه اتخاذ قرارات مصيرية يترتب عليها مستقبله فيما بعد، مثل انتقاله من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية، ففي أي اتجاه يسير ؟ هل يسير نحو التعليم العام أم التعليم الفني ؟ وإذا اختار التعليم الفني فأي منه يناسبه ؟ الصناعي أم التجاري أم الزراعي أم التمريض.. وإذا اختار أي مجال منهم فإلى أي قسم ينتسب؟.. وهكذا، وهناك الكثير من الطلاب الذين يلاقون صعوبات ويحتاجون إلى مساعدة في عملية اتخاذ القرار، ومنهم من تنقصه المعلومات التي يمكنه الاستفادة منها، ومنهم من لديه معلومات ويعجز عن استخدامها، ومنهم من لا يستطيع الاختيار بين البدائل المتاحة، وهكذا فهناك نماذج متنوعة من الطلاب ولكن يجمعهم هدف واحد في النهاية هو رغبتهم في الوصول إلى القرار المناسب في الوقت المناسب.

وهنا يقوم الإخصائي النفسي المدرسي بتدريب الطلاب على أساليب وطرق اتخاذ القرار، ولماذا يتخذ قرار دون غيره، وما يمكن أن يترتب علي اتخاذ قرار ما من خطورة مؤقتة في مقابل مستقبل أفضل، وكيف يستطيع الحصول على المعلومات المتصلة بالموضوع المراد اتخاذ قرار بشأنه، وكيف يقيم الاحتمالات المتوقعة لعدد من البدائل، وأخيرا كيف يستطيع اختيار أنسب الاحتمالات (أي اتخاذ القرار)، وهكذا يتحقق للطالب القدرة على الاستبصار الذاتي الذي يساعده في توجيه ذاته نحو القرار الأفضل.

٥ - تعديل وتغيير السلوك:

يستهدف التوجيه والإرشاد النفسي المدرسي إلى تغيير وتعديل سلوك الطلاب من السلوك اللاسوي غير المرغوب إلى السلوك السوي المرغوب فيه، وذلك من خلال تطويع الإخصائي النفسي المدرسي لنظريات الإرشاد النفسي المختلفة لهذا الغرض، وانتقاء ما يتناسب منها من فنيات لمواجهة المشكلات السلوكية، والنفسية، والسلوكية المتنوعة. إذ أن الهدف من تعديل السلوك تحسين الضبط الذاتي وتطويره من خلال تحسين مهارات الطالب، وقدراته،وامكانياته ومستوى استقلاليته.

٦ - تنمية طاقات الطلاب:

إن أحد الأهداف التي سعى إليها التوجيه والإرشاد النفسي المدرسي هو توفير الفرص المناسبة والملائمة للطلاب لتنمو طاقاتهم وإمكانياتهم لأقصى حد ممكن، فمن خلال الكشف عن قدرات الطلاب وميولهم يمكن توصيلهم إلى الطرق التي يمكن أن يحققوا فيها أعلى مستوى من الكفاءة، هذا إلى جانب توفير السبل والإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف وذلك من خلال التعاون المستمر بين المدرسة ومؤسسات المجتمع الأخرى التي يمكن من خلال توفير الفرص المناسبة لهؤلاء الطلاب لتحقيق ذاتهم ومن ثم تحقيق توافقهم الشخصي والاجتماعي.

وقد حدد (Reynolds, Gutkin , Elliott, & Witt, 1984) أهداف الإرشاد المدرسي في الآتي:

(١) التقويم والتقدير النفسي (الاجتماعي التعليمي) للطلاب وذلك باستخدام إجراءات المراقبة والملاحظة، وتطبيق الاختبارات النفسية والتعليمية، وإجراءات المقابلات الشخصية، والتقويم السلوكي.

(٢) التدخل بهدف توجيه الطلاب ومساعدتهم في أداء وظائفهم وأدوارهم بشكل صحيح، ومحاولة التأثير في الجوانب المعرفية والانفعالية والاجتماعية لهم، وذلك باستخدام أساليب مختلفة منها: التوصيات ، والتخطيط ، وتقويم خدمات التعليم المحددة ، والعلاج النفسي التعليمي ، والإرشاد ، والبرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تحسين المهارات التكيفية لدى الطلاب.

(٣) التدخل بهدف توجيه الخدمات التعليمية، وخدمات رعاية الطفولة، والخدمات الموجهة نحو العاملين في المدرسة وأولياء أمور الطلاب والمجتمع المحلي، وذلك عن طريق برامج التعليم الشخصي داخل المدرسة، وبرامج تعليم الوالدين وإرشادهم.

(٤) الاستشارة والتنسيق مع العاملين في المدرسة والوالدين في الأمور والجوانب المرتبطة بالمشكلات المدرسية.

(٥) تنمية وتطوير البرامج والخدمات للطلاب وإدارة المدرسة والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تصميم برامج إرشادية واجتماعية خاصة بكل فئة من هذه الفئات.

(٦) الإشراف على الخدمات النفسية والإرشادية (صالح أبو عباة ، عبد المجيد نيازي ، ٢٠٠١)

أما محمود توفيق ورضا عنان(١٩٨٩) فقد حدد أهداف الإرشاد المدرسي في النقاط التالية:

(١) مساعدة الطلاب على التحصيل والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من التعليم.

(٢) مساعدة الطلاب على النمو والتغير والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاعتماد على النفس.

(٣) إيجاد علاقات اجتماعية سليمة بين الطلاب وبين العاملين بالمدرسة.

(٤) مساعدة الطلاب على نبذ الاتجاهات الضارة وتدعيم القيم والاتجاهات البناءة، وإكسابهم القيم الجديدة التي يتطلبها بناء مجتمعهم.

(٥) مساعدة المدرسة على نشر خدماتها في المنطقة التي توجد فيها.

(٦) العمل على إيجاد ترابط وتفاهم قوي بين المنزل والمدرسة.

بينما يري فاروق عبد السلام وآخرون (١٩٩٢) أن أهداف الإرشاد المدرسي، يتلخص في النقاط التالية:

(١) مساعدة الأفراد علي فهم أنفسهم أي الفهم الدقيق لقدراتهم وإمكانياتهم وميولهم ورغباتهم الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية.

(٢) توفير المناخ النفسي المناسب لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي.

(٣) تنمية شعور واضح بتقدير وتقبل الذات لديهم.

(٤) تنمية الاستقلال الذاتي لدي كل فرد منهم ومنحه القدرة علي توجيه حياته ضمن إطار القيم والمعايير التي يؤمن بها المجتمع.

(٥) زيادة استبصارهم بمشكلاتهم والعمل علي إزالة التوتر المصاحب لهذه المشكلات ومعاونتهم علي تفريغ انفعالاتهم.

(٦) الإسهام الجاد في تصحيح انحرافاتهم السلوكية وعلاج الطلاب المشكلين.

(٧) التعرف علي أسباب ضعف التحصيل الدراسي لدي فئة من الطلاب ومساعدتهم للتغلب عليها.

مناهج واستراتيجيات التوجيه و الإرشاد المدرسي:

يقوم الإرشاد النفسي بالمدارس على ثلاثة مناهج رئيسية هي:

أولا: المنهج النمائي:

الذي يهدف بالدرجة الأولى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق النمو السوي المتوازن المتكامل، والذي يشمل الجوانب النمائية المختلفة (الجسمية، العقلية، الاجتماعية، النفسية) للطالب حتى يصل إلى أعلى مستوى من النضج والصحة النفسية والسعادة والكفاية، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال مراعاة متطلبات النمو لكل مرحلة تعليمية يمر بها الطالب، لأن النمو السوي يتطلب توفير جميع الوسائل والإجراءات التي تؤدي إلى النمو السليم، هذا إلى جانب استثمار وتنمية قدرات الطالب وطاقاته لأقصى حد ممكن.

كما يهتم المنهج النمائي بدراسة موضوعات مثل العادات والاتجاهات السلبية، ومفهوم الذات، وتعديل السلبيات وتدعيم الإيجابيات، وذلك من خلال البرامج الإرشادية.

ومن الجوانب التي يمكن تنميتها عند الطلاب في هذا الإطار ما يلي:

- برنامج لتنمية الاستقلالية والاعتماد على النفس.
- برنامج لتنمية الدافعية نحو التعليم.
- برنامج لتنمية روح الفريق والقيادة.
- برنامج لتنمية القدرة على التخطيط لشغل أوقات الفراغ.
- برنامج للتدريب على طرق الاستذكار الجيد.

وإلى غير ذلك من البرامج التي تهدف في المقام الأول إلى تنمية الطلاب في كافة جوانب حياتهم.

ثانيا: المنهج الوقائي:

يهدف المنهج الوقائي إلى محاولة منع المشكلة أو الاضطراب، بإزالة الأسباب المؤدية إلى ذلك، كما أنها تعمل على الكشف عن المشكلات السلوكية والانفعالية في مراحلها الأولى مما يسهل التصدي لها ومواجهتها.

ويحدد حامد زهران (١٩٩٨) للمنهج الوقائي ثلاث مستويات، هي:

الوقاية الأولية: وتتضمن محاولة منع حدوث المشكلة أو الاضطراب أو المرض بإزالة أسبابه.

الوقاية الثانوية: وتتضمن محاولة الكشف المبكر وتشخيص الاضطراب في مرحلته الأولى بقدر الإمكان للسيطرة عليه ومنع تطوره وتفاقمه.

الوقاية من الدرجة الثالثة: وتتضمن محاولة تقليل الآثار الناتجة عن حدوث الاضطراب أو المشكلة.

ويركز الإخصائي النفسي على ثلاثة جوانب وقائية في إطار حماية الطلاب من الوقوع فريسة للاضطرابات السلوكية والنفسية وهي:

الوقاية الصحية: وتتضمن الاهتمام بالصحة العامة للطلاب والكشف الدوري عليهم وتحصينهم ضد الأمراض الوبائية.

الوقاية النفسية: وتتضمن رعاية النمو النفسي السوي وتنمية الذات الواقعية، وتزويد الطلاب بالوسائل المتنوعة التي تعينه على تحقيق مطالبه في المراحل العمرية المختلفة.

الوقاية الاجتماعية: تتضمن تكوين اتجاهات إيجابية نحو المجتمع المدرسي، وتنمية المهارات الاجتماعية التي تسهم في التفاعل السوي بين الطالب والمحيطين به.

ويتضح مما سبق أن المنهج الوقائي يركز على الجانب التطبيقي من حيث حماية الطلاب من معاناة الاضطراب أو المشكلة عن طريق:

- معرفة الأسباب التي تؤدي إلى المشكلة وإزالتها.
- حماية الأفراد من المشكلات أو تقليل آثارها إذا حدثت.

ولتحقيق أهداف المنهج الوقائي في الإطار المدرسي توجد بعض الوسائل والتي تتمثل في الخدمات التربوية، والتي تهتم بتحديد مشكلات التعليم المرتبطة بالمدرسة، والمنهج الدراسي ونظام الامتحانات، والمشكلات السلوكية، والاضطرابات الانفعالية، والمشكلات الاجتماعية، وكذلك المرتبطة بالقدرات العقلية والاستعدادات والميول والاتجاهات والمشكلات المرتبطة بالمناخ المدرسي والتفاعل بين المعلم والمتعلم..الخ.

وتتمثل الإجراءات الوقائية بتوفير شروط الصحة النفسية السوية في البيئة المدرسية عن طريق:

(١) تحديد حاجات الطلاب والاهتمام بدراسة مشكلاتهم عند ظهورها.

(٢) توفير الجو القائم على التعاون والديمقراطية.

(٣) إتاحة الفرص أمام الطلاب للتعبير عن مشاعرهم وشخصياتهم.

ومن مجالات الإرشاد الوقائي المدرسي تبصير الطلاب بالآثار التي يتعرض لها الطالب في بعض النواحي مثل:

- التوعية من أضرار الإدمان والتدخين.
- التوعية من أضرار السلوك العنيف.
- التوعية من مسايرة رفاق السوء.

ثالثا: المنهج العلاجي:

تظهر الحاجة للمنهج العلاجي نتيجة لعدة أسباب هي:

(١) أن الخدمات والجهود التي تقدم من خلال المنهج النمائي أو المنهج الوقائي مهما تنوعت أو زادت كفاءتها لا يمكن أن تفي بكل حاجات الطلاب ذلك لأنها قد لا تصل إلى البعض منهم، أو أنها متوفرة ولكن الطلاب لا يستفيدون منها بشكل أو بأخر.

(٢) توجد تغيرات بيولوجية وفسيولوجية واجتماعية تجعل الطلاب عرضة لأزمات وفترات حرجة في مواقف متعددة وفترة زمنية متباينة.

(٣) من الصعب التنبؤ ببعض المشكلات و الاضطرابات فتحدث بالفعل.

ويهتم المنهج العلاجي بنظريات الاضطراب والمرض النفسي وأسباب وتشخيص وطرق علاجه. فهو يتعلق بمعالجة المشكلات و الاضطرابات التي يتعرض لها الطلاب وذلك لتحقيق حالة من التوازن بين جوانب النمو المختلفة لتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي، ويتم تحقيق هذا الهدف بدراسة أسباب المشكلات وأعراضها وطرق علاجها.

ويتم إرشاد الطلاب وفق ما هو متعارف عليه بين الجماعة التي يعيش معها الطالب بما يحقق له الرضا والصحة النفسية، وذلك بهدف زيادة إنتاجه وتحقيق ذاته وتوافقه مع جوانب الحياة المختلفة النفسية والاجتماعية والتربوية.

ومن بين البرامج العلاجية التي يمكن للإخصائي النفسي المدرسي ممارستها والمشاركة بها داخل الإطار المدرسي ما يلي:

- برنامج لمواجهة المخاوف المرضية (من المدرسة _ الحيوانات _ الطيور _ الظلام _ الأماكن المرتفعة _ الأماكن الضيقة.. وغيرها) من المخاوف الأخرى.
- برنامج لمواجهة مشكلة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم.
- برنامج لمواجهة قلق الامتحانات.
- برنامج لمواجهة مشاكل الأسرة.

- برنامج لمواجهة مشكلة الكذب.
- برنامج لمواجهة السلوك العدواني
- برنامج لمواجهة تخريب الممتلكات المدرسية
- برنامج لمواجهة الشعور بالوحدة النفسية.
- برنامج لمواجهة ضعف العلاقات الاجتماعية.
- برنامج لمواجهة نقص الانتباه والنشاط الزائد.
- برنامج لمواجهة عدم الانضباط في حجرة الدراسة.
- برنامج لمواجهة العزلة والانسحاب.
- برنامج لمواجهة التدخين وإدمان المخدرات.
- برنامج لمواجهة عدم القدرة علي اتخاذ القرار.

الفصل السادس

القائمين على الإرشاد في المدرسة

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على أدوار فريق التوجيه و الإرشاد بالمدرسة
  - مدير المدرسة
  - الأخصائي الاجتماعي
  - معلم التعليم العام
  - معلم التربية الخاصة
  - المرشد الطلابي
  - أولياء الأمور
  - الطالب
  - الأخصائي النفسي المدرسي

الفصل السادس

القائمين على الإرشاد في المدرسة

فريق الإرشاد بالمدرسة:

مما لا شك فيه أن الإرشاد النفسي المدرسي مسؤولية جماعية يتحملها فريق متكامل يضم مدير المدرسة، والإخصائي النفسي، والإخصائي الاجتماعي، والمعلمين، وأولياء الأمور وأخيرا الطلاب الذين هم محور الخدمة النفسية، فالخدمة النفسية المدرسية هي مسؤولية جميع أعضاء الفريق، فهو عمل جماعي يستهدف تحقيق أهداف برنامج التوجيه والإرشاد بحيث يعمل كل عضو في الفريق في مجال تخصصه، فهو عمل تعاوني يقوم على احترام كل فرد لحدود اختصاص الآخرين، والحرص على العلاقة المهنية السليمة معهم وتقديم المساعدات والمشورة المرتبطة بتخصصه إلى باقي زملائه حرصًا على تحقيق الأداء الشامل والمتكامل.

لتي يقوم بها الإخصائي الاجتماعي كأحد أفراد فريق الخدمة النفسية على النحو التالي:

(١) إعداد دراسة الحالة في نطاق المنزل من خلال فحص العلاقات المتبادلة داخل نطاق الأسرة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر والضغوط على الطالب.

(٢) المشاركة في تقديم المشورة في إطار مؤتمر الحالة كأحد أعضاء فريق الإرشاد مع التركيز على تأثير البيئة المحيطة على سلوك الطالب.

(٣) تقديم المساعدة في إحالة الطالب إلى المؤسسات الاجتماعية والصحية والتي يمكن أن يستفيد من الخدمات المقدمة فيها.

(٤) العمل على تغيير أو تعديل الظروف البيئية التي تحيط بالطالب والتي كانت سببا في حدوث خبرات مؤلمة له أثرت على استجاباته السلوكية.

(٥) المشاركة في الأنشطة الجماعية بالمدرسة، والتي تعمل على إشباع حاجات الطلاب للانتماء والمواطنة والمشاركة السياسية.. وغيرها من الحاجات النفسية والاجتماعية الأخرى.

(٦) تقديم بعض الخدمات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة (البصرية، السمعية، الجسمية.. وغيرها) بتوفير بعض الأجهزة المعينة التي يحتاجون إليها من خلال الاتصال بالمراكز الطبية والتأهيلية والمؤسسات الخاصة التي يمكنها توفير ذلك بالمجان أو بأسعار رمزية تكون في متناول الجميع.

(٧) المشاركة في الإرشاد الجماعي والإرشاد الأسري وإرشاد بعض حالات الجناح وسوء التوافق الاجتماعي وحل المشكلات الاجتماعية.

(٨) المحافظة على مواظبة التلاميذ والحد من تكرار الغياب عن المدرسة أو التأخر عن طابور الصباح.

معلم التعليم العام:

إذا جاز أن نشبه أعضاء الإرشاد النفسي المدرسي بسلسلة متصلة الحلقات فالمعلم هو الحلقة التي تصل بين الطلاب وباقي فريق الخدمة النفسية، فهو أقرب شخص للطلاب في المدرسة وهو النموذج الذي يقتدون به، وخاصة إذا اتسمت علاقتهم به بالصداقة والمودة والدفء، فإن ما يشعر به الطلاب من سمات تميز شخصية معلمهم تتبلور من خلال التفاعل اليومي بينهم. ولذلك فإن الدور الذي يلعبه المدرس في فريق الخدمة النفسية بمثابة الوقود الذي يحرك الخدمة النفسية ويدفعها للأمام والذي بدونه يصعب القيام بها، والذي لن يتحقق أيضا بدون أن يقوم بالأدوار التالية:

(١) الاحتفاظ بسجل لكل طالب يتضمن بيانات عن الاختبارات التي أجريت له ودرجاته في كل اختبار وملاحظته على سلوكه.. وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على استيفاء السجل المجمع.

(٢) المساعدة في الكشف عن الطلاب ذوي المشكلات التربوية والنفسية والسلوكية وإحالتهم إلى الإخصائي النفسي.

(٣) تحفيز الطلاب على الاتصال بالإخصائي النفسي المدرس وتعريفهم بالدور الذي يقوم به للاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد التي يمكن أن يقدمها لهم.

(٤) المساعدة في تطبيق الاختبارات والمقاييس النفسية والعقلية والتربوية والاستفادة من نتائجها في التعامل مع الطلاب.

(٥) المساعدة في إعداد دراسة الحالة والاشتراك في مؤتمر الحالة وملاحظة سلوك الطلاب وتقديم التقارير للأخصائي النفسي عن الحالات التي تتطلب ذلك.

(٦) المشاركة في ممارسة خدمات التوجيه الجمعي، وفي تنمية مهارات الاستذكار، وأنشطة التقويم الذاتي.. وغيرها.

(٧) مساعدة الطلاب على وضع الأهداف لأنفسهم بما يتفق وقدراتهم واستعداداتهم وميولهم مما يهيئ لهم التوافق السليم.

(٨) تنفيذ دوره في إطار برامج رعاية الطلاب المتأخرين دراسيا وذوي صعوبات التعلم.

(٩) تقديم الدعم والتعزيز للطلاب المتفوقين والموهوبين في إطار البرامج التي تهتم برعايتهم وتنميتهم.

(١٠) مساعدة فريق الخدمة النفسية على تنفيذ المقترحات والبرامج التي تم إعدادها للطلاب في إطار الإرشاد النمائي والوقائي.

(١١) الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي يقوم بإعدادها الإخصائي النفسي المدرسي عن المشكلات السائدة في المدرسة وكيفية مواجهتها.

(١٢) المساهمة في تقويم برامج الخدمة النفسية وتحديد جوانب القوة والضعف لرفع كفاءة خدمات التوجيه والإرشاد بالمدرسة.

معلم التربية الخاصة:

من المعلوم أن معلم التربية الخاصة يقوم بنفس الدور الذي يقوم به معلم التعليم العام، غير أنه يضاف إليها العديد من المهام التي تختلف باختلاف نوع الإعاقة التي يعاني منها ذوي الإحتياجات الخاصة، ومن بين هذه المهام ما يلي:

(١) تقديم المساعدة للتلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة للتغلب علي المشكلات المترتبة عن الإعاقة.

(٢) إكساب التلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة معلومات ومعارف حول المعينات السمعية والبصرية والتقنيات الحديثة ومساعدتهم علي الاستفادة من تلك المعينات لتقليل من أثر الإعاقة.

(٣) إكساب التلاميذ مهارات تواصلية واجتماعية. تمكنهم من تحقيق النجاح علي الصعيد المدرسي والاجتماعي.

(٤) التنسيق مع أعضاء فريق الخطط التربوية في إعداد وتنفيذ تلك الخطط بطريقة منظمة ودقيقة.

(٥) تقديم المعلومات الكاملة لمعلمي الفصول العادية فيما يتعلق بكيفية تدريس المواد الدراسية والاستراتيجيات التعليمية وتأدية الاختبارات ووضع الدرجات وكتابة التقارير وفهم

الأسس السليمة لكيفية التعامل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة داخل وخارج الفصل، وتزويدهم بالكتيبات والمنشورات والوسائل التعليمية التي تساعدهم في التعرف علي مفاهيم التربية الخاصة.

(٦) تدريس التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة المهارات الموضحة في الخطة التربوية الفردية والتي لا يستطيع معلم الفصل العادي القيام بها.

(٧) المشاركة في القياس والتشخيص وذلك عن طريق تنفيذه في فترة الملاحظة بغرض التوصل إلي تحديد الاحتياجات الأساسية لكل تلميذ.

(٨) ينبغي علي معلم التربية الخاصة الاشتراك في إجراء الأبحاث والدراسات، والدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال تخصصه.

(٩) تدعيم وتقوية التعاون بين أسر التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والمسئولين في المدرسة.

(١٠) توفير بيئة أكاديمية واجتماعية ونفسية يستطيع فيها التلاميذ العاديون وغير العاديين، علي حد سواء، لاستغلال كافة القدرات وتحقيق أسمي الطموحات.

(١١) الاهتمام بمشاركة التلاميذ ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة في الأنشطة الصفية واللاصفية.

(١٢) تقديم المساعدة لأولياء الأمور للتعرف علي الآثار النفسية والاجتماعية للإعاقة وتزويدهم بالمواد التربوية، والوسائل التعليمية التي تعمل علي تيسير مهمة متابعة واجبات أبنائهم المدرسية، والمساهمة في زيادة معرفتهم بخصائص واحتياجات وحقوق وواجبات أبنائهم، وإكسابهم المعارف حول الخدمات المتوفرة بالمجتمع.

المرشد الطلابي:

للمرشد الطلابي العديد من الأدوار التي يقوم بها، ومن بينها ما يلي:

(١) متابعة حالات الطلاب التحصيلية وتقديم الخدمات الإرشادية لهم.

(٢) التعرف علي الطلاب المتفوقين والموهوبين والمتأخرين دراسيًا والطلاب الذين لديهم تفاوت في التحصيل الدراسي لاتخاذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بتلبية احتياجات كل منهم بالتعاون مع ذوي الاختصاص.

(٣) التعرف على الأحوال الأسرية للتلاميذ وخاصة الاقتصادية منها ومساعدة ذوي المستويات الدنيا عن طريق الصندوق المدرسي.

(٤) دراسة الحالات الفردية للذين تظهر عليهم بوادر سلبية في السلوك وتفهم مشكلاتهم.

(٥) الاتصال والتعاون مع المدرسين بشكل عام ورواد الفصول بشكل خاص وكذلك عمداء الأسر والمشرفين الاجتماعيين في حالة المعاهد التي توجد بها أقسام داخلية لجمع المعلومات عن التلميذ المراد دراسة حالته.

(٦) توعية المجتمع المدرسي بأهداف التوجيه والإرشاد وخططه وبرامجه وخدماته بشكل عام وفي مجال التربية الخاصة بشكل خاص.

(٧) تعبئة السجل الشامل للتلميذ والمحافظة علي سريته وتنظيم الملفات والسجلات الخاصة بالتوجيه والإرشاد.

(٨) تدريس ما يسنده إليه مدير المدرسة من حصص والمشاركة في أعمال المراقبة وشغل حصص الانتظار.

(٩) المشاركة في البحوث والدراسات والدورات والندوات والمؤتمرات في مجال تخصصه.

الطبيب:

يعتبر الطبيب أحد أعضاء فريق الإرشاد النفسي بالمدرسة، إذ يمثل وجوده ضمن هذا الفريق ضرورة ملحة لتقديم الخدمات الطبية على المستويين الوقائي والعلاجي، ومن المعلوم أنه يوجد الآن بمعظم المدارس طبيب - ممارس عام - يقدم الخدمات الطبية للطلاب وهو المسئول عن تحويل الحالات إلى المتخصصين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويتحدد دور الطبيب في إطار عضويته في فريق الخدمة النفسية على النحو التالي:

(١) إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وخاصة المحالين إليه من الإخصائي النفسي.

(٢) المساهمة في البرامج النمائية والوقائية لنشر التوعية الطبية بين الطلاب.

(٣) الاشتراك مع الإخصائي النفسي في تحويل الطلاب الذين يعانون من مشكلات نفسية _ إذا دعت الضرورة _ إلى الطبيب النفسي بأحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحي المدرسي.

(٤) المساعدة مع فريق الإرشاد النفسي بالمدرسة في إجراء دراسة الحالة وذلك بإجراء الفحوص وإعداد التقارير الطبية الخاصة بالطلاب.

(٥) التعاون مع فريق الإرشاد النفسي في مؤتمر الحالة الخاص بأحد الطلاب ذوي المشكلات النفسية أو السلوكية لرسم صورة متكاملة عن تلك الحالة.

أولياء الأمور:

يلعب أولياء الأمور دورا هاما في فريق الإرشاد النفسي بالمدرسة، حيث يتعاظم دورهم في تزويد باقي أعضاء فريق الإرشاد النفسي بالمعلومات والبيانات عن أبنائهم الطلاب والتي تساعدهم في تشخيص حالتهم، ورسم الاستراتيجيات الإرشادية المناسبة لمساعدتهم، كما أنهم أيضا يلعبون دورا حيويا في تقديم الخدمة الإرشادية لأبنائهم من خلال المشورة التي تقدم لهم من باقي أعضاء الفريق عن أنسب الأساليب التي يمكن أن يتعاملوا بها مع أبنائهم من خلال البرامج الإرشادية، هذا إلى جانب دورهم في دعم البرامج التنموية والوقائية التي تقدم لأبنائهم، ولذلك فإن الدور الملقي على عاتق أولياء الأمور لا يمكن إغفاله مما يستوجب معه إيجاد قنوات اتصال دائمة معهم. وذلك للقيام بأدوارهم في تقديم الخدمة النفسية، من منطلق عضويتهم كشركاء أساسين في فريق الإرشاد المدرسي، والتي من بينها ما يلي:

(١) التعاون مع الإخصائي النفسي في الإدلاء بمعلومات صادقة وموضوعية عن الطالب بما يفيد في رسم صورة متكاملة الجوانب عن حالته للكشف عن الجوانب الغامضة لتحديد المشكلة وتخطيط البرامج الإرشادية.

(٢) تلبية دعوة الإخصائي النفسي لحضور الندوات واللقاءات للتعرف على الخدمات التي يمكن تقديمها لأبنائهم ولهم عبر البرامج الإرشادية النمائية، والوقائية، والعلاجية.

(٣) الاستعداد لتقديم المساعدة إذا طلب منهم ملاحظة سلوك ابنهما خلال فترات معينة في المنزل أو أثناء لعبه مع أخواته وأقرانه، أو أثناء تفاعله مع الأقارب حتى يمكن التعرف على الأسباب التي تقف وراء اضطرابه.

(٤) المساهمة بدور فعال وإيجابي في حالة ما إذا كان ابنهما يعاني من صعوبات تعلم أو تأخر دراسي في إطار البرنامج العلاجي المحدد لمساعدته.

(٥) تقديم الدعم والتشجيع لأبنائهم الموهوبين والمتفوقين في إطار رعايتهم وتنميتهم وذلك من خلال توفير الإمكانات اللازمة التي تصقل مواهبهم الخاصة.

(٦) يتعاظم دور أولياء الأمور في فريق الخدمة النفسية في حالة كون ابنها ذا إعاقة (سمعية، أو بصرية، أو عقلية، أو جسمية)، حتى يتثنى لهم الإلمام بطبيعة الإعاقة وأسبابها وطرق التعامل مع الطفل وكيفية تقديم المساعدة له للتغلب على مشكلاته ولإشباع حاجاته بما يسهم في إحداث التوافق الشخصي والاجتماعي له.

الطالب:

قد يعتقد البعض أن دور الطالب في فريق الإرشاد النفسي هو دور المتلقي للخدمة الإرشادية فقط دون أن يسهم في فعاليات برامج التوجيه والإرشاد. غير أن ذلك مخالف للواقع، فبدون التفاعل الإيجابي للتلميذ سوف تفشل كل الجهود التي تبذل من أجله، فإذا لم يبدي التلميذ التعاون والمشاركة لأعضاء الإرشاد النفسي بالمدرسة فسيصبح لا طائل لما يقدم له من خدمات إذ لم تكن لديه الرغبة الصادقة في حل مشكلاته. ويتحدد دور الطالب في إطار عضويته في فريق الخدمات النفسية على النحو التالي:

(١) ينبغي على الطالب أن يعترف بوجود مشكلة تؤرقه وتسبب له اضطرابًا ما يؤثر عليه وعلى الآخرين من حوله، ويشعر أيضا بأن من واجبه أن يتحمل حلها مع باقي أعضاء فريق الخدمة النفسية.

(٢) ينبغي على الطالب أن يستفيد من الأنشطة والبرامج التي تقدمها له برامج الخدمة النفسية المدرسية في إطار الإرشاد النمائي والوقائي.

(٣) يجب على الطالب أن يستجيب بصدق لكل ما يسأل عنه أثناء المقابلة أو عند أدائه لبعض الاختبارات والمقاييس التي تطبق عليه، وذلك حتى يسهل تقديم الخدمة الإرشادية والتوجيهية المناسبة له.

(٤) يجب على الطالب أن يقبل العلاقة الإرشادية مع أعضاء فريق الخدمة النفسية وأن يضع ثقته فيهم، وأن تبنى تلك العلاقة على أساس من التقبل والفهم والاحترام المتبادل والتعاون الصادق.

(٥) ينبغي على الطالب أن يبذل أقصى جهد في اقتراح الحلول المناسبة لمشكلته، وأن يمارس حقه في اتخاذ قراراته بنفسه.

(٦) ينبغي على الطالب أن يشارك في تقييم برامج الخدمة النفسية التي تقدم له في المدرسة واقتراح ما يؤدي إلى تحسين تلك البرامج.

الإخصائي النفسي المدرسي:

لقد أصبح دور الإخصائي النفسي المدرسي حيويًا وهامًا، فلا تكاد تخلو مدرسة في دول العالم المتقدم من الإخصائي النفسي أو ما يعرف أحيانا بالمرشد النفسي، وذلك إيمانًا منها بالدور الذي يقوم به في المساهمة في نمو الطلاب من كافة الجوانب بدءا من النواحي التربوية إلى الاهتمام بالجوانب الانفعالية والعقلية والاجتماعية بهدف تخريج مواطن صالح للمجتمع لا يعاني من الاضطرابات الانفعالية والانحرافات السلوكية، إلى جانب الدور الذي يقوم به لرعاية الموهوبين والعناية بذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وإذا كان الإخصائي النفسي عضو في فريق الخدمة النفسية المدرسية، إلا أنه بمثابة العقل الواعي الذي ينظم حركة الأعضاء ويوجهها نحو تحقيق الهدف المنشود، وفي هذا الإطار فإن دور الإخصائي النفسي الذي يقوم به في المدرسة يتحدد على النحو التالي:

أولا: التوجيه والإرشاد التربوي:

يعتبر الإرشاد والتوجيه التربوي أحد الأدوار البارزة التي يقوم بها الإخصائي النفسي المدرسي، والتي من خلالها يقدم للطلاب العديد من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع البيئة المدرسية. وذلك من خلال قيامه بالأدوار التالية:

(١) يقوم باستقبال الطلاب الجدد مع بداية كل مرحلة تعليمية جديدة (ابتدائي _ إعدادي _ ثانوي) وذلك لتعريفهم بطبيعة المرحلة التعليمية التي سوف يدرسون بها وتوضيح القوانين واللوائح التي تنظم العمل بالمدرسة والإجراءات المتبعة في تنظيم الحضور والغياب وتزويدهم بجدول الحصص وتعريفهم بأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية بالمدرسة.

(٣) يشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المدرسية المتنوعة وفقا لقدرات وميول كل طالب منهم بما يساعدهم على الاندماج مع زملائهم وتفريغ طاقاتهم الجسمية في أنشطة وهوايات مفيدة.

(٤) يساعد الطلاب على اختيار نوع الدراسة التي تلائم استعداداتهم وقدراتهم وميولهم ومستواهم التحصيلي وخاصة في المراحل التعليمية التي يسمح فيها بالاختيار بين

البدائل، ففي المرحلة الثانوية مثلا يساعد الطالب على الاختيار بين المجموعة الأدبية والمجموعة العلمية، وفي المدارس الصناعية والتجارية والزراعية يساعدهم أيضا على الاختيار بين الأقسام المختلفة وذلك من خلال تطبيق الاختبارات والمقاييس التي يمكن من خلالها تصنيفهم، وإعداد الكتيبات التي تحوي نظام كل شعبة أو قسم والمواد التي تدرس فيه وطبيعة هذه المواد وما تتطلبه من قدرات واستعدادات خاصة.

(٥) يقوم بعمل سجل مجمع لكل طالب، يتضمن بيانات أولية عن الطالب وبيانات أسرية وصحية ودراسية ومستواه التحصيلي في السنوات السابقة، وينتقل هذا السجل المجمع مع الطالب من فرقة دراسية إلى أخرى ومن مرحلة تعليمية إلى التي تليها وذلك للاستفادة منه في توجيه الطالب مع إضافة أي بيانات تستجد على الطالب أولا بأول.

(٦) يقوم بمتابعة حالات الغياب والتأخر الصباحي وذلك من خلال الإطلاع المستمر على سجلات الحضور والغياب وسجلات التأخر اليومي للطلاب، ومناقشة هؤلاء الطلاب في الأسباب التي تدفعهم لذلك لوضع الحلول المناسبة لتجنب ذلك في المستقبل.

(٧) يقوم بمساعدة الطلاب في وضع الخطط التي تعاونهم على تقويم تحصيلهم الدراسي وتشخيص معوقات تعليمهم وإنجازاتهم في المدرسة. وغير ذلك من الجوانب لتحقيق الرضا عن الأداء.

ثانيا: التقدير النفسي:

يعد التقدير النفسي أحد الأدوار المتميزة التي يلعبها الإخصائي النفسي بالمدارس، وفي سبيل تحقيق هذا الدور يستخدم الاختبارات والمقاييس المتنوعة، ووسائل جمع معلومات من مقابلة، وملاحظة، ودراسة حالة، وبطاقة مجمعة، وسيرة ذاتية. وغيرها من الوسائل التي تعينه على جمع أكبر قدر من المعلومات الموثوق بها لتوظيفها في إعطاء تفسيرات دقيقة عن الطالب.

وأثناء قيام الإخصائي بهذا الدور قد ينزعج الطلاب لتطبيق الاختبارات النفسية عليهم وجمع هذه المعلومات عنهم لأن في ذلك تهديد لخصوصيتهم، ولذلك فمن الضروري أن يتعرفوا على الهدف من جمع المعلومات وأن ذلك بغرض مساعدتهم. وأن من بين تلك المساعدات التي يقدمها الإخصائي النفسي لهم في إطار هذا الدور الذي يقوم به ما يلي:

(١) تقديم المساعدة للطلاب في الكشف عن قدراتهم العامة واستعداداتهم الخاصة مما يمكنهم من التعرف عليها، واستغلالها في كافة المجالات سواءً الرياضية أو الفنية أو الموسيقية أو الميكانيكية.. وغيرها.

(٢) تقديم المساعدة للطلاب في التعرف على ميولهم الأكاديمية والمهنية ومدى مطابقتها لقدراتهم واستعداداتهم الفعلية.

(٣) تقديم المساعدة للطلاب في التعرف على مستواهم التحصيلي للوقوف على نقاط القوة وتنميتها وجوانب الضعف وعلاجها.

(٤) تقديم المساعدة للطلاب في التعرف على اتجاهاتهم نحو القضايا و الموضوعات المختلفة، كاتجاهاتهم نحو المعلمين، وكذلك اتجاهات الآخرين نحوهم كما يدركونها كالاتجاهات الوالدية، واتجاهات الجنس الآخر.. وغيرها من الاتجاهات المؤثرة في تحقيق توافقهم الشخصي والاجتماعي.

(٥) تقديم المساعدة للطلاب في التعرف على المشكلات النفسية الكامنة لديهم كالمخاوف المرضية أو القلق، أو الشعور بالوحدة النفسية، أو الشعور بالذنب وغيرها من الاضطرابات التي قد تهدد أمنهم وسلامتهم النفسية.

ثالثا: الاستشارات النفسية:

الإخصائي النفسي المدرسي هو المسئول الأول عن تقديم الخدمة النفسية في المدارس، فهو يساعد الطلاب على التغلب على مشكلاتهم المدرسية، ومشكلات أقرانهم ومعلميهم، ومشكلات الاستذكار، ومشكلات الرضا عن الذات، والمشكلات السلوكية والمشكلات النفسية ومشكلات سوء التوافق.. وغيرها من المشكلات العديدة، ولا يقف دور الإخصائي النفسي عند تقديم الخدمة النفسية للطالب بل يمتد بيد المساعدة للمعلمين وإدارة المدرسة لمعاونتهم على أداء عملهم والرضا عنه وتحقيق جو من الألفة والمودة بين بعضهم البعض، وبينهم وبين الطلاب وذلك من خلال تهيئة المناخ المدرسي الملائم للعمل والإنجاز.

ومن خلال هذا الدور _ الاستشارات النفسية _ يقدم الإخصائي النفسي خدماته في إطار مناهج الخدمة النفسية النمائية والوقائية والعلاجية لتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي للطلاب. وذلك على النحو التالي:

١ - **في إطار الدور النمائي:** يقوم الإخصائي النفسي بمساعدة الطلاب على تكوين عادات واتجاهات وقيم إيجابية نحو العلم والعمل ويعمل أيضا على تنمية المهارات الذاتية والاجتماعية التي تعينهم على مواجهة الحياة في عصر العولمة.

٢ - **في إطار الدور الوقائي:** يقوم الإخصائي النفسي بإعداد البرامج الإرشادية للوقاية من المشكلات النفسية والسلوكية التي قد يقع فيها الطلاب عادة في المراحل العمرية المختلفة من خلال محاولة الكشف المبكر عن هذه المشكلات لمواجهتها بما يحقق في النهاية مبادئ التوعية الوقائية.

٣ - **في إطار الدور العلاجي:** يقوم الإخصائي النفسي بإعداد البرامج العلاجية لمواجهة بعض الاضطرابات النفسية والسلوكية التي يعاني منها بعض الطلاب بالفعل وخاصة تلك الاضطرابات البسيطة التي يمكن علاجها في ظل الدور العلاجي المحدد الذي يقوم به الإخصائي النفسي.

٤ - **أما في إطار أعمال الإحالة:** فإنه إذا لم يتمكن الإخصائي النفسي من التعامل مع حالة الطالب، يتم إحالته إلى الجهات المختصة سواء كانت في مجال الخدمة الطلابية أو في مجال الصحة العامة أو الصحة النفسية، وذلك مع كتابة تقارير مفصلة عنه يوضح فيها الخطوات التي اتخذت لإرشاده وأسباب عدم التمكن من الاستمرار معه، مع ضرورة متابعة الحالة بعد إحالتها والوقوف على ما حققه من نجاح في التغلب على مشكلته.

رابعا: مساعدة إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس:

الإخصائي النفسي هو أحد أعضاء الفريق المدرسي وله دور بارز في تلك المنظومة على عكس ما قد يتصوره البعض وذلك بما يقدمه من خدمات في مجال التوجيه والإرشاد التربوي والنفسي يكون لها عظيم الأثر في تهيئة مناخ العمل المدرسي. ومن بين تلك الخدمات التي يقدمها الإخصائي النفسي لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية بالمدرسة ما يلي:

(١) يقوم الإخصائي النفسي المدرسي بدور استشاري لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية بالمدرسة فيما يتعلق بالمشكلات التربوية والنفسية التي تواجه بعض الطلاب.

(٢) يشارك إدارة المدرسة في التخطيط لكل جوانب العمل المدرسي وذلك بدءًا من تحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم بالمدرسة وفقا لإمكانات المدرسة المتاحة، إلى توزيع هؤلاء الطلاب في الفصول الدراسية وفقا لقدراتهم الفعلية وخصائصهم النفسية.

(٣) يشترك مع إدارة المدرسة في وضع الحصص الدراسية وذلك لضمان توزيع المواد وفقا للأسس النفسية والتي تأخذ في الاعتبار طبيعة تلك المواد وطول اليوم الدراسي وزمن كل حصة وعلاقة كل ذلك بخصائص الطلاب الفعلية و التحصيلية، وكذا أعمارهم الزمنية.

(٤) يمد إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمعلومات عن الخدمات التي يمكن أن يقدمها مكتب الخدمة النفسية للطلاب من خلال برنامج التوجيه والإرشاد التربوي والنفسي حتى ينقلوا بدورهم صورة عن تلك الخدمات للطلاب داخل الفصول.

(٥) يعقد اجتماعات دورية (نصف شهرية _ شهرية _ فصلية) مع إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس لمناقشة بعض المشكلات المدرسية، مثل: الهروب من المدرسة، والتأخر الصباحي، والفوضوية وعدم الترتيب، والمشكلات الصفية الأكاديمية.. وغيرها والتي قد تصل إلى حد الظاهرة في بعض المدارس مما يستوجب معه مواجهتها وذلك للتعرف على الأسباب ووضع الحلول المناسبة للحد منها.

(٦) يتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في حل مشكلات الطلبة المتأخرين دراسيًا أو من يعانون من صعوبات تعلم.. وغيرها من المشكلات ذات الصلة، وذلك بداية من تحديد أسباب المشكلة حتى وضع الحلول المناسبة لمواجهتها.

خامسا: توجيه وإرشاد أولياء الأمور:

يتعاظم دور الإخصائي النفسي المدرسي مع أولياء الأمور، فهو بمثابة الجسر الذي يربط بين المدرسة والمنزل.. فمن خلال تعاونه مع أولياء الأمور يمكنه أن يزيل التصورات الخاطئة التي تشوب العلاقة بين المدرسة والمنزل، إذ قد يتصور بعض الآباء أن المدرسة لا تطلب منهم الحضور لمجالس الآباء إلا لتقديم المساعدة المادية والعينية لها لدعم الخدمات المدرسية، أو أن أي اتصال يأتي إليهم من المدرسة يعني أن أبناءهم قد تسببوا في مشكلة ما تستدعي حضورهم.. ولغير ذلك من التصورات التي تجعل أولياء الأمور يحجموا عن التعاون مع

المدرسة، وهنا يأتي دور الإخصائي في الكشف عن الدور الذي تقوم به المدرسة والخدمات التربوية والإرشادية التي يقدمها مكتب الخدمة النفسية لتقديم الدعم النفسي لهم ولأبنائهم ولن يتأتى للأخصائي النفسي القيام بهذا الدور إلا من خلال إيجاد قنوات اتصال بينه وبين المنزل سواء من خلال المكالمات التليفونية، أو اللقاءات، أو الندوات، أو الجلسات الإرشادية. وغيرها من وسائل الاتصال. وذلك للقيام بواحد أو أكثر من الأدوار التالية:

(١) عقد ندوات ومحاضرات مع أولياء الأمور لتعريفهم بطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها أبناؤهم ومطالب تلك المرحلة وكيفية التعامل السليم معهم من خلال تعرفهم على الأساليب السوية و اللاسوية في المعاملة الوالدية.

(٢) تقديم المعلومات والبيانات لأولياء الأمور التي تتعلق بتحصيل أبنائهم الدراسي واختباراتهم النفسية وحالاتهم الصحية وسيرتهم السلوكية داخل المدرسة.

(٣) توجيه نظر أولياء الأمور نحو أبنائهم ممن يتمتعون بقدرات عقلية ومهارية خاصة، وذلك للعمل على إتاحة الفرص المناسبة أمامهم لتنميتها.

(٤) عقد لقاءات مع أولياء الأمور يقدم من خلالها الإخصائي النفسي كتيبات ونشرات تحتوي على طبيعة الخدمات الإرشادية المدرسية التي يمكن تقديمها لأبنائهم وكيفية الاستفادة منها.

(٥) تشجيع أولياء أمور الطلاب الذين يعانون من مشكلات أو يحتاجون إلى خدمات نفسية من نوع خاص على المشاركة في البحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء معاناة أبنائهم ودورهم في مساعدتهم في التغلب عليها.

(٦) يناقش مع أولياء الأمور في لقاءات مفتوحة كيفية مساعدة أبنائهم الطلاب على اتخاذ القرارات الهامة بشأن التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

سادسا: فتح قنوات اتصال بالمجتمع المحلي:

لا ينحصر دور الإخصائي النفسي داخل أسوار المدرسة وإنما يتعدى ذلك المحيط من خلال انفتاحه على البيئة المحيطة بما فيها من مؤسسات ومنظمات وجماعات، والتي منها ما هو رسمي ومنها ما هو غير رسمي كالجمعيات الأهلية، ومنها ما هو متخصص ومنها ما هو غير متخصص وذلك للاستفادة منها في خدمة المجتمع المدرسي سواء بنقل خدماتهم إلى المدرسة أو انتقال

الطلاب لها للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها. ومن الأدوار التي يقوم بها الإخصائي النفسي في هذا الإطار ما يلي:

(١) الحصول على معلومات عن الهيئات والمراكز المحلية التي يمكنها تقديم المساعدات المتنوعة للطلاب كأفراد وكجماعات.

(٢) الاتصال ببعض الهيئات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية لنشر الوعي بخدمات الإرشاد المدرسي بين أفراد المجتمع.

(٣) الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تعقد بالجامعات والهيئات المختلفة للتعرف على الجديد الذي يمكن تقديمه للمجتمع المدرسي.

(٤) يمكن توفير فرص العمل للطلبة في أوقات فراغهم في العطلات المدرسية بالتنسيق مع بعض الجهات المختلفة.

(٥) رسم الخطط المتعلقة بالزيارات الميدانية للمعاهد العلمية والفنية والكليات المختلفة وكذلك الشركات والمصانع التي قد يحتاج الطلاب إلى معلومات عنها تفيدهم عند التخرج من المدرسة الثانوية.

سابعا: إجراء البحوث والدراسات العلمية:

إذا كانت الأدوار السابقة لها أهميتها في عمل الإخصائي النفسي المدرسي فإن دوره في إجراء البحوث والدراسات والمساهمة فيها يعد أحد أدواره المتفردة في إطار الخدمات التي يقوم بها وذلك لما لهذه البحوث من قيمة علمية وعملية تعمل على دفع عجلة الخدمة النفسية بالمدرسة وتساعده على أداء أدواره بكفاءة. ومن الأدوار التي يقوم بها الإخصائي النفسي في هذا الإطار:

(١) إجراء البحوث والدراسات النفسية بالتعاون مع زملائه الإخصائيين النفسيين بمدرسته وبالمدارس الأخرى للوقوف على مدى انتشار ظاهرة معينة كالتسرب، أو الرسوب، أو الغياب.. وغيرها من المشكلات للتعرف على أسبابها وسبل علاجها.

(٢) تقديم المساعدة للباحثين في المجال النفسي عند إجرائهم للبحوث النفسية بالمدرسة وتذليل العقبات الإدارية أمامهم وتبصيرهم بظروف وطبيعة الطلاب بالمدرسة، وتقديم كافة البيانات والسجلات التي تعينهم على أداء عملهم بكفاءة.

(٣) الاتصال بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث التربوية والنفسية لإجراء بعض الدراسات التي تتعلق بالمشكلات ذات التأثير على سير العمل بالمدرسة للبحث عن أسباب تلك المشكلات وأنسب الطرق لعلاجها.

(٤) القيام بإجراء الاستفتاءات المفتوحة والمقننة على الطلاب للتعرف على آرائهم في طرق التدريس والأنشطة المدرسية وأسلوب معاملة المعلمين وإدارة المدرسة.. وغيرها من المجالات للتعرف على جوانب القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وعلاجها.

(٥) تخطيط البحوث والدراسات المتعلقة ببعض مشكلات الطلاب والإشراف على تنفيذها، وإطلاع هيئة التدريس والهيئة الإدارية على نتائج هذه البحوث للاستفادة منها.

ثامنا: تقويم البرامج التربوية والنفسية:

يعد التقويم أحد الأدوار الحيوية التي يقوم بها الإخصائي النفسي المدرسي، إذ أنه يستخدم التقويم للحكم على مدى تحقيق الأهداف التي تم وضعها، والحكم على كفاءة سير العمل المدرسي، والحكم على مدى نجاح البرامج التي يقوم بإعدادها. وفي إطار هذا السياق فإن الإخصائي النفسي يقوم بالأدوار التالية:

(١) يستخدم الإخصائي النفسي التقويم التربوي في التعرف على مدى توافر بعض المهارات والقدرات العقلية لدى الطلاب التي يحتاجونها لدراسة منهج ما أو نوع معين من الدراسة، ويمكن الحصول على هذه المعلومات بتطبيق اختبارات الاستعدادات ومقاييس القدرات العقلية، والتي تتم قبل بدء العملية التعليمية.

(٢) يستخدم الإخصائي النفسي التقويم التربوي أيضا في التعرف على صعوبات التعلم والتأخر الدراسي لدى بعض الطلاب وتحديد المشكلات التي تحتاج إلى تدريس علاجي.

(٣) يستخدم الإخصائي النفسي المقاييس في التعرف على مدى تحقيق البرامج التربوية وبرامج التوجيه والإرشاد النفسي لأهدافها.

(٤) يقوم الإخصائي النفسي المدرسي في ظل دوره في عملية التقويم بإعداد التقرير الختامي للإنجازات التي تمت في ضوء الخطة التي تم وضعها مسبقا.

تاسعا: توجيه وإرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة:

يختلف طبيعة الدور الذي يلعبه الإخصائي النفسي المدرسي في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تبعا للمدرسة التي يعمل بها، فإذا تواجد في مدرسة للعاديين فإن اهتمامه يتركز على فئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيا وذوي صعوبات التعليم، أما إذا كان يعمل بأحد مدارس التربية الخاصة فإن عمله يتركز في التعامل مع أحد فئات ذوي الإعاقة العقلية أو السمعية أو البصرية أو الجسمية. وبالطبع لكل من الدورين طبيعته وأساليبه التي يتعامل بها الإخصائي النفسي مع تلك الفئات إلى جانب تنوع الخدمات التي يقدمها لهم ومنها:

(١) في مجال رعاية الموهوبين: يقوم الإخصائي النفسي بتحديد الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا من خلال المقاييس والاختبارات العقلية والنفسية، وتحديد القدرات العامة والخاصة التي تميز هؤلاء الطلاب، ووضع إستراتيجيات لرعايتهم وتنميتهم وتشجيعهم إلى جانب توجيههم إلى مراكز تنمية المواهب والمراكز الرياضية والفنية المتخصصة.

(٢) في مجال رعاية المتأخرين دراسيا: يقوم الإخصائي النفسي بحصر هؤلاء الطلاب بالمدرسة من خلال التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس، والتعرف على أسباب التأخر الدراسي لديهم ونوعه (عام _ خاص)، ثم وضع البرامج الإرشادية والتربوية لمساعدة تلك الفئة في التغلب على مشكلاتهم.

(٣) في مجال رعاية ذوي الإعاقات العقلية والبصرية والسمعية: فيقوم الإخصائي النفسي بأدوار متعددة ومعقدة، لأنه إلى جانب الأدوار التي يقوم بها الإخصائي النفسي بالمدارس العادية فإنه يتفرد بتقديم خدمات ذات نوعية خاصة لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة حيث تتعدد مسئولياته الفردية ومسئولياته الجماعية من خلال عضويته في فريق الخدمة النفسية بالمدرسة.

وقد حدد فاروق صادق (١٩٩٦) واجبات ومسئوليات الإخصائي النفسي بمدارس التربية الخاصة على النحو التالي:

- المشاركة في الفرز: وذلك من خلال المسوح التي تقوم بها السلطات التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية، بهدف التعرف على مدى انتشار حالات غير العاديين في فئة من فئات المجتمع، أو في فئاته المختلفة، لأن التعرف على حجم الظاهرة وخصائصها هو المدخل الطبيعي لتخطيط الخدمات، بما يتفق وحاجات المجتمع، مما يزيد من كفاءة البرامج ويقلل من أعبائها وتكاليفها.

- المشاركة في عملية التقويم الشامل للحالة: وذلك بهدف التعرف على إمكاناتها، وأوجه القصور فيها، عن طريق المقابلة مع الحالة أو مع ولي الأمر، ومصادر البيانات الأخرى المتاحة، وتتكامل البيانات المتوافرة في التقارير الطبية والاجتماعية والتعليمية إن وجدت، ومن ثم يجب على الإخصائي النفسي إجراء الاختبارات المناسبة والمقننة محليا، للتعرف على المسببات إن أمكن، وعلى الخصائص الظاهرة من السلوك التي تؤثر في الأداء إيجابا أو سلبا، مع تأكيد الحاجات الخاصة للحالة التي يجب أن تراعى خلال البرنامج، ومن ثم رسم مآلها بموضوعية.
- المشاركة في قبول الحالات في المؤسسة أو المعهد: وذلك بعد دراسة خصائص الحالة، ومعرفة مدى توافر شروط القبول بها، وهنا لابد للأخصائي النفسي اعتبار أن شروط القبول هي حالات مثالية نقية لا توجد أحيانا أو في كثير من الحالات المتقدمة للقبول، وهنا على الإخصائي (مع غيره من الإخصائيين) مراعاة التوازن في قرار القبول، وأن يكون معياره، هو مدى إمكان استفادة الحالة من برنامج الخدمات الموجود بالمدرسة فالهدف هو صالح الحالة وليس صالح المدرسة دون إخلال بنظام الخدمات أو تهديدها، إذا ما كانت مشكلات الحالة أكبر من إمكانات المدرسة العلمية كما أن العامل الإنساني أو الاجتماعي يجب مراعاته داخل هذه الحدود، ودون تقبل أية ضغوط غير موضوعية في هذا المجال، وما يجري خلال عملية التحويل هو نفسه ما يجري خلال عملية القبول.
- تصنيف الحالة وتسكينها: تحدد فئات الحالات ومستواها أحيانا بمعايير سهلة كالعمر الزمني وحده، كما في حالات المكفوفين أو الصم، والأمر أكثر صعوبة في حالات الإعاقة العقلية وخاصة من الدرجة المتوسطة أو الشديدة، فالتصنيف يجب أن يراعى فيه تعدد المعايير الوظيفية التي يمكن أن تعتبر مؤشرات واقعية لطبيعة الحالة ومستوى أدائها، ولذلك فإن الإخصائي النفسي عليه أن يتعرف على أفضل هذه المؤشرات لوصف الأداء الفعلي للحالة واعتبارها محكات للتصنيف أو التقسيم، الذي يمكن اعتباره فرضًا قابلًا للتحقيق أو التعديل، ويتطلب ذلك جمع البيانات عن الحالة بعد تصنيفها وتسكينها في مجموعة معينة، ومتابعة مدى ونوع أدائها ومدى تجانسها مع غيرها من الحالات في نفس المجموعة حتى نضمن أفضل أداء للحالة وأحسن تكيف ممكن.

- المشاركة في رسم البرنامج الفردي أو الجماعي وتنفيذه: يحتاج البرنامج في رسمه وتخطيطه وتنفيذه إلى عمل جماعي، فخصائص الحالة (جوانب التميز، وجوانب القصور) يمكن ترجمتها إلى برنامج له أهداف إجرائية معينة في فترة زمنية محددة يقوم خلالها الإخصائيون في المدرسة بواجبات فردية أو جماعية للتعامل مع الحالة، وتنمية إمكاناتها وعلاج جوانب القصور فيها، وهنا يمكن للأخصائي النفسي ترجمة أهداف هذه البرامج إلى أنماط سلوكية، وعادات، ومفاهيم ومهارات، يقوم بشرحها للمدرس أو المعالج، وتحدد نوع المواقف والإمكانات والأنشطة التي يمكن أن تستخدم مع الحالة، ومتابعتها في تقديم التقارير اللازمة لمناقشتها جميعًا، من خلال الفريق، وتحديد الخطوات التالية من البرنامج.
- معالجة عيوب التعلم: من المتوقع أن تصاحب الإعاقة بعض وصعوبات في التعلم، مثل صعوبات القراءة ، أو صعوبات الكتابة، أو صعوبات تعلم العمليات الحسابية أو الفهم الحسابي، أو صعوبات النطق والكلام والتعبير اللغوي، أو الصعوبات في العمليات الحسية الإدراكية الداخلة في التعلم. وكجزء من البرنامج التعليمي، فإنه يمكن للأخصائي النفسي المشاركة في تخطيط هذا وتنفيذه، ومتابعته، وتقييمه دوريا مع كل من المعلمين والإخصائيين المشاركين فيه.
- متابعة الحالات بعد انتهاء البرامج: يتخرج الأفراد من ذوي الحاجات الخاصة من المدرسة أو المؤسسات، حسب معايير تعليمية ومعايير مهنية معينة، ولكن من الصعب أن توازي هذه المعايير قدرتهم على التكيف الاجتماعي، أو تتناسب مع مستواهم التعليمي أو المهني المطلوب للعمل في المجتمع، ولذلك فإن الكثيرين من ذوي الحاجات الخاصة يظلون في حاجة إلى خدمات توجيهية وإرشادية حتى بعد تخرجهم من المؤسسة أو المعهد.

والواقع أن البحث عن عمل، أو الاتصال بأماكن العمل، أو التكيف في مجال العمل الذي به، والتوافق مع الشروط المطلوبة لعادات العمل، كل تلك أمور تحتاج إلى كثير من الجهد والتفاعل، كذلك الرغبة في الزواج وتكوين أسرة وتحمل مسؤوليات وتبعات ذلك، تعد من الأمور الصعبة على كثير من ذوي الحاجات الخاصة، وبالتالي فالتوجيه والإرشاد الزواجي والأسري يمثل ضرورة ملحة، ومهمة لابد أن ينهض بها الإخصائي النفسي، إذا أردنا لذوي الحاجات الخاصة من الطلاب التوافق الاجتماعي السوي.

- إعادة التأهيل: يستطيع الكثيرون من ذوي الحاجات الخاصة الحياة في مجتمع الأسوياء بعد اكتمال تعليمهم وتأهيلهم مهنيًا، والقليل منهم لا يستطيع ذلك، إما لعدم كفاءة البرنامج الذي تدربوا عليه، أو لقصور في كفاءة الفرد الشخصية والاجتماعية، بحيث يحتاج إلى الإشراف المباشر والمستمر، وهنا يمكن للأخصائي المشاركة في برنامج الورش المحمية، أو الوحدات الاجتماعية الإشرافية المستمرة، أما إذا كان البرنامج غير كفء أو كان التدريب غير مناسب للوقت المطلوب فيه، فإنه يعاد التدريب أو التأهيل ببرنامج جديد يتناسب مع احتياجات المجتمع، وخصائص الفرد، وهذا مجال يتيح للأخصائي النفسي فرصة التعامل الكفء مع هذه الظروف.
- تعليم وتدريب أولياء الأمور: يعتبر الوالدان والأسرة من أهم أعضاء فريق التأهيل لهذه الفئة، فالأسرة مسئولة مسئولية أولية عن الحالة، وكل ما يختص بها ويؤثر على الأسرة والمجتمع، ولذلك فإن تعريف الوالدين بطبيعة الإعاقة وأسبابها ومظاهرها وتأثيرها على الفرد والأسرة، وما يمكن عمله من أجلها، وأهداف البرنامج، ودور الأسرة في هذا البرنامج في تعليم الفرد وفي التعامل معه، ومعاونته في التغلب على مشكلاته، ومساعدته على التكيف الشخصي والاجتماعي والمهني، كل تلك أمور مرغوب فيها من أجل نجاح البرنامج، وتكيف ذوي الحاجات الخاصة، وهنا يعتبر الإخصائي النفسي عضوا هاما في فريق تعليم وتدريب أولياء الأمور، لمعرفته الدقيقة بإمكانات وجوانب القصور في كل حالة من حالات ذوي الحاجات الخاصة.
- الدفاع الاجتماعي: يشارك الإخصائي النفسي في حركة الدفاع الاجتماعي عن ذوي الحاجات الخاصة، فلهم حقوق الإنسان في حرية التعليم والتأهيل، وحق الدمج في المجتمع، وحرية العمل فيما يصلحون له، دون أي تمييز أو تحيز، يستوي في ذلك الإعاقة البسيطة والشديدة، وعلى المجتمع توفير كل وسائل التعليم والتأهيل لهم، وأن يوفر لهم الأجهزة التعويضية بالمجان، أو بأسعار رمزية، كما أن حقوقهم المدنية يجب أن تصان، وأن يحافظ على حقهم للمعيشة في المجتمع، والعمل فيه،وحقهم في الزواج وتكوين أسرة، وحماية حقوقهم في الميراث وإدارة الأعمال بالطريقة المناسبة..الخ.
- تحمل المسؤولية نحو أخلاقيات المهنة والوعي بحدودها: هناك مجموعة كبيرة من البحوث التي تعالج أخلاقيات المهنة في مجال ذوي الحاجات الخاصة تقتضي إطلاع

الإخصائي النفسي عليها، وأن أهم القواعد الأخلاقية في تقديم الخدمات النفسية إلى ذوي الحاجات الخاصة، ضرورة مراعاة التكامل بين الدين وعلم النفس من خلال التعاون مع رجال الدين في تقديم هذه الخدمات إلى هذه الفئات، وعدم التمييز في تقديمها، وعدم التحيز للحالات التي تنبئ بالتحسن السريع دون غيرها، أو تنتمي لمستوى اجتماعي أو ثقافي دون مستوى آخر، أو لبعض العرقيات دون الأخرى، أو لأية أسباب تنظيمية أو إدارية بحتة، والعمل على تنمية ممارسة هذه المبادئ في كل من القائمين على هذه الخدمات، والحالات التي تحتاج إلى هذه الخدمات، على قدم المساواة.

الأعمال التي تقع خارج دور الإخصائي النفسي المدرسي:

هناك بعض الأعمال التي تقع خارج دور الإخصائي النفسي المدرسي، ولا تمت بصلة إلى مهامه الأصلية التي أعد للقيام بها وهي على النحو التالي:

(١) يجب ألا يكلف الإخصائي النفسي المدرسي بالوقوف مع إدارة المدرسة أو المدرسين لحجز التلاميذ المتأخرين عن طابور الصباح، أو عن الحصص الأولى، ولكن عليه أن يستقبل هؤلاء التلاميذ المتأخرين في مكتبه عند تحويلهم إليه من قبل الإدارة المدرسية أو المدرسين للتعامل معهم بالأساليب الإرشادية المدرسية.

(٢) يجب ألا يكلف الإخصائي النفسي المدرسي بعقاب التلاميذ المخالفين لأنظمة ولوائح المدرسة أو المشاغبين في الفصول، أو المتسببين في الإزعاج العام للمدرسة.

(٣) يجب ألا يكلف الإخصائي النفسي المدرسي بأية أعباء كتابية أو إدارية لا تدخل في نطاق اختصاصه والتي من الممكن أن يؤديها أي عضو آخر في هيئة التدريس أو في هيئة موظفي المدرسة.

(٤) يجب ألا يكلف الإخصائي النفسي المدرسي بحصر الغياب وتسجيله أو محاسبة التلاميذ عليه ومعاقبتهم بسببه، أو أخذ التعهدات منهم ومن أولياء أمورهم بعدم تكراره، لأن هذا من اختصاص العمل الإداري بالمدرسة.

(٥) يجب ألا يكلف الإخصائي النفسي المدرسي بأي عبء تدريسي بأن يسد العجز في مادة ما يتولى مهام تدريسها، أو يحضر حصصًا بدلًا من معلم غائب، أو يتولى تصحيح اختبارات، أو رصد درجات مادة ما لسبب أو لآخر. (ماهر عمر،١٩٩٩)

الفصل السابع

مجالات الإرشاد النفسي المدرسي

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على خصائص مرحلة الطفولة.
- فهم طبيعة واحتياجات الطفولة.
- إدراك مشكلات الطفولة.
- التميز بين دور الإخصائي النفسي في إرشاد الأطفال.
- التعرف على خصائص مرحلة المراهقة
- توضيح أهم مشكلات مرحلة المراهقة.
- فهم أهمية الإرشاد في المدرسة الاعدادية والثانوية.
- التميز بين دور الإخصائي النفسي المدرسي في إرشاد المراهقين.

الفصل السابع

مجالات الإرشاد النفسي المدرسي

هناك العديد من مجالات الخدمة النفسية المتنوعة، فمنها إرشاد الأطفال، وإرشاد المراهقين، وإرشاد المسنين، والإرشاد العلاجي، والإرشاد الأسري، والإرشاد المهني، والإرشاد الزواجي، وإرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة.. وغيرها من مجالات الإرشاد. وبما أن مجال اهتمامنا في هذا الكتاب هو التركيز على إرشاد تلاميذ المدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، فسوف نتخير من بين مجالات الإرشاد النفسي ما يفيد الإخصائي النفسي المدرسي داخل هذه المنظومة التعليمية.

أولا: إرشاد الأطفال:

يستهدف إرشاد الأطفال العمل على مساعدة الطفل في تحقيق النمو المتوازن المتكامل لجميع الجوانب النمائية (الجسمية، والعقلية، والاجتماعية، والانفعالية) ومساعدة الطفل على فهم ذاته فيما يتعلق بحاجاته وبمطالب البيئة من حوله، كما يهدف إلى مساعدته في القيام بالتوافق مع المواقف الجديدة، فالإرشاد النفسي للأطفال لا يتعلق فقط بعلاج موقف متأزم أو مواجهة مشكلة ما، بل يتعلق بمفهوم استمرار النمو وترابط مراحله.

ويجب أن تقدم خدمات إرشاد الأطفال في ضوء معرفة كاملة بخصائص ومعايير ومطالب النمو في مرحلة الطفولة مع مراعاة الفروق الفردية والفروق بين الجنسين.

خصائص مرحلة الطفولة:

من **الناحية الجسمية** يتسم النمو الجسمي في هذه المرحلة بزيادة الطول والحجم، والوزن، ويسير النمو العضلي بمعدل أسرع من ذي قبل وأهم ما يميز الطفل في هذه المرحلة قدرته على النشاط العضلي كالجري، والقفز والتسلق، ولكن عموما نجد أن الأطفال يميلون إلى النحافة مما يزيد قابليتهم للعدوى ببعض الأمراض نتيجة لنموهم السريع وتبدأ الأسنان اللبنية في السقوط لتحل محلها الأسنان الدائمة.

وفي منتصف المرحلة نجد أن معظم **القدرات العقلية** تبدأ في النضج من تذكر وتفكير وانتباه يتحول تدريجيا إلى الواقعية والنظرة العلمية للبيئة وتزداد قدرة الطفل على التعلم بالخبرة (المحاولة والخطأ) ويكتسب فكرة عن المسافة والحجم والشكل وتزداد رغبته في جمع الأشياء وحب الاستطلاع ونجد الذكاء ينمو حتى الثانية عشرة (أي في نهاية المرحلة).

وتتميز **انفعالات** الطفل في بداية المرحلة بأنها شديدة ومبالغ فيها فهو يحب بشدة، ويكره بشدة ويغضب بشدة.. بل يزداد التعبير عن الغضب مثلا عن أدنى إحباط يمكن مواجهته، ويلاحظ أن البنات أكثر خوفا من البنين، ولكنهم في نفس الوقت أقل عدوانية من البنين، وتنشأ في تلك المرحلة مشاعر الغيرة، وتبدأ مع نهاية المرحلة انفعالاته في الثبات والاستقرار والسيطرة على كثير من انفعالاته ويعمل على تجميع معظم انفعالاته حول موضوع معين لتكوين ما يسمى بالعواطف والعادات الانفعالية.

أما من **الناحية الاجتماعية** فإننا نجد مع بداية المرحلة أن سلوك الطفل يتأرجح ما بين الاستقلالية، والاعتمادية، وتتسع دائرة العلاقات والتفاعل الاجتماعي في الأسرة ومع جماعة الرفاق، وبذهاب الطفل إلى المدرسة تتاح له فرصة تحقيق المكانة الاجتماعية من خلال اللعب ويتسم سلوكه الاجتماعي بالانطلاق والرغبة في لقاء من هم في سنه، فهو لا يحب العزلة، ولكنه في الوقت نفسه لا يميل إلى الاختلاط بالجنس الآخر.

طبيعة واحتياجات الطفولة:

لقد أوضح ماهر عمر (١٩٩٩) الحاجات التي ينبغي إشباعها في مرحلة الطفولة على النحو التالي:

أولًا: الحاجات العضوية **Physical Needs**

من أهم الحاجات التي يريد طفل المرحلة الابتدائية إشباعها، هي الحاجات العضوية. تلك الحاجات التي تتعلق بالصحة العامة للطفل، نوعية غذائه، التوازن بين الأنشطة التي يمارسها والراحة التي يتطلبها جسمه وعقله، وأخيرا علامات الاستفهام والأسئلة الحائرة حول الجنس التي تشغل تفكيره طول فترة نموه، خلال هذه الفترة الدقيقة من عمره.

(١) الصحة العامة للطفل **General Health of the Child**

لا يمكن لأحد أن ينكر أن العقل السليم في الجسم السليم، فإذا صح الجسم سلم العقل. لذلك فإن أي مرض يصيب الطفل يؤثر على تفكيره العقلي وإنجازه العضوي مما قد يتسبب في عرقلة تحصيله الدراسي. ولما كان طفل المرحلة الابتدائية أكثر عرضة من غيره للإصابة بالأمراض المعدية، التي تتناقل بين رفقاء عمره داخل المدرسة، ولما كان طفل المرحلة الابتدائية أقل خبرة من غيره في التعرف على بعض الأمراض التي قد تصيبه مثل ضعف البصر أو فقر الدم وما شابها، لذلك كان هذا الطفل في أشد الحاجة إلى من يساعده في التعرف على هذه

الأمراض والتخلص منها. ومن ثم، كان على فريق التوجيه النفسي بالمدرسة العبء الأكبر في إشباع هذه الحاجة عند طفل الابتدائي أن فحص الطفل مرتين على الأقل خلال العام الدراسي يعتبر بمثابة صمام أمن لصحته العامة، إن هذه الفحوصات الدورية تساعد فريق التوجيه النفسي بالمدرسة في التعرف على سلوك الطفل بصفة عامة داخل المدرسة وفي البيت. ومن ناحية أخرى تتيح الفرصة لأولياء الأمور لبذل المزيد من الرعاية الصحية لأطفالهم ومتابعة حالاتهم العضوية وتقدمها.

(٢) **نوعية الغذاء** **Kind of Diet**

مما لا شك فيه، أن نوعية الغذاء وكميته التي يتناولها الطفل ترتبط ارتباطًا وثيقاً بصحته العامة. فكثير من الأمراض التي يتعرض لها طفل الابتدائي تكون نتيجة لسوء التغذية إما لعدم تنوعها الغذائي أو لقلة كمياتها المتناولة. إن جسم الإنسان في حاجة إلى كميات متوازنة نوعا ما بين عناصر الغذاء الأساسية التي يحتاجها وهي: الكربوهيدرات (نشويات وسكريات)، الدهون، البروتين، الفيتامينات، الأملاح، الماء. لذلك فإن أي خلل في هذا التوازن الغذائي يسبب أمراضًا للطفل ناتجة عن سوء التغذية. يجب على الإخصائي النفسي المدرسي بالتعاون مع بقية أعضاء فريق التوجيه التعرف على حاجات الطفل المتعلقة بالتغذية والمشكلات الناتجة عنها.

(٣) **التوازن بين النشاط والراحة** **Balance of Activity & Rest** بالرغم أن الأنشطة التي يمارسها الطفل داخل المدرسة تعتبر جزءًا أساسيًا، ومكملًا للمنهج الدراسي في المرحلة الابتدائية، إلا أننا يجب ألا نغالي في الأنشطة التي ترهق الطفل وتستنفذ جهده مما يتسبب في قصوره وعجزه عن التحصيل الدراسي بشكل عام فتكون نتائجها عكسية لما هو متوقع منها، ومن ثم، على الإخصائي النفسي المدرسي مع فريق التوجيه أن يراعوا التخطيط السليم للأنشطة التي يكلف الطفل بممارستها داخل المدرسة. فلا يحملونه أكثر من طاقاته، ولا يطالبونه بأكثر مما يستطيع، مع مراعاة توفير الوقت اللازم لراحته العضوية والعقلية خلال مزاولته لهذه الأنشطة داخل المدرسة.

ثانيًا: تقبل الذات والتقبل من الآخرين

إن طفل المرحلة الابتدائية كعضو جديد في المجتمع المدرسي، يحاول أن يختبر ذاته مرة أخرى بين أقران عمره وفي محيط البالغين والراشدين من المدرسين وهيئة موظفي المدرسة،

وتدور في ذهنه تساؤلات ملحة يحاول أن يختبر الإجابة عليها خلال علاقاته وتفاعلاتهم معهم بالمدرسة: هل سيلقى الحب والتقبل والفهم منهم أم سيصدم بالعكس ؟ هل خبراته المدرسية ستتشابه مع خبراته المنزلية أم ستختلف عنها ! هل ستكون أفضل أم أسوأ منها ؟ ويشعر الطفل بخيبة أمل في مجتمعه المدرسي إذا شعر أو على الأقل إذا ظن أن أحدا لم يفهمه ولم يتقبله في المدرسة وبأنه غير محبوب فيها ؟ أو إذا وجد خبراته المدرسية أسوأ من خبراته المنزلية. فإذا فشل المدرسون وهيئة موظفي المدرسة في تصحيح اتجاهات نحوها ونحو علاقاتهم به، فإن هذا الفشل ينعكس على سلوكه الشخصي والاجتماعي والتربوي بصفة عامة داخل المدرسة وخارجها.

وعلى الإخصائي النفسي بالتعاون مع أعضاء فريق التوجيه بالمدرسة مساعدة الطفل على تقبل ذاته كما هي وزيادة إحساسه بتقبل الآخرين له، باذلين جهدهم لمساعدته في تدعيم موطن القوة في شخصيته وليتغلب على نقاط الضعف فيها ، وذلك خلال البرامج المخططة للأنشطة المدرسية التي يشجع الطفل على الاشتراك والانتظام فيها.

إن العمل الجماعي داخل المدرسة الابتدائية يدعم إحساس الطفل بتقبله لذاته وتقبله من الآخرين، ويساعده على تقبل نقاط ضعفه ومحاولة التغلب عليها ومواطن قوته ومحاولة تدعيمها، وينمي عنده القدرة على التفاعل الدينامي Dynamic Interaction بينه وبين أقرانه ومدرسية، ويطور العلاقات الاجتماعية بينه وبين الآخرين، يتيح الفرصة له للتفكير الابتكاري والتعبير الحر عن آرائه، يعوده على الاعتماد على النفس والاستقلالية، يمكنه من التعرف على قدراته وإمكاناته، يصحح أفكار واتجاهاته ويدعم الثقة في نفسه كعضو في جماعة لا تستغني عن وجوده فيها.

ثالثًا: التعامل مع الخوف والشعور بالذنب:

في بعض الأحيان يشعر الطفل بالخوف عندما يستمع إلى خبرات مخيفة يحكيها الآخرون، أو عندما يضع نفسه في المواقف المحركة التي لم يكن مستعدًا لمواجهتها. والشعور بالذنب يصاحب المواقف التي يسبب فيها إحراجًا للآخرين ولم تلق قبولا منهم ولا رضا عنها، والتي يؤنب ويلام عليها، والتي يشعر بالخجل منها.

لذلك يجب على الكبار في البيت والمدرسة مساعدة الطفل على تجنب الشعور بالخوف والتغلب على الشعور بالذنب، ولكن العقاب واللوم في أضيق الحدود وليكن التأنيب والتوبيخ

على الأخطاء المقصودة والمتكررة لأكثر من مرة وليس على تلك التي تصدر عنه عفويًا أو لأول مرة.

رابعًا:التعامل مع الواقع Dealiny With Reality:

إن عالم الخيال World of Fantasy الذي يعيش فيه الطفل يشعره بالآمن والسعادة أكثر مما يحس به في عالم الواقع World of reality ويجب أن تفرق بين أحلام اليقظة التي يهرب بها الطفل من مشكلات عدم توافقة مع الواقع وبين أحلام المستقبل Feature dream التي يتطلع بها الطفل إلى ما يجب أن يكون عليه من نجاح في الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية عندما يدخل عالم الكبار. الطفل العادي يمكنه أن يميز بين الواقع وأحلام المستقبل؛ بينما الطفل الذي يعاني من عدم توافق مع الواقع يخلط بينه وبين أحلام اليقظة التي يعيش فيها.

ويتحمل أهل البيت والعاملون في المدرسة مسؤولية مساعدة الطفل على التكيف السليم والتوافق السوي مع الواقع في حياته، وذلك بمساعدته على تحديد مشكلاته التي دفعت به إلى أحلام اليقظة، ووضع البدائل والخيار لحلها، واختيار الأنسب منها للتغلب عليها، واتخاذ الخطوات الإيجابية نحو التخلص منها؛ كما يجب مساعدته على التميز بين الخيال والواقع خطوة بخطوة خلال مراحل نموه اليومي بدون حدوث أي إحراج أو إحباط له، وذلك خلال مناقشته بجدية فيما يرويه من قصص خيالية وتوضيح الصورة أمامة بين لا معقولية ما يرويه وواقعية ما يجب أن يكون عليه.

خامسًا: التعرف على المسئولية تجاه الآخرين

طفل المرحلة الابتدائية إلى أن يتعرف على حدوده ومسئولياته نحو الآخرين، نحو آبائه وبقية أفراد الأسرة التي تعيش في كنفها، نحو أصدقائه ومدرسية وبقية أفراد هيئة موظفي المدرسة التي يتلقى العلم فيها. في كل موقف جديد يمر به الطفل نجده في حاجة لاختبار ما هو متوقع منه أن ينجزه، وقد يلجأ إلى المحاولة والخطأ في اكتشاف توقعات الآخرين منه ومسئولياته نحوهم. ويمكن للطفل أن يتعرف على حدوده ومسئولياته خلال تفاعلاته اليومية في البيت وداخل المدرسة خلال التوجيهات الرشيدة ممن يحيط به في كل منهما، حتى يتمكن من القيام بأدواره فيهما دون المساس بمشاعر الغير أو التجريح في شخصياتهم. لذلك يتحمل

الكبار في البيت والمدرسة مسئولية مساعدة الطفل في إتباع الاتجاه الصحيح نحو الآخرين فيحبهم كما يجب نفسه، ويتعامل معهم بالاحترام والتقدير،ولا يفضل نفسه عليهم وألا يكون تابعًا لهم.

مشكلات الطفولة:

هناك عدد من المشكلات التي تتميز بها مرحلة الطفولة دون غيرها من المراحل الأخرى ومشكلات أخرى تشترك فيها مع المشكلات التي تظهر في مرحلة المراهقة ومن بين تلك المشكلات ما يلي:

- اضطرابات النوم: ومنها الأرق، والكوابيس، وإفراط النوم والمشي أثناء النوم، والكلام أثناء النوم، وقرض الأسنان أثناء النوم، والرعب الليلي (الفزع أثناء النوم)، وتقلص العضلات أثناء النوم، والبلع غير السلس أثناء النوم.
- اضطرابات التغذية: فقدان الشهية، والإفراط في الأكل (الشره)، وفساد الشهية (أكل مواد غير صالحة)، والقيء، واضطراب الاجترار (البطء) في الأكل.
- اضطرابات الكلام: الثأثأة، والخنف، والبكم المتعمد، والتهتهة، اللثغة، وعسر اللسان، والبكم الهستيري، واضطراب الكلام الذهاني.
- اضطرابات الإخراج: التبول اللاإرادي أثناء الليل أو النهار، والتغوط اللاإرادي، والإمساك أو الإسهال، ومشكلات التدريب المبكر على الإخراج.
- مص الأصابع: مص الإبهام، ومص السبابة، والمص الدائم للأصابع، والمص المؤقت.
- قضم الأظافر: ومنها قضم أظافر الأيدي، وقضم أظافر الأرجل، وقضم أظافر الغير.
- اضطرابات سلوكية: ومنها الكذب، والسرقة، والتخريب، والعناد، والهروب، والسلوك العدواني.. وغيرها.

دور الإخصائي النفسي في إرشاد الأطفال:

يلعب الإخصائي النفسي دورا حيويا في إرشاد الأطفال والذي عادة ما يلازمه إرشاد الوالدين لتعريفهم بالخصائص النمائية للطفل وطبيعة المشكلات التي قد تواجهه حتى

يمكنهم التمييز ما بين السواء و اللاسواء في سلوك أطفالهم، فقد يكون شكوى الوالدين حيال سلوك ما يعتبر عاديًا بالنسبة لمرحلة النمو التي يمر بها الطفل، ولذا تستمد العلاقة الإرشادية مع الأطفال من الخصائص النمائية للطفل وحاجاته، وذلك على النحو التالي:

(١) يشبع الطفل حاجاته من خلال الاعتمادية الكلية على الأم، ثم يبدأ في التحرر والاستقلال فتتحول الاعتمادية الكلية إلى اعتمادية جزئية حتى يصل إلى الاستقلال الذاتي وتحمل المسئولية، ومع تطور الاستقلال الذاتي يدرك الطفل أن الآخرين كأفراد منفصلين، ولهم حقوق خاصة مثله تمامًا، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس دون عدوان أو منافسة غير مقبولة، وينظر الإخصائي النفسي إلى هذا التحول على أنه علامة من علامات نضج الطفل.

(٢) من الحاجات الأساسية للطفل، حاجته إلى أن يحب كشخص، وإذا كان الطفل يقبل دون شروط في السنوات الأولى، أي يقبل كما هو عليه حتى ولو كان يعاني من أمراض أو قصور، إلا أن هذا القبول (غير المشروط) ينخفض تدريجيا عندما يبدأ الوالدان أو المعلم في وضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه الطفل، ومن خلال المقابلة يشبع الإخصائي النفسي هذه الحاجة ويؤكد عليها عندما يتقبل الطفل بما هو عليه وليس ما ينبغي أن يكون عليه.

(٣) من الحاجات الأساسية للطفل حاجته إلى الأمن والطمأنينة، وإذا كان الوالدان يشبعان هذه الحاجة في السنوات الأولى: فإن هذا الإشباع ينخفض تدريجيا نتيجة استقلال الطفل وانصراف الوالدين عنه، ولذلك فإن الطفل يكون في حاجة إلى الشعور بالأمن مرة ثانية، ويستطيع الإخصائي النفسي إشباع هذه الحاجة من خلال المقابلة الإرشادية.

(٤) يتعامل الطفل مع بيئته في السنوات الأولى على أنها كاملة ومثالية، ومع تقدم الطفل يجد نفسه في حيرة وصراع بين ضرورة الحياة مع الواقع والتمسك بالكمال والمثالية، ويستطيع الإخصائي النفسي أثناء المقابلة مساعدة الطفل على التعامل مع الواقع تدريجيا.

(٥) يسعى الطفل إلى كسب حب الآخرين أو تجنب كره الآخرين، وفي سبيل ذلك قد يلجأ إلى التظاهر بما ليس هو عليه، كأن يظهر الحب إلى أخيه دون أن يكون كذلك بالفعل، وقد يلجأ إلى إنكار ما هو عليه مثل إنكاره لكره أخيه، في هذه الحالة يكون دور الإخصائي النفسي أثناء المقابلة هو الكشف عن مثل هذه الميكانيزمات والتبكير في إيجاد حلول لها، لأن إهمالها يؤدي إلى العصاب فيما بعد.

(٦) قد يوجد نقص في معارف وخبرات الطفل، وفي هذه الحالة يكون من الصعب على الطفل التمييز بين الحاجات الإيجابية مثل: الانتماء والارتباط والحب، وأنماط سلوكية وانفعالية أخرى مثل النرجسية والغيرة والعدوان، دور الإخصائي النفسي في هذه الحالة يتضح في مساعدة الطفل على التمييز بين هذه الحاجات والسلوكيات والانفعالات، والتأكيد على أن الاتزان الانفعالي يتحقق عندما يتم إشباع الحاجات الإيجابية.

(٧) قد تكون الأعراض الدالة على المشكلة أو الاضطراب هي مجرد وسائل عادية يحتج بها الطفل على موقف ما أو تصرف ما من قبل الآخرين، ودور الإخصائي النفسي في هذه الحالة حل هذه المشكلات في ضوء العلاقة الدافئة والمعاملة الهادئة التي بينه وبين الطفل، على أن يكون التركيز على تغيير الموقف أو تعديل السلوك بجانب التركيز على الطفل نفسه.

(٨) قد تكون حالات عدم التوافق لدى الطفل ناتجة عن الضغوط و الاحباطات، سواءً كان مصدرها الطفل نفسه أو البيئة الخارجية، ودور الإخصائي النفسي في هذه الحالة هو التخفيف من أثر هذه الضغوط و الاحباطات بإزالة الأسباب أو تدريب الطفل على مواجهتها أو تبسيطها أو التفكير في حلها، مع الوضع في الاعتبار أنه من الصعب إزالة كل الأسباب، كما أن الطفل قد يرى شيئا بأنه محبط لأنه يتعارض مع رغباته وتخيلاته وتوقعاته في حين يراه الآخرون عاديًا مرتبطًا بظروف النمو أو الموقف، في هذه الحالة نؤكد على أنه بقدر وجود فجوة واسعة بين تخيل الطفل للواقع والواقع الفعلي، تكون الضغوط و الاحباطات أكثر شدة وتزداد الصراعات و الاضطرابات وينحرف نمو الطفل ويزداد سوء التوافق.(محمد سعفان،٢٠٠١)

ثانيا: إرشاد المراهقين:

إذا كانت الحاجة للإرشاد النفسي تزداد في فترات الانتقال والنمو السريع وزيادة التوقعات الاجتماعية ومطالب النمو فإن المراهقة هي المرحلة التي ينبغي أن تكثف فيها الخدمات الإرشادية نظرا لكثرة ما يمر به الفرد من تغييرات في جميع مجالات نموه، ولزيادة إلحاح كل من المطالب النفسية والتوقعات الاجتماعية.

خصائص مرحلة المراهقة:

يعتبر **النمو الجنسي** من الملامح النمائية البارزة والواضحة في مرحلة المراهقة وعلامة على الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، ويتلخص أهم ما يحدث من نمو جنسي

في نضج الغدد التناسلية، أي أن تصبح قادرة على أداء وظيفتها في التناسل وإفراز الهرمونات وما يترتب على ذلك من ظهور العلامات الجسمية الدالة على البلوغ، وينتقل المراهق من الجنسية المثلية إلى الجنسية الغيرية وتظهر الكثير من الاهتمامات الجنسية في هذه المرحلة بموضوعات الجنس وقصصه ورسومه وصوره.

وتكتمل في هذه المرحلة **الوظائف العقلية العليا**، كما تظهر القدرات الخاصة كالقدرة اللغوية والرياضية والفنية.. وغيرها، كما تزداد سرعة التحصيل ونمو التذكر معتمدا على الفهم واستنتاج العلاقات وتزداد القدرة على التخيل المجرد والقدرة على التفكير والاستدلال وحل المشكلات والتحليل و التركيب وتنمو أيضا القدرة على التفكير النقدي والتجريدي.

أما من **الناحية الانفعالية** فتتصف انفعالات المراهق بالعنف بصورة لا تتناسب مع مثيراتها ولا يستطيع التحكم فيها، كما نلاحظ عدم الثبات والاتزان الانفعالي والخجل والميول الانطوائية والتمركز حول الذات وحب التفرد ومشاعر الذنب وانتشار المخاوف المرضية وأشهرها المخاوف الجنسية والاجتماعية، وتدفعه تلك الانفعالات إلى اللجوء لأسلوب من الأساليب اللاتوافقية للتخلص من التوتر الذي يعاني منه ومن بينها أحلام اليقظة والتقمص والنشاط الزائد والانعزال والمبالغة في المثالية.

وفيما يتعلق **بالخصائص الاجتماعية** للمراهق نجد الصراع الذي يحدث بينه وبين أشكال السلطة فيصبح في حاجة شديدة للانتماء وإلى جماعة الرفاق ويصبح لهذه الجماعة وزن في التأثير على سلوكه ويظهر أيضا في هذه المرحلة الاهتمام بالمظهر الشخصي، وينمو الوعي الاجتماعي وتحمل المسئولية الاجتماعية ويلاحظ أيضا التذبذب بين الأنانية والغيرة، والميل إلى الزعامة، كما أنه يحاول تأكيد مكانته بمنافسة زملائه في ألعابهم وتحصيلهم ونشاطهم.

أهم مشكلات مرحلة المراهقة:

⇦ المشكلات الانفعالية: ومنها الشعور بالقلق، ونقص الثقة بالنفس، والجناح، والسلوك العدواني، والغضب، والعصيان، والتمرد، والخجل، والانطواء، والاغتراب، وعدم القدرة على تحديد المسئولية، وعدم القدرة على السيطرة على الانفعالات والمخاوف المرضية (كالمخاوف المدرسية، والاجتماعية، والجنسية، والصحية) والتناقض الوجداني.

⇦ المشكلات الصحية: ومنها ظهور بثور الشباب، ونقص الوزن أو زيادته، واضطراب النوم، وعدم الوعي بمقدار ونوع الغذاء الصحي، ونقص الرعاية الصحية، نقص الشهية العصبي، أو الشرة العصبي.

⇦ المشكلات المدرسية: ومنها عدم القدرة على تنظيم وتخطيط الاستذكار، والتسيب وعدم الانضباط، وعدم الرغبة في الانخراط في النظام المدرسي، وعدم تناسب المناهج مع اهتماماتهم، وعدم احترام المدرسين، وإثارة الشغب في الفصل وكثرة التهريج، السخرية من الزملاء وعدم احترامهم، وطول اليوم الدراسي، وعدم الميل إلى مادة دراسية أو أكثر، وعدم التركيز في الفصل، التأخر الدراسي، والهروب من المدرسة، وعدم الخضوع لأوامر المدرسين، وعدم الاهتمام بأداء الواجبات المدرسية، والتأخر عن المدرسة.

⇦ المشكلات الاجتماعية: ومنها عدم الإلمام بالمعايير الاجتماعية، ومسايرة أصدقاء السوء، التمرد على السلطة، وقلة عدد الأصدقاء أو وعدم القدرة على تكوين صداقات جديدة، ونقص الخبرة في الاحتكاك الاجتماعي والمواقف الاجتماعية، والعزلة الاجتماعية، والبعد عن الزعامة.

⇦ المشكلات الأسرية: ومنها المبالغة في فرض القيود، وعدم الصراحة والحرية في المناقشات، ونقص الخصوصية في الأسرة، والعلاقات السيئة بين الأخوة، نقص المصروف، وعدم سواء العلاقة بين المراهق والوالدين، عدم الحرية في عمل الصداقات، وقد تكون المشكلات الأسرية بسبب وفاة أحد الوالدين أو الانفصال أو الترمل أو زواج أحدهما أو كليهما.

⇦المشكلات الدينية: ومنها عدم التوازن بين التزمت والتحرر، والتعصب الديني، وتأنيب الضمير الزائد، ونقص المعلومات الدينية فيما يتعلق بالحلال والحرام، والشك الديني، وعدم إقامة الفرائض والشعائر الدينية.

⇦المشكلات المهنية: ومنها نقص التأهيل والتدريب المهني، ونقص الخبرة بميادين العمل المتاحة، وعدم معرفة أماكن التأهيل والتدريب المهني، وعدم الربط يبن الميول المهنية والمهنة التي يشغلها.

أهمية الإرشاد في المدرسة المتوسطة والثانوية:

تتسم مرحلة المراهقة وهي المرحلة المتوسطة من المراحل الدراسية فيما يذكر(محمد منصور وفاروق عبد السلام، ١٩٨٠) بالأتي:

☑ التحول من خطوط الجسم قليلة الشبه بالكبار إلى خطوط الجسم والقوام المشابه للكبار.

☑ التحول من فترة تتميز بكثرة الميول المتغيرة إلى ميول مستقرة وقليلة العدد إلا أنها ذات معنى.

☑ التحول من فترة يقل فيها الاهتمام بمعايير الرفاق ومكانته بينهم إلى فترة تتميز بالاهتمام الكبير بالرفاق ومعاييرهم وبالمكانة التي يطمح فيها بينهم.

☑ التحول من فترة يندمج فيها في أي نشاط للنشاط ذاته إلى فترة يتحول فيها السلوك ويقترب من سلوك البالغين.

☑ التحول من فترة يكون فيها كل النشاط الاجتماعي بصورة غير رسمية ولا يخضع لآداب السلوك إلى فترة يكون فيها النشاط الاجتماعي اختياري وخاضع للعرف وآداب السلوك.

☑ التحول من فترة تتسم بالصداقات المؤقتة قصيرة الأمد إلى فترة تتسم بصداقات مستمرة وقوية.

☑ كما تتضمن المراهقة البحث عن الاستقلال الوجداني والاجتماعي والاقتصادي حيث يستخدم المراهق إمكاناته بصورة أكثر نضجًا وعلى مستوى أكثر تعقيدًا ليعطي كما يأخذ ، وليقيم علاقات مع الآخرين ويثق فيهم ويتعلم ما ينفعه وما يضره.

☑ ويمتاز المراهق بميزة تعتبر من أكثر خصائصه وضوحًا في المراهقة المبكرة وهي التمزق وعلى الأخص في نظر الكبار الذين يركزون على مقاومته لسلطتهم ونقده لهم وحساسيته الزائدة لآرائهم المتعلقة بنومه وخروجه ونوعية أصدقائه. ومن علامات التمزق أيضًا أنانية المراهق الطفلية وحبه لذاته بغض النظر عما يسبب للكبار من مضايقات.

☑ ويبدو على المراهق في هذه المرحلة أيضًا حب استطلاع زائد نحو نفسه ونحو بيئته فيقوم بالعديد من التجارب للكشف عن قدراته ونواحي قوته، وتكثير أسئلته التي يستفسر فيها عن الواقع وعن المثالية التي يتعلمها، وتكثر تبريراته للمواقف التي يشعر أنها غير ملائمة محاولًا بذلك النجاح.

☑ يهتم المراهق كثيرًا بالتوافق للتغيرات الجسيمة السريعة، فيتخذ وضعًا جسيمًا معينًا ليخفي ما يعتقد أنه عيب فيه، ويفرط أحيانًا في الأكل ليعوض النقص في

وزنه والناتج عن سرعة النمو، أو عن طريق رد الفعل الانفعالي للارتباك الناتج عن التغيرات الجسمية المفاجئة غير المناسبة.

☑ تظهر في هذه المرحلة للمراهق اهتمامات مهنية في محاولة منه للاستقلال، كما تظهر لدية اهتمامات باختيار ملابسة وأصدقائه بنفسه دون تدخل من والدية، كما تدفعة رغبته في الاستقلال إلى زيادة معارفه عن قدراته وميوله ومعلوماته.

☑ يراجع المراهق قيمة التي اكتسبها في مرحلة الطفولة ويبدأ بالبحث عن قيم جديدة، وقد يناصب الشخص الذي كان يحترمه في طفولته العداء، ويهتم كثيرًا بالصواب والخطأ، ويدافع بقوة عن قيم رفاقه الذين ينتمي إليهم.

وتشير نتائج بعض الدراسات إلى أن المراهقين الذكور يهتمون بشكل كبير بالآتي:قصر القامة والسمنة، وضعف البنية، وضعف القوة الجسمية، والشكل غير الطبيعي للوجه، والنمو غير الطبيعي في منطقة الحلمات، وحب الشباب، ونمش الوجه واليدين.

أما البنات فتدور اهتماماتهن حول ما يلي:الطول الزائد والسمنة وشكل الوجه، والمظهر الجسمي العام، والنحافة، وصغر الثديين وحب الشباب، والشعر وضخامة الفخذين.

وإضافة إلى ذلك يعتبر المراهقين من الجنسين أن للمشاكل الاجتماعية والوجدانية والصداقات والعلاقة مع الوالدين والأشقاء والمشكلات التحصيلية والعلاقة مع المدرسين وتنظيم الوقت من المشكلات الملحة أيضًا.

ومن هنا تبدو أهمية إرشاد المراهقين في النقاط التالية:

❐ الحاجة إلى الإرشاد العلاجي:

يكاد يكون الإرشاد في المدرسة المتوسطة والثانوية في الوقت الحاضر في معظمة إرشادًا علاجيًا. فهو يقدم للطالب الذي يفشل في فصلة خدمة علاجية من خلال محاولة الإخصائي بحث الأمر معه ومحاولة فهم ما إذا كان فشله يرجع إلى تقصيره، أم راجع لخصائصه الشخصية أم للفصل الذي يدرس فيه أم لأسباب أخرى، يقدم الإخصائي أيضًا خدمات علاجية لأولئك الطلاب الذين يجدون صعوبة كبيرة في اتصالهم بأندادهم أو بعائلاتهم بقصد تحقيق إصلاح أفضل لأوضاعهم. ويقترح المنظرون في الإرشاد أن برامج الإرشاد التي تنظم إما لمنع القصور أو لمساعدة الفرد في مجال نموه العادي أن تكون برامج علاجية.

❐ الحاجة إلى الإرشاد الوقائي:

إن الحاجة إلى الإرشاد حاجة عامة، وهذه الحاجة ليست مقتصرة على فترة الطفولة والشباب، بل الحاجة إليها موجودة في كل مرحلة من مراحل العمر، حيث يحتاج الفرد إلى المساعدة في الاختيار أو التنظيم أو حل المشكلة. وهذه الحقيقة ظاهرة في المجهودات المتزايدة التي تثبت حاجة المسنين الذين تقاعدوا أو الذين هم على وشك التقاعد وكذا المعوقين من جميع الأعمار إلى هذا النوع من المساعدة. إن الإرشاد يجب أن يكون في تقدم مستمر على مدى الحياة لهؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدة.

ومن الواضح على كل حال أن أهم وأكثر فترة لها تأثيرها وحاجتها الشديد للمساعدة في الفترة التي تتشكل فيها العادات والاتجاهات والمثل العليا، وحتى يتطور أسلوب المساعدة الذاتية، فإن إعطاء الإرشاد في هذه الفترة سوف يقلل إلى حد كبير الحاجة إلى المساعدة فيما بعد، وسيزيد من القدرة على اختيار المهنة والنشاطات المدنية والاجتماعية بحكمة في حياة الشباب. فالإرشاد الوقائي في المدارس المتوسطة والثانوية يقلل الحاجة للإرشاد العلاجي فيما بعد.(فاروق عبد السلام وآخرون، ١٩٩٧).

دور الإخصائي النفسي المدرسي في إرشاد المراهقين:

غالبا ما يتشكك المراهق عند الدخول في علاقات جديدة مع الآخرين أو عند طلب الدعم العاطفي والانفعالي من أحد، لذا يجد المراهق صعوبة كبيرة في الوثوق بالإخصائي النفسي وخاصة إذا ما أجبر على التوجه إليه من قبل الوالدين أو إدارة المدرسة وذلك بسبب ما يتعرض له المراهق من اللوم والتوبيخ لما يعترضهم من مشكلات سواء كان ذلك في محيط الأسرة أو المدرسة أو المجتمع بشكل عام، ولذلك نجدهم يترددون في طلب الخدمات النفسية من تلقاء أنفسهم ولذا يتعاظم دور الإخصائي النفسي في التعامل مع المراهقين حتى يستطيعون الوثوق به، ولذلك فقد حددت ممدوحة سلامة (١٩٩٢) عدد من المهام التي يكلف بها الإخصائي النفسي المدرسي عند تعامله مع الطلاب في مرحلة المراهقة، وهي:

(١) المهمة الرئيسية أمام الإخصائي النفسي هي المحافظة على إقامة علاقات مهنية مع الطلاب تختلف عن علاقتهم بأولياء أمورهم، ورموز السلطة في حياتهم، ومنذ بداية هذه العلاقة ينبغي أن يوضح الإخصائي النفسي دوره بدقة مع إيضاح الدور الذي يمكنه تقديمه وكيف يحافظ على خصوصية وسرية المقابلات وما يدور فيها.

(٢) ينبغي أن يقوم الإخصائي النفسي منذ اللحظة الأولى في علاقته بالطالب بإقناعه بأنه ليس عضوا في مؤامرة يحيكها الكبار له وأنه ليس متحالفًا مع الوالدين أو سلطات المدرسة ضده وأنه يعمل لصالحه.

(٣) ينبغي أن يكون الإخصائي النفسي صريحًا، بسيطًا دون التقليل من شأن مؤهلاته ودون التفاخر العلمي والمهني، فالمراهق لديه القدرة على التقاط التصنع والادعاء العلمي.

(٤) كثيرا ما يؤدي دخول الإخصائي النفسي في مناقشة تلقائية حرة مع الطالب إلى شعور الطالب باحترام الإخصائي النفسي له مما ينعكس بدوره على زيادة ثقته بنفسه وبقدرته على تناول المشكلات وتقرير المصير، هذا علاوة على ما يتبعه النقاش من خفض للتوتر بطريقة بناءة.

(٥) ضرورة تحديد وفرض حدود معينة، فكثيرا ما يفسر المراهق عدم فرض ضوابط أو حدود معينة على سلوكه على أنه إما عدم اهتمام أو عدم فهم من جانب الإخصائي النفسي لذلك ينبغي أن يكون الإخصائي النفسي قادرا على فرض ضوابط - عند الضرورة - دون أن يحمل ذلك مشاعر كراهية أو عداء.

(٦) ينبغي أن يأخذ الإخصائي النفسي في الاعتبار أن تحقيق الاستقلال هو من أهم مطالب النمو في هذه المرحلة، لذا فعليه أيضا أن يعي خطورة تشجيع اعتمادية المراهق بل على العكس لابد من توفير خبرات تؤدي إلى الاستقلال والاعتماد على النفس.

الفصل الثامن

أساليب الإرشاد النفسي المدرسي

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على طبيعة وتنفيذ الإرشاد الفردي.
- التميز بين أنواع الإرشاد الجماعي.

الفصل السادس
أساليب الإرشاد النفسي المدرسي

أولا: الإرشاد الفردي:Individual Counselling

وهو يعني " تلك العلاقة المخططة بين الإخصائي النفسي والطالب ، حيث يتم إرشاد فرد واحد وجها لوجه في الجلسات الإرشادية ،و يعتمد في فاعليته على العلاقة الإرشادية المهنية" ويعتبر بعض الإخصائيين أن التعامل مع اثنين أو ثلاثة هو علاج فردي، ويعتبر العلاج الفردي هو نقطة الارتكاز لأنشطة متعددة في كل من برامج التوجيه والإرشاد، ومن الوظائف الرئيسية للإرشاد الفردي تبادل المعلومات وإثارة الدافعية لدى الفرد وتفسير المشكلات ودفع خطط العمل المناسبة، وإن كان يحتاج هذا النوع من الإرشاد إلى توافر عدد كبير من الإخصائيين النفسيين لمواجهة الحاجات الفردية للإرشاد، ويتراوح وقت الجلسة الإرشادية الفردية ما بين (٣٠: ٦٠) دقيقة، ويتحدد طول وقصر الفترة الزمنية على عدة اعتبارات منها:الهدف من الجلسة الإرشادية، وطبيعة المشكلة، وخصائص الفرد.

حالات استخدام الإرشاد الفردي:

يستخدم الإرشاد الفردي مع الطلاب الذين يعانون من المشكلات ذات الطابع الشخصي والتي لا يصلح عرضها أمام الآخرين كما في العلاج الجماعي، أي تلك الحالات التي تتطلب درجة من السرية، ومن بين تلك المشكلات، ما يلي:

(١) المشكلات الاجتماعية: كانعكاس المشكلات ذات الطابع الأسري علي ما يعانيه التلميذ من آثار نفسية وتحصيلية، مثل حالات الطلاق، والهجر، ووفاة أحد الوالدين، والخلافات الزوجية الحادة..وغيرها.

(٢) المشكلات النفسية: مثل التي تحدث بسبب إصابة التلميذ بأحد الأمراض الخطيرة أو إعاقات جسدية أو حسية، أو المشكلات النفسية التي تحدث نتيجة لما يعانيه التلميذ من اضطرابات نفسية كالوحدة النفسية، أو السلوك العدواني، أو المخاوف المرضية.

(٣) المشكلات المدرسية: ومن بينها مشكلة التسرب المدرسي، والرسوب المتكرر، وصعوبات التعلم، والغياب المستمر، وغيرها من المشكلات ذات الطابع المدرسي.

ولقد أوضح محمد سعفان (٢٠٠١) هناك مجموعة من أنماط الأشخاص الذين يصلح معهم الإرشاد الفردي وهم على النحو التالي:

(١) يصلح الإرشاد الفردي مع الطلاب أصحاب التوجه النفسي، أي الذين ينظرون إلى مشاكلهم من زاوية شخصية في المقام الأول، ويرون أنه لا فائدة من التعامل مع الآخرين ولا يكترثون بما يقوله الآخرون، ولديهم استعداد ضعيف للمشاركة الوجدانية، والأغلبية من هؤلاء لديهم ميول للتمركز حول الذات (وإن كان بدرجات مختلفة).

(٢) يصلح الإرشاد الفردي مع الطلاب الذين لديهم أسباب مقنعة أو غير مقنعة للغياب المتكرر عن جلسات الإرشاد الجمعي، لأن كثرة الغياب لا يساعد على تحقيق الأهداف الموضوعة، بالإضافة إلى أنه مضيعة للوقت والجهد، ويجعل هناك تفاوت بين أفراد الجماعة في متابعة وتنفيذ خطوات البرنامج الإرشادي.

(٣) يصلح الإرشاد الفردي مع الطلاب الذين يشعرون بأنهم مرفوضون من الجماعة لاعتبارات تتعلق بالخصائص الجسمية أو العقلية أو الاجتماعية أو الانفعالية، في هذه الحالة يكون الإرشاد الفردي أكثر فعالية في المراحل الأولى لحل المشكلة، ثم يتبعه الإرشاد الجماعي.

(٤) يصلح الإرشاد الفردي أيضا مع الطالب النرجسي الذي لا يهتم بما يدور في محيطه البينشخصي من ناحية ويحاول جذب انتباه الآخرين إليه بصورة متكررة مبالغ فيها لدرجة تجعله يتجهم على الآخرين وينتقدهم ويفرض آراءه عليهم، مثل هذا السلوك من المفترض أن يثير غضب الجماعة، ولذلك يفضل استخدام الإرشاد الفردي مع الطالب النرجسي، في الخطوات الأولى لحل المشكلة ثم يليه الإرشاد الجماعي.

(٥) يصلح الإرشاد الفردي أيضا مع الطالب الذي لديه ميول انسحابية، مثل هذا النمط من الأفراد يصعب أن تقدم لهم خدمات إرشادية من خلال الإرشاد الجماعي، لأن هؤلاء كثيرا ما يشعرون بعدم جدوى وجودهم مع جماعة، وربما يكون لديهم مشكلات مرتبطة بوجودهم مع الآخرين مثل رهاب التحدث أمام الآخرين، وفي هذه الحالة يكون الإرشاد الفردي أكثر فعالية.

(٦) يصلح الإرشاد الفردي أيضا مع الطالب المتململ أو المتهيج لأن هذا النمط يسبب الكثير من الإزعاج والغضب لدى أفراد الجماعة.

إجراءات الإرشاد الفردي:

يعتبر الإرشاد الفردي هو تطبيق إجرائي لكل ما تم عرضه من إجراءات تتعلق بالعملية الإرشادية - في الفصل السابق - من بداية تكوين العلاقة الإرشادية مرورا بالتشخيص وتطبيق للفنيات الإرشادية وإنهاء عمليات الإرشاد حتى القيام بعملية المتابعة.

ثانيا: الإرشاد الجماعي: Group Counselling

إن الإرشاد الجماعي لا يمكن أن يكون بديلا عن الإرشاد الفردي، فهناك بعض الطلاب الذين يستجيبون بصورة أفضل في المواقف الجماعية بينما نجد البعض الآخر يحتاج إلى رعاية فردية خاصة، ومنهم من يحتاج إلى النوعين من الإرشاد لمساعدتهم على التوافق السليم، غير أن الجماعة في الإرشاد الفردي، وهذا التأثير مستمد من جانبين، أولهما الإخصائي النفسي نفسه، والثاني هو الجماعة الإرشادية الذين يبذلون الجهد لمساعدة زميلهم، وهذا يؤدي إلى شعور أعضاء الجماعة الإرشادية بالطمأنينة أكثر من مقابلة الإخصائي وحده في الإرشاد الفردي.

حالات استخدام الإرشاد الجماعي:

يستخدم الإرشاد الجماعي في المدارس مع الحالات التالية:

- حالات الطلاب التي لا تتطلب درجة عالية من السرية.
- حالات الإرشاد التربوي والمهني.
- الحالات التي يستخدم معها الإرشاد الوقائي لتنمية أحد جوانب الشخصية كالاستقلالية والانتماء وروح الفريق والقيادة.. وغيرها.

فالإرشاد الجماعي يوفر لكل هؤلاء عددا من المميزات التي يستفيدون منها، هي:

(١) أن الإرشاد الجماعي كفء من حيث التكلفة، فالإخصائي يستطيع أن يرى العديد من الطلاب في وقت واحد.

(٢) يمكن أن توفر المجموعة نوعا من العلاج الوقائي، حيث يمكن للأعضاء أن يسمعوا تجارب الآخرين وهم يناقشون مشاكلهم، تلك المشاكل التي لم يواجهوها من قبل في حياتهم.

(٣) بعض التجارب والنشاطات والتمارين لا يمكن أداؤها إلا في مجموعات كلعب الأدوار مثلا.

(٤) توفر الجماعة ميزة إخراج انفعالات معينة يمكن التعامل معها عندئذ في الواقع في إطار الجماعة.

(٥) بعض المشاكل يتم التعامل معها بصورة أكثر فعالية في إطار المجموعة مثل عيوب المهارات الاجتماعية والتعامل مع الآخرين، ويمكن أن يتدرب الطالب على سلوكيات جديدة وطرق للارتباط بالناس من خلال الجماعة.

(٦) في إطار الجماعة يمكن للطلاب تلقي قدرا من المعلومات عن سلوكهم.

(٧) تتولد في إطار الجماعة الكثير من الاقتراحات التي تتعلق بمشكلة ما مما لو تواجد الإخصائي مع فرد واحد فقط.

ولكن يحذر هنا أن ينضم إلى الجماعة الإرشادية الطلاب الذين لديهم مشكلات سلوكية ونفسية متطرفة كحالات الجناح والعنف والإيذاء الذاتي والاضطرابات النفسية الخ.

شروط الجماعة الإرشادية:

هناك عدة شروط أوضحتها كاميليا عبد الفتاح (١٩٩٨) يجب مراعاتها عند تكوين جماعة إرشادية ومنها ما يلي:

✍ حجم الجماعة: ينبغي أن يكون عدد أفراد الجماعة الإرشادية معقولا فلا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة عشر حتى لا تمثل عبئا ثقيلا على كاهل الإخصائي النفسي وحتى تستفيد الجماعة من فوائد الإرشاد الجمعي.

✍ عمر الجماعة: يعتبر الإرشاد الجمعي ذا فائدة لكل من الأطفال (في عمر المدرسة الابتدائية) والمراهقين، ولكن عند تكوين الجماعة الإرشادية يفضل أن يكون هناك تقارب في عمر الأعضاء وذلك لاختلاف طبيعة كل مرحلة عمرية وحاجاتها وخصائصها والمشكلات التي تميزها عن المرحلة العمرية الأخرى.

✍ جنس الجماعة: إن التجانس أو عدم التجانس في جنس المجموعة الإرشادية يتوقف على العمر الزمني للأعضاء ففي مرحلة الطفولة يمكن أن يشترك البنين والبنات معا في المجموعة الإرشادية، أما في مرحلة الطفولة المتأخرة ومع بداية مرحلة المراهقة يفضل أن يتم الفصل بين الجنسين عند تكوين الجماعة الإرشادية وذلك لاختلاف طبيعة واهتمامات كل جنس، هذا إلى جانب أن هناك موضوعات عند إثارتها قد تسبب الشعور

بالخجل أمام الجنس الآخر وخاصة في مرحلة المراهقة مما قد يكون له تأثير سلبي على العملية الإرشادية.

✍ الذكاء: لاشك أن وجود طالب بين مجموعة إرشادية معظم أفرادها أعلى منه في مستوى الذكاء سوف تؤثر عليه سلبا، أما إذا كان المستوى العقلي لأحد الطلاب أعلى من معظم أفراد المجموعة الإرشادية فقد يؤدي ذلك إلى نبذه من باقي زملائه في المجموعة، لذلك يفضل أن يتم التكافؤ في الذكاء إلى حد ما بين أفراد المجموعة الإرشادية.

✍ نوعية المشكلات: إن وجود مشكلات مشتركة بين أفراد المجموعة الإرشادية الواحدة يساعد الطالب على إشباع حاجته إلى الشعور بالانتماء والإحساس بأن الآخرين يفهمونه، وهذا بلا شك يطمئنه إلى أنه لا يختلف عن الآخرين، إذ قد يؤدي الاختلاف والتنوع الكبير في نوع المشكلات إلى صعوبات تتعلق بعمليات التفاهم والانسجام فيما بين أفراد المجموعة.

أساليب الإرشاد الجمعي:

تتنوع الطرق المستخدمة في الإرشاد الجمعي ومن بينها ما يلي:

✍ السيكودراما: تعرف أحيانا بالدراما النفسية أو التمثيل النفسي المسرحي، وتتميز السيكودراما بأنها أسلوب تشخيص وعلاج في نفس الوقت، ويستخدم هذا الأسلوب عادة مع أغلب المشكلات ومع جميع المراحل العمرية.

✍ السيسودراما: يعرف أيضا بالتمثيل الاجتماعي المسرحي، وهو يركز على القواعد الاجتماعية المألوفة للفرد في علاقته مع الآخرين، فهي تتناول المشكلات ذات الطابع الجماعي المتصل بوظيفة الجماعة أو تركيبها كالمشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية العامة والتي تسبب التوتر والاضطراب للمجتمع، وهذا على العكس من السيكودراما التي تهتم بمشكلة عضو معين من أعضاء الجماعة، حيث يكون التركيز على الحياة الشخصية للفرد.

✍ لعب الأدوار: يختلف لعب الدور عن كل من السيكودراما والسيسودراما، في أن لعب الدور يعطي الأشخاص أمثلة ونماذج لكي يقلدونها ويكررونها أما في السيكودراما والسيسودراما فالتركيز لا يكون على التعليم والتقليد بقدر ما يكون التركيز على التلقائية والارتجالية وتنمية القدرة على اتخاذ القرارات.وفي لعب الدور يتم تناول أي موقف يسبب

الاضطراب للطالب بشكل تمثيلي فالطالب الذي يعاني من الخجل والانطواء يمكن أن يستخدم مع هذا الأسلوب في التدريب على تنمية المهارات الاجتماعية المختلفة.

✍ المحاضرات والمناقشات الجماعية: هي طريقة تربوية تستهدف تعديل بعض السلوكيات والأفكار والمعتقدات والاتجاهات لدى بعض الطلاب، ويتم خلالها إلقاء محاضرة حول موضوع الجلسة يتخللها مناقشات مفتوحة وإلقاء أسئلة من جانب الطلاب المشاركين،وعادة ما يقوم الإخصائي النفسي المدرسي بإلقاء تلك المحاضرات، أو إدارة الحوار والمناقشات في حالة استضافة متخصصين في مجالات متنوعة كالطب والدين والسياسة والاجتماع..وغيرها، وتتم المناقشة من جانب الطلاب إما بعد إلقاء المحاضرة أو أثنائها. ويستخدم أحيانا الإخصائي النفسي أو الضيف بعض الوسائل التوضيحية المساعدة من أفلام تعليمية أو كتيبات أو نشرات إرشادية.. إلى غير ذلك من الوسائل التي تعين الطلاب على الاستيعاب والمناقشة.

دور الإخصائي النفسي المدرسي في الإرشاد الجماعي:

يلعب الإخصائي النفسي دورا حيويا في الإرشاد الجماعي، حيث يلقى عليه العبء الأكبر في العملية الإرشادية ومن بدايتها حتى نهايتها، وتتدرج العملية الإرشادية التي يقوم بها الإخصائي النفسي عبر الخطوات التالية:

(١) يبدأ الإخصائي النفسي المدرسي بتكوين مجموعة الإرشاد الجماعي من مجموعة الطلاب الذين يرغبون في مناقشة مشكلاتهم ويجمع بينهم مشكلات متشابهة، ويتم بداية جمع المعلومات عن كل طالب من أفراد المجموعة باستخدام وسائل جمع المعلومات المختلفة ثم يقابل كل فرد على حدة ليتحدث معه عن الإرشاد الجماعي.

وعند اختيار الطلاب لتكوين الجماعة الإرشادية ينبغي التأكيد على الآتي:

- ❖ مدى قدرة كل طالب على التعبير عن مشكلاته داخل المجموعة.
- ❖ مدى استعداد كل منهم للاستماع للآخرين والتعاون معهم.
- ❖ مدى قدرتهم على المثابرة وتحمل المسئولية في مواجهة المشكلات.

(٢) بعد تكوين الجماعة الإرشادية يقوم الإخصائي النفسي المدرسي بالاجتماع بهم في مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء والمشتتات ويبدأ في خلق جو من المودة والصداقة والتفاهم مؤكدا على ضرورة سرية ما يقال حتى يشعر جميع الطلاب بالاطمئنان، ويبدأ كل منهم بتعريف نفسه

للآخرين وعرض مشكلته، وخلال ذلك يحاول باقي الطلاب التركيز على ما يمكنهم ذكره عن مشكلاتهم الخاصة عندما تتاح لهم فرصة للحديث.

(٣) يحدد الإخصائي النفسي المدرسي مواعيد الجلسات بالاتفاق مع باقي الطلاب المشاركين في الجلسة، وهو عادة ما يخصص لذلك إحدى الحصص، ولما كانت مدة الحصص لا تتعدى ساعة فيمكنهم أن يلتقوا مرتين في الأسبوع، وهنا يؤكد الإخصائي على ضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات، لأن عدم الانتظام والتأخير في الحضور يعتبر مؤشرا على عدم اهتمام الطالب، وفي هذه الحالة قد يتم إنهاء عضوية ذلك الطالب.

(٤) يستخدم الإخصائي النفسي أحد أساليب الإرشاد الجمعي كالسيكودراما أو السيسودراما أو لعب الأدوار..وغيرها، ويتوقف اختيار نوع الأسلوب المستخدم على نوع المشكلة المعروضة.

(٥) يقوم الإخصائي النفسي بإنهاء الجلسات الإرشادية بعد تحقيق الأهداف المحددة مسبقا والانتهاء من إجراءات العملية الإرشادية وتقييم ما يتم تحقيقه ثم كتابة التقرير الختامي.

ثالثا: الإرشاد باللعب:

إن الأسس النفسية التي يرتكز عليها الإرشاد باللعب تقوم على أساس التنفيس الانفعالي أو تفريغ الشحنات الانفعالية المكبوتة داخل الفرد عن طريق اللعب، حيث يكشف من خلالها عن وإحباطاته وصراعاته وعلاقته بأفراد أسرته والمحيطين به الذين يمثلهم بالدمى التي يلعب بها، ويترك هذه المشاعر تطفو إلى السطح وهو يواجه مشاعره هذه بعد ذلك ويتعلم أن يضبطها أو يتحكم فيها أو يتخلى عنها، ويختلف اللعب في مراحل النمو المختلفة.. ففي مرحلة الطفولة يلاحظ أن اللعب بسيط وعضلي ثم تدخل عمليات التفكير والذكاء في لعب الطفل، وفي الطفولة المبكرة يكون اللعب في جملته فرديا، ثم يتجه إلى المشاركة مع الآخرين، ويحاول تقليد الكبار ولعب أدوارهم ويستخدم خياله بدرجة كبيرة، ثم يكون الطفل أصدقاء اللعب وتظهر أهمية السلوك الاجتماعي، ويتمايز لعب الذكور عن الإناث.. فنجد الذكور يهتمون بالفك والتركيب وألعاب العنف والحرب، بينما تهتم الإناث بالألعاب المهارية التي يقمن فيها بدور الأمومة والألعاب

المنزلية، وفي مرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة المراهقة تظهر الألعاب الجماعية ثم الهوايات وتبزغ الميول والاهتمامات.

أنواع الألعاب وشروطها:

تختلف المواد المستخدمة في اللعب باختلاف سن الطالب وقدراته العقلية، والجسمية، والانفعالية، وأيضا باختلاف جنس الطالب، وينبغي أن تتوافر في هذه الألعاب مجموعة من الشروط لتحقيق الفائدة المرجوة منها.. ومن المواد المستخدمة في الألعاب ما يلي:

- بيت اللعب: ويتضمن عرائس مطاطية تمثل الرجال والنساء والأطفال التي تعبر عن أفراد الأسرة والأشخاص المحيطين به.
- ألعاب العنف: مثل المسدسات، والبنادق، والدبابات، والطائرات، والغواصات، والبوارج الحربية.. وغيرها
- آلات موسيقية: مثل الطبلة، والمزمار، والبيانو، والجيتار، والأورج، والرق،.. وغيرها
- الأدوات الفنية: مثل الألوان (المائية، والشمعية، والخشبية..) وكراسات الرسم، والصلصال.. وغيرها
- الأدوات الرياضية: مثل الكرة بأنواعها، والمضارب، وقفازات الملاكمة، وملابس السباحة.. وغيرها
- أدوات المهن المختلفة: كأدوات الطبيب، والنجار، والمهندس، والجزار، والميكانيكي.. وغيرها
- ألعاب وسائل المواصلات: مثل السيارات، والطائرات، والسفن، والمناطيد.. وغيرها
- ألعاب متنوعة: مثل دمى الحيوانات،وإناء الرمل والماء، والجواريف، والحبال.. وغيرها

أما الشروط الواجب توافرها في هذه الألعاب ما يلي:

(١) تصنع بحيث لا تكون مؤذية أو ضارة.

(٢) تثير التشويق والاهتمام، أي يتوافر فيها عنصر الجذب.

(٣) تقاوم أقصى درجات العنف المحتمل أن يصدر عن طفل عدواني.

(٤) أن تتناسب والقدرات العقلية والجسمية والانفعالية لمستخدمها.

تقسيم الألعاب:

تقسم الألعاب وفقاً لعدد من الجوانب منها عدد المشتركين في اللعبة، أوحسب طبيعة اللعبة أو حسب نوع النشاط.. وفيما يلي تفصيل هذه التقسيمات:

(١) حسب عدد المشتركين:

أ - اللعب الفردي: وفيه إما أن يقوم الطفل باللعب بمفرده تماما أو أن يلعب في حضور طفل آخر أو عدد من الأطفال ولكن كل منهم يلعب بألعابه الخاصة به بمفرده دون الاشتراك مع الأطفال الآخرين وغالبا ما يكون هذا النوع من الألعاب في عمر مبكر من حياة الطفل حينما لا يتعدى عمره الثلاث سنوات، وغالبا ما يكون اللعب في هذه المرحلة من النوع الاستكشافي.

ب - اللعب الجماعي: في هذا النوع من الألعاب يشترك الطفل مع طفل آخر في اللعب أو مع مجموعة من الأطفال الآخرين، وهي تشمل الألعاب التي يقلد فيها الأطفال الآخرين، ويعد هذا النوع المفضل للأطفال من عمر ثلاث سنوات حتى الرابعة. أما الأطفال من عمر أربع إلى ست سنوات فهم غالبا يفضلون الألعاب التي تتضمن تقليدا للآخرين يتبعها أوامر محددة، أما بالنسبة للأطفال الأكبر من عمر السادسة فإنهم يفضلون الألعاب الجماعية ذات القواعد المحددة والتي تخضع لأسس وتعليمات يلتزم بها اللاعبون ككرة القدم واليد والطائرة.. وغيرها من الألعاب الجماعية.

(٢)حسب طبيعة اللعب:

أ -اللعب الحر: ذلك النوع من الألعاب يكون تلقائيا وارتجاليا، لا يخضع لقواعد أو تنظيم محدد، فالطفل يلعب وقتما يشاء ويكف حينما يريد، ولا يستخدم فيه أدوات للعب فهو يعبث بأي شئ يصادفه وهي غالبا ألعاب فردية استكشافية فهذا النوع من الألعاب ينمي خيال الطفل.

ب - اللعب الإيهامي: يعرف أيضا باللعب الدرامي، ويقوم الأطفال خلاله بتمثيل أدوار للشخصيات التي يحبونها في الحياة الحقيقية، ويكون في البداية من خلال العرائس والدمى التي تمثل الحيوانات فالبنت تلعب دور الأمومة مع عروستها، والولد يلعب بالعصا على إنها حصان أو بندقية.. وهكذا ثم يتطور إلى أن تستبدل هذه العرائس برفاق السن وكل منهم

يأخذ أحد الأدوار المحببة إليه ويقوم بأدائها فمنهم من يقوم بدور الطبيب والآخر يقوم بدور المعلم.. وهكذا، وكلما تقدم الأطفال في العمر أصبحت ألعابهم الدرامية أكثر تعقيدا.

ج - اللعب التكويني: أو ما يعرف "بألعاب البناء" وتلك الألعاب يستخدم فيها أدوات اللعب التي يقوم فيها بالفك والتركيب لعمل أشياء ليست لغرض نفعي ولكن بغرض الاستمتاع بما يفعلون، ويستخدم فيه المكعبات الخشبية والطين والصلصال وأدوات الرسم، وهذا النوع من الألعاب يعمل على تنمية بعض العمليات العقلية لديهم كالقدرة على التركيز والملاحظة والانتباه.

٣ - حسب نوع النشاط:

أ - اللعب الكلامي: وهو نوع من اللعب الذي يستخدم الرموز والأصوات والكلمات للتعبير عنه، وهذا النوع يعتبر قاسما مشتركا في كثير من أنواع اللعب، ومن بين الألعاب الكلامية الألعاب السؤالية، والألغاز، والأناشيد وإطلاق المسميات الحقيقية والخيالية.

ب - اللعب الحركي: يشمل اللعب الحركي ألعاب تعود الطفل على تنسيق الحركات بشكل خاص، والقيام بحركات قوية لأعضاء الجسم ويتوقف أداؤها على حجم المجهود المبذول فيها ومن أمثلتها (الجري والقفز والوثب..الخ).

ج - اللعب الحسي: يشمل كل نشاط من شأنه تدريب الأطفال على أعمال الحواس المختلفة سواء أكانت حاسة السمع أو البصر أو اللمس أو الشم أو التذوق، الأمر الذي يؤدي إلى قيام أعضاء الحواس بوظيفتها على أكمل وجه، ومن هذه الألعاب الاستماع للموسيقى وترديد الأناشيد وأصوات الحيوانات، وكذلك التمييز البصري ما بين الألوان والأحجام والأطوال، وتنمية التمييز الشمي بالتدريب على التفرقة بين الروائح المختلفة.. وغيرها من أشكال التمييز باللمس والتذوق.

أساليب الإرشاد باللعب:

يبدأ الإخصائي النفسي بتكوين علاقة إيجابية مع الطفل، ويحاول كسب ود الطفل حتى يستطيع الطفل الاطمئنان له، و يرى حامد زهران (١٩٩٨) بأنه ينبغي أن يتبع أحد الأساليب الآتية في الإرشاد باللعب:

١ -اللعب الحر: وهو غير محدد وتترك فيه الحرية للطفل لاختيار اللعب وإعداد مسرح اللعب وتركه يلعب بما يشاء وبالطريقة التي يراها دون تهديد أو لوم أو استنكار أو رقابة أو عقاب، وقد يشارك الإخصائي في اللعب وقد لا يشارك وذلك حسب رغبة الطالب.

٢ -اللعب المحدد: وهو لعب موجه مخطط، وفيه يحدد الإخصائي النفسي مسرح اللعب ويختار اللعب والأدوات بما يتناسب مع عمر الطفل وخبرته، بحيث تكون مألوفة له حتى تستثير نشاطا واقعيا أو أقرب إلى الواقع، ويصمم اللعب بما يناسب مشكلة الطفل، ثم يترك الطفل يلعب في جو يسوده التعاطف والتقبل، وغالبا يشترك الإخصائي في اللعب، ليعكس مشاعر الطفل ويوضحها له حتى يعرف إمكاناته ويحقق ذاته.

٣ -اللعب بطريقة الإرشاد السلوكي:

هناك بعض الحالات التي يستخدم فيها اللعب بطريقة الإرشاد السلوكي، فمثلا في حالات الخوف من حيوانات يمكن تحصين الطفل تدريجيا بتعويده على اللعب بدمى هذه الحيوانات في مواقف آمنة سارة متدرجة حتى تتكون ألفة تذهب بالحساسية والخوف مبدئيا، ويمكن أن يلي ذلك زيارات لحديقة الحيوانات لمشاهدة هذه الحيوانات في استرخاء دون خوف.

دور الإخصائي النفسي في الإرشاد باللعب:

يقوم الإخصائي النفسي بعد أن يقرر استخدام اللعب كوسيلة إرشادية بعدد من الإجراءات التي تعمل على تحقيق الهدف منه والتي تتمثل فيما يلي:

- ❑ يقوم الإخصائي النفسي بإقامة علاقة مع الطفل يسودها الألفة والتقبل ليطمئن الطفل للأخصائي النفسي ويستطيع أن يمارس حريته في اللعب في جو يسوده الشعور بالأمن.
- ❑ يقوم الإخصائي النفسي باختيار الألعاب التي تتناسب مع ميول كل طفل ومتطلبات المرحلة العمرية التي يمر بها.
- ❑ مع بدء الطفل في اللعب يقوم الإخصائي النفسي بمتابعة أسلوبه في اللعب والأدوار التي يقوم بها من خلال ذلك النشاط ومدى مشاركته للآخرين.
- ❑ يحاول الإخصائي النفسي أن يكون له دور إيجابي في مشاركة الطفل في ألعابه حتى يكشف عن قرب عن الصراعات والإحباطات والجوانب اللاشعورية لدى الطفل.

❑ بعد نهاية اللعب يوجه الإخصائي النفسي للطفل تساؤلات حول الشخصيات التي تمثلها العرائس التي يلعب بها، ولماذا حطم هذه اللعبة، ولماذا أبقى على لعبة أخرى بجانبه.. وغيرها من التساؤلات التي تكشف عن طبيعة المشكلة التي يعاني منها الطفل.

رابعا: الإرشاد السلوكي:

يشير مصطلح الإرشاد السلوكي لوصف عدد من الطرائق الإرشادية التي استحدثت في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن الطرائق الحالية تتباين ما بين العلاج بالتحصين إلى العلاج بالتنفير والعلاج بالغمر والنمذجة.. وغيرها إلا أنها تشترك جميعا في التصورات النظرية، والأساس المنطقي الذي يتبناه بشكل أو آخر كل الممارسين للإرشاد السلوكي ينحصر في أن السلوك العصابي والأنماط الأخرى من الاختلالات إنما هي بشكل غالب مكتسبة، وإذا كان السلوك العصابي مكتسبا فعندئذ يكون من المحتم أن يخضع لقوانين التعلم التي تم الوصول إليها، والمعلومات عن التعلم لا تختص فقط باكتساب أنماط سلوكية جديدة، ولكن أيضا بإضعاف أو إزالة أنماط قائمة من السلوك.

وأبرز الطرق المستخدمة في العلاج السلوكي هي:

- الطرق القائمة على الإشراط الكلاسيكي.
- الطرق القائمة على الإشراط الإجرائي.
- الطرق القائمة على التعلم الاجتماعي.

وفيما يلي توضيح لهذه الطرق، وأهم الفنيات التي تقوم عليها:

أ - الطرق القائمة على الإشراط الكلاسيكي:

ترجع نشأة الإشراط الكلاسيكي إلى عالم الفسيولوجيا الروسي "بافلوف" Pavlov، بينما كان يدرس الأعمال المنعكسة الإرادية الخاصة بعملية الهضم، فأثناء قيامه بإجراء تجربة على كلب أجرى له عملية جراحية عند الفك حتى يحصل على اللعاب الذي يسيل من فم الكلب وقياسه، وبدأ في تقديم الطعام للكلب وقياس اللعاب الذي يسال منه عند رؤية الطعام ثم في المرات التالية سبق تقديم الطعام قرع جرس وهنا قد لاحظ أن سيلان اللعاب من فم الكلب يتم ليس فقط في حالة وضع الطعام وإنما لمجرد رؤية الطعام، ولقد سمي بافلوف سيلان اللعاب في الحالة الثانية بأنها استجابة غير متعلمة أو استجابة غير شرطية، ولكنه أعتقد جازما بأن سيلان اللعاب لمجرد رؤية منظر الأكل هو شئ لا يأتي إلا عن طريق التعلم،

ولذا قام بتعليم الكلب أن يسيل لعابه ليس فقط لمجرد رؤية الطعام وإنما عند تعرضه لمثيرات أخرى لا صلة لها بالطعام مثل سماع صوت جرس أو رؤية ضوء، وهكذا.

وقد استفاد عالم النفس الأمريكي "واطسون" من تجارب "بافلوف" في مجال التعلم فقد أجرى تجربة على طفل صغير ليعلمه خوفا جديدا عن طريق الإشراط، وبدأ "واطسون" يعرض الطفل أثناء نشاطه العادي لمثيرات مثل الفأر، وقد لاحظ أن الطفل يتعامل معه بدون خوف، ثم بدأ يشرط ظهوره بصوت عالي مفاجئ مزعج، فكلما ظهر وبدأ الطفل بلمسه سمع صوت عالي مزعج مما أثار إليه رد فعل الخوف، وظل يكرر هذه التجربة حتى بدأ الطفل يخاف دون أن يسمع الصوت المصاحب لظهوره، وقد انسحب هذا الخوف على كل حيوان يشبه الفأر.

ولقد أكملت "مارى جونز" تحت إشراف "واطسون" علاج الخوف الذي اكتسبه الطفل ونجحت في استخدام الإشراط المباشر وهو ربط موضوع الخوف (الفأر) بمثير سار (الحلوى) بدلا من المثير المنفر (الصوت المزعج) فبعد أن يقدم الحلوى للطفل، وأثناء انشغاله في أكلها يظهر الفأر بعيدا عنه، ومع تكرار هذا الموقف يقترب الفأر رويدا رويدا من الطفل إلى أن يتقبل الطفل وجوده بعد أن كان يخاف منه.

ومن أهم الأساليب التي بنيت على الإشراط الكلاسيكي أسلوب التخلص المنظم من الحساسية أو ما يعرف بالتحصين التدريجي والذي يستخدم بنجاح في علاج الخوف والقلق، وكذلك أسلوب الغمر أو الإغراق، وغيرها من الأساليب الأخرى.

وفيما يلي شرح لبعض الطرق التي تعتمد على الإشراط الكلاسيكي في العلاج:

(١) التحصين التدريجي:

لقد وصف "فولبه" الأسس النظرية التي استمد منها هذا الإجراء في كتاب بعنوان "العلاج النفسي بالكف المتبادل" وقد اقترح فيه أن تقليل الحساسية التدريجي هو أحد أشكال الإشراط المضاد، وما يشير إليه الإشراط المضاد هو إمكانية استخدام قوانين التعلم بهدف استبدال استجابة بأخرى، وكانت الفرضية التي استند إليها "فولبه" في تطوير هذا الإجراء هي أنه بالإمكان محو الاستجابة الانفعالية غير المرغوب فيها كالخوف مثلا إذا استطعنا إحداث استجابة مضادة لها بوجود المثير الذي يسببها، فعلى سبيل المثال لا يستطيع الإنسان أن يشعر بالخوف وهو في حالة استرخاء تام ذلك أن الاسترخاء يكبح هذه الاستجابات الانفعالية.

خطوات إجراء التحصين التدريجي:

تتكون طريقة إجراء التحصين التدريجي عادة من أربع خطوات هي:

أولا: التدريب على الاسترخاء العضلي:

يشير "فولبه" Wolpe (١٩٧٦) إلى أنه ليس هناك تتابع ضروري للتدريب بالنسبة للمجموعات العضلية المختلفة في الجسم، ولكن التتابع المتبع ينبغي أن يكون مرتبا ونظاميا، وقد عبر عن ذلك بقوله: "إنه من خلال ممارستي الخاصة للعلاج هي أن أبدأ بالذراع لأنها مناسبة لأغراض الشرح ولأن استرخاءها يسهل مراجعته والتأكد منه، وتليها منطقة الرأس بعد ذلك لأن أكثر التأثيرات المثبطة للقلق نحصل عليها غالبا بالاسترخاء في تلك المنطقة" ويستطرد "فولبه" ويذكر أن معظم المرضى يكون نجاحهم محددا عندما يجربون الاسترخاء لأول مرة ولكنهم يطمئنون بأن الاسترخاء الجيد يتطلب الممارسة المستمرة، وإذا كانت (٢٠) دقيقة من الاسترخاء في بداية التدريب قد لا تحدث الاسترخاء إلا للذراع مثلا، فإنه سيكون من الممكن في نهاية التدريب إرخاء الجسم كله في خلال دقيقة أو دقيقتين، ولكن في الوقت نفسه هناك بعض الأفراد المحظوظين الذين يشعرون في المحاولة الأولى باسترخاء عميق وممتد للذراعين ومصحوب بتأثيرات عامة مثل الهدوء والميل إلى النوم.

وغالبا ما يبدأ التدريب بفترات قصيرة ثم بعد ذلك سيجد الطالب سهولة في الوصول إلى حالة الاسترخاء بعد مدة ست ساعات ونصف من الجلسات ويتم ذلك عن طريق التدريب المستمر ثم تكرار المراحل التي تم التدريب عليها يوميا في المنزل. وسوف يتم عرض نموذج عملي في الفصل السادس للتدريب على الاسترخاء في إطار علاج مشكلة المخاوف الاجتماعية لدى بعض الطلاب.

ثانيا: تحديد المنبهات المثيرة للقلق:

عادة ما يبدأ الإخصائي النفسي بناء مدرجات القلق أو الخوف المرضي في نفس الوقت الذي يتم فيه تدريب الطلاب على الاسترخاء، ولكن ما ينبغي الاحتياط إليه أن يتم الحصول على المعلومات اللازمة لمدرج القلق أو الخوف عندما يكون الطالب في حالته العادية بعيدا عن تدريبات الاسترخاء، فما يريده الإخصائي هو الكشف عن استجابات المريض الاعتيادية والتي ستكون موضع الدراسة والبحث.

ولقد تم تحديد أربعة مصادر رئيسية من أجل الحصول على معلومات يكون لها الدور البارز في مرحلة تكوين مدرج القلق أو الخوف، وهي:

١ - تاريخ حالة الطالب.

٢ - استجابات الطالب على اختبارات معينة (تتعلق بالقلق أو المخاوف المرضية).

٣ - استجابات الطالب على أسئلة الذي يقوم به الإخصائي وكذلك رأي الأقران عن طريق مقابلاتهم بحيث يكون ذلك بعد موافقة الطالب.

٤ - رأي الإخصائي وتحليله للموقف الذي أدى إلى القلق أو الخوف لدى الطالب.

كما يمكن كذلك تكليف الطالب _ كواجب منزلي _ بأن يعد قائمة لكل شئ يخطر بباله يمكن أن يرعبه أو يزعجه أو يضايقه أو يجرحه على أي نحو، وذلك بعد أن يتم استبعاد المواقف التي يمكن أن تسبب الرعب لأي شخص مثل "رؤية أسد جائع".

وبعد تحديد مصادر القلق وتقسيمها إلى مجموعات فإن الإخصائي يتولى تحديد ما يحتاج منها إلى علاج، فهناك مخاوف ذات طبيعة تكيفية يحتاجها الفرد في حياته (فالطالب الذي يخاف مسايرة زملائه في المدرسة في التدخين في دورات المياه لا يمكن أن نعالجه من هذا الخوف فهو خوف مرغوب وصحي وله قيمته التكيفية).

ثالثا: تدريج المنبهات المثيرة للقلق:

بعد أن يتم حصر جوانب القلق الرئيسية التي سوف يتم علاجها وبعد أن يتم الحكم بأن تلك المواقف رئيسية وليست هامشية تبدأ مرحلة أخرى من العلاج، حيث يضع الإخصائي المواقف المثيرة للقلق في قائمة مدرجة، أي قائمة من المواقف التي تستثير القلق في حياة الطالب بدرجات متفاوتة بحيث يوضع الموقف الذي يستثير أعلى درجة من القلق في أعلى القائمة ويوضع أقلها استثارة في أسفل القائمة.

وفي بعض الأحيان وأثناء علاج الطالب وعند عرض مثير ما عليه نلاحظ أنه أبدى كمية غير متوقعة من القلق، وهذا بعد أن تم عرض بعض المثيرات عليه في المراحل السابقة وكانت المحاولات ناجحة، لهذا فإن مثل هذا الموقف _ أي في حالة ظهور درجة كبيرة من القلق _ يتطلب هذا من الإخصائي العودة ثانية إلى الخطوات السابقة في مدرج القلق والتي هي أخف قلقا، حتى يدخل الخطوات الجديدة، والناقصة داخل خطوات مدرج القلق.

لذلك يمكن للأخصائي إجراء بعض التعديلات على مدرج القلق الذي وضعه، وذلك بعد عمل تجربة استطلاعية يختبر من خلالها صلاحية المثيرات وتدرجها المنطقي وكفايتها، كما يمكن للأخصائي الاستغناء عن مثير ما، أو عن خطوة معينة وذلك إذا

وجد أنها لا تؤدي إلى ضرر في سير عملية العلاج، وأنها لا تسبب قلقا ملحوظا، ويمكن للأخصائي إعادة البحث عن مثيرات أخرى يمكن إضافتها وتؤدي إلى إثارة درجة من القلق لدى الطالب.

ولإيضاح هذه الخطوة سنقدم هرم القلق التالي الذي وصفه "فولبه" Wolpe(١٩٥٨) والذي كان قد تم إعداده لمعالجة طالبة كانت تعاني من قلق شديد من الامتحانات:

- أربعة أيام قبل الامتحان.
- ثلاثة أيام قبل الامتحان.
- يومان قبل الامتحان.
- يوم واحد قبل الامتحان.
- ليلة الامتحان.
- الطالبة في طريقها إلى الجامعة يوم الامتحان.
- الطالبة تقف أمام باب قاعة الامتحان.
- الطالبة بانتظار توزيع أوراق الامتحان.
- ورقة الامتحان بين يدي الطالبة.
- أثناء الإجابة عن أسئلة الامتحان.

رابعا: إجراء عملية التحصين:

تلك هي الخطوة الأخيرة في تقليل الحساسية التدريجي والتي تشتمل على إقران المثيرات التي تبعث على القلق لدى الطالب بالاستجابة البديلة للقلق (الاسترخاء) فبعد أن يتم تدريب الطالب على الاسترخاء، وإعداد مدرج القلق، تبدأ عملية التخلص التدريجي من الحساسية والتي تتم إما في الواقع الملموس أو عن طريق التخيل وهو الأكثر شيوعا، وإذا كان الطالب لديه أكثر من نوع من القلق وأعد له أكثر من مدرج فإن العلاج يركز في البداية على أكثر هذه المدرجات أهمية بالنسبة له.

وفي جلسة التحصين الأولى التي دائما ما تكون استكشافية، يبحث الإخصائي عن عائد المعلومات عن حالة الطالب، سائلا إياه أن يقرر مدى القلق الذي يشعر به، فإذا كان صفرا أو يقترب من الصفر _ وفقا للقياس الذاتي _ يمكن أن نبدأ في تقديم المناظر، أما إذا كان الطالب لا يزال يشعر ببعض القلق برغم أنه يبذل أقصى جهد في الاسترخاء، يمكن أن يتخيل

بعض المناظر التي يشعر فيها بالراحة "كأن يتخيل أنه في يوم صيفي هادئ مستلقيا على عشب لين ويراقب السحاب وهي تتحرك ببطء.. وهكذا.

بعد ذلك يطلب من الطالب أن يتخيل عددا من المناظر التي ستوصف له، وأن يرفع إصبع يده اليسرى حين يبدأ في تخيل المنظر الذي يتعين عليه أن يستمر في تخيله له دون قلق لمدة لا تقل عن (١٠) ثوان منذ رفع إصبع يده اليسرى، ويطلب منه أيضا أن يرفع إصبع يده اليمنى حينما يشعر بالقلق أثناء تخيل المنظر السابق، وأن ينهي تخيله لهذا المنظر والعودة إلى الاسترخاء عن طريق تخيل منظر سار له شخصيا، ولا ينتقل الطالب إلى المنظر التالي في القائمة قبل أن يتمكن من تخيل المنظر مرتين على الأقل دون رفع إصبع يده اليمنى والاسترخاء لفترة وجيزة بين المرتين.

وفي الجلسة التالية من التحصين والتي تكون بعد يوم أو أكثر، فإن الإجراءات تتوقف على ما حدث في الجلسة السابقة، فالمشهد الذي لم ينتج عنه أي إزعاج على الإطلاق يتم استبعاده، وبدلا منه يتم تقديم البند الذي يليه صعودا في المدرج، أما المشهد الذي كان مزعجا بدرجة هينة فيتم تقديمه من جديد دون تغيير.

وعادة ما تدوم جلسة التحصين التدريجي حوالي (٢٠:٦٠) دقيقة، ويمكن أن تطول هذه الفترة إذا وجد هناك ما يتطلب ذلك، وعادة فإن فترة (٢٥) دقيقة التي تناسب جلسة العلاج تسمح بتقديم (٤ -٥) مشاهد وعادة ما يستغرق المشهد من (٥:١٥) ثانية.

(٢)الغمر:

هو أحد أساليب الإشراط الكلاسيكي ويطلق عليه أحيانا العلاج بالإغراق أو الإفاضة، ويرجع الفضل في هذا النوع من العلاج إلى "جرافتس" Grafts ، ولكن أول من بدأ العمل بهذه الطريقة هو "ماليسون" Mallesan عام ١٩٥٩. وتقوم هذه الطريقة على وضع الفرد في مواجهة المثيرات أو المواقف المقلقة أو المخيفة بصورة مباشرة، فالافتراضات التي تقوم عليها تلك الطريقة هو أن تجنب الشخص للمثيرات والاستجابات التي تسبب له القلق والخوف يبعده عن الشعور بالقلق والخوف هي افتراضات خاطئة حيث أن استجابات الفرد التجنبية تؤدي إلى إزالة الشعور بالقلق والخوف، وبل على العكس تماما فهي تعمل على تعزيزه وعودته مرة أخرى.

أنواع الغمر:

أ -الغمر بالواقع Flooding

يعتمد الغمر بالواقع على إرغام الفرد القلق على مواجهة المواقف التي تقلقه أو تخيفه بشكل مباشر مع عدم السماح له بمحاولة تجنبها، ويهدف ذلك إلى أن يدرك الفرد أن الشيء الذي يخيفه لن يترتب عليه النتائج التي كان يتوقعها فإن كان الفرد يخاف من الأماكن المرتفعة يتم الصعود به مرة واحدة إلى أحد الأبنية الشاهقة، وإذا كان يخشى الأماكن المزدحمة يتم الذهاب به إلى أحد المراكز التجارية المزدحمة، وإن كان وجوده داخل أماكن ضيقة يسبب له الضيق يتم وضعه في أحد المصاعد أو أحد الغرف الضيقة لفترة من الوقت.

ب - الغمر بالتخيل Implosive

تعتمد هذه الطريقة على مدى قدرة الفرد على التخيل، حيث يطلب الإخصائي النفسي من الطالب أن يتخيل أحد المواقف التي تخيفه كالخوف من الثعبان، فمثلا يطلب منه أنه يواجه ثعبانا ضخم ومفترس وهو يلتف حوله ولا يستطيع مقاومته..وهكذا، والعلاج بالغمر يبدأ مباشرة بالموقف المثير حتى يصل الفرد إلى الحد الأقصى من القلق أو الخوف، ليس ذلك فحسب، بل يقوم الإخصائي بتهويل الأمر وذلك بهدف إبقاء الطالب في حالة من القلق الشديد لمدة طويلة.

ب - الطرق القائمة على الإشراط الإجرائي:

يرجع الفضل في نشأة الإشراط الإجرائي إلى عالم النفس الأمريكي "سكينر" Skinner ومن المعلوم أن الإشراط الإجرائي يكمل الإشراط الكلاسيكي حيث أن معظم المبادئ الخاصة بهما متشابهة، ولكن على أية حال فإن شروط التجربة وظروفها تختلف في النوع الأول إلى النوع الثاني، كما تختلف بعض المقاييس المستخدمة في قياس قوة الإشراط في الحالتين.

ولتوضيح ذلك نورد التجربة التي قام بها "سكينر" للحصول على إشراط إجرائي في المعمل، حيث قام بوضع فأر جائع في صندوق (أطلق عليه صندوق سكينر) ولا يوجد بهذا الصندوق سوى رافعة أو قضيب يوجد تحته طبق للطعام كما يوجد فوقه ضوء يمكن إضاءته حسب رغبة المشرف على التجربة.

يقوم المشرف على التجربة بربط مخزن الطعام مع الرافعة بحيث أنه كلما قام الفأر بالضغط عليها فإن قطع الطعام تنزل إلى الطبق الموجود تحتها، وبعد أن يفرغ الفأر من أكل الطعام فسرعان ما يضغط على الرافعة مرة ثانية.. وهكذا، وهنا يصبح تقديم الطعام معزز لحركة الضغط على الرافعة، فإذا ما تم فصل مخزن الطعام عن الرافعة بحيث لا ينزل إذا ما ضغط عليها، فإن معدل القيام بعملية الضغط سوف ينخفض، أي أن الاستجابة الإجرائية تأخذ في الانطفاء نتيجة لعدم التعزيز تماما.

وقد تعددت الفنيات القائمة على الإشراط الإجرائي وقد تم تقسيمها إلى:

- فنيات لتنمية السلوك المرغوب ومن بينها: التعزيز، والتشكيل.. وغيرها.
- فنيات لتقليل السلوك غير المرغوب فيه ومنها: العقاب والانطفاء.. وغيرها.

أولا: فنيات تنمية السلوك المرغوب:

(١) التعزيز:

ركز "سكينر" Skinner على قيمة التعزيز وذكر أن تعلم أي سلوك يجب أن يقسم إلى خطوات صغيرة متتابعة وتعزز كل خطوة تتم بنجاح، وكل خطوة يجب أن يتم تعلمها بدرجة صحيحة وتعزز قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، وبطبيعة الحال يجب أن ترتب الخطوات الواحدة تلو الأخرى بحيث تؤدي السابقة إلى اللاحقة وتعتبر بمثابة تهيئة لها.

أشكال التعزيز:

١ -التعزيز الأولي والثانوي:

التعزيز الأولي: هو ذلك المثير الذي يؤدي بطبيعته إلى تقوية السلوك دون تعلم أو خبرة سابقة، وهناك نوعان من التعزيز الأولي هما التعزيز الأولي الإيجابي مثل (الطعام والشراب والدفء..) والتعزيز الأولي السلبي (كالبرد الشديد والحر الشديد، والألم..) وكل من المعززات الأولية الإيجابية والسلبية حيوية بالنسبة لاستمرار حياة الفرد.

أما التعزيز الثانوي: فهو ذلك المثير الذي يكتسب خاصية التعزيز من خلال اقترانه بالمعززات الأولية، ولهذا فقد سمي بالمعزز المتعلم، ومن أمثلته المال والإطراء (المديح)، واللوم والحب فهي مثيرات يتعلم الفرد أن يقدرها، ولهذا فإن معظم المعززات التي تستخدم في الحياة اليومية وفي برامج تعديل السلوك هي معززات ثانوية.

٢ -التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي:

التعزيز الإيجابي: يعني ظهور مثير معين بعد السلوك مباشرة مما يؤدي إلى احتمال حدوث هذا السلوك في المستقبل في المواقف المشابهة، كثناء المعلم للطالب بعد إجابته عن السؤال بصورة صحيحة، ومن أمثلة التعزيز الإيجابي المعززات الغذائية، والاجتماعية، والرمزية، والمادية.. وغيرها.

أما التعزيز السلبي: فهو يعني إزالة مثير سيئ (شيء يكرهه الفرد) بعد حدوث السلوك المرغوب فيه مباشرة مما يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث السلوك بنفس الطريقة في المستقبل في المواقف المماثلة، كحل الطالب للواجب المدرسي لتجنب عقاب المعلم أو تأنيبه الشديد.

٣ -التعزيز الضمني والتعزيز الصريح:

التعزيز الضمني أو ما يعرف بالتعزيز غير الظاهر: هو نوع من التعزيزات الداخلية التي يعزز بها الطالب نفسه مثل تقبله ورضاه عن سلوك ما قام به أو مشاعر الفخر والزهو التي تنتابه لأداء سلوك معين.

أما التعزيز الصريح: هو ذلك النوع من التعزيزات التي تتم بحصول الطالب على تعزيز خارجي سواء أكان هذا التعزيز إيجابيا أو سلبيا.

أنواع المعززات:

المعززات الغذائية: وهي تشمل كافة أنواع الأطعمة والمشروبات التي يحبها الطالب مثل الوجبات الغذائية المتنوعة والفاكهة والحلوى والمشروبات المثلجة والساخنة.. وغيرها.

المعززات المادية: وتشمل كل الأشياء المادية التي يحبها الطالب كالصور وشارات وأوسمة المدرسة وشهادات التقدير.. وغيرها.

المعززات النشاطية: وتشمل مجموعة الأنشطة التي يفضلها الطالب مثل لعب الكرة بأنواعها وركوب الدراجة واللعب في الماء ومشاهدة التليفزيون والرحلات والتنزه والرسم والموسيقى.. وغيرها.

المعززات الاجتماعية: وتشمل الابتسام والتقبيل والربت على الكتف ونظرات الإعجاب والتقدير وتشمل أيضا المعززات اللفظية كالثناء والمديح وكلمات التقدير.. وغيرها.

المعززات الرمزية: وتشمل المعززات التي يستطيع الطالب أن يستبدلها فيما بعد بأي شيء من مقصف المدرسة كالحصول على البونات والفيشات وكوبونات النجوم.. وغيرها.

استخدام الإخصائي النفسي لفنية التعزيز:

يستخدم الإخصائي النفسي فنية التعزيز في حالات كثيرة لما لها من مميزات تجعلها في مقدمة كثير من الفنيات الإرشادية الأخرى لتدعيم السلوكيات المرغوب فيها،وقد أوضح سعيد العزة وجودت عبد الهادي (٢٠٠١) هناك عدد من الاعتبارات التي يجب على الإخصائي النفسي أن يضعها في اعتباره عند استخدام فنية التعزيز وهي:

١ - فورية التعزيز: إن أحد أهم العوامل التي تزيد من فعالية التعزيز هو تقديمه مباشرة بعد حدوث السلوك المرغوب فيه فقط فإذا أعطينا الطفل لعبة اليوم لأنه أدى واجبه المدرسي بالأمس قد لا يكون ذلك ذا أثر كبير، فالتأخر في تقديم المعزز قد ينتج عنه تعزيز سلوكيات غير مستهدفة لا نريد تقويتها، قد تكون حدثت في الفترة الواقعة بين حدوث السلوك المستهدف وتقديم المعزز.

٢ - استمرارية التعزيز: يجب أن يقدم التعزيز دائما بعد ظهور السلوك المرغوب فيه في بداية تعلم السلوك الإيجابي، ويجب ألا يتصف التعزيز بالعشوائية، فمن المهم تعزيز السلوك بتواصل في مرحلة اكتساب السلوك وبعد ذلك، أي في مرحلة المحافظة على استمرارية السلوك فإننا ننتقل إلى التعزيز المتقطع.

٣ - كمية التعزيز: يجب تحديد كمية التعزيز التي ستعطى للفرد وذلك يعتمد على نوع المعزز وبشكل عام فكلما كانت كمية التعزيز أكبر. كانت فعالية التعزيز أكثر _ مادامت كمية التعزيز ضمن حدود معينة _ فقولنا للطفل "جيد" قد يكون أقل فعالية من قولنا "رائع جدا" إلا أن إعطاء كمية كبيرة جدا من المعزز في فترة زمنية قصيرة قد يؤدي إلى الإشباع، والإشباع يؤدي إلى فقدان المعزز قيمته، لهذا علينا استخدام معززات مختلفة لا معزز واحد.

٤ - مستوى الحرمان _ الإشباع: كلما كان حرمان الفرد (أي الفترة التي مرت عليه دون الحصول على المعززات) أكبر كان المعزز أكثر فعالية، فمعظم المعززات تكون أكثر فعالية عندما يكون مستوى حرمان الفرد منها كبيرا نسبيا أما الإشباع فيشير إلى الحالة

التي أخذ فيها الفرد المعزز إلى المدى الذي لا يعود معه المعزز معززا، ولمنع وتأخير وصول من نريد تعديل سلوكه إلى مرحلة الإشباع علينا أن نكتفي بتقديم قدر بسيط من المعزز في كل مرة تعزيز.

٥ - درجة صعوبة السلوك: إن المعزز ذا الأثر البالغ عند تأدية الفرد لسلوك بسيط، قد لا يكون فعالا عندما يكون السلوك المستهدف سلوكا معقدا، أو يتطلب جهدا كبيرا وكلما زادت درجة تعقيد السلوك أصبحت الحاجة إلى كمية كبيرة من التعزيز أكثر.

٦ - التنويع: إن استخدام معززات متنوعة أكثر فعالية من استخدام معزز واحد كذلك فاستخدام أشكال مختلفة من المعزز نفسه أكثر فعالية من استخدام شكل واحد.

٧ - الجدة: إن مجرد كون الشيء جديدا يكسبه خاصية التعزيز أحيانا لذلك ينصح بمحاولة استخدام أشياء غير مألوفة قدر الإمكان مع الأطفال كمعززات.

٨ - التعليمات: مما يساعد في تسريع أثر التعزيز في السلوك معرفة الفرد بسبب تعزيزه ومع أن التعليمات غير ضرورية لكي يكون التعزيز فعالا إلا أنها تزيد من فاعلية هذه الإجراءات.

٩ - الفطام _ الرجوع إلى المعززات الطبيعية: ويقصد به فطام من نريد تعديل سلوكه عن المعززات الخارجية التي تم استخدامها في البرنامج واستبدالها بالمعززات الطبيعية. فمثلا إذا عزز تلميذ بوضع نجوع على دفتره لتقوية سلوك حل المسائل الحسابية عنده، فإن استحسان من حوله عندما يواجه مواقف تتطلب حل مسائل حسابية في الحياة اليومية هو معزز طبيعي، وإذا استخدمنا هذا المعزز الطبيعي فإننا في النهاية بحاجة إلى النجوم كمعزز وهذا هو الهدف النهائي.

(٢) التشكيل :

أو ما يعرف بالتقريب التتابعي أو التدريجي، وهو يعني تعزيز السلوك الذي يقترب تدريجيا من السلوك المرغوب أو يقاربه في خطوات صغيرة تيسر الانتقال بسهولة من خطوة إلى أخرى، فمثلا في حالة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النطق يقوم أخصائي التخاطب أولا بتعليم الطفل الانتباه إليه، ثم يتعلم تقليد السلوك غير اللفظي ثم يتعلم تقليد الألفاظ والتي يتدرج في تعلمها بحيث تتقارب بقدر متزايد مع الألفاظ الصادرة عن

الإخصائي، حتى يصل إلى السلوك النهائي المرغوب فيه وهو تشكيل لغة الطفل بحيث يصبح كلامه صحيحا، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم تعزيز الطفل بعد كل خطوة ينجزها بنجاح.

ولنضرب مثالا آخر بحالة طالب يعاني من نقص في المهارات الاجتماعية مما يؤثر على علاقته بزملائه في المدرسة وأقرانه في الحي وكيف سيتغير سلوكه خلال الخطوات التالية والتي تتم عبر عملية التشكيل:

الخطوة الأولى: تتطلب مساعدة الطالب في التعرف على أهمية التفاعل والتعاون مع الآخرين.

الخطوة الثانية: يتم خلالها عمل موقف بسيط يطلب فيه الطالب الاشتراك مع زميل له بأداء عمل تعاوني بينهما (كعمل مجلة الحائط..)

الخطوة الثالثة: عندما يتم التفاعل بين الطالب وزميله ولو على أدنى مستوى يتم تقديره من قبل الإخصائي النفسي أو المعلم.

الخطوة الرابعة: يتم إعداد موقف جديد يشترك فيه الطالب مع مجموعة صغيرة من زملائه، حتى إذا نجح في التواصل معهم يتم تعزيزه..

الخطوة الأخيرة: تتعلق بتعزيز الطالب لتفاعله مع زملاء فصله ثم زملائه في المدرسة وفي تلك العملية فإن التعزيز الخارجي الذي يتم عن طريق الإخصائي النفسي أو المدرسة قد يستخدم لدفع عملية التشكيل في البداية نحو الهدف النهائي ولكن سرعان ما سيصبح الدافع هو التعزيز الذاتي الذي يستمده الطالب من استمتاعه بأداء سلوكه المرغوب فيه.

ولذا فإن استخدام التعزيز الخارجي هنا في البداية له وظيفتان في عملية التشكيل:

الوظيفة الأولى: إنها تجعل الطالب يتبع التعليمات وينفذ المهام الموكولة إليه لأنها تزيد من دافعيته.

الوظيفة الثانية: إنها تسمح للطالب بأن يتعرف على نتائج عمله، فهو لا يحصل على التعزيز إلا بعد أدائه الصحيح.

استخدام الإخصائي النفسي لفنية التشكيل:

يستخدم التشكيل في تعلم سلوكيات متنوعة، منها على سبيل المثال: تعلم مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية (مثل الاقتراب من الآخرين والتعاون معهم والتحدث إليهم..)، والمهارات الحركية (مثل تعلم الألعاب الرياضية بأنواعها ومساعدة من يعانون من مشكلات

حيوية في الحركة) والبرمجة الأكاديمية (في تعلم القراءة والكتابة) وتعليم الأطفال الصم إخراج الحروف، ومهارات العناية بالذات (خاصة مع ذوي الإعاقة العقلية).

ويستخدم الإخصائي النفسي المدرسي فنية التشكيل وفقا للخطوات التالية:

١ - تحديد السلوك النهائي:تبدأ عملية التشكيل بتحديد الهدف النهائي الذي ينبغي الوصول إليه وتعريفه بكل دقة في شكل هدف سلوكي.

٢ - تحديد السلوك المبدئي: تتضمن تلك الخطوة تحديد نقطة البدأ، فكما تم تحديد الهدف النهائي في الخطوة السابقة، ينبغي تحديد سلوك يشبهه لحد ما للبدء به، وذلك من خلال ملاحظة الفرد عدة أيام للتعرف على السلوك الذي يستطيع أدائه بكفاءة وتعزيزه، والوصول إلى السلوك النهائي.

٣ - اختيار المعززات: تتطلب عملية التشكيل من الإخصائي النفسي أن يتعرف على أكثر المعززات فعالية بالنسبة للفرد وذلك للحفاظ على درجة دافعيته للوصول إلى السلوك النهائي، فمثلا إذا كانت مشكلة أحد الطلاب هي اتخاذ أساليب أكثر كفاءة في استذكار الدروس، واكتشف الإخصائي النفسي أن الطالب مغرم بلعب كرة القدم هنا يستطيع الإخصائي النفسي بالاتفاق مع الوالدين أو مع الطالب نفسه ترتيب نظام يستطيع الطالب بمقتضاه أن يلعب الكرة في مقابل كمية محددة من الاستذكار.. وهكذا.

٤ - الاستمرار في تعزيز السلوك المبدئي:بعد أن يتم اختيار المعززات الفعالة بالنسبة للفرد، يتم بعد ذلك تعزيز السلوك المبدئي بصورة مستمرة حتى يمكن الوصول إلى حدوث تغير يقرب الفرد من السلوك النهائي.

٥ - الانتقال من مستوى أداء إلى آخر:تتطلب تلك الخطوة الانتقال التدريجي من مستوى أداء إلى مستوى آخر بشكل متتابع ومنظم، والمبدأ العام الواجب إتباعه في تحديد المدة اللازمة للانتقال من خطوة لأخرى هو تعزيز الأداء من ثلاث إلى خمس مرات قبل الانتقال إلى المستوى التالي

وبشكل عام يمكن إتباع القواعد التالية في تعزيز الخطوات المتتابعة للاستجابة النهائية:

القاعدة الأولى: التقدم ببطء لكي لا تمحى الخطوات السابقة.

القاعدة الثانية: عدم الانتقال المفاجئ من خطوة لأخرى لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان الخطوة السابقة وبالتالي عدم إنجاز الخطوة التالية.

القاعدة الثالثة: إذا حدث محو للخطوة السابقة نتيجة السرعة الزائدة، تتم العودة إلى تلك الخطوة من جديد حتى يتم تعلمها بدقة.

ثانيا: فنيات إنقاص السلوك غير المرغوب:

(١) العقاب :

إذا كان من شأن حدث يعقب استجابة ما، أن يقلل من احتمال تكرار حدوث هذه الاستجابة، سمي هذا الحدث الذي أعقب الاستجابة عقابا، فالعقاب إذا هو أي إجراء يؤدي إلى تقليل احتمال حدوث السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة.

أشكال العقاب:

أ -العقاب السلبي:

حينما يصدر الفرد استجابة ما، وأعقب هذه الاستجابة استبعاد شيء سار بالنسبة لهذا الفرد، وترتب عن ذلك نقص الاستجابة أو انقطاعها سمي ذلك عقابا سلبيا.

ومن أنواع العقاب السلبي التي تستخدم في مجال تعديل السلوك:

١ -زمن الإبعاد: ويتمثل هذا الإجراء بحرمان الطالب لبعض الوقت من المعززات المرغوبة، ويستخدم هذا الإجراء بفعالية في الفصل الدراسي

٢ -ثمن الاستجابة: وهي تعني سحب أو فقدان تعزيز مرتبط بالسلوك كأن تلغى "الماركات" في نظام "الماركات" أو توقيع غرامة كلما ارتكب الطالب خطأ ما، ومن مزايا هذا الإجراء أن أثاره الجانبية المنفرة قليلة إذا ما قورن بالعقاب الإيجابي.

٣ -زيادة التصحيح: حيث يطلب من الفرد تصحيح ما يترتب على سلوكه اللاسوي ويزيد من هذا التصحيح بعمل أكبر منه، فمثلا إذا قام الطالب بكسر الكرسي الذي يجلس عليه في الفصل يتم تكليفه بإصلاح كل الكراسي المكسورة بالمدرسة.

ب - العقاب الإيجابي:

حينما يصدر عن الفرد استجابة ما، ويعقبها وقوع شيء منفر أو مؤلم للفرد، فإن ذلك قد يؤدي إلى نقص الاستجابة أو توقفها، ويسمى ذلك بالشيء المنفر عقابا إيجابيا.

ومن أنواع العقاب الإيجابي التي تستخدم في مجال تعديل السلوك:

١ -الصدمات الكهربائية: ويستخدم هذا الإجراء مع حالات الاضطرابات السلوكية الشديدة مثل حالات عقال الكاتب وإيذاء الذات..الخ.

٢ -التعبيرات اللفظية: وهي من قبيل التوبيخ واللوم والسخرية والنقد..الخ.

٣ -التعبيرات غير اللفظية: مثل تعبيرات الوجه التي تعكس عدم الرضا عن سلوك الآخرين.

٤ -العقاب البدني: مثل الضرب بكافة صوره وأشكاله وهو من أكثر طرق تقليل السلوك استخداما في الحياة اليومية.

استخدام الإخصائي النفسي للعقاب:

يلجأ الإخصائي النفسي المدرسي لاستخدام أسلوب العقاب كفنية إرشادية أو بنصح المعلمين باستخدامها عندما تفشل الأساليب الأخرى في تدعيم السلوك المرغوب أو إنقاص السلوك غير المرغوب، وينصح أيضا ألا يكون الإخصائي النفسي هو المنفذ للعقاب حتى لا يفقد ثقة الطلاب فيه ويصبح رمزا للقسوة بدلا من أن يصبح مصدرا للدفء والتقبل والاحترام والثقة المتبادلة، وذلك لما للعقاب من مساوئ وأثار سلبية منها:

- أن الشخص الذي يوقع العقاب يصبح نموذجا يقتدي به الطالب في سلوكه العدواني.
- أن توقيع العقاب على سلوك غير مرغوب لا ينتج بالضرورة سلوكا مرغوبا، فقد ينتج استجابات مثل الخوف والقلق والكراهية لمن يوقع العقاب على الطالب.
- قد يتعلم الطالب الهروب أو تجنب الناس أو المواقف مما ينتج عنها مخاوف مرضية مرتبطة بالمدرسة أو عدم الانتظام في الدراسة.
- قد يؤدي العقاب المستمر إلى تعود الطالب عليه مما يؤدي في النهاية إلى عدم فعاليته في الحد من السلوك المرغوب فيه.
- يؤثر العقاب على مفهوم الذات لدى الطالب ويحد من التوجيه الذاتي لديه خاصة إذا حدث بشكل متكرر وإذا لم يصاحبه تعزيز للسلوك المرغوب فيه.

ولكن عندما يصبح العقاب ضرورة لا مفر منها للحد من السلوك غير المرغوب، فعلى الإخصائي النفسي مراعاة عدد من العوامل التي تؤثر في فعالية العقاب حتى يحقق النتائج

المرجوة منه وهي في نفس الوقت مجموعة من النصائح التي ينبغي على الإخصائي النفسي إتباعها بكل دقة، وقد أوضح سعيد العزة (٢٠٠١) موجز لهذه العوامل:

(١) تحديد السلوك المستهدف: يجب تحديد السلوك المستهدف أي السلوك المراد تقليله وتعريفه إجرائيا، كذلك يجب التأكد من أن الطالب الذي سيخضع سلوكه للعقاب يفهم جيدا ما هو متوقع منه، وما هو السلوك المستهدف قبل البدء بتنفيذ العقاب.

(٢) استمرارية العقاب: إن استمرارية العقاب أكثر أهمية من نوع العقاب المستخدم، إذ أن العقاب المتواصل أكثر فعالية من العقاب المتقطع، وبناء على ذلك ينصح بمعاقبة السلوك غير المرغوب في كل مرة يحدث فيها وتجنب معاقبته في بعض الأحيان فقط.

(٣) طبيعة المثيرات المستخدمة: لابد التأكد من أن المثير الذي يستخدم لتقليل سلوك الطالب مثير منفر له بالفعل، فما قد يبدو للأخصائي النفسي على أنه منفر قد لا يكون كذلك بالنسبة للطالب.

(٤) شدة العقاب: كلما زادت شدة العقاب كان أثره في السلوك أكبر، وإن ذلك لا يعني استخدام العقاب العنيف وإنما تجنب زيادة شدته تدريجيا فذلك سيؤدي في النهاية إلى تعود الطالب عليه.

(٥) فورية العقاب: يجب معاقبة السلوك غير المرغوب فيه بعد حدوثه مباشرة، فالعقاب المباشر يجعل الطالب يقرن السلوك غير المرغوب فيه بالعقاب ويؤكد له على أن ذلك السلوك لن يحتمل، ومن ناحية أخرى فقد يترتب على العقاب المؤجل معاقبة سلوكيات مقبولة ربما تكون قد حدثت بعد السلوك المراد تقليله، وأخيرا فإن معاقبة السلوك منذ بداية حدوثه أكثر فعالية من الانتظار إلى أن ينتهي الطالب من تأديته.

(٦) استخدام العقاب بهدوء: لا تستخدم العقاب في حالة انفعالية شديدة، فذلك قد يترتب عليه عواقب وخيمة، فقد يكون غضبك وانفعالك بمثابة مكافأة للطالب المعاقب.

(٧) استخدام العقاب بطريقة منظمة: إن عدم الثبات في التعامل مع السلوك غير المرغوب فيه يحد إلى درجة كبيرة من إمكانية ضبطه، ولذلك يجب عند استخدام العقاب أن يتم بشكل منظم.

(٨) تعزيز السلوك المرغوب فيه: إضافة إلى معاقبة السلوك غير المرغوب فيه يجب تعزيز السلوك المرغوب فيه، فذلك يحد النتائج السلبية للعقاب ويساعد الفرد على التمييز

بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول، فالتعزيز يبني العلاقات الإيجابية ويزيد على المدى البعدي فعالية العقاب.

(٩) الامتناع عن تعزيز السلوك غير المرغوب فيه: يجب تجنب تعزيز السلوك غير المرغوب فيه بعد معاقبته، فذلك يحد من فعالية العقاب، وبالرغم من أن ذلك يبدو أمرا بديهيا إلا أن كثيرا من الآباء والمعلمين يعاقبون، فإذا أحسوا بالندم ابتدءوا مباشرة بترضية (تعزيز) الطالب.

(١٠) معاقبة السلوك وليس الفرد: عاقب على السلوك غير المرغوب فيه دون الاعتداء على كرامة الطالب، وإلا فقد يحاول الانتقام بشكل مباشر أو غير مباشر من ناحية، أو قد يتأثر مفهوم الذات لديه تأثرا بالغا من ناحية أخرى

(١١) تهيئة الظروف البيئية المناسبة: إذا كنت تريد من الطالب أن يتوقف عن سلوك معين فعليك أن تهيئ الظروف التي ستدفعه إلى تأدية سلوكيات بديلة، وذلك يتطلب إزالة المثيرات التي تشجعه على القيام بالسلوك غير المقبول وتوفير المثيرات التي ستزيد مدافعيته للقيام بالسلوك المقبول.

(٢) الانطفاء:

يقصد بالانطفاء وقف التعزيز عن استجابة سبق تعزيزها، بمعنى أنه عندما يعطي مثير شرطي بصورة متكررة ولا يعقبه المثير غير الشرطي فإن الاستجابة للمثير الشرطي يتوقف نهائيا، فالكلب عندما كان يقرع الجرس (مثير شرطي) ويقم له مسحوق الطعام (مثير غير شرطي) كان يسيل لعابه بمجرد أن يسمع صوت الجرس (استجابة شرطية) لأنه ربط هذا الصوت بتقديم الطعام، أما إذا استمر قرع الجرس لمرات عديدة دون أن يقدم له الطعام عقب كل مرة يقرع فيها الجرس فسوف لا يسيل لعابه، ويعني ذلك أنه حصل انطفاء في استجابة سيلان اللعاب عند الكلب. ويستخدم الانطفاء لتقليل السلوك غير المرغوب فيه أو محوه، وهو الأكثر استخداما في برامج تعديل السلوك، فهو يتضمن تجاهل السلوك والامتناع عن إظهار أي استجابة من جانب الإخصائي النفسي أو المعلم أو الوالدين.. أو غيرهما لهذا السلوك لفظيا أم حركيا، ومع انتظام التوقف عن التعزيز وحجبه سيقل تكرار السلوك حتى يزول تماما، فمثر

حينما يغفل المدرس السلوك غير المرغوب (الشكل) الذي يظهره أحد الطلاب داخل الفصل ويتجاهله تماما، فإن هذا السلوك ينطفئ ويختفي.

استخدام الإخصائي النفسي لفنية الانطفاء:

لكي يكون إجراء الانطفاء ناجحا وفعالا عند استخدام الإخصائي النفسي له يؤكد جمال الخطيب(١٩٩٠) بأنه يجب إتباع المبادئ التالية:

(١) يجب أن يصحب انطفاء سلوك ما التعزيز الإيجابي لسلوك آخر مرغوب فيه: فبدلا من أن تقول للطالب ما الذي يجب ألا يقوم به فقط، علينا أن نشير إلى سلوك آخر نود منه القيام به، أي أن نعمد إلى تعزيز السلوك الإيجابي المضاد للسلوك السلبي.

(٢) ضبط مصادر التعزيز الأخرى للسلوك المراد تقليله: من المهم في أثناء تطبيق الانطفاء أن يضمن الإخصائي النفسي أن معززات بديلة لا تتبع السلوك غير المرغوب فيه، ويمكن لهذه المعززات البديلة أن تأتي من أشخاص آخرين أو من البيئة المادية الطبيعية، فمثلا إذا كان أفراد عائلة ما يتجاهلون بكاء طفل لهم، وتدخل الجارة وتجد الطفل وتعطيه حلوى حتى يتوقف عن البكاء فإن احتمالات بكاؤه ستزيد في المدى البعيد، وفي هذه الحالة فإنه من الأفضل أن ينفذ برنامج الانطفاء في غياب هؤلاء الناس.

(٣) الموقف الذي ينفذ فيه برنامج الانطفاء: تتنوع المواقف التي يمكن استخدام إجراء الانطفاء فيها، ويمكن أن تختلف هذه المواقف من مواقف انطفاء عادية لانطفاء سلوك يسهل انطفاؤه إلى مواقف مصطنعة إلى حد بعيد لانطفاء سلوك من الصعب انطفاؤه في المواقف الحياتية العادية، وتعود الصعوبة في المواقف من النوع الثاني إلى سببين هما:

- عدم إمكان ضبط مصادر التعزيز الأخرى.
- تحرج من يطبق برنامج الانطفاء من الإصرار على الاستمرار فيه، كأن يبكي الطفل والزوار موجودين فتضطر الأم _ التي كانت تود لو تطبق إجراء الانطفاء _ أن تنبه لطفلها وتعززه خجلا من الزوار.

(٤) التعليمات: تساعد التعليمات التي تعطى للطالب في سرعة تناقص السلوك المطلوب انطفاؤه، وتتمثل التعليمات في أن نقول له: في كل مرة تقوم بها بالسلوك غير المرغوب (س) فإنك لن تحصل على المعزز (ص) بعد قيامك بهذا السلوك.

(٥) يكون الانطفاء بعد التعزيز المستمر أسرع منه بعد التعزيز المتقطع: في التعزيز المستمر، يعزز الفرد في كل مرة يقوم بها بسلوك ما، أما التعزيز المتقطع فيتم بموجبه تعزيز السلوك أحيانا وعدم تعزيزه في أحيان أخرى، وإذا كان السلوك المطلوب انطفاؤه قد عزز بشكل مستمر فإنه أسهل زوالا من السلوك الذي سبق أن عزز بشكل متقطع.

ج - الطرق القائمة على التعلم الاجتماعي:

يرجع الفضل إلى نشأة التعلم الاجتماعي إلى ألبرت باندورا Bandura,A إذ يرى بأن السلوك الإنساني يتعلمه الفرد بالتقليد أو المحاكاة أو النمذجة، وأن معظم السلوكيات البشرية السوي منها وغير السوي هي سلوكيات متعلمة من بيئة الفرد، لذلك يمكن إعداد نماذج تعبر عن السلوك الصحيح في إطار تجريبي يتم من خلالها تغيير سلوكيات الفرد، وقد عبر "باندورا" عن ذلك بقوله: "أن باستطاعة الفرد اكتساب الأنماط السلوكية المعقدة من خلال ملاحظة أداء النماذج المناسبة، فالاستجابات الانفعالية يمكن إشراطها بالملاحظة وذلك من خلال ملاحظة أداء النماذج المناسبة، فالاستجابات الانفعالية يمكن إشراطها بالملاحظة وذلك من خلال مشاهدة ردود الفعل الانفعالية لأشخاص آخرين يمرون بخبرات مؤلمة تبعث على الخوف دون التعرض لعواقب سلبية، ويمكن خفض السلوك من خلال مشاهدة آخرين يعاقبون على تأديته، وأشهر الطرق القائمة على التعلم الاجتماعي هي النمذجة.

النمذجة:

تقوم النمذجة على افتراض أن معظم السلوكيات غير السوية سببها التعلم الخاطئ عن طريق التقليد ومشاهدة الآخرين يقومون بها، والنمذجة أو التقليد كإجراء علاجي، يمكن أن يزيد من حدوث السلوك المرغوب فيه، ويكون ذلك من خلال إعطاء الفرد المتعلم نماذج للسلوك المرغوب فيه مصاحب بتعليمات لفظية خلال ملاحظته للنموذج، ومن ثم إثارة دافعية الفرد للتعلم.

أنواع النمذجة:

أ - النمذجة الحية: وهي تعني أن تكون النماذج أشخاصا متواجدين بالفعل ويقوموا بتأدية السلوك المراد تقليده، ومن الأفضل أن يكون النموذج مشابها للطالب الذي يراد تعليمه ذلك السلوك، ويحتاج الشخص الذي يقوم بدور النموذج إلى تدريب حتى يؤدي دوره بفعالية، وينبغي ألا يكون النموذج ظاهر الهدوء تماما عند اقترابه من موضوع الخوف _ كالثعبان

مثلا _ لأن ذلك سوف يبدو غير واقعي بالنسبة للطالب كما أنه قد يزيد من قلقه لشعوره بالعجز.

ب - النمذجة الرمزية: تلك التي تستخدم فيها التسجيلات الصوتية أو الأفلام أو الكتب أو النشرات الإرشادية.. وغيرها من الوسائل الأخرى وذلك في حالة تعذر وجود نموذج حي. وتستخدم النمذجة الرمزية على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام كالتليفزيون والسينما في تقديمهم لبعض السلوكيات المراد تنميتها بين أفراد المجتمع كالوعي الصحي وترشيد الاستهلاك.. وغيرها وكذلك تقديم بعض السلوكيات المراد القضاء عليها كالتدخين والإدمان.. وغيرها من السلوكيات الضارة والسيئة.

ج - النمذجة التخيلية: في بعض الأحيان يصعب توفير نموذج حي أو رمزي لعرضه على الطالب الذي يعاني من مشكلة ما، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى استخدام النمذجة المتخيلة، والتي يقوم خلالها الإخصائي النفسي بحث الطالب على تخيل لنموذج يقوم بالسلوك المراد تعلمه، ولأن النمذجة تركز على عرض معلومات يود الإخصائي النفسي أن يوصلها للطالب، فإن حثه للطالب على تصور تتابع سلسلة من الأحداث يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة التي تؤديها النمذجة الحية أو الرمزية.

د - النمذجة المشاركة: يقوم خلالها الطالب بمراقبة النموذج الحي ثم يقوم بتأدية السلوك المطلوب بمساعدة النموذج، وأخيرا يؤدي الاستجابة بدون مشاركة أو مساعدة من الإخصائي، وتعتبر هذه الطريقة ذات فاعلية أكبر من مجرد ملاحظة الطالب للنموذج الحي أو الرمزي أو التخيلي، حيث أنه يتضمن ثلاث عمليات هي:

أولا: ملاحظة النموذج أثناء تأدية السلوك المطلوب تعديله.

ثانيا: القيام بأداء السلوك من جانب الطالب.

ثالثا: تقديم توجيهات تقويمية وتعزيزية من جانب الإخصائي النفسي للطالب أثناء تأديته السلوك المطلوب.

العوامل المؤثرة على فعالية النمذجة:

هناك عوامل رئيسية تؤثر في فعالية النمذجة، منها عوامل تتعلق بالطالب (الملاحظ) ومنها عوامل تتعلق بالنموذج، وعوامل تختص بالسلوك الملاحظ، وأخيرا عوامل تتعلق بنتائج السلوك، وفيما يلي توضيح لهذه العوامل بالتفصيل:

١ - عوامل تتعلق بالملاحظ:

الطالب الملاحظ قد يكون طفلا أو مراهقا، وعادة ما يكون مثارا انفعاليا وفي حاجة لتقديم يد المساعدة، ولذلك حتى نزيد من فعالية تعلمه بالنمذجة يجب أن تتوافر فيه العوامل التالية:

أ - النمذجة بالمشاركة: إن الطالب إذا لم ينتبه للنموذج الذي يقدمه له الإخصائي النفسي فلن تكون هناك فائدة تُذكر من عملية النمذجة، ولذلك قد يتطلب هذا تلقينه بأشكال معينة بأن يقال له: أنظر ماذا سوف يحدث الآن، أو قد يكون التلقين جسديا كربت على كتفه لحثه على الانتباه للنموذج.

ب - واقعية الملاحظ: كذلك الحال فيما يتعلق بدافعية الطالب (الملاحظ) فإذا لم تكن لديه الدافعية لتقليد النموذج فسوف تفشل عملية النمذجة، والطالب قد لا يقلد النموذج إذا توقع أن نتائج سلوكه ستكون سلبية، ولكنه سيقلده إذا كان يتوقع أن النتائج ستكون إيجابية.

ج - قدرة الملاحظ على تقليد سلوك النموذج: يتعلق هذا العامل بطبيعة السلوك المراد تعلمه، ومدى قدرة الطالب (الملاحظ) على تقليده، فهو يحتاج لمتطلبات جسدية معينة أو قدرات عقلية خاصة.. وهكذا، وهنا يمكن اللجوء إلى فنيات إرشادية أخرى كالتعزيز أو التشكيل أو التسلسل في تدريب الطالب على هذا السلوك.

د - قدرة الملاحظ على الاستمرار في تأدية السلوك: طلب هذا العامل حث الإخصائي النفسي وتشجيعه للطالب على الاستمرار في تأدية السلوك المطلوب تعديله، حتى لا يحدث انطفاء للسلوك المكتسب بعد فترة.

٢ - عوامل تتعلق بالنموذج:

يمكن أن يكون النموذج أحد الوالدين، أو قد يكون المعلم، أو رفاق السن، أو أحد أقاربه، أو أحد نجوم السينما، أو أحد الشخصيات السياسية أو الأدبية أو التاريخية، لذا تؤثر خصائص النموذج على مدى فعالية النمذجة، ويزداد احتمال حدوث التعلم بالنمذجة إذا اتصف النموذج بواحدة أو أكثر من الخصائص التالية:

- أن يكون النموذج ذا مكانة مرموقة في المجتمع.

- أن يكون مشابها للطالب (الملاحظ) في السن والنوع.. وغيرها من المتغيرات الأخرى.
- أن يكون مصدر إثابة وتعزيز للطالب.

٣ - عوامل تتعلق بالسلوك الملاحظ:

قد يكون السلوك المراد تعليمه للطالب نمطا سلوكيا كاملا، أو بعض السلوكيات البسيطة المكملة لسلوك ما، ولذا عند تدريب الطلاب أو الطالب المراد تعلمه هذا السلوك الكلي المعزز، أن يتم تقسيم هذا السلوك إلى أجزاء يتم تعلمه على مراحل متتابعة حتى يسهل على الطالب استيعابه.

٤ - عوامل تتعلق بنتائج السلوك:

عادة ما يتطلع الفرد إلى نتائج العمل الذي يؤديه، لذلك إذا رأي الطالب النموذج يحصل على إثابة من نوع ما فإنه يميل إلى تقليده، أما إذا رأي الطالب النموذج يعاقب على فعل ما فيميل إلى الابتعاد عنه، فمثلا الطفل الذي يشاهد قرينه وهو يعاقب على سلوكه العدواني فغالبا نجد هذا الطفل يميل إلى الابتعاد عن إتيان هذا السلوك في المستقبل، أما إذا رأى أنه يحصل على مكاسب من وراء سلوكه العدواني كالحصول على ممتلكات الآخرين أو خشية الآخرين منه فإنه غالبا ما يحاول تقليد مثل هذا السلوك.

استخدام الإخصائي النفسي المدرسي للنمذجة:

يستخدم الإخصائي النفسي المدرسي النمذجة في التخلص من سلوكيات غير مرغوب فيها تواجهه داخل الإطار المدرسي مثل: السلوك العدواني، والانطواء والعزلة، والمخاوف المرضية كالخوف من المدرسة أو الخوف من الامتحان.. وغيرها من السلوكيات، وكذلك في المقابل يستخدمه في غرس سلوكيات وعادات مرغوب فيها: كالنظافة العامة، والنظام داخل الفصل وخارجه، وأداء الواجبات المدرسية، والمحافظة على ممتلكات المدرسة..وغيرها.

ولتحقيق هذه الأهداف يقوم الإخصائي النفسي المدرسي بما يلي:

(١) تحديد السلوكيات المرغوب تنميتها أو السلوكيات غير المرغوب فيها للقضاء عليها.

(٢) اختيار نوع النموذج الذي سوف يستخدمه سواء كان نموذجا حيا أو نموذجا رمزيا.. أو غيرها من النماذج الأخرى، وقد يستخدم أكثر من نموذج في نفس الوقت كأن يستخدم النموذج الحي إلى جانب النموذج الرمزي أو يستخدم الأخير مع لنموذج بالمشاركة وهكذا.

(٣) بعد أن يتم تحديد النموذج يتخذ الإجراءات المطلوبة لإحداث التأثير الفعال باستخدام هذا النموذج، فمثلا إذا تم اختيار النموذج الحي عليه أن يراعي في اختياره ما يلي:

- أن تكون شخصيته محببة لدى الطلاب سواء كان هذا النموذج أحد أقرانهم أو معلميهم.. أو أي أفراد يمكن الاستعانة بهم.
- وفي حالة ما إذا كان أحد أقرانهم هو الذي سيقوم بدور النموذج يفضل أن تتشابه خصائصه مع خصائص الطلاب، سواء في السن أو الجنس أو المظهر العام أو الهوايات.. إلى غير ذلك من الخصائص ذات التأثير.

(٤) بعد أن تتم عملية النمذجة ينبغي على الإخصائي النفسي التأكد من عمل الطلاب وذلك من خلال متابعتهم اليومية المستمرة للتأكد من تحقيق الأهداف المحددة مسبقا.

الفصل التاسع

تطبيقات على مشكلات الطفولة والمراهقة

بعد قراءة هذا الفصل، يتوقع من الطلاب أن يكونوا قادرين على:

- التعرف على مشكلة التبول الاإرادي وكيفية التغلب عليه.
- فهم طبيعة مشكلة الكذب وعلجها.
- إدراك مشكلة الهروب من المدرسة والتصدى لها.
- التعرف على مشكلة السرقة وعلاجها
- توضيح مشكلة التدخين ومضارها والتصدي لها.

الفصل التاسع

تطبيقات على مشكلات الطفولة والمراهقة

نوعية المشكلات التي يتدخل فيها الإخصائي النفسي المدرسي:

إن الخدمة النفسية التي يقوم بها الإخصائي النفسي بالمدرسة ليست مطلقة ولكنها محددة تحديدا دقيقاً بما يتناسب مع الإعداد الأكاديمي والمهني للإخصائي النفسي، وكذلك محددة بطبيعة الدور الذي يمارسه في المدرسة من تشخيص أوإرشاد أوعلاج،وللتعرف علي حدود الإخصائي النفسي في التعامل مع الإضطرابات النفسية أو المشكلات السلوكية بالمدرسة نعرض فيما يلي بعض الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية الأكثر ملاءمة لعمل الإخصائي النفسي بالمدرسة:

وفيما يلي عرض لأكثر المشكلات شيوعاً في مرحلة الطفولة، ومرحلة المراهقة، ولدي ذوي الإحتياجات الخاصة.

أولا: بعض مشكلات مرحلة الطفولة:

(١) التبول اللاإرادي:

من أبرز المشكلات التي يعاني منها الآباء عند تنشئة أبنائهم في مرحلة الطفولة، هي مشكلة التبول اللاإرادي سواء أكان ذلك أثناء النوم أو اليقظة حتى سن الخامسة وفي بعض الحالات حتى العاشرة وربما إلى ما بعد ذلك، الأمر الذي يقلق الآباء ويؤثر في صحة الصغير ويشعره بالخجل والنقص.

وعملية التحكم في التبول لكي تتم لابد من توافر أربعة آليات هي: النضج والنمو والتعلم والتشريط. حيث يعتمد الإخراج على نضج الجهاز العصبي، فعادة يتعلم الطفل تحت تأثير التدريب أن يكف انقباض العضلة الضاغطة ويمسك عن التبول باستخدام العضلات

الإرادية، ثم يتطور (ينمو) إلى المرحلة التي يستطيع عندها أن يتحكم في الضغط داخل البطن باستخدام الحجاب الحاجز وعضلات البطن، ثم يتطور إلى المرحلة النهائية التي عندها يستطيع أن يوقف اندفاع البول عند أي درجة من الامتلاء، والتعلم جزئيا بالمحاكاة وجزئيا بالأمر والتدريب، والتدريب يساعد الطفل كثيرا عندما يكون مستعدا في النمو، وخلال فترة التدريب يصبح تفريغ الطفل لمثانته مشروطا بإحساس عجزيه بحافة الإناء، وإذا عوقب الطفل لعدم استخدام الإناء فإنه يشرط بحافة الإناء (أي يكون رابطه ضد الإناء) لربط الإناء بالعقاب.

ويختلف سن ضبط الجهاز البولي من طفل إلى آخر تبعا لحساسية الجهاز البولي، أو إلى حجم المثانة وسعتها، وعادة الطفل لا يمكنه التحكم في التبول أثناء الليل إلا قرب الأربعين شهرا، وقد يبكر بعض الأطفال في قدرتهم إلا أن المألوف أن الأم تبدأ بتدريب الطفل على ضبط عملية التبول قرب الثانية من عمره، وعلى الآباء ألا يقلقوا من التبول اللاإرادي حتى سن الثالثة، ولكن بعد ذلك فإن الأمر يستدعي اهتمامهم وخاصة إن تعدى الطفل سن الرابعة دون أن يستطيع التحكم في ضبط مثانته.

أشكال التبول اللاإرادي:

١ - التبول اللاإرادي الليلي: هو النوع السائد، ويحدث خلاله إخراج البول ليلا أثناء النوم فقط، وعادة ما يحدث البول خلال الثلث الأول من النوم، وفي حالات قليلة يحدث خلال فترة النوم المصحوب بحركة العين السريعة وهي التي قد يذكر الطفل فيها حلما خلال عملية الإفراغ وتصل نسبة هذه الفئة من الأطفال حوالي ثلثي حالات التبول اللاإرادي.

٢ - التبول اللاإرادي النهاري: وهو إفراغ البول إراديا ساعات الاستيقاظ نهارا وتظهر هذه الحالات خلال السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، وغالبا ما نجد الطفل يحاول ضم رجليه بسرعة وقت نزول البول ولكن دون جدوى حيث لا يستطيع أن يتحكم في

توقفه. وتتراوح نسبة انتشار هذا النوع ما بين ٣٪، ٥٪ تقريبا من حالات التبول اللاإرادي.

٣ - التبول اللاإرادي الليلي النهاري: وفي هذا النوع نجد الطفل يتبول لاإراديا في الليل وفي النهار وتصل نسبة هؤلاء الأطفال إلى حوالي ثلث حالات التبول اللاإرادي.

٤ - التبول اللاإرادي النكوصي: وهو الذي يحدث بعد أن يكون الطفل قد تعلم التحكم في السيطرة على عملية التبول وذلك لفترة لا تقل عن ستة أشهر أو سنة بعدها نجد الطفل ينتكس مرة أخرى ويعود للتبول اللاإرادي وقد يكون أحد أسبابه الغيرة.

٥ - التبول اللاإرادي المصاحب للأحداث: ويحدث هذا النوع بعد أن يكون قد تعلم الطفل السيطرة على التبول ولكن نتيجة لوقوع حدث يزلزل كيانه يعود مرة أخرى للتبول لاإراديا ومن هذه الأحداث وفاة أحد الوالدين، رسوبه في الامتحان، تعرضه لحادث مؤلم.. غيرها.

٦ - التبول اللاإرادي غير المنتظم: وفيه يتبول الطفل على نفسه مرة ثم يختفي لمدة طويلة ثم يعود للتبول اللاإرادي مرة ثانية ثم يختفي وهكذا، ويرتبط هذا النوع بأحداث اليوم أو الليلة التي يحدث فيها التبول اللاإرادي.

أسباب التبول اللاإرادي:

أولا: الأسباب الفسيولوجية:

تتعدد الأسباب الفسيولوجية التي تؤدي إلى مشكلة التبول اللاإرادي ومنها ما يلي:

١ - الوراثة: تشير بعض الدراسات إلى انتشار التبول اللاإرادي في بعض العائلات نتيجة لأسباب وراثية فقد وجد أن الآباء الذين يعانون من التبول أثناء طفولتهم نجد أبنائهم يعانون من نفس المشكلة أيضا، فقد وجد أن البوال عبارة عن اضطراب عائلي حيث يحدث بنسبة عالية بين الوالدين والأخوة. وقد لوحظ أيضا أن أقارب الأطفال البوالين من الدرجة

الأولى كانوا يعانون من نفس المشكلة بنسبة تصل إلى (٧٧٪) تقريبا، كما أن معدل تطابق حدوث البوال بين التوائم المتماثلة أكثر منه بين التوائم غير المتماثلة.

٢ - بعض المشكلات الصحية: قد يتسبب إصابة الطفل ببعض المشكلات الصحية إلى حدوث ظاهرة البوال ومنها:

(١) تضخم اللوز والجيوب الأنفية.

(٢) التهاب المثانة والتهاب الحالب والتهاب في حوض الكلية والتهاب المستقيم

(٣) الديدان التي تهيج منطقة التبول وديدان البلهارسيا والانكلستوما.

(٤) عدم التئام الفقرات القطنية أو الجزء السفلي من العمود الفقري.

(٥) الإصابة بفقر الدم ونقص الفيتامينات مما يؤدي إلى الضعف العام.

٣ - صغر حجم المثانة الوظيفي: لقد اتضح أن الأطفال البوالين يصغر حجم المثانة لديهم عن أقرانهم الآخرين مما يتسبب في كثرة التبول خلال ساعات النهار وتقاس السعة الوظيفية للمثانة بالطريقة الآتية:

يسقى الطفل ماء بمعدل ٣٠مليمتر لكل كيلوجرام من وزنه، وإن زاد وزنه يصبح أقصى حجم للماء المشروب ٥٠٠مليلتر ويطلب من الطفل عدم التبول حتى يصل إلى الدرجة التي يشعر عندها بالضيق الشديد والحاجة للتبول، وعندئذ يقاس حجم البول الذي خرج منه، وعادة يعتبر حجم أكبر عينتين من البول هي السعة الوظيفية للمثانة.

ثانيا: التفسيرات النفسية:

تلعب الأسباب النفسية دورا حيويا في ظهور مشكلة البوال، ومن أهم الأسباب النفسية التي تؤدي إلى مشكلة التبول اللاإرادي عند الأطفال ما يلي:

١ - الغيرة: فقد يحدث أن يولد في الأسرة مولود جديد، فنجد أن الطفل الأكبر بسبب الغيرة قد يحدث له نكوص لمرحلة سبق أن تخطاها فيتبول لاإراديا بعد أن كان تعلم التحكم في عملية التبول وذلك في محاولة منه لجذب انتباه الوالدين إليه بعد أن تركز اهتمامهم حول

القادم الجديد، أو قد يحدث ذلك نتيجة لغيرة الطفل من أخوته الذين يحظوا بحب وعطف أحد الوالدين أو كلاهما وذلك في محاولة لاستعادة الحب المفقود. وقد يغار الطفل من أحد الوالدين، فالطفل الذكر يتعلق بأمه تعليقا كبيرا ويجد في أبيه منافسا على حبها، والبنت الصغيرة تتعلق بوالدها وتجد في الأم منافسا لها على حب الأب.

٢ - الخوف: قد يؤدي تهديد أمن الطفل إلى التبول لاإراديا، فقد يخاف الطفل من الظلام أو الخوف من القصص المزعجة أو الصور المرعبة في الأفلام المعروضة بالتلفزيون أو الخوف من بعض الحيوانات، وإلى غير ذلك من أشكال الخوف التي تؤدي إلى اضطراب الطفل وشعوره بعدم الأمان، ومن أكثر المواقف التي تسبب التبول اللاإرادي خوف الطفل من فقدان اهتمام والديه به إلى الأبد.

٣ - الشعور بالنقص: يعاني بعض الأطفال من مشاعر النقص نتيجة لوجود إعاقة أو انخفاض مستواهم الاجتماعي أو أنهم أقل تحصيلا من زملاءهم. وإلى غير ذلك من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث مشكلة التبول اللاإرادي.

٤ - الإكتئاب: لقد كشفت الدراسات التي تجري في مجال الإكتئاب على أن بعض الأطفال المصابين بالأكتئاب يحدث لديهم تبول لاإرادي ولكن باستخدام مضادات الإكتئاب مثل الايميبرامين يسبب اختفاء التبول اللاإرادي لدى هذه الحالات.

ثالثا: التفسيرات الاجتماعية:

١ - أساليب المعاملة الوالدية اللاسوية: ترجع مشكلة التبول اللاإرادي في أحيان كثيرة إلى سوء معاملة الوالدين للطفل واستخدامهما للعقاب والتهديد ومحاولة السيطرة والتحكم في كل تصرفاته، ولذلك نجد أن الطفل يحاول الانتقام منهما من خلال قيامه بالتبول اللاإرادي في محاولة لا شعورية من لإثارة ضيق وحنق الوالدين.

٢ - خطأ التدريب على التحكم في عملية البوال: هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها الوالدان غير تدريب ابنهما على التحكم في عملية البوال، فقد نجد من الوالدين من

يحاول التعجيل في التدريب على تلك العملية المعقدة قبل اكتمال نضج أجهزة الطفل التناسلية في قدرتها في السيطرة على البول، ومن الأخطاء التي ترتكب من بعض الآباء قيامهم بالتساهل عندما يتبول الطفل لاإراديا اعتقادا منهم بأن ذلك نوع من الحنان ولعدم إغضاب الطفل، وإن كان ذلك يعني إهمالها في تدريب الطفل على التحكم في تلك العملية، ومن الأخطاء أيضا التي يرتكبها بعض الآباء في حق الطفل معاملته بقسوة شديدة أثناء تدريبه على عمليتي التبول والإخراج كنوع من المبالغة في الحفاظ على نظافته مما يترتب عليه فشله في السيطرة على عملية التبول.

٣ - أسباب مدرسية: قد يرجع التبول اللاإرادي إلى خوف الطفل من المجتمع المدرسي عند بداية التحاقه بالمدرسة، أو نتيجة لخوفه من معلم بعينه يعاقبه بشدة أو لغيرته من بعض زملائه الذين يتفوقون عليه أو فشله في القدرة على التحصيل الدراسي، أو نتيجة لمعايرة زملاءه له بسبب ما.. أو لغير ذلك من الأسباب التي تؤدي به إلى النكوص مرة أخرى لمرحلة سابقة.

٤ - التفكك الأسري: يعاني بعض الأطفال من فقدان الشعور بالأمن والطمأنينة داخل المنزل نتيجة للصراعات التي تحدث بين الوالدين، والمشاجرات التي قد تحدث أمامه وما يترتب عليها من خلافات أو ترك أحد الوالدين للمنزل أو نتيجة لزواج الأب أو زواج الأم.. وإلى غير ذلك من المشكلات التي قد تتسبب في حدوث مشكلة التبول اللاإرادي.

دور الإخصائي النفسي في مواجهة مشكلة التبول اللاإرادي:

قبل البدء في علاج الإخصائي النفسي للطفل ينبغي عليه أولا أن يبدأ بتشخيص الحالة في ضوء عدد من المحكات هي:

(١) ألا يقل عمر الطفل الزمني عن خمس سنوات وعمره العقلي عن أربع سنوات.

(٢) أن يكون خالي من أي اضطراب جسمي كالصرع والتهاب مجرى البول أو التهاب في الجيوب الأنفية أو غيرها من الأسباب التي تم ذكرها آنفا.

(٣) أن يتكرر التبول اللاإرادي مرتين على الأقل إذا كان عمر الطفل ما بين الخامسة والسادسة ومرة واحدة عن كان أكبر من ذلك.

(٤) أن يتكرر أيضا إفراغ البول ليلا أو نهارا، في الفراش أو في الملابس سواء أكان إراديا أو لاإراديا.

ويذكر زكريا الشربيني(٢٠٠١) أنه إلى جانب المحكات السابقة تضاف الإجراءات التالية:

(أ) إجراء طبي: لفحص الجهاز البولي والتناسلي وجهاز الإخراج، وإجراء التحاليل للبول والبراز والدم بالإضافة إلى الفحص بالأشعة وفحص طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وذلك للتأكد من عدم وجود التهابات أو أسباب مهيجة للطفل أو خلل في تركيب البول أو وجود ديدان بالبراز وعدم وجود تضخم لحمية خلف الأذن. وبطبيعة الحال إذا جاءت الإجراءات الطبية كاشفة عن وجود علة عضوية فإن الأمر لا يعقبه خطوات تالية إلا بعد فشل العلاج الطبي.

(ب) مقابلة الطفل: يتطلب الأمر مقابلة الطفل عددا من المرات للتعرف على بعض سلوكياته وتصرفاته الواضحة التي تصاحب التبول اللاإرادي مبدئيا مثل الهروب من المدرسة أو الخوف أو الغيرة.. وغيرها.

(ج) مقابلة أهل الطفل: بهدف جمع معلومات أكثر عن تطور حالة الطفل وبداية ظهور التبول اللاإرادي وأوقاته وتأثيره على تصرفات الطفل وأساليبهم في معاملته والظروف الأسرية المحيطة، وجمع المعلومات عن أخوة الطفل.. وغيرها.

(د) تطبيق بعض الاختبارات السلوكية: يجب معرفة المزيد عن القدرة العامة للطفل (الذكاء) باستخدام واحد من اختبارات الذكاء مثل اختبار وكسلر أو لوحة سيجان أو

اختبار رسم الرجل، وكذلك تطبيق بعض الاختبارات النفسية مثل اختبارات الخوف والغيرة واختبار الكات أو اختبار رسم الأسرة.

وفيما يلي بعض الطرق التي تستخدم في علاج الأطفال الذين يعانون من التبول اللاإرادي:

أولا: تدريب المثانة:

يقصد بها زيادة قدرة المثانة على الاحتفاظ بأكبر قدر من البول حتى عندما تكون المثانة ذات قدرة محدودة على استيعاب البول. ومن الطرق المستخدمة في تدريب المثانة ما يلي:

١ - الاحتفاظ بالبول: حيث ينصح الطفل بعدم الاستجابة للنداء الأول للمثانة، فإذا شعر برغبة في التبول فعليه ترويض نفسه أو عدم الذهاب للتبول، بل يعطي لنفسه فرصة أخرى، أي يحدث التبول على فترات متباعدة نسبيا وبهذا يدرب مثانته على استيعاب أكبر كمية من البول حتى في أثناء النوم.

٢ - تقطيع مسار البول: حيث يؤدي ذلك إلى زيادة قدرة الطفل على تحمل انقباضات المثانة، ويزيد من تقوية صمام عنق المثانة الذي يتحكم في خروج البول منها، وبهذا يتمكن الصمام من أداء أفضل أثناء النوم.

ثانيا: العلاج السلوكي:

والذي يقوم على أساس إعادة التشريط استنادا إلى مبدأ الإشراط الكلاسيكي ويرجع الفضل في هذه الطريقة إلى مورر Mowrer الذي استخدم في ذلك جهازه المشهور "الوسادة والجرس" وهي عبارة عن ملاءة من القماش توضع بين رقاقتين من المعدن بكل منهما ثقوب وموصل كل منهما بسلك متصل ببطارية (٩ فولت) متصلة بجرس، وعندما ينام عليها الطفل ويبلل فراشه يسقط الماء على الرقاقة المعدنية الأولى فينساب من القماش إلى الرقاقة الثانية فتتصل الدائرة الكهربية ويصدر صوت الجرس الذي يوقظ الطفل، ومع تكرار هذه

العملية يؤدي ذلك إلى تخفيف عمق النوم وإيقاظ الطفل ويتوتر جهازه العصبي فتنقبض المثانة ويذهب إلى الحمام.

وقد طور "ليفيبوند" Livibond هذه الطريقة بتصميم جهاز يشبه الجهاز السابق ولكنه يعطي إشارتين بدلا من إشارة واحدة، الإشارة الأولى تعطي صوت عربة وهذا الصوت هو المنبه المزعج الذي يوجه للطفل النائم ويؤدي إلى تقلص المثانة، ويتبع ذلك صوت جرس خفيف لمدة دقيقة يفيد في استدعاء الأم أو الأب وتسمى هذه الطريقة بثنائية الإشارة.

ويفيد أيضا في هذا الجانب توجيه نظر الآباء لمراعاة بعض القواعد للحد من مشكلة التبول اللاإرادي الليلي. ومن هذه الاعتبارات والقواعد ما يلي:

(١) تعويد الطفل نهارا على ضبط نفسه أطول مدة ممكنة.

(٢) تعويد الطفل الاستيقاظ ليلا والذهاب إلى الحمام وخلع ملابسه.

(٣) منع الطفل من تناول كميات كبيرة من السوائل قبل النوم.

(٤) منع المواد الحريفة أو الشديدة الملوحة عن الأطفال ليلا، لأنها تتطلب شرب كميات كبيرة من المياه.

(٥) الابتعاد عن القسوة في المعاملة والتهديد بالعقاب على تبوله لاإراديا.

(٦) عدم تأنيب الطفل وتوبيخه أمام الآخرين على سلوك التبول اللاإرادي

(٧) إذا كان الطفل يخاف من الظلام فليوضع في غرفة نومه ضوء بسيط أو إناء خاص بالتبول.

(٨) تعزيز الطفل ومكافأته على عدم التبول في أحد الليالي وإخطاره بأنه سوف يحرم من هذه المكافأة إذا لم يستطع التحكم في التبول مرة ثانية.

(٩) عدم مقارنة الطفل بأخوته الآخرين القادرين على التحكم في عملية التبول.

(١٠) تجنب التصرفات التي تثير غيرة الطفل من المولود الجديد.

(٢) السرقة:

المنزل هو البيئة الأولى لتعليم فكرة الأمانة، والسرقة صفة يتعلمها الطفل نتيجة للظروف المحيطة به، فهي مثل الأمانة تكتسب عادة عن طريق الممارسة تحت ظروف معينة أو نتيجة الإقتداء بالآخرين، وغالبا ما يتعلم الطفل السرقة في الطفولة المبكرة، كما أنها تظهر في حياة الطفل أو المراهق إذا ما وقع تحت تأثير الضغوط النفسية واضطر إلى السرقة لإثبات ذاته أو حمايتها.

والسرقة من السلوكيات الشائعة في مرحلة الطفولة رغم ندرة ظهورها بسبب تردد أولياء الأمور في مناقشة سرقات أطفالهم والإفصاح عنها، والطفل الذي يسرق غالبا ما يكون مجهول الهوية بسبب ما يقوم به من محاولات ليتستر على جريمته حتى يصعب إثبات التهمة عليه وغالبا ما نجده ينكر تماما أن له علاقة بهذه الفعلة ويقسم أغلظ الإيمان على ذلك أي أنه يقرن السرقة بالكذب أيضا، بل قد نجده ينسب سرقته إلى أخ له أو زميله.

ومن المعلوم أن الطفل يتعلم أول دروس الأخذ والعطاء داخل الأسرة فهو يتعلم أن له ملابس خاصة به ولعب يلعب بها ومكان ينام فيه.. وعندما يكبر ويتعامل مع الأطفال الآخرين يبدأ مفهوم الملكية الخاصة في التغيير التدريجي فنجد أخيه أو صديقه يريد أن يلعب بلعبته، ويريد هو أن يلعب بلعبهم وهنا تصطدم الملكيات الخاصة لكل منهم. والأسرة السوية هي التي تعود أطفالها على الأخذ والعطاء، وفي الوقت نفسه تدعم الشعور بالملكية الخاصة.

وعلى العكس مما سبق نجد أن هناك بعد الأسر لا تدرب الطفل على التمييز بين ما يمتلكه هو وما يمتلكه الآخرون فكل شيء مشاع بين الأخوة، الملبس والألعاب وأماكن النوم فيتعلم الطفل أن من حقه الحصول على ما ليس له فلا يميز بين ما له وما عليه وهذه الأسر تفعل ذلك اعتقادا منها في أن ذلك يعلم الطفل حب الآخرين والإيثار، على الرغم من أن يزرع فيهم أول دروس عدم احترام ملكية الآخرين ومن ثم يجروا أبناءهم إلى طريق السرقة.

أشكال السرقة:

١ - سرقة الحرمان: وفيه يلجأ الطفل إلى السرقة نتيجة لحرمانه من أشياء يستمتع بها من هم في مثل عمره من مأكل وملبس ومصروفات فيحاول سرقة بعض ما يمتلكوه.

٢ - سرقة جذب الانتباه: يلجأ الطفل لهذا النوع من السرقة للفت نظر والديه أو الكبار من حوله نتيجة تعرضه للإهمال أو الرفض أو انشغالهم عنه.

٣ - سرقة التقليد: يقوم الطفل بالسرقة لتقليد رفاقه، وخاصة إذا كان يحصل من السرقة على تعزيز يدفعه للاستمرار فيها.

٤ -السرقة للانتقام: يلجأ الطفل هنا للسرقة لكراهيته الشديدة لمن يسرق منهم سواء أكانوا الكبار أو أقرانه وذلك حتى يصيبهم بالحزن والألم.

٥ - سرقة إثبات الذات: يقوم الطفل بالسرقة ليثبت لنفسه بأنه الأقوى خصوصا أن رفاق السوء وبعض الأطفال يشعرون بمتعة في ذلك العمل.

٦ - سرقة حب التملك: يلجأ الطفل في هذا النوع إلى السرقة لإشباع حاجاته إلى الاستحواذ على ما يمتلكه الآخرون وما يحصل عليه من متعة من جراء ذلك.

٧ - السرقة كاضطراب نفسي: قد تكون السرقة عرضا لاضطراب نفسي يعاني منه الطفل فقد يعاني من مرض ذهاني، وفي هذه الحالة يفضل إحالة الطفل للعلاج النفسي.

أسباب السرقة:

١ - أساليب المعاملة الوالدية اللاسوية: أن الطفل الذي تعود أن تجاب له كافة مطالبه ورغباته، فعندما يكبر ويختلط بزملائه في المدرسة فإنه يصطدم بأنه كما يريد أن يأخذ يجب أن يعطي للآخرين وهو لم يتعود ذلك، فلا يجد بدا من أن يلجأ لسرقتهم للحصول على ما يريد دون أن يقدم المقابل. كذلك الحال بالنسبة لقسوة الوالدين وعقابهما الشديد لطفلهما، فيعتبران مسئولان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن نشأة سلوك السرقة كنوع من الانتقام من الوالدين، كذلك عندما يفرق الوالدان بين الأبناء، فقد

يلجأ أحد الأطفال إلى السرقة بدافع الغيرة من أخوته وقد لا ينتفع بما يسرقه فقد نجده يقوم بتحطيم اللعبة أو إتلافها.

٢ - عدم النضج: يقوم بعض الأطفال بالسرقة وذلك لعدم قدرتهم على إدراك الفرق ما بين الاستعارة والسرقة وذلك لعدم نضوجهم فمثل هؤلاء الأطفال يقومون بالسرقة للحصول على ما يريدون في الحال دون التفريق بين ملكيتهم وملكية الآخرين.

٣ - تعويض مشاعر النقص والدونية: غالبا ما نجد السرقة تنتشر بين أبناء الطبقة الاجتماعية الدنيا وذلك بسبب الفقر الشديد وحرمانهم من التمتع بملذات وطيبات الحياة التي يتمتع بها أقرانهم، فيلجئون للسرقة حتى يظهروا بأنهم ليسوا بأقل منهم بل يشبهونهم فيما يأكلوه ويشربوه ويلبسوه.

٤ - الانتقام من الآخرين: أحيانا نجد أن الطفل يلجأ إلى السرقة كأحد مظاهر السلوك العدواني حيث يستخدمه كنوع من الانتقام وإذلال المسروق منه والاستمتاع بذلك فالأب الذي يحرم الطفل من طعام ما، يتلذذ ذلك الطفل بالحصول على بعض من هذا الطعام دون علم والده بل الأكثر من ذلك قد يفسد ما تبقى من الطعام انتقاما من والده.

٥ - رفاق السوء: يلعب رفقاء السوء دورا حيويا في بدء سلوك السرقة وفي استمرار وتعزيز هذا السلوك فالطفل قد يسرق ليكسب رضاء رفاقه بما يمنحهم من المسروقات، أو بإعطائه دور القيادة بينهم بما ينفقه عليهم مما يسرقه من أموال أبيه أو أمه أو الآخرين.

٦ - الاستهزاء والابتزاز: أحيانا ما يكون الطفل من النوع الذي يسهل استهوائه فيقع في براثن شخص منحرف قد يكون زميله أو شخص ناضج يستخدمه كأداة لسرقة الآخرين تحت تأثير أي خطأ ما يمكن أن يهدده به من وقت لآخر.

٧ - الحرمان العاطفي: يشعر الطفل أحيانا بأنه مهمل ممن حوله فيحاول من خلال السرقة جذب انتباههم إليه عن طريق فعل سلوك مشين يجعله محط الأنظار أو قد يتخذه كفعل انتقامي من والديه الذين يفتقد لحنانهما ورعايتهما من خلال وضعهما في موقف سيئ.

دور الإخصائي النفسي في مواجهة مشكلة السرقة:

عند إحالة الطفل السارق إلى الإخصائي النفسي من قبل إدارة المدرسة أو معلم الفصل أو نتيجة لشكوى الوالدين، عليه أن يقوم بما يلي:

(١) تنظيم مقابلة مع الطفل يقوم خلالها بالتعرف على الدوافع التي تجعل الطفل يقوم بهذا السلوك وأسباب ذلك، لتحديد أي أنواع السرقة يقوم بها الطفل، ليتسنى له وضع البرنامج الإرشادي الملائم له، أو قد يحتاج الأمر بعض التوجيهات والنصائح فقط والتي تتعلق بتعريف الطفل الفرق بين ملكيته وملكية الآخرين والملكية العامة.

(٢) قد يتطلب الأمر تنظيم مقابلة مع الوالدين ليتعرف منهما على مدى تكرار هذا السلوك، وما يمكن أن يقدماه من مساعدة لابنهما في التخلص من هذا السلوك، مع طمأنتها على السرية في معالجة المشكلة والتركيز على أهمية التصدي لها وعدم التهاون معها من خلال إنكارها أو نفيها وتوعيتهما بخطورتها وما يترتب عليها من نتائج سيئة.

(٣) تستخدم وسائل جمع المعلومات المتنوعة كالملاحظة ودراسة الحالة والاختبارات والمقاييس النفسية والعقلية وذلك لتحديد ما يلي:

- هل سلوك السرقة عرض لأحد الاضطرابات النفسية أو هي مشكلة مستقلة ؟
- ما هي الدوافع الخفية وراء قيام الطفل بهذا السلوك ؟ وما مدى تكراره ؟
- ما هي الصراعات والإحباطات التي تواجه الطفل فتدفعه لهذا السلوك ؟
- ما هي نوعية الأشياء التي يتم سرقتها ؟
- ما مدى نجاح الطفل أو فشله الدراسي ؟
- ما المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لأسرة الطفل ؟

وفي ضوء الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها مما يثار في ذهن الإخصائي النفسي يتم وضع الحلول المناسبة.

أولا: استخدام النمذجة في إنقاص السلوك:

حيث تستخدم طريقة الأثر الكافي أو المانع وفيه يعرض على الطفل نموذج يتلقى عقابا على سلوك السرقة فيصبح أقل ميلا للقيام بهذا السلوك في المستقبل. وفي إطار ذلك يمكن أن يجلس الطفل مع بعض المساجين في حوادث سرقة ليحكوا له عن تجربتهم داخل السجن ومدى المعاناة التي يلقونها. وعادة ما تستخدم تلك الطريقة مع الأطفال الذين تفشل معهم الطرق الأخرى لما لها من أثر سيئ في نفس الطفل.

ثانيا: التعزيز:

يمكن من خلال التعزيز تقليل أو الحد من سلوك السرقة عند الأطفال. حيث يمكن للإخصائي النفسي بالاشتراك مع الوالدين في المنزل والمعلم في المدرسة تنظيم بعض المواقف التي تظهر أمانة الطفل وما يعقب ذلك من تعزيز سواء كان تعزيز رمزي أو اجتماعي أو مادي أو معزز غذائيا.. وإلى غير ذلك من المعززات. كما يمكنه استخدام فنيات أخرى كالانطفاء والعقاب بأنواعه للحد من سلوك السرقة.

ويقوم الإخصائي النفسي بعقد لقاء مع والدي الطفل الذي يقوم بالسرقة وذلك لكي يكون لهما دور فعال في الحد من ذلك السلوك وذلك من خلال إتباع التعليمات التالية:

(١) تنمية الوازع الديني والضمير لدى الطفل وذلك بإخباره بعقوبة السارق في الآخرة وأنها إحدى الكبائر التي نهى الله عنها. وإعطائه أمثلة ونماذج يمكنه الإقتداء بها دائما في الأمانة، وخير مثال لذلك رسول الله والذي عرف بالصادق الأمين.

(٢) ينبغي على الوالدين البحث عن الأسباب التي تدفع الطفل لذلك السلوك، هل هو بسبب غيرته من أخوته أم بسبب سوء معاملتهما له، أم بسبب الحرمان المفروض عليه. وإلى غير ذلك من العوامل حتى يسهل التصدي للمشكلة وعلاجها من جذورها.

(٣) ينبغي أن يعرف الطفل ما له وما عليه، أو بمعنى أخر الحدود الفاصلة بين ما يملكه وما يمتلكه الآخرون، مع ضرورة احترام ملكية الآخرين.

(٤) عدم ترك أشياء مغرية أمام الطفل يسهل سرقتها كالنقود والذهب، وغيرها من الأشياء الثمينة التي يمكن أن تغريه.

(٥) ضرورة متابعة سلوك الطفل ومراقبته وذلك حتى لا يتكرر سلوك السرقة فيتأصل وتصعب عادة يصعب علاجها. وضرورة التعرف على رفاق الطفل وسلوكهم حتى لا يحذو حذوهم.

(٦) ضرورة تحديد مصروف ثابت للطفل يشتري منه ما يراه ضروريا، وأن يعطي الثقة عند طلب نقود مادام أنها تصرف في أشياء مفيدة.

وكما قدم الإخصائي النفسي بعض التعليمات والنصائح للوالدين، ينبغي تقديم بعض النصائح للمعلمين حتى يمكنهم مواجهة سلوك السرقة داخل الفصل:

(١) إذا تم ضبط تلميذا يسرق فلا ينبغي التشهير به أمام زملاءه، بل يجب دراسة حالته، وأن يعمل المعلم على معالجة الموقف بحكمة، حتى لا يخلق منه مجرما وسط زملائه.

(٢) إذا امتدت يد التلميذ إلى شيء لا يحق له أن يأخذه، نعلمه في رفق أنه يجب أن يستأذن قبل أخذ شيء ليس له.

(٣) ينبغي دراسة حالات التلاميذ الاجتماعية، والعمل بما تيسر على مساعدة الفقراء منهم مساعدة مادية بما يجعلهم في غير ذي حاجة إلى خوض تجربة السرقة.

(٣) الكذب:

في كثير من الأحيان يشكو الآباء والمعلمين من لجوء بعض الأطفال إلى الكذب وذلك باختلاقهم للأعذار أو سرد قصص غير حقيقية أو ذكر حقائق مخالفة للواقع أو التزييف المتعمد بقصد الغش والخداع.. وغيرها.

ولكن قد يكون الآباء أو المعلمون من القسوة بأن يوصموا الطفل بهذا السلوك السيئ وخاصة في السنوات الأولى من حياة الطفل إذ أنه خلال هذه الفترة تخلو حياة الطفل من الكذب وإن كانت لا تخلو من الأقوال المحرفة أو غير الصادقة ظاهريا والتي تبدو للكبار على أنها كذب، وذلك لأن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية يصعب عليه التفرقة بين عالم الواقع المحيط به وبين عالم الخيال الذي ينسجه لنفسه لذلك يصعب أن نصف الطفل في هذه المرحلة بأنه كاذب. ولكن مع بداية سن المدرسة يبدأ الأطفال في اختلاق الأكاذيب لتجنب العقاب أو لكي يجذبوا نظر الآخرين إليهم، أو للانتقام من غريم لهم أو للتفاخر والتباهي بين الآخرين.. أو لغير ذلك من الأسباب التي تدفعهم إلى اللجوء إلى الكذب.

ولكن الخطر في الكذب فيما يرتبط به من مشكلات اجتماعية عديدة، منها الخيانة وعدم احترام صفة الصدق. فالكاذب يتعمد اللجوء للكذب أيضا ليغطي الأخطاء والجرائم التي ارتكبها مثل السرقة والغش والهروب من المنزل أو المدرسة.

أشكال الكذب:

١ - كذب التفاخر والمبالغة: يقوم فيه الطالب بنسج القصص الكاذبة للحصول على إعجاب وزهو الآخرين به ويلجأ إليه الطفل حينما يجد نفسه وسط مجموعة يحصلون على تقدير الآخرين، فيحاول اختلاق الأكاذيب لأشياء يستحق عليها الذكر والتنويه.

٢ - الكذب الخيالي: يعد محاولة من الطفل للهروب من عالم الواقع الذي لا يشبع فيه حاجاته إلى العالم الخيالي الذي يستطيع أن يحقق فيه هذا الإشباع.

٣ - كذب الالتباس: أحيانا نجد الطفل تلتبس عليه الحقائق وتعجز ذاكرته على تذكر تفاصيل موقف أو موضوع أو حادثة معينة بكل تفاصيلها فيذكر جزء من الحقيقة ويضيف الباقي من عنده ولا يعتبر هذا النوع كذبا مقصودا إذ أنه مع نمو القدرات العقلية للطفل يستطيع تذكر التفاصيل الدقيقة.

٤ - الكذب الدفاعي: هو ذلك النوع من الكذب الذي يلجأ إليه الطفل لحماية نفسه من عقاب الوالدين أو المعلم وذلك باختلاق الأعذار للمعلم لعدم أداء الواجب المنزلي.. وغير ذلك من المواقف الأخرى.

٥ - الكذب لجذب الانتباه: يلجأ إليه الطفل للحصول على اهتمام ورعاية الآخرين، فقد يدعي الطفل المرض أو تعرضه لحادثة معينة حتى يجذب انتباه والديه نحوه.

٦ - كذب المحاكاة: حيث يقلد الطفل الكبار المحيطين به، فعندما يجد الطفل والده أو أمه أو أحد من أخوته يكذب يسهل عليه بعد ذلك محاكاة ذلك السلوك.

٧ - كذب الكراهية والانتقام: يقصد الطفل من وراء الكذب الكيدي أو كذب الانتقام بإلصاق التهمة أو الصفة المشينة بالشخص المكروه والذي قد يكون الأخ أو الزميل وذلك بتدبير المؤامرات وتلفيق الأكاذيب.

٨ - الكذب الاجتماعي: يلجأ إليه الطفل لحماية أخيه أو زميله في المدرسة أو لكتمان سر ائتمنه عليه أحد والديه.

٩ - الكذب المرضي (الباثولوجي): وهو كذب متعمد ويرتبط عادة باضطراب سلوك الطفل المتضمن لسمات أخرى مضطربة مثل الهروب من المدرسة أو السرقة، وغيرها من السلوكيات اللاسوية.

أسباب الكذب:

١ - تقليد الكبار: غالبا ما يكون كذب الأطفال انعكاسا لكذب الكبار من حوله سواء أكان ذلك في المنزل أو المدرسة فهو تقليد لهم، فالطفل عندما يرد على التليفون ويطلب منه والده أو أخوه أن يقول لمن يتصل بأنه غير موجود، والأم التي تعد طفلتها بالخروج في نزهة ثم لا تفي بوعدها، والمعلم الذي يطلب منه زميله قلما وينكر وجوده

أمام الطفل بالرغم من رؤيته للقلم معه، وغيرها من النماذج الأخرى تعطي للطفل القدوة للكذب.

٢ - الخوف من العقاب: كثيرا ما يلجأ الأطفال إلى الكذب للهرب من التعرض للعقاب وخاصة في الأسر التي يسود فيها النظام الصارم والقسوة الشديدة، فالطفل الذي يحطم شيئا ما وهو يعرف أنه ستعرض للعقاب لا محالة يتخذ من الكذب ملجأ لحماية نفسه، وخاصة عندما يتحقق من أن الأمانة لن تجدي في تخفيف العقاب عنه.

٣ - تمييز الآخرين: يلجأ الطفل أحيانا للكذب نتيجة لأسلوب التفرقة الذي يتعامل به أحد الوالدين أو كلاهما معه وذلك من خلال تمييز أخوته عنه، فيحاول الانتقام من ذلك الأخ باختلاق الأكاذيب عنه والوشاية للوالدين بالكذب عما فعله ليعاقباه. كذلك الحال بالنسبة للمعلم الذي يحابي دائما لأحد التلاميذ لهوى في نفسه على حساب التلاميذ الآخرين، فنجد منهم من يدفعه الحقد على هذا التلميذ إلى تلفيق الأكاذيب التي تجعله عرضة لعقاب المعلم.

٤ - الشعور بالنقص والدونية: أحيانا يلجأ الطفل للكذب عندما يشعر أنه أقل ممن حوله سواء من أخوته أو زملائه حيث يجدهم متفوقين ومحل إعجاب الآخرين فيدفعه الإحباط إلى اختلاق نجاحات قام بها في المدرسة حتى يحصل على ثناء وسرور والديه.

٥ - تدعيم الكذب: قد نجد تأييدا من الوالدين لكذب طفلهما، فالطفل الذي يختلق الأعذار لمعلميه عن عدم ذهابه إلى المدرسة بأنه كان مريضا ويجد استحسانا من أحد والديه على هذا السلوك، نجد أن الطفل يميل إلى تكرار الكذب في مناسبات أخرى.

دور الإخصائي النفسي في مواجهة كذب الأطفال:

يجب على الإخصائي النفسي المدرسي بداية تحديد نوع الكذب الذي يقوم به الطفل، فليس كل الأنواع تحتاج إلى إرشاد وعلاج، إذ أن البعض منها يرتبط بمرحلة نمائية عندما يبلغها الطفل يتخلص من تلقاء نفسه من هذا النوع من الكذب كالكذب الخيالي وكذب

الالتباس. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي تتعلق بتحديد الأسباب الرئيسية لكذب الأطفال، إذ أن كل سبب من الأسباب السابقة يحتاج إلى طريقة معينة لمواجهته وعادة يلجأ الإخصائي النفسي لمشاركة الوالدين في تحديد الأسباب وكذلك في عملية الإرشاد كذلك يمكنه إشراك المعلمين في هذه الأدوار. أما المرحلة الثالثة فتأتي بعد تحديد السبب أو الأسباب التي تؤدي بالطفل إلى اللجوء إلى الكذب، وهنا يتم استخدام الأساليب أو الفنيات التالية لمساعدة الطفل على التخلص من هذه العادة السيئة، وذلك على النحو التالي:

١ - التدعيم:

يث يستخدم الإخصائي النفسي كل من التدعيم الإيجابي والسلبي ويطلب من الوالدين استخدامها في المواقف التي يتأكدان من خلالها أن الطفل يقول الحقيقة.

ومن أشكال التدعيم الإيجابي:

١ -استخدام المعززات الغذائية: وتستخدم في ذلك الحلوى والشيكولاته والأيس كريم والعصائر، وغيرها.

٢ -المعززات الاجتماعية: مثل استخدام كلمات المدح والثناء والتقدير على ذكر الحقيقة وكذلك اللمسات الدالة على الرضا مثل التربيت على الكتف وتعبيرات الوجه مثل الابتسامة والتعبير عن السرور.

٣ -المعززات المادية: والتي يمكن استخدامها في المدرسة من المعلم وذلك بإعطاء الطفل بطاقات أو قطع معدنية أو بلاستيكية يمكنه من خلالها استبدالها من مقصف المدرسة بمعززات أخرى كطعام والهدايا.. أو غيرها.

أما التدعيم السلبي:

فهو يعني حذف شيء غير مرغوب عن الطفل مثل (العقاب أو تخفيف الألم، أو الخوف أو غيرها من الأمور التي يحبها الطفل، فالطفل عندما يقول الحقيقة قد نرفع عنه عقابا كان قد وقع عليه.

٢ - إعادة التغذية الحقيقية أو الواقعية:

عندما يقوم الطفل بسرد قصة طويلة يدعه الأب أو الأم أو المعلم يشعر بأنه مهتم وأنها قصة جميلة وشيقة. ثم يمكن مساعدة الطفل على التمييز بين الحقيقة والخيال من خلال الاستفسار هل هي حقيقة أم تشبه الحقيقة ؟ وعندما يخبرنا الطفل بأنها غير حقيقية مثلا نتركه يذكر لنا قصة أخرى حقيقية حتى يتعلم أن يفرق بين الخيال والحقيقة.

٣ - العقاب:

وعادة لا يلجأ إليه إلا في حالات نادرة وذلك لأنه في بعض الأحيان قد يكون سبب كذب الطفل، ولكن يمكن استخدام بعض الفنيات التالية:

١ - الحرمان أو الاستبعاد لبعض الوقت: حيث يحرم الطفل الكاذب لبعض الوقت من المعززات ومن الأشياء المرغوبة مثل الانضمام لجماعات النشاط أو الاشتراك في الترتيب لحفلة أو الخروج في رحلة.

٢ - ثمن الخطأ: حيث يغرم الطفل من مصروفه بأن يدفع ثمن كذبه، ومثال ذلك ما يتبع في أسلوب الغرامات وإلى جانب الأساليب والفنيات السابقة ينبغي على الإخصائي النفسي توعية الوالدين إلى بعض الأمور التالية التي ينبغي الانتباه لها عند تنشئة أبنائهم، ومنها:

- البعد عن القسوة عند ارتكاب الطفل لخطأ ما.
- الوفاء بأي وعد يقطعونه على أنفسهم للطفل أو تبرير عدم الوفاء به.
- عدم التفرقة بين الأخوة أو إهانة وتحقير الطفل _ الكاذب _ أمام أخوته.
- أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم بابتعادهم عن الزج بالطفل في قول ما يخالف الحقيقة.
- تقديم قصص تدعم قيمة الصدق.

- عدم السخرية من الطفل أو الاستهزاء به.

ومن التوجيهات التي يقدمها الإخصائي النفسي للمعلمين بشأن كذب التلاميذ ما يلي:

١ - يجب على المعلمين أن يتجنبوا المواقف التي تعطي الفرصة للكذب كالقسوة والتشدد في طلب الواجبات المدرسية، فإن هذا يضطر التلميذ إلى الكذب تفاديا للعقاب.

٢ - يجب أن ينمي المعلمين في تلاميذهم الصفات التي تحث على الصدق بأنواعه: فلا كذب ولا غش ولا تجسس، ولا نفاق ولا اختلاق للأعذار. إلى غير ذلك من الصفات.

٣ - ينبغي على المعلمين تقبل اعتراف التلميذ بخطئه واعتذاره عنه، فلا ينبغي توقيع العقوبة لأن للاعتراف قدسيته وتوقيع العقاب بعد اعترافه بالصدق هو عقاب على الصدق ذاته.

٤ - يجب أن يتصف الجو المدرسي بالصدق والمحبة بدلا من الشدة والعقاب حتى يشجع ذلك التلاميذ على الصدق.

ثانيا: بعض مشكلات مرحلة المراهقة:

(١) التدخين:

يعد البدء في تدخين السجائر عملية معقدة، إذ أن المراهق لا يدخن بين يوم وليلة، وإنما يمر بعدة مراحل، تقف وراء مل مرحلة منها عدة متغيرات بيئية واجتماعية وبيولوجية ونفسية بل أن هذه المتغيرات تختلف بالنسبة للمراهق الواحد من موقف لآخر فتهيئ هذه المتغيرات المراهق غير المدخن لأن يجرب السيجارة الأولى، ويسهم بعضها الأخر في تكرار المحاولة، كما تسهم فئة ثالثة من هذه المتغيرات في استمرارية المراهق في تدخين السجائر وبعد أن يتمكن التدخين من المراهق، تظهر رغبته في الابتعاد عن التدخين لكن تسهم مجموعة من المتغيرات في فشل هذه المحاولات والعودة مرة أخرى للتدخين بعد الامتناع عنه لفترة قصيرة في أغلب الأحيان مما ينتج عنه في النهاية انخفاض مستوى فعالية الذات. ولا يخفى على أحد ما للتدخين من أضرار وأثار خطيرة

على صحة الفرد، بما يسببه من أمراض نفسية وجسمية خطيرة، وإن كان أخطرها على الإطلاق سرطان الرئة والحنجرة، وأورام المثانة والإجهاض بين الحوامل المدخنات، إلى جانب جلطات القلب والأوعية الدموية هذا إلى جانب ما يلحقه من أضرار بالغة بالعمليات العقلية العليا الضرورية لحياة الفرد اليومية كالانتباه والإدراك والتذكر.. وغيرها، إلى جانب ما يحدثه التدخين من زيادة درجة الاعتماد النفسي والبيولوجي على النيكوتين، كما يهيئ الفرد لتعاطي مواد أشد تأثيرا في جهازه العصبي وأكثر إحداثا للضرر الجسمي والنفسي.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن التدخين يؤدي إلى وفاة ما يقرب من (٢,٥) مليون فرد على مستوى العالم سنويا، ومن المحتمل أن يتضاعف هذا المعدل في العشرين سنة المقبلة، فإذا لم تتخذ القرارات الفعالة فإن التدخين يحتمل أن يصبح ثاني أكثر الأمراض الوبائية في القرن التالي بعد الإيدز.

وإلى جانب ما سبق من أضرار يلحقها التدخين بصحة المدخنين، فإن التدخين يهدد الكثير من الطاقات البشرية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال تمثل ميزانية التدخين (٧,٢٪) من ميزانية الأسرة المصرية بعد ارتفاع أسعار التبغ وقد أوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر المتوسط أن حجم استهلاك السجائر في مصر عام ٢٠٠٠ قد وصل إلى (٨٥) مليار سيجارة، فإلى جانب الخسارة المادية الفادحة في الاستهلاك المادي لهذه السجائر يضاف أيضا ما تنفقه الدولة على المواطنين في علاج الأمراض التي يتسبب فيها التدخين من أدوية ومصحات وميزانية المستشفيات الحكومية، إلى جانب خسارة أيام عمل هؤلاء المدخنين ليبلغ إجمالي الهدر العام مليارات من الجنيهات.

أسباب التدخين:

١ - تقليد الآخرين: لعل أكثر الأسباب التي تجعل المراهق يقوم بسلوك التدخين هو ميله لتقليد الكبار، فقد وجد أن أبناء المدخنين أكثر احتمالا من غيرهم لأن يكونوا أو يصبحوا

من المدخنين فقد يؤثر تدخين الأب، تأثيرا مباشرا من خلال كونه تدعيما إيجابيا لأبنائهم، فهو يقدم نموذجا أدائيا لكيفية التدخين _ كما أن سلوك الأب على هذا النحو يسهم في تكوين اتجاهات إيجابية للتدخين مما يحفزهم لمحاولة التجريب.

٢ - ضغط الأقران: في مرحلة المراهقة غالبا ما يميل المراهق إلى مسايرة أقرانه في سلوكهم، فعندما يصاحب المراهق أقران له يدخنون يميل إلى أن يفعل مثلهم وخاصة عندما يحصل على الإثابة منهم وتعزيز هذا السلوك لديه، بل انه قد يتعرض للنقد الشديد والنفور إذا لم يفعل مثلهم، وهكذا يصبح زملاؤه مصدرا للضغط عليه لتقليدهم.

٣ - جذب الانتباه: يحاول المراهقون جذب انتباه الآخرين من خلال إشعالهم السجائر، وإثبات رجولتهم من خلالها، حيث يعتقد أغلب المراهقين أن التدخين يعد أحد مظاهر الرجولة، وأنه يعطيهم الشعور بأنهم أصبحوا أكثر نضجا وخشونة. وليظهروا للآخرين من خلال التدخين أنهم قد عبروا مرحلة الطفولة.

٤ - وهم مواجهة الضغوط والتوترات: يرتبط التدخين في أذهان كثير من المدخنين بأن أحد أهم ما يجنونه من وراء التدخين أنه يساعدهم على مواجهة ضغوط وتحديات الحياة اليومية، وأن تدخينهم يزداد عند شعورهم بالقلق والتوتر والخوف فهو في اعتقادهم وسيلة لتخفيف التوتر، وإن كانت الدراسات الحديثة قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك خطأ هذا الزعم وأكدت أن التدخين يعد أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الشعور بالتوتر والقلق.

٥ - سمات الشخصية: عادة ما يرتبط سلوك التدخين وخاصة في مرحلة المراهقة ببعض سمات الشخصية فقد وجد أن أغلب المراهقين المدخنين لديهم تقدير منخفض لذواتهم، إلى جانب أنهم متمردين وثائرين، بل ويحتمل أيضا أن يكونوا ممن ينخفض أداؤهم المدرسي بشكل كبير، وأنهم أقل إيجابية وأكثر قلقا من المراهقين غير المدخنين.

٦ - عدم الرضا بأضرار التدخين: حيث يلعب جهل المراهقين بأضرار التدخين الصحية دورا هاما في إقدامهم على تجربة التدخين حيث أنهم غير مدركين لخصائص التدخين الإدمانية، إذ أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون التوقف وقتما يريدون فيندفعوا إلى المغامرة والتجريب فيقعوا فريسة لتلك العادة السيئة.

٧ - خطورة وسائل الإعلام: تلعب وسائل الإعلام دورا خطيرا في تربية النشء، وهذا بما تقدمه في أجهزتها المختلفة من سينما وصحف ومجلات في الإعلان عن التدخين، ويؤثر تأثيرا كبيرا في تشكيل سلوكيات الناس في سلوك التدخين. فشركات التبغ تقدم للمراهقين بصفة خاصة الرجل المدخن وهو في سباق الخيل والدراجات البخارية، والسيارات.. وغيرها وترسم له صورة إيجابية يبرز خلالها علامات الثقة بالنفس والقوة والشجاعة مما يرسخ في أذهان هؤلاء المراهقين الاتجاهات المحبذة للتدخين.

دور الإخصائي النفسي في مواجهة مشكلة التدخين:

يلعب الإخصائي النفسي المدرسي في مواجهة تلك المشكلة دورا حيويا بما يقدمه من خدمات وقائية للمراهقين الذين لم يقعوا في شباك التدخين، وخدمات أخرى علاجية للتصدي لتلك المشكلة مع هؤلاء الذين وقعوا في حبائلها بالفعل.

ففيما يتعلق بالدور الوقائي: يقوم الإخصائي النفسي في إطار هذا الدور بتنظيم المحاضرات والمناقشات في إطار الإرشاد الجماعي للطلاب في المدارس وذلك لتعريفهم بالأسباب التي تقف وراء إقدام المراهق على سلوك التدخين وتوعيتهم بالأضرار الجسمية والعقلية والنفسية المترتبة على ذلك. ويمكن الاستعانة في ذلك بالأطباء للتحدث عن الأضرار الصحية، وكذلك رجال الدين للتعرف على حكم الدين في التدخين، هذا إلى جانب استعانة الإخصائي النفسي بالأفلام التعليمية والصور التي تحتوي على ما يلي:

١ - معلومات عن الآثار الفسيولوجية المباشرة للتدخين.

٢ - معلومات عن نتائج تدخين السجائر لفترات طويلة المدى على الصحة العامة.

٣ - تصحيح المدركات الخاطئة الشائعة عن التدخين.

٤ - زيادة تقدير المراهقين لذواتهم وإمدادهم بمهارات اجتماعية عامة تزيد من كفاءتهم على مواجهة المواقف المشجعة على بدء التدخين.

وإلى غير ذلك من المعلومات والمهارات المختلفة التي تزيد من دفاعات المراهق لمواجهة سلوك التدخين.

أما فيما يتعلق بالدور العلاجي:

ففي إطار هذا الدور يقوم الإخصائي النفسي باستخدام عدد من الفنيات العلاجية التي تقوم على الإرشاد السلوكي وغيرها من العلاجات الأخرى وذلك على النحو التالي:

١ - الفنيات القائمة على المثيرات المنفرة:

والتي تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات التي تستخدم كمثيرات منفرة لتثبيط سلوك التدخين ومنها ما يلي:

أ - أسلوب الإشباع: الذي يقوم على أساس أنه عندما يتشبع الفرد بشيء معين فإن استمرار تعرضه لهذا المثير يصبح بمثابة عقاب له، وهنا يقوم الفرد بتدخين السجائر بمعدلات مضاعفة للمعدل الذي يستهلكه في التدخين اليومي العادي، فمثلا إذا كان الفرد يدخن في اليوم (١٠) سجائر فقط، يطلب منه أن يقوم بتدخين من (٣٠:٦٠) سيجارة في اليوم حتى يحدث التشبع الذي يجعله ينفر من التدخين.

ب - التدخين السريع: يقوم هذا الأسلوب على أساس استخدام مثير سلبي مقرونا بالاستجابة التي يسعى الإخصائي النفسي لمحوها، ففي هذه الطريقة يطلب من المدخن أن يجلس في حجرة مغلقة ويسحب نفسا كل خمس ثوان مثلا حتى يعجز عن تدخين المزيد من

السجائر، ولقد أثبتت هذه الطريقة فاعليتها في امتناع المدخنين عن التدخين تماما، ولكن لا ينصح باستخدام هذه الطريقة إلا نادرا وذلك لأثارها الخطيرة على القلب والأوعية الدموية.

ج - حبس الدخان: هي إحدى طرق الإشراط التنفيري وتقوم هذه الطريقة على جعل الدخان نفسه مثيرا منفرا، وفيه يطلب من الفرد تدخين سيجارة وحبس الدخان في فمه بدون تنفس لفترات طويلة.. وهكذا.

د - أساليب التنفيس التخيلي: يطلب الإخصائي النفسي من الطالب المدخن أن يتخيل مشهدا يرى فيه أنه بعد إشعاله للسيجارة أعقب ذلك حدوث موقف منفر مثل التقيؤ، ويحدث ذلك بعد كل نفس يسحبه من السيجارة.. وهكذا.

٢ -الفنيات القائمة على الضبط الذاتي:

هي مجموعة من الاستراتيجيات التي تستهدف مساعدة المدخن على السيطرة على الظروف البيئية التي تدعم سلوك التدخين ومن طرائقها ما يلي:

أ - الثواب والعقاب: يقوم الإخصائي النفسي من خلال هذه الطريقة بتدريب الطالب المدخن على الامتناع التدريجي من خلال المكافأة والعقاب، فعليه أن يحدد لنفسه مكافأة إذا تمكن من الامتناع عن التدخين لفترة معينة من الزمن يحددها لنفسه (عدة ساعات _ يوم _ أسبوع) ويحدد لنفسه عقابا إذا فشل في تحقيق هذا الامتناع.

ب - ضبط المثير قبل الاستجابة: يتضمن ذلك تغيير عناصر البيئة التي تستخدم كمثيرات تقود المراهق لأن يقوم بسلوك التدخين بمعنى أن كثير من المدخنين _ فيما يذكرون _ يحتاجون لأن يأخذوا سيجارة في مواقف معينة (بعد الوجبات مثلا أو مع القهوة..) وغيرها من المواقف التي يمكن تغييرها بطرق مختلفة وكثيرة، فعلى سبيل المثال، عن طريق إزالة مثيرات التدخين كالطفايات وعلب الثقاب وعلب السجائر، أو الجلوس على المائدة بعد الوجبات، وهذه الطريقة لها فعالية كبيرة في الحد من التدخين.

ج - ضبط المثير بعد الاستجابة: وتعرف هذه الطريقة بالتنظيم المسبق لنواتج الاستجابة، وتتضمن التغير المنظم لبيئة الفرد وذلك حتى تتبع الاستجابات المرغوبة نتائج سارة وتتبع الاستجابات غير المرغوبة نتائج غير سارة، فمثلا بعد تدخين سيجارة يتعاطى المدخن عقارا يؤدي إلى الشعور بالدوار والقيء، مما يؤدي إلى ابتعاده عن التدخين مستقبلا، وإن كانت هذه الطريقة لها فعالية ضعيفة بسبب امتناع المدخن عن تناول الدواء.

د - إبدال الاستجابة: ويتضمن هذا الأسلوب استبدال سلوك التدخين بسلوك آخر بديل فمثلا إذا كان الشخص المدخن اعتاد على تناول سيجارة مع القهوة بعد الإفطار، يمكن أن يترك القهوة ويذهب لأداء أي عمل ما يشغله عن التدخين.

(٢)الهروب من المدرسة:

مما لا يخفى على أحد أن المدرسة، تلعب دورا حيويا في تنشئة أبنائها الطلاب، فهي تعد ثاني أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية بعد المنزل في إعداد الطلاب للحياة، وعلى الرغم من ذلك نجد فئة من هؤلاء الطلاب تجد صعوبة في التوافق معها، وتشعر بالكراهية تجاه المدرسة، هذه الكراهية بعضها يتعلق بالمحيط الدراسي، وبعضها الآخر يتعلق بالبيئة المنزلية ولكن أي كان السبب وراء نفور الطلاب من المدرسة فإن الهروب المتكرر منها يؤدي إلى تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى هؤلاء الطلاب، بل الأخطر من ذلك هو ما يترتب على الهرب من المدرسة من نتائج. فاكتشاف الوالدين أو إدارة المدرسة لهروب الطلاب يجعلهم يختلقون الأعذار والأكاذيب. ووجود الطالب في الشارع قد يعرضه لمصاحبة رفاق السوء الذين يجرونه لطريق مجهول قد يؤدي به لضياع مستقبله.

وفي الحقيقة أن مشكلة الهروب من المدرسة أصبحت تعد من المشاكل الكبيرة التي تواجه بعض المدارس، حيث تنتشر في بعض المدارس لدرجة أنها تعد ظاهرة، وذلك إما نتيجة لضعف الإدارة المدرسية أو نتيجة لتشجيع الطلاب لبعضهم البعض أو خضوع الطالب

لإغراءات زملائه، فقد يقبل دعوة زميله للسينما ويتغيب لأول مرة عن المدرسة، ويزداد إقبالا على هذا السلوك إذا تضافرت العوامل التي تؤدي إلى كراهيته للمدرسة.

ومن هذا المنطلق وجب على الإخصائي النفسي المدرسي مواجهة تلك المشكلة وذلك من خلال حصر المسببات والتصدي لها، وفتح قناة اتصال مع الأسرة لتوعيتها بمدى خطورة هذا السلوك في تهديد مستقبل ابنهما الأكاديمي والمهني فيما بعد، والتأكيد على ضرورة التعاون بين المنزل والمدرسة لمساعدة الطالب على العودة إلى مدرسته مرة أخرى، وكذا يمكن إعداد البرامج الإرشادية الوقائية لتوعية الطلاب بأخطار الهروب من المدرسة وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات، وبرامج أخرى علاجية للطلاب الذين يهربون بالفعل من المدرسة واتخاذ التدابير اللازمة معهم سواء من خلال التدعيم أو العقاب حتى يتم الحد من هذا السلوك غير المرغوب.

أسباب الهروب من المدرسة:

١ -أسباب تتعلق بالبيئة المدرسية:

أ - سوء العلاقة بين المدرس والطالب: مما لا يخفى على أحد أنه كما يوجد معلمين يتركون الأثر الطيب في طلابهم ويدفعونهم إلى التحصيل والوصول إلى مستويات عليا من الطموح، فإنه نجد في المقابل معلمين يتركون أثرا سيئا في نفوس طلابهم ويكونوا السبب في نفور بعض الطلاب من المدرسة بما يثيرونه فيهم من مشاعر النقص والإحباط، مما يجعلهم يشعرون بالتوتر ليكون الحل هو الهروب من المدرسة.

ب - كثرة الواجبات المدرسية: كثير من المعلمين يستخدمون الواجبات المدرسية وسيلة للعقاب والتهديد، فيشغلوا كاهل الطلاب بأعباء كبيرة تجعلهم عاجزين عن أدائها، فيصبحوا هدف لعقاب المعلم، مما يجعل الجو الذي تتم فيه العملية التعليمية جو لا يبعث على الشعور بالاطمئنان والرضا، فلا يجدوا مناصا من ذلك سوى الهروب.

ج - عدم مناسبة المناهج الدراسية: إذا كان ذكاء الطالب وإمكاناته العقلية لا تتفق مع المنهج الدراسي، ويعاني الطالب من صعوبة هذه المواد فسوف يشعر بالنقص والدونية أمام زملائه، وبالتدريج يحاول التماس الأعذار للتغيب، كذلك في المقابل نجد من الطلاب من يميل إلى الدراسة ويكون مستواه العقلي أعلى بكثير من باقي الطلاب، فسوف نجدهم يعزفون عن ذلك النوع من الدراسة لأنه لا يشبع نهمهم المعرفي وخاصة إذا كانت المناهج الدراسية لا تقدم الجديد ولا تتحدى قدراتهم فقد يشعروا بمرور الوقت أن تغيبهم لن يؤثر على تقدمهم الدراسي فيؤثرون عدم الذهاب.

د - الخوف من العقاب: إن تهديد المعلم المستمر لطلابه بالعقاب القاسي يؤثر على عدم انتظامهم بالمدرسة، بل الأمر الأكثر من ذلك أن يسود الجو الأوتوقراطي الاستبدادي النظام المدرسي ككل، فيؤدي ذلك إلى كراهية المدرسة بالكامل فالطالب الذي يتأخر عن مواعيد المدرسة لأسباب قهرية ويتعرض للعقاب الشديد، قد يفضل بعد ذلك عدم الذهاب إلى المدرسة بقية اليوم وقد يعتاد الطالب على ذلك فيما بعد.

٢ -أسباب تتعلق بالبيئة المنزلية:

أ - استخدام المدرسة كأداة للتهديد: قد نجد أحيانا أن الوالدين يستخدما المدرسة كأداة لتهديد الطالب منذ صغره، مما يجعله ينظر إليها كخطر يهدده بالألم والعقوبة فإذا أراد الأب أن يجبر ابنه على فعل شيء يرفض أدائه يهدده بأن يشكوه إلى مدير المدرسة لمعاقبته، وهكذا تصبح المدرسة مصدر قلق فيكون الآباء قد زرعوا في نفس المراهق كراهية المدرسة منذ طفولته، فلا عجب أن يحاول الهرب منها عند الكبر.

ب - عدم مبالاة الوالدين: قد يثبت الوالدان سلوك الهرب من المدرسة دون قصد منهما عندما يبقيان على الطالب في المنزل لمساعدتهما في الأعمال المنزلية أو لمشاركتهما في رحلة معينة، أو لمساعدتهما في مواسم الحصاد، وهكذا يجد الطالب في المنزل تربة صالحة لانتحال المعاذير والهروب من المدرسة.

ج - أمية الوالدين: قد نجد أن بعض الآباء الأميين يشعرون أن المدرسة قد أدت مهمتها بمجرد ما يستطيع الصغير أن يقرأ ويكتب ويقوم ببعض العمليات الحسابية وبذلك فهم يكتفون بهذا القدر من التعلم ويحتجزوه ليساعدهم في القيام بأعباء الحياة، وينتشر هذا التفكير خاصة في الريف وفي المستويات الاجتماعية الاقتصادية الدنيا.

د - اضطراب العلاقة بين الطالب ووالديه: يمكن إرجاع كراهية المدرسة والهرب منها إلى اضطراب علاقة المراهق بأسرته حيث يعتبر الرفض وعدم التقبل أحد الأسباب الأساسية، أو قد يكون طموح الوالدين ورغبتهم في بلوغ أبنائهم الكمال من الأسباب التي تثير القلق لدى الأبناء وتوقع الفشل وكراهية المدرسة، أو يرجع ذلك لقيام الوالدين بعقد مقارنة بين الطالب وأخوته المتفوقين عليه والسخرية منه وتعبيره بهذا النقص الأمر الذي قد يؤدي إلى كراهيته للمدرسة والهروب منها.

دور الإخصائي النفسي في مواجهة مشكلة الهروب من المدرسة:

في البداية على الإخصائي النفسي المدرسي التعرف على الأسباب التي أدت بالطالب إلى هروبه من المدرسة، وهل هي أسباب تتعلق بعلاقة الطالب بالمدرسين أم علاقته بزملائه أم لانخفاض مستواه التحصيلي.. وإلى غير ذلك من الأسباب المدرسية السابق ذكرها، أم أن هذه الأسباب ترجع إلى مشكلات تتعلق بالمنزل وأساليب معاملة الوالدين أو إدراكها للدور الذي تلعبه المدرسة في تنشئة أبنائهما ويتم التشخيص من خلال مقابلة مع التلميذ وإذا تطلب الأمر يتم عمل دراسة عمل له للوقوف على الأسباب الفعلية وراء هذا السلوك أو يستخدم استمارة الملاحظة المدرسية للتعرف أيضا على مدى انضباط الطالب في المدرسة وسلوكه العام وذلك للاستفادة منها في التخطيط للإرشاد.

ثم تأتي الخطوة التالية وتتعلق بوضع برنامج إرشادي للتغلب على مشكلة الهروب من المدرسة ويمكن من خلالها استخدام الفنيات الإرشادية التالية:

١ - التعزيز: يستخدم التعزيز لتشجيع وحث الطالب على الحضور للمدرسة وذلك باستخدام المعززات المختلفة كالتعزيز الاجتماعي والتي تتضمن عدد من الإجراءات مثل المدح والتلاحم الجسدي (كالربت على الكف)، والتعبيرات الإيجابية للوجه كالابتسامة، والتلاحم البصري.. وغيرها كذلك يمكن استخدام الامتيازات والأنشطة في تعزيز سلوك الانتظام في المدرسة، حيث يسمح للطلاب الاشتراك في أنشطة من اختيارهم في أوقات الراحة أو علاج ما لديهم من مشكلات.

٢ - العقاب: تستخدم أساليب العقاب في علاج مشكلة الهروب المدرسي ولكن بدرجة أقل من استخدام التعزيز لما له من أثار سيئة على الطالب، ومن أساليب العقاب ما يلي:

❖ **التأنيب اللفظي:** والذي يستخدم فيه عبارات التأنيب من قبيل (إنني أحذرك، إنني أنذرك، إنني لا أوافق على سلوكك هذا).. وغيرها من الكلمات التي تتكرر داخل الفصل.

❖ **التصحيح الزائد والإجراء الإيجابي:** في هذا الأسلوب يطلب من الطالب الذي يتكرر هروبه من المدرسة أداء أعمال لا يحب عملها كأن ينظف ويرتب فصله في كل مرة يهرب فيها من المدرسة.. وهكذا.

❖ **الوقت المستقطع من التعزيز:** يستخدم هذا الأسلوب بأن يحرم الطالب من أشكال التعزيز التي تقدم للطلاب كالحرمان من القيام برحلة مع زملائه أو الحرمان من وجبة غذائية، أو الحرمان من ممارسة الأنشطة المحببة إليه بعض الوقت..الخ.

(٣)التأخر الدراسي:

مما لاشك فيه أن مشكلة التأخر الدراسي تحتل مكانا بارزا في تفكير المشتغلين في مجال العلوم التربوية والسيكولوجية، بل هي من أهم المشكلات التي تؤرق بال المربين والآباء والطلاب على حد سواء. ذلك لأنها من المشكلات التي تؤرق بال المربين والآباء والطلاب على حد سواء. ذلك لأنها من المشكلات التي تتشابك فيها الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية لنسج خيوطها مما يجعلها من المشكلات الحيوية ذات التأثير الخطير على المناخ العام المدرسي بما تعكسه

من مشكلات أخرى تترتب عليها، فقد يتحول الطالب المتأخر دراسيا لمصدر إزعاج وقلق في فصله بشكل خاص وفي المدرسة عامة بما يثيره من مشكلات بسبب ما يعانيه من مشاعر النقص وعدم الكفاءة والإحساس بالعجز عن مسايرة الزملاء، فيحاول التعبير عن هذه المشاعر السلبية بالسلوك العدواني أو الانطواء أو الهروب من المدرسة أو الانتماء لرفاق السوء من أمثاله مما عجزوا عن تحقيق ذاتهم، وقد تضيع على الطالب سنوات كاملة من عمره مما يفوت عليه بعض فرص الحياة.

إلى جانب ما سبق يمكن القول أن مشكلة التأخر الدراسي لها أيضا انعكاساتها الاقتصادية بما تؤدي إليه من خسارة فادحة وخاصة بالنسبة للدول التي ما زالت في طور النمو كمصر، فكثير من الطلاب الذين ينقطعون عن مواصلة دراستهم لعجزهم عن مسايرة زملائهم العاديين، سرعان ما ينضمون إلى حصيلة العاطلين، ليس هذا فحسب بل قد يمارس هؤلاء الطلاب أعمال غير مشروعة كالسرقة والإدمان.. وغيرها من المشكلات التي تؤخر عجلة التنمية وتؤدي إلى فاقد وهدر اقتصادي.

أشكال التأخر الدراسي:

١ - التأخر الدراسي العام: ونعني به تخلف ظاهر عند الطالب في كل المواد الدراسية، وهذا يرتبط بالطلاب الذين يتراوح معامل ذكاءهم ما بين (٧٥:٩٠).

٢ - التأخر الدراسي الخاص: وهو التقصير الملحوظ في عدد قليل من المواد الدراسية، فقد يكون الطالب متخلفا في الرياضيات أو اللغات، وغير ذلك من المواد الأخرى.

أسباب التأخر الدراسي:

تتعدد الأسباب التي تؤثر في مشكلة التأخر الدراسي ما بين أسباب شخصية واجتماعية وعقلية ومدرسية، وفيما يلي توضيح لهذه الأسباب بشيء من التفصيل:

أولا: الأسباب الجسمية: هناك مجموعة من الأسباب الجسمية (الخلقية) التي تلعب دورا حيويا في التأثير على مشكلة التأخر الدراسي وهي:

١ - القصور الجسمي: فضعف الإبصار، وضعف السمع يلعبان دورا في إحداث مشكلة التأخر الدراسي وذلك لأن قصور تلك الحواس يؤدي إلى صعوبة متابعة الطالب لشرح المعلم وخاصة الذي لا يستخدم الوسائل المعينة كالنظارة وسماعات الأذن، أضف إلى ذلك الأثر النفسي الذي قد تحدثه تلك الإعاقة الجزئية عند الطالب إذا قارن نفسه بالآخرين.

٢ - الصحة العامة: قد يعاني الطالب المتأخر دراسيا فقر الدم الحاد أو ضعف البنية الجسمية، مما يحول بين الطالب والقدرة على الانتباه والتركيز والمتابعة، ويصبح أكثر قابلية للتعب والإنهاك أكثر من غيره من الطلاب الآخرين.

٣ - الإعاقات: إن الطالب الذي يعاني من بعض الإعاقات كصعوبات النطق وعيوب الكلام وبعض الإعاقات الجسدية، وغيرها قد تشعره بالنقص والدونية وأنه موضع ملاحظة الطلاب الآخرين وسخريتهم وهذا يسبب له الضيق والنفور من الدراسة بشكل عام.

ثانيا: الأسباب العقلية:

١ - نسبة الذكاء: يعد الذكاء أحد أهم العوامل المؤثرة في مشكلة التأخر الدراسي، إذ أن انخفاض معامل ذكاء الطالب يؤدي إلى تأخره العام. ولهذا فقد حددت هيئة الصحة العالمية واليونسكو معامل ذكاء الطلاب المتأخرين دراسيا ما بين (٧٠:٩٠).

٢ - القدرات الطائفية: لقد أكدت الدراسات وجود علاقة بين القدرات الطائفية كالقدرة اللغوية والقدرة المكانية والتحصيل الدراسي، فقد يعني تأخر الطلاب في الجبر والهندسة أو في الرياضيات عموما بأنه يعاني من انخفاض القدرة العددية لدى هذا الطالب.

ثالثا: الأسباب الاجتماعية:

وتتضمن مجموعة العوامل الأسرية والمدرسية التي تؤثر على التحصيل الدراسي كالتالي:

١ - العوامل الأسرية:

أ - الخلافات الأسرية: إن الجو الأسري الذي يسوده التفكك بين الزوجين والمشاجرات والخلافات العائلية يؤدي إلى تأخر التلميذ دراسيا.

ب - أساليب المعاملة الوالدية اللاسوية: يعاني بعض الطلاب من معاملة الوالدين بطريقة لا سوية قد تكون قاسية أو يغلفها التدليل والحماية الزائدة أو التسلط.. وإلى غير ذلك من الأساليب التي تعوق الطالب عن الأداء المدرسي الجيد.

ج - أمية أحد الوالدين أو كلاهما: قد ينعكس جهل أحد الوالدين على نظرته للمدرسة والتعليم بشكل عام إذ قد لا يرى ضرورة لمتابعة الطالب لدرسه أو إكمال تعليمه وقد يؤدي ذلك إلى انصراف الابن أو الابنة عن التعليم.

د - انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة: حيث أن الحرمان الذي يتعرض له أبناء الطبقة الدنيا من وسائل العصر يؤدي إلى تخلفهم عن زملائهم ومتابعة دراستهم وذلك أيضا لأنهم قد يضطروا إلى مساعدة والدهم لمضاعفة دخل الأسرة أو نتيجة لنقص الخبرات والتجارب التي تزيد من معارفهم داخل تلك البيئة.

٢ - العوامل المدرسية:

أ - أساليب معاملة المعلمين: قد يؤدي أسلوب معاملة المعلمين إلى تأخر الطلاب دراسيا بسبب تسلط المعلم أو قسوته أو شدته في التعامل مع الطلاب مما ينعكس بدوره على عدم قدرتهم على متابعة شرح المعلم بسبب توجسهم للخطر القادم منه.

ب - عدم كفاءة التدريس: إن ضعف التدريس يؤد إلى عدم إتقان الطالب للمهارات الأساسية للمادة، فكم من طالب تخلف في الكيمياء وأصبح كارها لها نتيجة لسوء تدريس المعلم، وكم من طالب كان تحصيله في مادة الرياضيات منخفضا بسبب ضعف الوسائل التي يستخدمها المعلم.

دور الإخصائي النفسي في مواجهة مشكلة التأخر الدراسي:

يتبع الإخصائي النفسي المدرسي عدة خطوات لمواجهة التأخر الدراسي العام أو الخاص لدى أحد الطلاب على النحو التالي:

أولا: التشخيص:

يتم جمع معلومات عن الطالب المتأخر دراسيا من خلال وسائل جمع المعلومات المتنوعة وأهمها الاختبارات والمقاييس حيث يقوم الإخصائي النفسي بتطبيق المقاييس التالية:

أ -مقياس للذكاء.

ب -مقاييس للشخصية.

ج -اختبارات تحصيلية مقننة.

وإلى جانب ذلك تتم مقابلة الطالب للحصول على معلومات وبيانات خاصة عنه وفحص السجل المجمع الخاص بالطالب وعمل دراسة حالة إن استلزم الأمر ذلك، وكل ذلك من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء مشكلة تأخر الطالب دراسيا.

ثانيا: العلاج:

من أساليب إرشاد علاج المتأخرين دراسيا ما يلي:

١ -الإرشاد الوقائي:

تدور الخدمات الوقائية حول التصدي للأسباب التي تقف وراء التأخر الدراسي وذلك كما يلي:

(١) توجيه الطلاب إلى نوع الدراسة الملائمة لمستوى تحصيلهم وقدراتهم العقلية وميولهم وذلك لتفادي تعثر الطلاب فيما بعد في نوع معين من الدراسة لا يتلاءم مع قدراتهم.

(٢) توعية المعلمين بضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ باستخدام الوسائل التعليمية.

(٣) متابعة الجوانب الصحية للطلاب بشكل دوري وإمداد المحتاجين منهم بالوسائل التعويضية كالنظارات الطبية أو سماعات الأذن.

(٤) فتح قنوات اتصال بين المدرسة والوالدين في المنزل لمساعدة الطالب المتأخر دراسيا على تجاوز الصعوبات الدراسية.

(٥) التصدي لبعض المشكلات التي يعكسها التأخر الدراسي كالسلوك العدواني والهروب من المدرسة، وسوء التوافق الشخصي والاجتماعي.

٢ -البرامج العلاجية:

تختلف الخدمات العلاجية باختلاف نوع التأخر الدراسي، كما يلي: (٥٨)

أولا: إذا كان التأخر الدراسي عاما وشاملا، فلاشك أن التفكير سيتجه في هذه الحالة إلى انخفاض عام في معامل ذكاء الطالب، حيث أكدت مقاييس الذكاء ذلك، وعلى الإخصائي النفسي هنا أن يتفحص العناصر المكونة للمقياس للتعرف على جوانب الضعف عند الطالب وتنمية تلك الجوانب، إضافة إلى استثمار السمات النفسية والدافعية على اعتبار أن الفقدان الجزئي للمكونات العقلية للتفوق يقابله تنمية الجوانب الشخصية الأخرى، ويتبع ذلك تدخل نفسي اجتماعي لمحاولة تعديل البيئة المحيطة بالطالب على اعتبار أنها تلعب دورا في تأخره العام وذلك على النحو التالي:

❶ تعديل اتجاهات الطالب السلبية نحو المدرسة.

❷ تنمية الثقة بالنفس، ونمو مفهوم إيجابي للذات حتى لا يستسلم الطالب لفكرة الفشل.

❸ تعديل توقعات الأفراد المحيطين بالطالب كالآباء والمعلمين وتعديل أسلوب معاملتهم له على أساس من الثقة.

❹ إذا كان التأخر الدراسي طارئا فعلى الإخصائي النفسي التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية من قبيل تلك العوامل التي تم عرضها مسبقا.

ثانيا: إذا كان التأخر الدراسي في مادة واحدة أو مادتين فإن الإخصائي النفسي عليه هنا استبعاد عوامل الضعف العقلي أو وجود عوامل اجتماعية مؤثرة، ذلك أنه لو كان التأخر الدراسي ناتجا عن أحد تلك الأسباب لانعكس ذلك على كل المواد، لذا فإن العلاج ينصب على كل ما له صلة بهذه المادة.. كالمدرس، طريقة التدريس، عدم إتقان أساسيات المادة.. وغيرها. فإذا اتضح من السجل المجمع للطالب استمراره في إظهار ضعفا في تلك المادة، هنا نحتاج إلى ما يسمى "بالتدريس العلاجي"، ويتلخص هذا النوع في الملاحظة المستمرة للطالب أثناء قيامه بحل مسألة حسابية مثلا (إذا كان التأخر في مادة الرياضيات)، تمهيدا لتحديد أخطائه ونقاط الضعف، ثم يبدأ معه المعلم بتعليمه الأساسيات ويتدرج حتى يصل إلى مستوى أقرانه.

(٤)اضطرابات الأكل:

يعد كل من فقدان الشهية العصبي والشرة العصبي هما أكثر اضطرابات الأكل شيوعاً، وأكثر الإضطرابات التي دُرست في هذا السياق في حين وضعت بقية الإضطرابات تحت اضطرابات الأكل غير المصنفة في موضع آخر مثل اضطراب الاستمتاع الفوضوي بالأكل Binge – eating Disorder الذي يتسم صاحبه بسلوكيات الاستمتاع بالأكل بصورة متكررة ولكن دون سلوكيات التحكم في الوزن إذا كان غير مناسبا كما في حالة الشره العصبي (DSM. IV, 1994)

ويتطور كل من الشره العصبي، وفقدان الشهية العصبي لدي الفتيات أثناء مرحلة المراهقة، ويفسر ذلك بأن مرحلة المراهقة هي الفترة التي تعاني فيها الفتيات عموما من انخفاض تقديرهن لذواتهم، ويكن أكثر عرضة للإختلالات العاطفية من الذكور، وفي المقابل لذلك نجد أن صورة الذات للفتيات المراهقات ذات أثر توجيهي في العلاقات البينشخصية، كما أن البنات المراهقات أكثر انشغالا بمظهرهن وبعلاقاتهن مع الآخرين، ونتيجة لذلك

فإن الفتيات أكثر ميلاً من الذكور في تأثر مشكلاتهن العاطفية بصورة الجسم ومحاولتهن التأثير فيها (محمد عبد الرحمن، ٢٠٠٠) إذ تنظر المراهقة لكل عضو من أعضاء جسمها وكأنه جزء قائم بذاته، فهي مرحلة الفحص الجزئي المدقق. وتبدأ المراهقة في معاناة جديدة نتيجة للتغيرات المفاجئة التي تعترى جسمها. وغالبا ما تكون المراهقة غير راضية عن شكل أجزاء جسمها، وربما تشعر بالقلق للبدانة التي حلت علي بعض أجزاء جسمها، وهي خاصية ربما تنفرد بها المراهقات أكثر من المراهقين.

وقد أوضح فيلد .Field, L (٢٠٠٢) أن صورة الجسم تعد أحد أهم اهتمامات الفتيات في مرحلة المراهقة، وأن ذواتهن الجسمية تلعب دوراً هاماً في شعورهن بذواتهن، وإذا عانت إحداهن من اضطراب صورة الجسم فإنهن قد يكن معرضات لنشأة اضطرابات الأكل.

ومن العوامل النفسية والشخصية التي أسفرت الدراسات السابقة عن ارتباطها بتطور اضطرابات الأكل، هي:اضطراب صورة الجسم، المخاوف الاجتماعية، ضعف التحكم في الدوافع والرغبات، انخفاض تقدير الذات، القلق والمخاوف الاجتماعية، وسوء المعاملة الوالدية، والشعور بالرفض الذاتي والاكتئاب.

ولقد قام سويل .Sewell,T (٢٠٠٠) برسم بروفيل للعوامل المنبئة بفقدان الشهية العصبي و الشرة العصبي لدي المراهقين، وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن الإناث أكثر تعرضاً لإضطرابات الأكل من الذكور، وقد ارتبطت اضطرابات الأكل لديهن بعدد من العوامل المهيئة لظهور تلك الاضطرابات لديهن والتي من بينها انخفاض تقدير الذات، وعدم الرضا عن صورة الجسم، الإكتئاب، واضطراب البيئة الأسرية.

❋ الشره العصبي:

يأتي مصطلح الشره العصبي Bulimia من كلمة يونانية هي Bous Limos وهي تعنى جوع الثور وهو أسم مغلوط لأن الجوع الحقيقي غير مرتبط بالمرض. والشره العصبي يعد مرض مختلف عن فقدان الشهية العصبي وقد يكون أكثر شيوعاً منه، فقد

أشارت أحد الدراسات أن الشره يعادل في انتشاره ٦ مرات فقدان الشهية بين عينة من طلاب جامعة واشنطن. وفي جامعة كاليفورنيا حينما تم افتتاح عيادة لإضطرابات الأكل لخدمة مرضى فقدان الشهية العصبي تحديداً سرعان ما غير المتخصصين اهتمامهم نحو مرضى الشره العصبي لأن عددهم يعادل (٥)مرات مرضى فقدان الشهية العصبي.

إن أغلب النساء ذوى الشره العصبي حتى لا يزداد وزنهم فإنهم يحاولون إتباع نظام غذائي صارم، ولكنهم مع استمرارهم في هذا النظام فإنهم يشعرون بالحرمان المؤلم والجوع الشديد والدائم، فهم يظلون في حالة من الجوع حتى بعد الأكل. ولكنهم لا يستطيعون مقاومة حالة الجوع التي يعانون منها ،ومن ثم يأكلون ،غير أن هذا السلوك يشعرهن بالتعاسة والذنب وعدم القدرة على الضبط. ومن هنا تزداد جهودهن لضبط الطعام أو التخلص منه بالقئ أو ممارسة الرياضة أو استخدام المسهلات أو مدرات البول. إن القئ يخفف بسرعة تعاستهن ويقلل لديهن مشاعر الذنب، وهكذا يصبح لدى هؤلاء النساء الحل المناسب لتجنب الجوع عن طريق تناول الأكل وتقيؤه (Johnson ,& Connors,2001)

وعندما يتبع هؤلاء النساء نظام غذائي نجدهم يقمن بحساب السعرات الحرارية والتخطيط للوجبات. لكن عندما يبدءن في الأكل لا يستطعن التحكم في تناولهن للطعام ولا يقمن بحساب السعرات الحرارية، وبدلا من ذلك نجدهم في حلقة مفرغة مابين الأكل والقئ. (Yates,A.,1991)

ومن الأسباب التي تعجل بحدوث الشره العصبي والتي من بينها: تكرار إتباع نظام غذائي قبل بدء الشره المرضى وحدوث تقلبات في الوزن ما بين السمنة والنحافة، إذ تسهم فكرة الفتاة عن نفسها بأنها مفرطة في الوزن في نمو متلازمة الشره المرضى. كما أن تعرض الفرد للأحداث المثيرة للضغوط النفسية، حيث يذكر ٨٨٪ من ذوى الشره العصبي أنهم تعرضوا في بداية إصابتهم للشره

لبعض أشكال الفقدان (كفقد أحد الوالدين أو الأصدقاء..) أو الصراعات والانفعالات غير السارة.

ويتضمن هذا الاضطراب عناصر معرفية وأخرى سلوكية، أما العناصر المعرفية فتتضمن الانشغال الزائد بوزن الجسم، وحجمه، وشكله، ورغبة الفرد في أن يكون أكثر نحافة حيث تضع النماذج الخاصة بالشره العصبي أهمية كبيرة على نسق القيم في المجتمع والذي يجعل من النحافة هدفاً مرغوبا خاصة بالنسبة للإناث. هذا إلى جانب إدراك الفرد أنه لا يمكنه يسيطر على نفسه أثناء نوبات الأكل أو حتى عندما يرى الطعام، في حين تضم العناصر السلوكية نوبات متكررة من الأكل، والتقيؤ المثار ذاتيا، وزيادة في الوزن.

❑ محكات تشخيص الشره العصبي:

الشرة العصبي هو زملة تتميز بنوبات متكررة من الإفراط في الأكل وانشغال شديد بالتحكم في وزن الجسم، يؤدى بالفتاة إلي نمط من الإفراط في الأكل يليه قيء أو استخدام الملينات ويشترك هذا الاضطراب في كثير من السمات النفسية مع فقدان الشهية العصبي بما فيها الاهتمام الشديد بشكل ووزن الجسم (أحمد عكاشة،٢٠٠٣)

هناك طرق مختلفة لتشخيص الزملة العيادية للشره العصبي أو المتلازمات العيادية التي تسببها .وبرغم تعدد أسماء هذه الزملة مثل: Bulimaarexia And Thedhetary Chaos Syndrome إلا أن أغلب الباحثين والعياديين في أمريكا وانجلترا يفضلون مصطلح .Bulimia Nervosa.

وفي النسخة الرابعة من دليل التشخيص الإحصائي للأمراض النفسية والعقلية الأمريكي DSM IV (١٩٩٤) تم تعديل تسمية الشره المرضى إلى الشره العصبي، كما تم

تعديل المحكات التي يتم في ضوئها تشخيص اضطراب الشره العصبي وذلك على النحو التالي:

(١) حدوث نوبات متجددة من الأكل حتى التخمة وتتميز نوبة الأكل بما يلي:

- أن يأكل الفرد خلال فترة زمنية محددة كأن تكون كل ساعتين مثلاً، وتناول كمية كبيرة من الطعام تزيد عما يستهلكه الناس خلال نفس الفترة الزمنية.
- شعور الفرد بفقدان القدرة على ضبط سلوك الإفراط في الأكل، حيث لا يستطيع التوقف عند تناول الطعام، وأنه لا يستطيع التحكم في نوع الطعام الذي يتناوله.

(٢) المحاولات المتكررة لإنقاص الوزن من خلال سلوك تعويضي غير ملائم لإنقاص الوزن وذلك بإتباع نظام غذائي صارم أو حث الذات على القئ أو استخدام المسهلات أو مدرات البول.

(٣) أن يكون المتوسط الأدنى من نوبات الأكل حتى التخمة والتخلص منه مرتين أسبوعيا لمدة ٣ شهور.

(٤) أن يتأثر التقييم الذاتي للفرد بشكل جسمه، ووزنه.

(٥) لا يحدث هذا الاضطراب خلال نوبات فقد الشهية العصبي.

إن أسلوب ذوى الشره العصبي في تناولهم للطعام والتخلص منه يتم علي النحو التالي:

أولاً: لا تهتم الفتاة التي تعانى من الشره العصبي بنوعية الطعام الذي تتناوله أو رائحته أو مذاقه، وإنما ينصب اهتمامها على الكمية التي تتناولوها من تلك الأطعمة. كما أنها تخشى أنها إذا بدأت في تناول قدر بسيط من الطعام الغنى الكربوهيدرات فإنها تلتهم المتاح أمامها كله.

ثانيا: تلجأ أيضا الفتاة التي تعانى من الشره العصبي إلى تناول الطعام سراً وبمعزل عن الآخرين، فهي تعطى لمكان تناولها الطعام أهمية كبيرة، حيث أنها تفضل أن تكون بعيداً عن أعين الآخرين.

ثالثاً: إن الفتاة التي تعانى من الشره العصبي قد تدرك فجأة أن التقيؤ هو الوسيلة الناجحة لضبط الوزن دون اللجوء إلى تجويع الذات، والدخول في مواجهات مع الوالدين والآخرين، فهي تأكل بشكل طبيعي لراحة الوالدين، وتبدأ في التقيؤ لراحة نفسها.وقد لا تلجأ الفتاة للقئ، إما لأنها لا تستطيع القيام بذلك أو لأن الظروف المحيطة بها لا تسمح لها بذلك. وفي هذه الحالة قد تلجأ إلى المسهلات أو مدرات البول أو القيام بالتمارين الرياضية القوية.

❑ الآثار البدنية والنفسية للشره العصبي:

إن أغلب مرضى الشره العصبي يعايشون مرحلة أولية من فقدان الوزن عند بدأ أعراض الشره. وعندما يتقدم المرض يزداد وزن هؤلاء المرضى الأمر الذي يعكس تغير نمطهم في الأكل. فيترتب علي ذلك عدد من الآثار البدنية والتي من بينها: أن الفرد يعانى من الخمول وضعف التركيز، والشكوى من آلام المعدة واتساعها بشكل كبير، بالإضافة إلى حدوث تأكل لطبقة المينا المغلفة للأسنان بسبب القئ المتكرر لما يحمله هذا القئ من أحماض المعدة. كما أنهن يعانين من الرغبة الشديدة في النوم، والشعور بالتعب والإعياء من أقت مجهود، واضطراب الحيض (كأن يحدث الطمث مرتين في الشهر).

كما أن القئ المتكرر من الممكن أن يؤدى إلى تمزق المرئ برغم ندرة ذلك. هذا إلى جانب أن سوء تعاطى المسهلات من الممكن أن يضعف القولون، ويعوق القدرة على التبول بشكل طبيعي.

ويصاحب الشره العصبي سوء الهضم المزمن، وانتفاخ الوجه، التهاب الحلق، وقد يحدث جفاف في الجلد وخمول، كما لوحظ أيضا تصلب اليدين والأصابع من حث الذات على التقيؤ.

إن تقيئ طعام يحتوى على السكريات من الممكن أن يؤدى إلى انخفاض سكر الدم نتيجة زيادة الأنسولين.كما أن خطورة الشره العصبي تكمن في أن المرضى به يبدو وزنهم طبيعي أو قريب من ذلك ولذا لا يبدو عليهم المرض، وبالتالي فإن عدم التوازن الفسيولوجي الذي يهدد الحياة لا يتم ملاحظته حتى تزداد شدته لدرجة كبيرة.

إن النساء ذوات الشره العصبي يدركن البيئة المحيطة بهن على أنها محبطة وتثير لديهن الضغوط النفسية، وأنهن غير قادرات على ضبط المتغيرات من حولهن أو التمكن منها.لذلك فإن نمط أكلهن يعد استجابة للأحداث المحيطة بهم.ولذلك تزداد لديهن نوبات الأكل كلما تعرضن للضغوط النفسية، حيث يستخدمن الطعام كطريقة للهروب من تلك الضغوط، و إذا اجبرن على التوقف عن الأكل والقئ فإنهن يعانين من القلق الأكتئاب والشعور بفقدان الضبط والرغبة والانسحاب.

دور الإخصائي النفسي في مواجهة الشره العصبي:

يتبع الإخصائي النفسي المدرسي عدة خطوات لمواجهة الشره العصبي:

العلاج التدعيمي: وهو يهدف إلى تعديل نمط حياة الفتاة ونصحها بتجنب مواقف الانفعال الشديد والإجهاد العقلي المتواصل - وشرح وتفسير العلاقة بين الانفعال وردود الفعل الفسيولوجية، وإعادة تعليم الفتاة بخصوص الأفكار الخاطئة.

ولاشك: أن مجرد شعور الفتاة بأن هناك من يهتم بأمره ويسعى لسعادته وتحقيق شفائه - مجرد هذا الشعور يؤدي إلي تحسين حالته.. ومجرد وجود إنسان متفهم يتحدث إليه ويفصح له عما يجيش في صدره ويكون متقبلاً له، كل ذلك يؤدي إلي تحسين حالته.

العلاج المعرفي السلوكي: يعد العلاج المعرفي السلوكي من العلاجات الفعالة مع الشره العصبي للطعام حيث يعمل علي التأثير في سلوكيات الأكل الصاخب فيؤدي إلي الإقلال من

معدل حدوثه إلي جانب الإقلال من حدة الإضطرابات النفسية التي تلازمه. ويهدف العلاج السلوكي المعرفي إلي تغيير النمط الفوضوي في الأكل لدي الفتاة، وعندما يقلع الفرد عن الأكل الصاخب بسبب العلاج يقل وزنه كثيراً. وهذا يعني أننا يجب أن نعاج الأكل الصاخب أولاً، ثم نلفت بعد ذلك إلي الوزن.

التنظيم الغذائي

ينصح الإخصائي النفسي الفتاة المراهقة بضرورة تعديل السلوك الغذائي عن طريق التدعيم الموجب لسلوك الأكل السوي وإطفاء السلوك الشره.. ومن المقترحات التي يجب أن توضع في الاعتبار وأن تتفهمها الفتاة لتنظيم غذائها، وذلك على النحو التالي:

- أن يكون الغذاء متوازناً، وأن أكل الأطعمة المناسبة بالكميات الصحيحة مهم لبناء العقل والجسم والنمو والتطور.
- أن كل الأطعمة تمد الجسم بالطاقة، وأن بعض الأطعمة تحتوي علي طاقة أكبر وسعرات حرارية أكثر من البعض الآخر - ولذلك: فان المرء إذا استهلك سعرات حرارية أكثر مما يستخدم الجسم، فإن هذه السعرات تختزن علي شكل دهن في الجسم.
- أن الجسم يحتاج للطعام للحصول علي الطاقة، وكلما زاد استخدام الجسم للطاقة قلت كمية الدهن المخزون... وأن الأنشطة الرياضية والجري والقفز والتسلق تستهلك طاقة أكثر من مجرد الجلوس والوقوف.
- الوجبات الخفيفة التي تقدم بين الوجبات الرئيسية تسهم في مجموع ما يحصل عليه يومياً من الطعام، وأن بعض الوجبات الخفيفة تحتوي علي سعرات أقل من البعض الآخر وتكون أكثر تغذية.

- أن يراقب الإنسان نفسه عند تناول الطعام - وإذا كان طفلاً فلتراقبه الأم وتشجعه بتقديم كميات صغيرة من الطعام، فإذا احتاج مزيداً فليعطي أيضاً كمية صغيرة دون تجاوز الحد.
- أن يأكل الطفل ببطء ويتمهل ويمضغ ببطء، وأن يأخذ لقمات صغيرة وينتظر بينهما، ويمكن الدخول مع الطفل في حديث سار أثناء الأكل وإعطائه فرصة للكلام والإنصات والضحك.
- تجنب الأطعمة التي تحتوي علي كميات كبيرة من السكر والدهون تحتوي علي سعرات عالية ولا تحتوي علي قيمة غذائية كالمشروبات الغازية، ورقائق البطاطس، وقطع الحلوى.
- تسجيل الخط القاعدي لبداية تطبيق البرنامج الغذائي، وتتم مراقبة الوزن تدريجياً حتى الوصول إلي الوضع المثالي، ويجب ملاحظة: أن الهدف ليس خفض الوزن ولكن القضاء علي سلوك الشره المفرط، مع مواصلة تعزيز وتدعيم سلوك الأكل المناسب بشكل متكرر.(ايفا عيسي:١٩٩٣)

❋ فقدان الشهية العصبي:

يعد هيلد بروش Hilde Bruch من أوائل الذين كتبوا في مجال فقدان الشهية في العصر الحديث، وذلك في مقالته عام ١٩٦١ بعنوان " الاضطرابات الإدراكية والمفهومية في فقدان الشهية العصبي" وقد أكد الكثيرين أن هذه المقالة هي بداية مرحلة جديدة لفهم هذا المرض .

ويعرف فقدان الشهية العصبي بأنه فقد خطير في الوزن مصحوب باختلال في صورة الجسم، حيث يبقي الفتاة خائفاً من زيادة وزنه، ويبدي اختلالاً واضحاً في إدراكه لشكل

وحجم الجسم، ورغم ذلك يعد مسمي هذا الإضطراب غير مطابق تماماً لأعراضه لأن فقد الشهية عادة ما يكون أمراً نادراً (محمد عبد الرحمن،٢٠٠٠) فهو رفض للطعام ومقاومته بكل الطرق وليس فقد الشهية كما يطلق عليه (أحمد عكاشة، ٢٠٠٣).

إن فقدان الشهية العصبي يعد اضطراب انفعالي معقد يلقى بضحاياه في أحد نظم الغذاء لملاحقة النحافة الشديدة. إذ ينظر هؤلاء المرضى إلى النحافة على أنها الحل المثالي للمشكلات الحياتية.

إن اتخاذ القرار الخاص بإتباع نظام غذائي للنحافة يظهر بطرق مختلفة، وتعتمد هذه الطرق علي شخصية المرأة والظروف الخاصة التي ترى بها نفسها. إن بدء فقدان الشهية العصبي بين المراهقات، ينبع من إدراكها بأنها لا تحب شكل أو حجم جسمها. وذلك عندما تدرك الفتاة المراهقة تلك التغيرات التي تطرأ على جسمها أثناء مرحلة البلوغ أو عندما ينبهها الآخرين إلى أهمية محافظتها على وزنها ،فتبدأ في الإقلاع عن الطعام ،ويلازمها خوف مرضى من الإصابة بالسمنة المفرطة. فغالباً ما تكون إصابة الفتيات بفقدان الشهية العصبي مع بداية التغيرات البدنية المنبئة بقرب نزول الطمث فينحبس ،وانحباسه يوحى بالصلة بين العزوف عن الطعام و الجنس.

ويعد فقدان الشهية العصبي من الاضطرابات التي تتسم باهتمام شديد بشكل الجسم ومحاولات تجنب زيادة الوزن، إذ يرتبط بالعزوف عن الطعام أو الامتناع عنه بغرض الرشاقة وتحقيق معايير الجاذبية الجسمية وفقاً لثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد.

- محكات تشخيص فقدان الشهية العصبي:

يحدد الدليل التشخيصي الإحصائي للأمراض النفسية والعقلية الأمريكي في الطبعة الرابعة DSM I V (١٩٩٤) المحكات التالية لتشخيص فقد الشهية العصبي كأحد اضطرابات الأكل على النحو التالي:

(١) رفض الإبقاء على وزن الجسم عند المعدل الطبيعي الذي يتناسب مع الطول والعمر، أو الإبقاء على وزن الجسم أقل من ٢٥ ٪ من المتوقع، أو عدم القدرة على تحقيق الزيادة المتوقعة في الوزن خلال فترة النمو مما يؤدى إلى أن يصبح وزن الجسم أقل مما هو المتوقع.

(٢) الخوف الشديد من زيادة الوزن أومن أن يصبح الفرد بديناً حتى إن كان وزنه أقل من معدله الطبيعي.

(٣) حدوث اضطراب في الطريقة أو لأسلوب الذي الفرد وزن أو شكل جسمه، مع التأثير المفرط لوزن الجسم أو شكله على تقييم الفرد لذاته، أو أفكاره لخطورة انخفاض وزن جسمه أو نقصه وذلك بالصورة التي يكون عليها.

(٤) انقطاع الطمث غير الطبيعي لدى الإناث وذلك بعد بداية الدورة الشهرية، وانقطاعها ثلاث شهور متتالية.

وهناك مجموعتان من مرضى فقدان الشهية العصبي ،هما:

المجموعة الأولى: وهي التي تفقد الوزن من خلال تقليل الطعام بشدة وتشكل ما يقرب من ٦٠ ٪ من مرضى فقدان الشهية العصبي.

المجموعة الثانية: وهي التي تأكل حتى التخمة، وتتقيأ محاولة بذلك منع امتصاص الجسم للطعام من خلال حث الذات على التقيؤ أو استخدام الملينات (المسهلات) أو الأدوية المدرة للبول أو الحقن الشرجية أو التدخين بشراهة.

❑ الآثار البدنية والنفسية لفقدان الشهية العصبي:

إن الفتاة التي تعانى من فقد الشهية العصبي عادة تقلل من الطعام اللازم أو رفضه كليّة أو استصعاب مضغه وبلعه، وكراهية إدخاله إلى القناة الهضمية ، و الإصابة بضعف شديد في

مقاومة الجسم ، كما تصاب الفتاة بالنحافة نتيجة لفقدها لكمية كبيرة من الدهون مما يترتب عليه شعورها بالتغيرات المناخية – الحرارة أو البرودة – بصورة أكبر من غيرها. كما أنها تبدو شاحبة اللون، وقد يصبح جلدها جاف ويتقصف شعرها ويضعف، ويبدو الوهن على وجهها وذراعها وظهرها،وينخفض ضغط دمها بسبب محاولة جسمها التوافق مع الطاقة المنخفضة التي يمتصها الجسم، هذا إلى جانب حدوث قروح على القدمين والركبتين والإليتين،والعانة وخلف الرأس والكوعين، وتبرز الأسنان وتصغر، ويضعف الصوت ويرفع.

كما يؤدى فقدان الشهية العصبي إلى حدوث نوع من الأنيميا وضيق محيط العظام، ونقص البروتين في الجسم، بالإضافة إلى زيادة نشاط الغدة اللعابية وظهور تشنج بالعضلات، وعدم انتظام ضربات القلب. وكلها انعكاسات غير مباشرة تحدث للمرضي الذين يحثون الذات على التقيوء.

ويعد توقف الطمث أحد المظاهر البدنية لفقدان الشهية العصبي، وهو يحدث قبل الانخفاض الحقيقي للوزن وذلك بسبب الهبوط المفاجئ لنسبة الدهون بالجسم، هذا إلى جانب قلة البوتاسيوم والذي يؤدى إلى التوتر وسرعة الانفعال العصبي والفتور والخمول.

إن الفتاة التي تعانى من فقدان الشهية العصبي تتسم في مرحلة الطفولة بأنها أكثر إحساساً بمشاعر الآخرين وتحاول تخمين ما يريده الآخرين منها لتلبيته، ونجدها تتجنب المشاكل قدر الإمكان، كما يصفها الوالدين والمعلمين بأنها في طفولتها تتسم بالانبساطية والأدب في تعاملها مع الآخرين. و لا تتسبب في أي مضايقات للآخرين وأنها مرتفعة التحصيل، ولكنها في مرحلة المراهقة قد تتعرض لعدد من المواقف المثيرة للضغوط النفسية.

إن المراهقات ذوات فقدان الشهية العصبي شديدات العناد إلى حد أنهن يؤذين أنفسهن برفض الطعام، أو قد يكن منبوذات فيثأرن لأنفسهن بمرضهن و يعذبن أبويهم بمرضهن، ومع بداية فقدانهن لوزنهن يتحول الاهتمام إليهن – وهو ما يعرف بالمكسب الثانوي من المرض.

كما يعانى ذوى فقدان الشهية العصبي من اضطراب علاقتهم مع الآخرين، والأهل على وجه الخصوص، وهذا ما يجعل الغير يكنّ الكره لهؤلاء المرضى بسبب سلوكهم العام غير الودي، وإظهارهم لتصرفات غير مرغوبة أو محببة مثل الكذب، والتبرير.

دور الإخصائي النفسي في مواجهة فقدان الشهية العصبي:

وعادة ما تعتمد العلاجات الفردية لفقد الشهية العصبي علي كل من العلاج السيكودينامي والعلاج المعرفي للنساء المرضي. ويقوم هذا المدخل علي افتراض أن فقد الشهية العصبي هو خوف من اكتساب الوزن الطبيعي ويسببه صراع حول الوصول إلي دور المرأة الناضجة والذي يعني اكتساب الوزن الطبيعي وبدانة البنية، ونظرا لأن العلاج السيكودينامي غير فعال بمفرده في هذه الحالة فإنه من الضروري إقحام العلاج المعرفي ولو في بعض وسائله لأن اضطرابات الأكل ما هي إلا أساليب لا تكيفية لمواجهة الصراعات العاطفية ومن ثم فإن العلاج يهدف إلي حل الصراعات الضمنية ومساعدة المرضي علي تطوير أساليب أكثر بنائية للمواجهة مع اضطرابات النمو.

هذا ويجب أن تسير خطة العلاج علي النحو التالي:

(١)تقديم نموذج العلاج المعرفي السلوكي علي أن يتضمن ذلك ما يلي:

- التعرف علي منطق العلاج.
- التعرف علي تلك الضغوط التي يمكن أن تؤدي إلي الإضطراب.

(٢) تقديم المعلومات وإجراء المناقشات حول ما يلي:

- مخاطر نقص الوزن والعزوف عن الأكل.
- الضغوط الثقافية التي ترتبط بالأكل وحجم الجسم.
- التقيد بنظام غذائي معين وعدم الخروج عنه.
- التغذية الجيدة والأنماط الجيدة لتناول الأكل.

◈ التخطيط للوصول إلي الوزن العادي.

◈ التذبذب في الوزن وكيفية الوصول إلي الوزن العادي.

(٣) زيادة كم ونوع التغذية المراد تناولها بغرض استعادة الوزن والوصول به إلي المستوي الصحي العادي.

(٤) تحديد المعارف المختلة وظيفياً والتي ترتبط بالأكل والوزن وحجم الجسم.

(٥) العمل علي تعديل تلك الأفكار المختلة وظيفياً من خلال إتباع استراتيجيات علاجية معينة.

(٦) تناول جوانب أخري ذات صلة بالاضطراب كتقدير الذات، والإكتئاب، والمهنة، والأسرة، إلي جانب العديد من الأمور الاجتماعية المختلفة.

(٧) التدريب علي إستراتيجيات المواجهة حتى تجنبنا حدوث انتكاسة بعد انتهاء البرنامج العلاجي.

المراجع

إبراهيم السويلم (٢٠٠٢): **التوجيه والإرشاد الطلابي**، الرياض، دار طويق للنشر والتوزيع.

أحمد عباس عبد الله (١٩٩٩): إرشاد أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" رسالة إلى العاملين في مجال الإرشاد"، **ندوة الإرشاد النفسي والمهني من أجل نوعية أفضل لحياة الأشخاص ذوى الاحتياجات**، جامعة الخليج العربي، البحرين، ص ص: ١٨٧ — ٢٠٨.

أحمد عكاشة (٢٠٠٣): **الطب النفسي المعاصر**، القاهرة: مكتبة الأنجلو.

أحمد محمد الزغبي (٢٠٠١): **الاضطرابات النفسية والدراسية عند الأطفال والمشكلات السلوكية**، الرياض: دار زهران للنشر والتوزيع.

إسماعيل الفقي (١٩٩٠): دور الأخصائي النفسي في المدرسة. **ندوة الإعداد العملي والمهني للأخصائي النفسي في مصر**، مركز الدراسات والبحوث النفسية ، جامعة القاهرة ، ص ص ٣ - ١٠ .

أشرف محمد عبد الحميد (١٩٩٥) : دراسة بعض متغيرات البيئة المدرسية وعلاقتها بالتوافق النفسي لدى ذوي الإعاقة البصرية، **رسالة ماجستير** (غير منشورة) ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق .

آلان كازدين (٢٠٠٠) : **الاضطرابات السلوكية للأطفال والمراهقين**، ترجمة : عادل عبد الله ، القاهرة ، دار الرشاد .

السيد محمد الجندي (١٩٩٦) : مستوى الكفاءة المهنية لحركة الإرشاد النفسي مقابل الانحرافات النفسية والاجتماعية بالمدارس الثانوية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، **مجلة علم النفس** (العددان ٤، ٤١) ص ص ٩٨ - ٩٩.

ايفا عيسي (١٩٩٣): **المرشد العملي لحل المشكل السلوكية في مرحلة ما قبل المدرسة**، ترجمة: عبد العزيز الدخيل وآخرون، الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج.

إيهاب الببلاوى (١٩٩٥): العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية والسلوك العدواني لدي ذوي الإعاقة السمعية، **رسالة ماجستير** (غير منشورة) كلية التربية، جامعة الزقازيق.

إيهاب الببلاوى (١٩٩٩): فعالية العلاج المعرفي والسلوكي في خفض القلق لدى ذوي الإعاقة البصرية، **رسالة دكتوراه** (غير منشورة) كلية التربية، جامعة الزقازيق.

إيهاب الببلاوى (٢٠٠٣):**اضطرابات النطق(دليل أخصائيي التخاطب والمعلمين والآباء)**، القاهرة: دار النهضة المصرية.

بشير الرشيدي، راشد السهل(٢٠٠٠): **مقدمة في الإرشاد النفسي**، الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع.

جمال الخطيب (١٩٩٠): **تعديل السلوك: القوانين والإجراءات**، الرياض: مكتبة الصفحات الذهبية.

جمال الخطيب (١٩٩٣): **تعديل سلوك الأطفال المعوقين (دليل الآباء والمعلمين)**، عمان: مكتبة إشراق للنشر والتوزيع.

جمال الخطيب (١٩٩٥): مقدمة في الإعاقة السمعية، عمان: دار الفكر.

جمال مختار حمزة(١٩٩٥): **دور الأخصائي النفسي مع فريق العمل في تناول حاجات المعوقين عقلياً**، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. **مجلة علم النفس**. العدد (٣٥). ص ص١٢٢ -١٢٩

جميل محمود الصمادي (١٩٩٧): صعوبات التعلم والإرشاد النفسي التربوي، **المؤتمر الدولي الرابع لمراكز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس في الفترة ٢ -٤ ديسمبر، ص ص ١٠٦٩ - ١٠٨٢.

جميل الصمادي (١٩٩٩): الإرشاد النفسي للأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، **ندوة الإرشاد النفسي والمهني من أجل نوعية أفضل لحياة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة**، جامعة الخليج العربي، البحرين، ص ص :٩٥ — ١١٦ .

جيلدارد، د(١٩٩٨): **الدليل العملي للمرشدين النفسيين والتربويين" أساسيات الإرشاد الفردي"**، ترجمة: نادر فهمي الزيود، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

حامد زهران (١٩٩٨): **التوجيه والإرشاد النفسي**، ط٢، القاهرة: عالم الكتب.

حسام الدين عزب (١٩٨١): **العلاج السلوكي الحديث**، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

حسن مصطفى عبد المصطفى(١٩٩٨): **علم النفس الإكلينيكي**، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر.

حسن مصطفى عبد المصطفى (٢٠٠١): **الاضطرابات النفسية الطفولة والمراهقة**، القاهرة: دار القاهرة للنشر.

حسن مصطفى عبد المصطفى (تحت الطبع): **العلاج المعرفي بين النظرية والتطبيق** ، القاهرة : مكتبة النهضة المصرية .

دونالد مورتنس، الن شمولر(ب.ت) : **التوجيه في المدرسة**، ترجمة: إبراهيم حافظ، إبراهيم خليل، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية والجمعية المصرية للدراسات النفسية(١٩٩٥): **الميثاق الأخلاقي للمشتغلين بعلم النفس في مصر.**

رأفت محمد بشناق(٢٠٠١): **سيكولوجيا الأطفال**، دمشق: دار النفائس.

رشدي فام منصور (٢٠٠٠): **علم النفس العلاجي والوقائي**، القاهرة: الأنجلو المصرية.

رمزية الغريب (١٩٨٢): البناء النفسي للمعوق وتوافقه النفسي والاجتماعي، **ندوة الطفل المعوق**، القاهرة، من ٣١يناير - ٤فبراير، مكتبة الأنجلو المصرية، ص ص ٤ - ١٣.

رمضان القذافي(١٩٩٣): **سيكولوجية الإعاقة**، طرابلس:مكتبة الجامعة المفتوحة

زكريا الشربيني (٢٠٠١): **المشكلات النفسية عند الأطفال**، القاهرة: دار الفكر العربي.

شيفر وملمان (١٩٩٩): **سيكولوجية الطفولة والمراهقة**، ترجمة وتعريب: سعيد العزة، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر.

سعد جلال (١٩٩٢): **التوجيه النفسي والتربوي والمهني**، القاهرة: دار الفكر العربي.

سعيد العزة (٢٠٠٠): **الإرشاد الجماعي العلاجي**، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر.

سعيد العزة (٢٠٠١): **الإرشاد النفسي أساليبه وفنياته**، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر.

سعيد العزة _ جودة عبد الهادي (٢٠٠١): **تعديل السلوك الإنساني**، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر.

سعيد دبيس وآخرون (٢٠٠٤): دليل معلم التدريبات السلوكية (الأخصائي النفسية)، المملكة العربية السعودية: وزارة التربية والتعليم

سهام درويش (١٩٨٨): **مبادئ الإرشاد النفسي**، الكويت: دار القلم.

سهير كامل أحمد (١٩٩٨): **التوجيه والإرشاد النفسي**، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

سوزانا ميلر(١٩٨٧): سيكولوجية اللعب، ترجمة: حسين عيسى، الكويت. **سلسلة عالم المعرفة**، العدد (١٢٠).

سيد عبد الحميد مرسي (١٩٨٧): **الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني**، ط٢، القاهرة: مكتبة وهبة.

شاكر قنديل(١٩٩٦): الاستجابات الانفعالية السلبية لآباء الأطفال المعاقين عقليا ومسئولية المرشد النفسي (دراسة تحليلية) ، **المؤتمر الدولي الثالث لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس٢٣ - ٢٥ ديسمبر، ص ص ٦٢٥ - ٦٤٢ .

شاكر عبد الحميد(١٩٩٦): دور الأخصائي النفسي في الكشف عن الواعدين بالإبداع في السياق التربوي، **الدورة التأسيسية الأولى للأخصائي النفسي المدرسي**، مركز البحوث والدراسات النفسية، جامعة القاهرة، في الفترة من ٣١أغسطس - ٥سبتمبر . ص ص ٢٠٧ _ ٢٢٤.

صالح أبو عباة، عبد المجيد نيازي(٢٠٠١): **الإرشاد النفسي والاجتماعي**، الرياض، مكتبة العبيكان.

صلاح احمد مراد (١٩٩٦): دور القياس والتقويم في دعم الخدمة النفسية في السياق المدرسي، **الدورة التأسيسية الأولى للأخصائي النفسي المدرسي**، مركز البحوث والدراسات النفسية، جامعة القاهرة، في الفترة من ٣١أغسطس _ ٥سبتمبر . ص ص ١٥ _ ٢٣.

عادل عبد الله محمد (٢٠٠٠): **العلاج المعرفي السلوكي**، القاهرة: دار الرشاد.

عبد الحميد الهاشمي(١٩٨٦):**التوجيه و الإرشاد النفسي (الصحة النفسية الوقائية)**، جدة: دار الشروق.

عبد الرحمن العسيوي (٢٠٠٠): **اضطرابات الطفولة والمراهقة وعلاجها**، بيروت: دار الكتاب الجامعية.

عبد الرحمن سليمان، شيخة الدربستي (١٩٩٦): الحاجات الإرشادية للأطفال المعاقين. **المؤتمر الدولي الثالث لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس في الفترة من ٢٣ _ ٢٥ديسمبر. ص ص ٧٥١ - ٧٨٨.

عبد الرحمن سليمان، هشام عبد الله (١٩٩٨): إعداد المرشد النفسي وتحديات القرن الحادي والعشرين: الواقع وتطلعات المستقبل، **المؤتمر الدولي الخامس لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس١ -٣ ديسمبر، ص ص ٤٨٣ - ٥١٩.

عبد الستار إبراهيم (١٩٩٤): **العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث**، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.

عبد العزيز الشخص (١٩٩٠):أثر المعلومات في تغيير الاتجاهات نحو المعوقين، **مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية** (١)، الرياض، المجلد الثاني، ص ص ٧٧ - ٩٩.

عبد الغفار الدماطي (١٩٨٧):الخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية للصم، **ندوة المعوقين بين الواقع وتطلعات المستقبل**، جامعة الملك سعود. الرياض، ص ص ١ - ٣٤.

عبد الفتاح عثمان (١٩٧٧): **خدمة الفرد والمجتمع المعاصر**، ط ٢، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

عبد الكريم سليمان (١٩٩٧): لمحة عن التوجيه الإرشادي الطلابي في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، **المؤتمر الدولي الرابع لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس، ص ص ١١٦٣ - ١١٦٩.

عبد المطلب أمين القريطي (١٩٩٦): **سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم** ، القاهرة: دار الفكر العربي.

عبد المنعم شحاتة (١٩٩٨): **سيكولوجية التدخين**، القاهرة: دار غريب.

عدنان محمد الفرح (١٩٩٨): إعداد المرشد المدرسي بين الحاضر والمستقبل، **المؤتمر الدولي لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس، ١ -٣ديسمبر. ص ص ٥٢١ - ٥٣٤.

عزيز سمارة، عصام نمر(١٩٩٢): **محاضرات في التوجيه والإرشاد**، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.

عطية محمود هنا (١٩٥٩): **التوجيه التربوي والمهني**، القاهرة:دار النهضة المصرية .

علاء الدين كفافي (٢٠٠٣): **الصحة النفسية والإرشاد النفسي**، الرياض: دار النشر الدولي.

على السيد سليمان (١٩٩٦): التكامل بين التربية الاجتماعية والخدمة النفسية التربوية بالتعليم. **المؤتمر المهني الرابع للتعليم حول تحديث دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي**، نقابة المهن الاجتماعية بالقاهرة. ديسمبر . ص ص ١ -١٠.

على عبد الله على (٢٠٠٠): برنامج إرشادي لتنمية فعالية الذات والضبط الذاتي للحد من سلوك التدخين لدى عينة من المراهقين، **رسالة ماجستير** (غير منشورة) كلية التربية، جامعة الزقازيق.

فاروق صادق (١٩٩٦): دور الأخصائي النفسي المدرسي نحو ذوي الحاجات الخاصة، **الدورة التأسيسية الأولى للأخصائي النفسي المدرسي**، مركز البحوث والدراسات النفسية، جامعة القاهرة، في الفترة من ٣١أغسطس - ٥سبتمبر، ص ص ٩٣ - ١٠٥.

فاروق سيد عبد السلام (١٩٨٢): المعوقون وتصنيفهم وخصائصهم الشخصية، **مجلة كلية التربية، جامعة أم القرى**، العدد العاشر، ص ص ٩ - ٥٥.

فاروق عبد السلام (١٤٠٨): **في التوجيه والإرشاد الطلابي**، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي.

فاروق عبد السلام، ميسره طاهر، يحي مهني (١٩٩٧): **مدخل إلى الإرشاد التربوي والنفسي**، مكة: الدار السعودية للنشر والتوزيع.

فاروق حمدي الفرا (١٩٨٤): التوجيه والإرشاد بدولة الكويت، **ندوة علم النفس التربوي**، كلية التربية، الكويت.

فتحي عبد الرحيم (١٩٨٥):**استخدام المنهج الإسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية كمتغيرات وسيطة بين العجز الجسمي وسوء التوافق النفسي(دراسة ميدانية في البيئة الكويتية)** في لويس كامل مليكة: قراءات في علم النفس الاجتماعي في الوطن العربي، (المجلد الرابع)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

فتحية أحمد بطيخ (١٩٩٦): تقويم الدور الإرشادي للمدرسين بفصول التربية الخاصة للأطفال المعاقين سمعيا في ضوء متطلبات الإرشاد النفسي لهم. **المؤتمر الدولي الثالث لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس، في الفترة من ٢٣ - ٢٥ديسمبر، ص ص ٤٤٧ - ٥٠٦.

وليم هـ. فريدمان (١٩٩٧): **ممارسة العلاج الجمعي**، ترجمة: ناصر بن إبراهيم المحارب، الرياض: جامعة الملك سعود النشر العلمي.

كاميليا عبد الفتاح (١٩٩٨): **سيكولوجية العلاج الجماعي للأطفال**، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.

كمال مرسي، بشير الرشيدي (١٩٨٤): التوجيه والإرشاد "فلسفته وأخلاقياته في المجتمعات الإسلامية، **ندوة علم النفس التربوي**، كلية التربية، الكويت.

لطفي فطيم (١٩٩٣): **العلاج النفسي الجمعي**، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

لويس كامل مليكة (١٩٩٠): **العلاج السلوكي وتعديل السلوك**، الكويت: دار القلم.

ماجي إبراهيم (١٩٩٦): أهداف ومستويات العملية الإرشادية النفسية، **المؤتمر الدولي الثالث لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس ٢٣ - ٢٥ديسمبر، ص ص ١١٩٧ - ١٢٠٩.

ماهر محمود عمر (١٩٩٨): **المقابلة في الإرشاد والعلاج النفسي**، ط٢، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

ماهر محمود عمر(١٩٩٩): **المرشد النفسي المدرسي**، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

مجدي عبد الكريم حبيب (١٩٩٦): **التقويم والقياس في التربية وعلم النفس**، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.

محمد أحمد إبراهيم سعفان (٢٠٠١): **الإرشاد النفسي للأطفال**، الجزء الثاني، القاهرة: دار الكتاب الحديث.

محمد السيد عبد الرحمن (١٩٩٩): **علم الاضطرابات النفسية والعقلية**، الجزء الثاني، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر.

محمد عماد الدين إسماعيل (١٩٨٩): **الطفل من الحمل إلى الرشد**، الجزء الثاني، الكويت: دار القلم.

محمد محروس الشناوي، محمدين عبد المحسن (١٩٩٦): الإرشاد وتحديات العصر. **المؤتمر الدولي الثالث لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس، في الفترة من ٢٣ - ٢٥ديسمبر، ص ص ٨٨٥ - ٩٢٤.

محمد محروس الشناوي (١٩٩٤): **نظريات الإرشاد العلاج النفسي**، القاهرة: دار غريب.

محمد محروس الشناوي (١٩٩٦): **العملية الإرشادية**، القاهرة: دار غريب.

محمد محروس الشناوي، محمد التويجري (١٩٩٦): الإرشاد وتحديات العصر، **المؤتمر الدولي الرابع لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس

محمد محروس الشناوي، محمد السيد عبد الرحمن (١٩٩٨): **العلاج السلوكي الحديث**، القاهرة: دار قباء.

محمد منصور وفاروق عبد السلام(١٩٨٠): **النمو من الطفولة إلى المراهقة**، جدة: تهامة للنشر والتوزيع.

محمد جعفر جمل الليل(٢٠٠٢): **المساعدة الإرشادية النفسية**، مكة: الدار السعودية للنشر والتوزيع.

محمد نجيب أحمد الصبوة (١٩٩٨): تصور علمي لأدوار الأخصائي النفسي المدرسي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. **مجلة علم النفس**. العدد (٤٦). ص ص ٦٠ - ٧٢.

محمود السيد أبو النيل (١٩٩٦): دور الأخصائي النفسي المدرسي في التوجيه التربوي والمهني، **الدورة التأسيسية الأولى للأخصائي النفسي المدرسي**، مركز البحوث والدراسات النفسية، جامعة القاهرة، في الفترة من ٣١أغسطس - ٥سبتمبر. ص ص ٢٧ - ٥٧.

محمود عطا عقل (٢٠٠٠): **الإرشاد النفسي والتربوي(المداخل النظرية –الواقع –الممارسة)**،الطبعة الثانية، الرياض: دار الخريجي للنشر والتوزيع.

ممدوحة محمد سلامة (١٩٨٤):أساليب التنشئة وعلاقتها بالمشكلات النفسية في مرحلة الطفولة الوسطي، **رسالة دكتوراه(غير منشورة)** ، جامعة عين شمس، معهد دراسات الطفولة.

ممدوحة محمد سلامة (١٩٩٢): **الإرشاد النفسي "منظور إنمائي"**، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

منير حواشين - زيدان حواشين (١٩٩٦): **النمو الانفعالي عند الأطفال**، القاهرة: مكتبة دار الفكر.

مها زحلوق (١٩٩٧): برامج الإسراع والإثراء للتلاميذ المتفوقين عقليا. **المؤتمر الدولي الرابع لمركز الإرشاد النفسي**، جامعة عين شمس، الفترة من ٢ -٤ديسمبر، ص ص ١١٢٣ - ١١٤٠.

هدى عبد الحميد برادة - فاروق محمد صادق (٢٠٠٠): **علم نفس النمو**، القاهرة: وزارة التربية والتعليم.

والتر بينجهام، بروس مور (١٩٩٩): **سيكولوجية المقابلة**، ترجمة فاروق عبد القادر وآخرون، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.

يوسف القاضي، لطفي فطيم، محمود عقل (١٩٨١): **الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي**، الرياض: دار المريخ.

American Psychiatric Association (1987). Diagnostical and statistical manual of mental disorders. DSM- III- R. Washington; D.C.

Brown, S. D. & Lent, R. W. (Ed.)(1992) : **Handbook of counseling psycholog**y, (2nd ed.) New York : John Wiley & Sons .

Corey,.(1992).Theoryandpractice ofcounselingand psychotherapy (4 th ed.) pacific Grove, CA: Brooks/ Cole.

Ellis,A.(1962). **Reason and Emotion in psychotherapy**. Secaucus: N.J Lyle Stuart.

Ellis, A. (1973) **. Humanistic psychotherapy the rational - emotive approach**, New York : McGraw - Hill book company .

Ellis,A.(1976).Rational-Emotive psychotherapy (In) sahakian,W., psychotherapyandcounseling Techniques in Intervention, Chicago: McNally collegepublishing company.

Ellis,A.(1977) **Reason and Emotion in psychotherapy**, NewJersy: The citadel press.

Ellis, A. (1978) A note on The treatment of agoraphobics with cognitive versus prolonged exposure in vivo. **Beha. Res .& Therapy**, Vol.17,pp. 162 - 164, June.

Ellis, A. (1979). Discomfort Anxiety: A new cognitive behavioral construct. **Rational living**, Vol. 14, (2), part 1, pp. 3-p.

Ellis, A. (1980a) Discomfort Anxiety: A new cognitive behavioral construct. **Rational living** , Vol. 16, (1). Part2, pp.25 - 30.

Ellis, A. (1980b). Rational - emotive therapy and cognitive - behaviour therapy: Similarities and differences. **Cognitive Therapyand Research**, Vol.4,pp.325-340.

Ellis, A. . & Bernard, M. (1985) **: What is rational - emotive therapy (RET) ?** (In) Ellis, A. & Bernard, M. (eds.), Clinical Applications of Rational, Emotive Therapy, New York : plenum .

Ellis, A. & Dryden, W. (1987) : **The Practice of Rational - Emotive therapy** . New York: Springer.

Filed,L.F.(2002). The body image experience of adolescent females :Body image development and the influences of self-efficacy **Dissertation Abstracts International** , 63-01B,P.565.

Gilliland and McGuiness, J. (1989) : **Counselling and special educational needs .** In : Jones, N. (ed.), Special Educational needs review, Vol. 2, Lewes : Falmer press.

Goldfried,M.& Goldfried, A. (1975) : **Cognitive change methods.** In kanfer, F. & goldstein, A. (ED.). Helping people change, New York: Pergamon press.

Hepworth,D.&Larsen,J.,1990 .**Direct social work practice: Theory and skills**.(3 rd) . Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Keable, D. (1997) **: Behavioral and cognitive theories of anxiety in the management of anxiety. A guide for therapists,** New York : Churchill Livingstone.

McGuiness, J. (1998) : **Counselling in schools**. London : Wellington House .

McLaughlin, C. Clark, p. & Chisolm, M. (1996) : **Counselling and Guidance in schools**, London. David Fulton.

Schaefer, H. & Martin, p. (1975): **Behavioural Therapy.** New York: McGraw, Hill-Book Company.

Schram, B. & Mandell, B.1986**.Human services strategies of intervention**. New York: Macmillan Publishing Company.

Sewell, T.L. (2000). Developing risk factors profiles for anorexia and bulimia nervosa in young adults,**DissertationAbstracts International** , 40-03, P782.

Telford, W.U. & Sawrey, J. M. (1972). **The Exceptional Individual.** New Jersey: prentice-Hall, Inc., Englewood gliffs.

Walpe, J. (1985) **. psychotherapy by reciprocal inhibition**. (In) Sohakian, W. (Ed.) psychotherapy and Counselling techniques in intervention, Rand McNally College publishing company.

جامعة الزقازيق
كلية التربية النوعية

مقرر الصحة النفسية
والإرشاد النفسي

الفصل الدراسي الأول

أسم الطالب/ الطالبة:
الفرقة الدراسية:
الشعبة:

ملحوظة مهمة:

في حالة عدم كفاية الصفحات للإجابة أضف صفحات من عندك.

الفصل الأول
مدخل إلى الصحة النفسية

أولا – هناك (١٥) مؤشرًا تدل على الصحة النفسية المطلوب منك:

أ-إضافة مؤشرات أخرى تراها مهمة من وجهة نظرك (في حالة وجودها أذكرها).

.....

.....

.....

.....

أ-ترتيب المؤشرات من حيث الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية من خلال خبرتك الخاصة في الحياة .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ب-تخير ثلاثة مؤشرات الأكثر أهمية بالنسبة لك وثلاثة مؤشرات الأقل أهمية بالنسبة لك. ثم اشرح مبررات ترتيبك لهذه المؤشرات.

مبررات اختياري للمؤشرات الأكثر أهمية (١-٢-٣)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مبررات اختياري للمؤشرات الأقل أهمية (١٣-١٤-١٥)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ثانيا - وضح الصواب أو الخطأ في العبارات الآتية

م	العبارة	العلامة
١	مفهوم الصحة النفسية مفهوم ثقافي	
٢	السلوك الشاذ في ضوء التحليل النفسي ينتج عن إعاقة الانسان عن تحقيق ذاته	
٣	خفض الصراعات مؤشر جيد للصحة النفسية في ضوء النظرية السلوكية	
٤	ايجاد الانسان معنى لوجوده معيار جيد للصحة النفسية في ضوء النظرية الوجودية	
٥	التوجه المنتج معيار جيد للصحة النفسية عند " فروم "	
٦	الابداعية معيار جيد للصحة النفسية عند "رانك "	
٧	تحقيق مطالب الانا عبر مراحل النمو معيار جيد للصحة النفسية عند " اريكسون "	

ثالثا- علل

١- الصحة النفسية فرع تطبيقي من فروع الصحة النفسية

.....

.....

.....

.....

.....

٢-الصحة النفسية حالة دائمة نسبيًا

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٣-الوقاية خير من العلاج مبدأ من مبادئ الصحة النفسية الايجابية

.....

.....

.....

.....

.....

.....

رابعا – اشرح المصطلحات الآتية :

١-المواءمة في الصحة النفسية

.....

.....

.....

.....

.....

٢- تحقيق الذات

.....

.....

.....

.....

.....

.....

رابعا – في ضوء دراستك لموضوعات الفصل الأول هل يمكنك تحديد مدخلات ومخرجات الصحة النفسية (سؤال للمتميزين)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تطبيقات الفصل الثاني
السواء واللاسواء في الصحة النفسية

اولاً- من المؤشرات الدالة على السلوك : شدة السلوك – كمون السلوك - تكرار السلوك ؛ المطلوب منك توضيح متى يكون المؤشر دال على السوية أو دال على اللاسوية

نموذج إرشادي للإجابة

المؤشر	حالات يكون فيها المؤشر ايجابي	امثلة عليها	حالات يكون فيها المؤشر سلبي	امثلة عليها
شدة السلوك				
كمون السلوك				
تكرار السلوك				

ثانيا- استخدام المحكات في معرفة السوية واللاسوية في الصحة النفسية سهل على الاخصائيين والمعالجين تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بالصحة النفسية ومع ذلك كان لكل محك من المحكات مميزات وعيوب جعلت الحاجة إلى استخدام أكثر من محك لنحكم بموضوعية على الشخصية.

المطلوب منك

١- توضيح فوائد وعيوب الأخذ بكل محك

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢-ترتيب أهم خمسة محكات من حيث أهميتها من وجهة نظرك

نموذج إرشادي للإجابة

المحكات	فوائد الأخذ بالمحك	عيوب الأخذ بالمحك
الاحصائي		
الذاتي		
الاجتماعي		

المحكات	فوائد الأخذ بالمحك	عيوب الأخذ بالمحك
المثالي		
النفسي		
القيمي		
التكاملي		
الباثولوجي		
الشخصية السوية		

ترتيب أهم خمسة	محكات من حيث أهميتها	من وجهة نظري
	مبررات اختياري	درجة تطبيق المحك على نفسي (الدرجة من عشرة)
١-		
٢-		
٣-		
٤-		
٥-		

ثالثا- علل لما يآتي

١- الفرق بين السوية واللاسوية فرق في الدرجة وليس النوع.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢-تحديد الحد الفاصل بين الصحة العقلية والمرض النفسي يكون صعب في مرحلة الطفولة عنه في المراحل العمرية التالية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٣-مؤشر التوافق النفسي غير كاف وحده للحكم على الشخصية السوية.

.....

.....

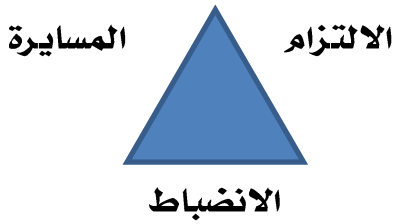
.....

.....

.....

.....

رابعا – توجد وجهة نظر ترى أن محددات السوية ثلاثة: الالتزام والمسايرة والانضباط وهي تأخذ شكل المثلث



والمطلوب منك (للمتميزين)

١- شرح مفهوم كل محدد من المحددات الثلاثة

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢- إضافة محددات أخرى لِتُكَوِّن بها شكل المربع أو اشكال هندسية أخرى

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٣- شرح مفهوم كل محدد من المحددات التي اضفتها

.....

.....

.....

.....

.....

تطبيقات الفصل الثالث

حيل الدفاع النفسي

أولا- علل

١- استخدام الحيل الدفاعية باعتدال يؤدي إلى التوافق والإفراط في استخدامها يؤدي إلى الاضطراب النفسي والعقلي.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢-يستطيع بعض الأشخاص التحكم في رغباتهم المكبوتة ويصعب على البعض الآخر ذلك.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٣- تعد حيلة الاعلاء من اسباب قيام الحضارة والإبداع والإبتكار.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٤-الافراط في استخدام حيلة النكوص يؤدي إلى الاضطرابات النفسية والعقلية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٥-يمارس كل من الاسوياء والمرضى الحيل الدفاعية على السواء.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٦-استجابة النكوص تشبه استجابة النمو.

.....

.....

.....

.....

.....

٧-حيلة التوحد الدفاعية قد تكون مفيدة للشخص أو مضرة.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٨- حيلة احلام اليقظة الدفاعية قد تكون مفيدة للشخص أو مضرة.

.....

.....

.....

.....

.....

ثانيا – فسر الظواهر النفسية الآتية .

١-تدرج العادة السلوكية إلى حيلة دفاعية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢-النقص الذي يشعر به الشخص قد يكون حقيقيا أو وهميا.

.....

.....

.....

.....

.....

٣-يفسر ميكانيزم الإنكار في ضوء مبدا اللذة والواقع.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ثالثا- في جدول قارن بين الظواهر النفسية المتقابلة والمرتبطة بالحيل الدفاعية الآتية :

الكبت	القمع
الكبت	النسيان
الدفاع في الكبت	الدفاع في الاعلاء

الاسقاط	التبرير
التبرير	**الكذب**
الشعور بالنقص	**عقدة النقص**
الانكار	**الكبت**
النكوص الجزئي	**النكوص الكلي**

رابعا – (للمتميزين) ما هي أكثر الحيل الدفاعية ارتباطا بحيلة الكبت ، ثم اشرح طبيعة العلاقة التفاعلية لكل حيلة بحيلة الكبت (كيف تُكملها أو تسبقها أو تتفاعل معها أو تنتج عنها).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تطبيقات الفصل الرابع

الاضطرابات النفسية والعقلية

أولا- عرف المصطلحات الاتية

١-المرض النفسي

.....

.....

.....

٢-العصاب

.....

.....

.....

٣-الاضطراب

.....

.....

.....

٤-باثولوجيا الشخص وباثولوجيا الاسرة

.....

.....

.....

ثانيا-اشرح (مستخدما الأدلة العلمية والأمثلة) التأثير المتبادل والمكمل لعاملي الوراثة والبيئة في نشأة الأمراض النفسية والعقلية.

وراثة × البيئة = المرض النفسي أو العقلي.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ثالثا-ناقش القضايا العلمية الآتية (مع تقديم الادلة)

١- نسبة تأثير الوراثة في بعض الأمراض أكبر من نسبة تاثير البيئة

.....

.....

.....

.....

.....

٢- نسبة تأثير البيئة في بعض الأمراض أكبر من نسبة تاثير الوراثة

.....

.....

.....

.....

رابعا-في جدول قارن بين الأمراض النفسية والأمراض العقلية من حيث الأسباب والأعراض ودرجة وعي الشخصية وتماسك الشخصية والعلاقات الاجتماعية وإمكانية العلاج

جوانب المقارنة	المرض النفسي	المرض العقلي
الأسباب		
الأعراض		
وعي الشخصية		
تماسك الشخصية		
العلاقات الاجتماعية		
إمكانية العلاج		

خامسا- (للمتميزين) ناقش القضايا الآتية

١-قدمت المدنية الكثير من الرفاهية للإنسان ومع ذلك زادت الأمراض النفسية والعقلية (كمًا وكيفًا).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

٢-متى يتحول المرض النفسي إلى مرض عقلي؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تطبيقات على الفصل الخامس

أذكر مجالات التوجيه والإرشاد المدرسي

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تطبيقات على الفصل السادس

تكلم عن أدوار فريق الإرشاد بالمدرسة

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تطبيقات على الفصل السابع

أذكر الفروق بين إرشاد الأطفال والمراهقين من حيث طبيعة المشكلات

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تطبيقات على الفصل الثامن

وضح الفروق بين الإرشاد الفردي والجماعي

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

تطبيقات على الفصل التاسع

تخير أحد مشكلات الطفولة والمراهقة وقارن بينهما من حيث الأسباب والعلاج

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....